REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Ministère de la
Santé Publique, Hygiène et
Prévoyance Sociale

Secretariat Général de la Santé Publique et Hygiene

Direction Générale d'Organisation et Gestion des Services et Soins et Santé

Plan Stratégique National de Santé Communautaire 2025-2030

« Des communautés engagées en faveur de la CSU et de la sécurité sanitaire en vue du développement durable »

Kinshasa, 2025

Plan Stratégique National de Santé Communautaire 2025-2030

« Des communautés engagées en faveur de la CSU et de la sécurité sanitaire en vue du développement durable »

unicef
pour chaque enfant

ICHESS

Table des matières

Préface 6
Remerciements 7
Liste des tableaux 8
Liste des figures 9
Abréviations et acronymes 10
Glossaire des concepts clés 14
Résumé exécutif 17
Introduction 19
I. Cadre général du pays 22
1.1. Contexte national 22
1.1.1. Situation géographique et administrative 22
1.1.2. Situation démographique 22
1.1.3. Situation socio-économique 25
1.1.4. Situation sécuritaire et humanitaire 26
1.1.5. Situation culturelle et linguistique 27
1.1.6. Situation du genre et de l'équité 28
1.1.7. Situation des urgences et catastrophes 29
1.1.8. Changement climatique 29
1.2. Organisation du système de santé 29
1.2.1. Système de santé 29
1.2.2. Système de santé communautaire 31
1.2.3. Organisation de la gestion des urgences dans la communauté 34
1.2.4. Organisation du contrôle citoyen 36
II. Cadre analytique 38
2.1. Revue des performances du système de santé 38
2.1.1. Etat de santé et sécurité sanitaire de la population 38
2.1.2. Principales causes et facteurs de risques de la mortalité 42
2.1.3. Principales causes des décès maternels, néonatals, infanto-juvénile et des adolescents en RDC 44
2.1.4. Tendance des années de vie corrigées de l'incapacité 45
2.1.5. Maladies à potentiel épidémique et urgences de santé publique 45
2.1.6. Situation des maladies non transmissibles 47
2.1.7. Situation des personnes en situation de handicap 47
2.1.8. Situation de la santé mentale 48
2.1.9. Situation des maladies tropicales négligées (MTN) 48
2.1.10. Situation des maladies cancéreuses 48
2.1.11. Situation de la drépanocytose 49
2.1.12. Situation de la couverture santé universelle en RDC 49
2.1.13. Disponibilité du personnel de santé 54
2.1.14. Couverture sanitaire 54
2.1.15. Analyse des interventions prioritaires 54
2.1.16. Analyse situationnelle du système de santé communautaire 57
2.2. Déterminants sociaux de la santé et autres indicateurs des ODD 62
2.2.1. Education 62
2.2.2. Eau, hygiène et assainissement 63
2.2.3. Accès à l'électricité 63
2.2.4. Accès aux technologies de l'information et de la communication 63
2.2.5. Enregistrement à l'état civil 63
2.2.6. Autres indicateurs des ODD 64

2.3. Quelques approches de santé communautaire 66
2.3.1. Child Friendly Communities and Real Time Monitoring ou « Communautés Amies des Enfants et Suivi en Temps Réels » 66
2.3.2. Renforcement du système de santé communautaire avec SANRU-FM, cas du Maniema 67
2.3.3. Amélioration de la qualité de référence dans les foyers pour enfants avec de l'artésunate rectal pour le paludisme (Community Access to Rectal Artesunate for Malaria/CARAMAL) 67
2.3.4. Amélioration du dépistage et du traitement de la Tuberculose pédiatrique par les ASC/RECO (Tuberculosis Implémentation Framework Agreement) 67
2.3.5. Suivi communautaire dans le cadre de contrôle citoyen par les OSC 68
2.3.6. Developpement des documents de politique, stratégiques et normatifs de communication sur les risques et engagement communautaire 68
2.3.7. Engagement communautaire dans la gestion des épidémies 69
2.3.8. Approche « VIVA » ou Famille en bonne santé ou Famille épanouie 69
2.3.9. Approche « Bulletin Communautaire de Performances » (BCP) 70
2.3.10. Approche Nutrition à assise communautaire (NAC) 70
2.3.11. Approche « Village Santé » 70
2.3.12. Quelques modèles des systèmes de santé communautaire dans le monde 73
2.4. Analyse FFOM du système de santé communautaire 75
2.5. Problèmes prioritaires du système de santé communautaire 77
2.5.1. Problèmes prioritaires liés à la gouvernance et au leadership 77
2.5.2. Problèmes prioritaires liés au financement en santé communautaire 78
2.5.3. Problèmes prioritaires liés aux ressources humaines en santé communautaire 78
2.5.4. Problèmes prioritaires liés aux prestations des services en santé communautaire et à la résilience du système de santé face aux urgences et risques sanitaires 78
2.5.5. Problèmes prioritaires liés à la gestion de la chaine d'approvisionnement et au système d'information en santé communautaire 79
2.5.6. Problèmes prioritaires liés à la communication sur les risques et à l'engagement communautaire 79
III. Cadre stratégique 80
3.1. Fondement de la santé communautaire 80
3.1.1. Engagements au niveau international, régional et sous régional 80
3.1.2. Engagements au niveau national 81
3.2. Vision, mission, principes directeurs et valeurs 81
3.2.1. Vision 81
3.2.2. Mission 81
3.2.3. Principes directeurs et valeurs 82
3.3. But, objectifs stratégiques et résultats attendus 82
3.3.1. But 82
3.3.2. Objectif stratégique général 82
3.3.3. Objectifs spécifiques 83
3.3.4. Résultats et cibles attendus 83
3.4. Axes ou priorités stratégiques, interventions et actions prioritaires 83
3.4.1. Axe stratégique 1 : Promotion des pratiques familiales essentielles 84
3.4.2. Axe stratégique 2 : Amélioration de l'offre des soins et services de santé au niveau communautaire 85
3.4.3. Axe stratégique 3 : Renforcement de la prévention, préparation et riposte communautaire face aux urgences de santé publique (épidémies et catastrophes naturelles) et aux effets climatiques 87
3.4.4. Axe stratégique 4 : Accroissement des financements et d'autres investissements en faveur de la santé communautaire 88

3.4.5. Axe stratégique 5 : Développement du système d'information sanitaire et recherche opérationnelle axés sur la digitalisation 89
3.4.6. Axe stratégique 6 : Renforcement de la gouvernance en santé communautaire 91
3.5. Théorie de changement 93
IV. Cadre de mise en œuvre 98
4.1. Opérationnalisation du plan stratégique 98
4.1.1. Ancrage et contribution du PSN SACO 2025-2030 dans le PNDS 2024-2033 98
4.1.2. Cadre programmatique 102
4.1.3. Priorisation des DPS dans la mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030 112
4.1.4. Description du paquet des soins et services de santé communautaire (Paquet Minimum d'Activités Communautaires) 113
4.2. Modalités d'exécution 118
4.2.1. Mécanisme de planification et de mise en œuvre du plan 118
4.2.2. Documents d'accompagnement du PSN SACO 119
4.2.3. Rôles et responsabilités des intervenants 119
4.2.4. Institutionnalisation de la santé communautaire et professionnalisation des acteurs communautaires 121
4.2.5. Gouvernance institutionnelle de la santé communautaire 125
4.2.6. Gestion de risque 130
4.2.7. Plan de communication et vulgarisation 131
4.2.8. Charge de travail des ASC et RECO 132
4.2.9. Rémunération et motivation des ASC et RECO 133
V. Cadre de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage 135
5.1. Mécanisme de suivi, évaluation, apprentissage et redevabilité 135
5.1.1. Considérations générales 135
5.1.2. Mécanisme de suivi et évaluation 136
5.2. Dispositif institutionnel du suivi et de l'evaluation 139
5.3. Cadre de performance 142
VI. Cadre budgétaire 153
6.1. Budget estimatif de la mise en œuvre du plan 153
6.1.1. Estimation du budget global 153
6.1.2. Estimation du budget par axes stratégiques, interventions et actions prioritaires 155
Annexes 177
Annexe 1 : Matériels et équipements pour ASC et RECO 177
Annexe 2 : Produits/Intrants pour ASC 177
Annexe 3 : Estimation besoin en SSC et ASC, par ZS 178
Annexe 4 : Projection démographique de 2025 à 2030, par ZS 188
Annexe 5 : Estimation nombre de ménage de 2025 à 2030, par ZS 201
Annexe 6 : Estimation besoin en RECO de 2025 à 2030, par ZS 215
Annexe 6 : Participants aux travaux d'élaboration du PSN SACO 2025-2030 229

Préface



La République Démocratique du Congo (RDC), pays à la géographie vaste et complexe, abrite une population diversifiée qui fait face à de nombreux défis en matière de santé. Depuis plusieurs décennies, le système de santé du pays s'efforce de répondre aux besoins de ses citoyens, souvent confrontés à une offre de soins insuffisante et de faible qualité, à un accès limité aux services de santé et à des épidémies récurrentes et situation sécuritaire précaire.

Le droit à la santé pour tous étant garanti par la Constitution de la République Démocratique du Congo, le Chef de l'Etat, Président de la République, Son Excellence **Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo**, en sa qualité du Garant de la Nation, s'est engagé, dans l'exercice de ses mandats, à relever de manière positive ce défi préoccupant en mettant en place le système de Couverture Santé Universelle (CSU) comme stratégie la plus adaptée en vue de conduire le peuple congolais sur le chemin vers l'accession à son droit fondamental. Dans ce contexte, le rôle de la santé communautaire est plus que jamais essentiel pour assurer les soins de santé primaires et la CSU visant l'atteinte des Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030.

Ainsi, ce plan stratégique de la santé communautaire 2025-2030, s'aligne aux priorités nationales, conformément au PNDS PS 2024-2033 et aux engagements internationaux. Il repose sur une approche holistique, intégrant les domaines d'interventions curatives, préventives, promotionnelles et réadaptatives. Il met en avant la participation active des communautés, en reconnaissant leur rôle central dans le continuum de soins à travers la prévention des maladies, la promotion de pratiques saines, et l'orientation des personnes vers les services de santé appropriés. Ce modèle de santé communautaire s'inscrit dans la logique de la décentralisation.

Le présent document est le fruit d'un travail participatif et inclusif de toutes les parties prenantes notamment le gouvernement, les partenaires techniques et financiers (PTF), les organisations de la société civile et, les communautés elles-mêmes. Chaque étape de son élaboration a été guidée par la volonté d'assurer que les actions entreprises soient alignées sur les besoins réels des populations et sur les priorités nationales de santé publique.

À travers ce plan, la RDC s'engage à renforcer les capacités des acteurs de santé communautaire, à améliorer les structures de financement et de gouvernance, à intégrer les innovations technologiques dans les services de santé de proximité, et à promouvoir une approche basée sur les résultats. Ce document stratégique est assorti d'une feuille de route claire pour garantir que chaque congolais, quel que soit son lieu de résidence, ait accès à des soins de santé de qualité, accessibles et équitables.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration de ce document. Votre engagement et votre collaboration sont des piliers essentiels pour faire de cette vision une réalité concrète. Ensemble, nous pouvons bâtir un système de santé résilient, capable de répondre aux besoins de nos populations, aujourd'hui et pour les générations futures.

C'est avec un immense espoir et une grande détermination que je vous invite à soutenir et à mettre en œuvre ce Plan National Stratégique de la Santé Communautaire (PSN SACO), un outil essentiel de progrès vers des communautés en bonne santé.

Dr Roger Samuel Kamba

Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Remerciements



L'élaboration du Plan Stratégique National de la Santé Communautaire (PSN SACO) de la République Démocratique du Congo qui couvre la période de 2025 à 2030 n'aurait pas été possible sans l'engagement, la collaboration et la contribution active de nombreux acteurs à qui nous tenons à exprimer notre gratitude.

Nous adressons tout d'abord nos remerciements à Son Excellence, le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale pour sa vision et son leadership dans l'amélioration du système de santé de la RDC en général, et du programme de la gratuité des soins maternels et néonatals en particulier. La gratuité des soins de santé joue un rôle crucial dans l'amélioration de la santé communautaire en réduisant les inégalités sociales et en améliorant globalement la qualité de vie des individus. Son soutien constant et son engagement à faire de la santé communautaire une priorité nationale ont guidé l'élaboration de ce document.

Nous remercions également tous les experts du Ministère de la santé, réunis au sein du groupe technique de travail dénommé « la Sous-Commission Santé communautaire » coordonnée par la Direction Générale d'Organisation et Gestion des Services et Soins de santé (DGOGSS). Leur participation active a été d'un grand apport à la qualité de ce plan sans oublier le comité technique d'accompagnement du processus d'élaboration du PSN SACO 2025-2030.

Nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires techniques et financiers, notamment l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), l'Agence des Etats Unis pour le Développement International (USAID), la Banque mondiale (BM), le Fonds Mondial /SANRU ainsi que les nombreux organismes bi et multilatéraux pour leur accompagnement technique et financier.

Nos plus sincères remerciements s'adressent également aux agents de terrain, les relais communautaires qui œuvrent en première ligne, ainsi qu'aux communautés locales. Leur dévouement à fournir des soins de santé et à sensibiliser les populations aux bonnes pratiques de santé est le fondement même de la réussite de ce plan. Votre rôle est primordial pour l'atteinte des objectifs de ce plan, et votre engagement est un exemple de service public.

Nous exprimons aussi notre gratitude aux représentants de la société civile, aux ONG locales et internationales, et aux organisations communautaires de base pour leurs contributions tout au long du processus de planification. Vos perspectives, basées sur les réalités de terrain, ont permis de garantir que ce plan réponde aux besoins réels des populations.

Enfin, nous remercions le bureau de consultance International Center for Health Systems Strengthening (ICHESS) pour son assistance technique. Votre expertise, vos analyses et votre dévouement ont été essentiels pour structurer ce plan combien ambitieux qui servira à guider notre système de santé communautaire vers un avenir meilleur.

Nous remercions tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à l'élaboration de ce plan qui est le reflet de notre engagement collectif pour une meilleure santé pour tous en RDC, et nous sommes convaincus que grâce à la coopération de chacun, il permettra de construire un système de santé communautaire plus fort, résilient et équitable.

Dr Sylvain Yuma Ramazani

Secrétaire Général à la Santé Publique et Hygiène

Liste des tableaux

Tableau 1: Projection démographique de la RDC de 2025 à 2030, par province 23
Tableau 2: Projection démographique de la RDC de 2025 à 2030, par tranche d'âge 24
Tableau 3: Projection nombre de ménage par province, de 2025 à 2030 25
Tableau 4: Autres taux de mortalité 41
Tableau 5: Causes de mortalité 42
Tableau 6: Principales facteurs de risque de mortalité et des AVCI 43
Tableau 7: Composante de l'indice de couverture universelle des services de santé en RDC 50
Tableau 8: Evolution de l'indice de CSU en RDC 51
Tableau 9: Tendance de l'indice de CSU en RDC 51
Tableau 10: Disponibilité du personnel de santé 54
Tableau 11: Analyse des interventions de la santé de la reproduction 54
Tableau 12: Recherche de soins et traitement des maladies des enfants 55
Tableau 13: Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 56
Tableau 14: Prevention du paludisme 57
Tableau 15 : Niveau de fonctionnalité du système de santé communautaire de la RDC par domaine. 57
Tableau 16: Besoin et Nombre de SSC existants 58
Tableau 17: Nombre de RECO existants et opérationnels, et besoin en RECO 59
Tableau 18: Mise en place et fonctionnalité des CAC 61
Tableau 19: Mise en place et fonctionnalité des CODESA 62
Tableau 20: Matrice d'analyse FFOM du système de santé communautaire de la RDC 76
Tableau 21: Ancrage et contribution du PSN SACO 2025-2030 98
Tableau 22: Chronogramme de mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030 par axes stratégiques, par interventions et par actions 102
Tableau 23: Paquet de soins et services de santé communautaire 114
Tableau 24: Rôles et responsabilités des interventions dans la mise en oeuvre du PSN SACO 2025-2030 . 119
Tableau 25 : Modalités d'exécution pour la professionnalisation des ASC et RECO en RDC. 122
Tableau 26: Mécanismes de coordination technique et multisectorielle 128
Tableau 27 : Plan de gestion des risques éventuels et mesures d'atténuation lors de la mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030 131
Tableau 28: Estimation charge de travail des ASC et des RECO 132
Tableau 29 : Liste des indicateurs du cadre de suivi de la progression et d'évaluation des performances du système de santé communautaire 144
Tableau 30 : Ventilation du budget du PSN SACO 2025-2030 par axe stratégique et par an. 153
Tableau 31 : Budget estimatif du PSN SACO 2025-2030 par axe stratégique, par interventions et par action 155

Liste des figures

Figure 1: Carte géographique de la RDC 22
Figure 2: Ancrage de l'organisation du système de santé communautaire dans la pyramide sanitaire en RDC 33
Figure 3: Tendance de l'espérance de vie à la naissance 38
Figure 4: Tendance de mortalité brute 39
Figure 5: Tendance du ratio de mortalité maternelle 39
Figure 6: Risque de mortalité maternelle 40
Figure 7: Tendance du taux de mortalité néonatale 40
Figure 8: Tendance du taux de mortalité infanto-juvénile 41
Figure 9: Tendance de la population des ménages avec des dépenses de santé à au moins 10% du budget total des ménages 52
Figure 10: Dépenses de santé et sources de financement 53
Figure 11: Vaccination des enfants 55
Figure 12: Etat nutritionnel des enfants 56
Figure 13 : Théorie de changement 94
Figure 14: Priorisation des provinces 113
Figure 15: Cadre organisationnel de la santé communautaire 129
Figure 16: Intérêt d'un système d'information sanitaire à base communautaire 135
Figure 17: Valeur ajoutée du mécanisme de suivi et évaluation des interventions à base communautaire 136
Figure 18: Circuit de l'information de santé communautaire 141
Figure 19: Remontée des données du système de santé communautaire 141
Figure 20: Cycle de performance de la santé communautaire 143

Abréviations et acronymes

AC	Animateur Communautaire
ACQUASS	Accroître la Communication de Qualité dans les Service de Santé
ACSA	Agents Communautaires de la Santé Animale
AFASAC	Approche Familiale à la Santé Communautaire
AFI	Alphabétisation Fonctionnelle Intensive
AGR	Activités Génératrices des Revenus
ANJE	Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant
APA	Autorité Politico-Administrative
APVP	Années Potentielles de vie Perdues
ARC	Artésunate Recto-Capsule
ARPTC	Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo
ARV	Anti Rétroviral
AS	Aire de Santé
ASC	Agent de Santé Communautaire
ATPC	Assainissement total piloté par la Communauté
AVCI	Années de Vie Corrigées d'Incapacité
BCP	Bulletin Communautaire de Performances
BCZS	Bureau Central de la Zone de Santé
CAC	Cellule d'Animation Communautaire
CAD	Comité d'Aide au Développement
CB-AT	Chef de Bureau - Appui Technique
CB-IS	Chef de Bureau Information Sanitaire
CCSC	Communication pour Changement Social et de Comportement
CDC	Centre for Disease Controle
CDR	Centrale de Distribution Régionale
CDV	Centre de Dépistage Volontaire
CEICA	Centres d'Ecoute et d'Informations Conviviales pour Adolescents
CFC-RTM	Child Friendly Communities-Real Time Monitoring
CHIPS	Community Health Influence Promoters and Services
CHW	Community Health Workers
CLM	Community Led Monitoring
CNP-SS	Comité National de Pilotage du Secteur de la Santé
CNRSC	Coordination Nationale de Renforcement des Systèmes Communautaires
CODESA	Comité de Développement de l'Aire de Santé
CODEV	Comité de Développement
COGE	Comité Gestion
COUSP	Centre d'Opérations d'Urgences de Santé Publique
CPN	Consultaion Pré Natale
CREC	Communication sur les Risques et Engagement Communautaire
CREC-M	Communication sur les Risques et Engagement Communautaire-Multisectorielle
CS	Centre de Santé
CSC	Changement Social et de Comportement
CSU	Couverture Santé Universelle
DBC	Distribution à Base Communautaire
DCS	Dépense Courante de Santé
DG	Directeur Général
DGOGSS	Direction Générale d'Organisation et Gestion des Services et Soins de santé

DHIS-2	District Health Information System
DI	Dossier d'Investissement
DIS	Dépense d'Investissement de la Santé
DOT	Directly Observed Treatment
DPS	Division Provinciale de la Santé
DSCRP	Document Stratégique de la Croissance et de Réduction de la Pauvreté
DTC	Diphtérie, Tétanos et Coqueluche
ECP	Equipes Cadres Provinciales
ECZS	Equipe Cadre de la Zone de Santé
EDS	Enquête Démographique et de Santé
EHA	Eau Hygiène et Assainissement
ESPK	Ecole de Santé Publique de Kinshasa
ESS	Etablissement de Soins de Santé
ETD	Entité Territoriale Décentralisée
FAP	Femmes en Age de Procréer
FDSS	Fonds de Développement des Services de Santé
FEFA	Femmes enceintes et allaitantes
FFOM	Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces
FGD	Focus Group Discussion
FMI	Fonds Monétaire International
FONLIV	Food and Nutrition for Life of Vulnerable
GPJ	Glucose Plasmatique à Jeun
HGR	Hôpital Général de Référence
HTA	Hypertension Artérielle
ICBHS	Integrated Community-Based Health Services
ICHESS	International Center for Health Systems Strengthening
IHME	Institute For Health Metrics and Evaluation
IHP+	International Health Partnership
IIG	Indice Inégalité de Genre
INSP	Institut National de Santé Publique
ILD	Initiative Locales de Développement
IPC	Integrated Food Security Phase Classification
IRA	Infections Respiratoires Aigues
ISF	Indice Synthétique de Fécondité
ISU	Institut Statistique de l'UNESCO
IT	Infirmier Titulaire
ITA	Infirmier Titulaire Adjoint
MAA	Monitorage Amélioré pour Action
MAPEPI	Maladies à Potentiels Epidémique
MAS	Malnutrition Aigüe Sévère
MCCA	Millenium Challenge Corporation Account
MCZ	Médecin Chef de Zone
MEAP-ASC/RECO	Matrice d'Evaluation et d'Amélioration des Prestations des Agents de Santé Communautaire/Relais Communautaire
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey
MII	Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide
MILD	Moustiquaire Imprégnées à Longue Durée
MNP	Micro-Nutriments en Poudre
MNT	Maladies Non Transmissibles
MSPHPS	Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

MUSA	Mutuelle de Santé
MVE	Maladie à Virus Ebola
NAC	Nutrition à Assise Communautaire
NTIC	Nouvelles Technologie de l'Information et Communication
NV	Naissances Vivantes
OAC	Organisation à Assise Communautaire
OCDD	Observatoire Congolais du Développement Durable
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD	Objectifs de Développement Durable
OEV	Orphelins et Enfants vulnérables
OMS	Organisation Mondial de la Santé
OSC	Organisation de la Société Civile
PAIC	Plan d'Action Intégré de Communication
PAO	Plan d'Action Opérationnel
PBF	Financement Basé sur la Performance
PCIMNE	Prise en Charge Intégrée des Maladies du Nouveau-né et de l'Enfant
PCIMNE-c	Prise en Charge Intégrée des Maladies du Nouveau-né et de l'Enfant au Niveau Communautaire
PDI	Personnes Déplacées Internes
PDZS	Plan de développement des Zones de Santé
PEC MTN	Prise en Charge des Maladies Tropicales Négligées
PEC TB-C	Prise en Charge de la Tuberculose au niveau Communautaire
PF	Planification Familiale
PFA	Paralysie Flasque Aigue
PFE	Pratiques Familiales Essentielles
PFP	Promotion de la Famille Paysanne
PHAST	Participatory, Hygiène and sanitation Transformation
PIB	Produit Intérieur Brut
PNCPS	Programme National de la Communication Pour la Santé
PNDS	Plan National de Développement Sanitaire
PNECHOL-MD	Programme National d'Elimination du Choléra et de lutte contre les autres Maladies Diarrhéiques
PNEHA	Programme National Eau, Hygiène et Assainissement
PNLT	Programme National de Lutte contre la Tuberculose
PNS	Politique Nationale de Santé
PNSD	Plan National Stratégique de Développement
PODI	Poste de Distribution
PPDS	Plan Provincial de Développement Sanitaire
PSN	Plan Stratégique National
PTF	Partenaire Technique et Financier
PVVIH	Personnes Vivant avec le VIH
RECO	Relais Communautaire
RSI	Règlement Sanitaire International
SACO	Santé Communautaire
SANRU	Santé Rurale
SIGL	Système d'Information en Gestion Logistique
SIMR	Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte
SNAME	Système National d'Approvisionnement en Médicament Essentiels
SNIS	Système National d'Informations Sanitaires
SP	Sulfadoxine Pyrimethamine

SRMNEA-NUT	Santé de la Reproduction de la Mère, du Nouveau-né, de l'Enfant et de l'Adolescent et de la Nutrition
SRO	Sels de Réhydratation Orale
SRSS	Stratégie de Renforcement du Système de Santé
SSC	Site des Soins Communautaires
SSP	Soins de Santé Primaires
TAR	Thérapie Anti Rétrovirale
TB	Tuberculose
TBN	Taux Brut de Natalité
TGFG	Taux Global de Fécondité Générale
TIDC	Traitement d'Ivermectine sous Directives Communautaires
TPI	Traitement Préventif Intermittent
UCODESA	Union des Comités de Santé
UCOP+	Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH
UNICEF	United Nations Children's Fund (Fonds des nations unies pour l'enfance)
USPPI	Urgences de Santé Publique de Portée internationale
VBA	Visual Basic for Applications
VBG	Violences Basées sur le Genre
VIH	Virus d'Immunodéficience Humaine
WASH	Water Sanitation and Hygiene (Eau, Hygiène et Assainissement)
ZS	Zone de Santé

Glossaire des concepts clés

Pour rendre aisée la compréhension de ce plan stratégique, il est établi une liste des définitions des termes clés utilisés en santé communautaire adaptées de référence nationale et internationale[1,2,3,4,5].

Acteur communautaire : C'est toute personne qui, indépendamment de sa situation hiérarchique dans une communauté, une entreprise, une administration ou une structure quelconque, a la capacité de fournir un paquet de soins et services spécifiques (DBC/PF, Pairs éducateurs/VIH) et à la volonté de prendre des initiatives ou de participer activement à toute action visant à faire évoluer sa communauté et pour l'adapter aux évolutions de l'environnement.

Agent de santé communautaire : Autrefois appelé relais prestataire des sites de soins communautaires, l'agent de santé communautaire (ASC) est un type de relais communautaire qui fournit un paquet minimum de services curatifs, spécifiquement la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant et du nouveau-né (PCIMNE-c) et les maladies infantiles de base ainsi que d'autres prestations complémentaires telles que la distribution des contraceptifs, le traitement d'Ivermectine sous directives communautaires (TIDC), l'application du traitement directement observé de la tuberculose « Directly Observed Treatment (DOT), etc.

Communauté : Groupe spécifique de personnes, vivant généralement dans une zone géographique définie, qui partagent des valeurs, des normes, une culture et des coutumes communes, et qui sont organisées autour d'une structure sociale multidisciplinaire, voire multisectorielle (CODESA, CAC, etc.) en fonction des relations que le groupe a collectivement développées au fil du temps.

Communication sur les risques : Un échange en temps réel et en routine d'informations, de conseils et d'avis entre les experts, les responsables locaux ou décideurs politiques et les personnes exposées à des risques spécifiques identifiés.

Engagement communautaire : C'est une composante essentielle de la société civile, de la pratique de développement international, et de l'aide humanitaire. Il est basé sur le principe simple que les communautés doivent être écoutés et jouer un rôle significatif dans les processus et les questions qui les concernent (Cfr UNICEF 2021 : normes de qualité et indicateurs pour l'engagement communautaire). L'engagement communautaire s'appuie sur les forces et les capacités locales et améliore la participation, l'appropriation, l'adaptation et la communication au niveau local.

Institutionnalisation des acteurs communautaires : Il s'agit du processus par lequel une personne ou un groupe s'intègre dans une organisation ou une institution formelle tels qu'un ministère, un département ou un organisme gouvernemental, un établissement d'enseignement ou un établissement de santé. Cela implique souvent l'établissement de règles, des procédures et des structures hiérarchiques pour régir le comportement et les interactions au sein de l'institution.

Mobilisation sociale : Processus utilisant la communication pour rallier à l'action un grand nombre de personnes, notamment la société civile, afin de rassembler les forces, de mettre les énergies et les ressources ensemble pour réaliser un but social commun.

---

[1] OMS. Glossaire de la série « Santé pour tous » (n° 9). OMS, Genève, 1984.
[2] OMS. Glossaire pour la promotion de la santé. WHO/HPR/HEP/98.1.
[3] Centres for diseases control and prevention-Africa. Priorités stratégiques quinquennales du CDC Afrique en matière de santé communautaire (2024-2028).
[4] MSPHP. PNECHOL-MD. "Guide de mise en œuvre des sites de soins communautaires". Mbanza-Ngungu, Avril 2023.
[5] MSPHP. PRONANUT. "Informations utiles sur la mise en œuvre de la Nutrition à Assise Communautaire (NAC) en RDC.

Organisation à assise communautaire : C'est une structure organisée représentant un groupe de personnes poursuivant un but commun. Elle est organisée localement par des membres de la communauté et peut être formelle ou non.

Participation communautaire : Selon l'OMS, il s'agit d'un processus par lequel les membres d'une collectivité géographique ou sociale, conscients de leur appartenance à un même groupe, réfléchissent en commun sur les problèmes de leur santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des activités les mieux aptes à répondre à ces priorités.

Professionnalisation : C'est un processus qui permet de structurer et de standardiser un métier ou une activité, en assurant que les personnes qui l'exercent possèdent les compétences nécessaires, respectent des normes éthiques et professionnelles, et sont reconnues par les institutions et la société. Ce processus est essentiel pour garantir la qualité, la responsabilité, et l'évolution des professions.

Promotion de la santé : Elle désigne un ensemble de stratégies, d'actions et de politiques visant à améliorer la santé des individus et des populations en agissant sur les facteurs déterminants de la santé. Contrairement aux approches curatives qui se concentrent sur le traitement des maladies, la promotion de la santé met l'accent sur la prévention, l'éducation et l'amélioration des conditions de vie pour permettre à chacun d'atteindre un état de bien-être optimal.

Relais communautaire : Il s'agit de toute personne (femme ou homme), volontaire, sélectionnée dans et par sa communauté conformément aux critères définis, ayant reçu une formation de base sur un paquet de soins et services communautaires pour offrir dans sa communauté des services préventifs, et promotionnels sous l'encadrement technique des ASC qualifiés et l'appui du leader de la communauté.

Dans le cadre de ce plan, le terme « RECO » correspond au relais promotionnel alors que celui de « ASC » correspond au relais prestataire ou RECOSITE.

Santé communautaire : Il s'agit d'une approche de résolution des problèmes de santé fondée sur la multisectorialité (santé humaine, santé animale, santé végétale, santé environnementale) et sur l'engagement des communautés. Elle s'occupe des services de prévention, de promotion, de traitement, de réadaptation et de surveillance des maladies, lesquels services sont délivrés par les communautés elles-mêmes sous la supervision du personnel de santé. Elle vise à étendre la couverture des prestations sanitaires jusqu'à la périphérie géographique du pays pour atteindre les populations les plus vulnérables et d'accès difficile. Elle implique une réelle participation de la communauté à l'amélioration de sa santé : identification des problèmes ou des écarts, réflexion sur les besoins, les priorités, la mise en place des actions, la gestion et l'évaluation des activités.

Services de santé communautaires : Ils constituent le fondement des soins de santé primaires et une stratégie clé pour promouvoir des comportements sains et améliorer l'accès à des interventions de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente à fort impact, ainsi qu'à d'autres interventions en matière de santé, tenant compte des déterminants sociaux de la santé (y compris le changement climatique), en particulier dans les communautés difficiles à atteindre.

Site de soins communautaire : C'est une unité de prise en charge communautaire. Cette unité couvre une aire géographique dans laquelle la population d'un ou plusieurs villages d'accès difficile bénéficient d'un paquet défini des prestations des soins fournis par un RECOSITE/ASC formé et régulièrement supervisé. Le paquet d'interventions est définie dans le guide de mise en œuvre des SSC.

Surveillance à base communautaire : C'est un processus actif de participation communautaire dans la détection, la notification, la réponse et le suivi relatif aux événements de santé dans la communauté.

Système de santé communautaire : C'est un ensemble d'acteurs, de relations et de processus locaux engagés dans la production, la défense et le soutien de la santé dans les communautés et les ménages en dehors des structures de santé formelles, mais existant en relation avec elles.

Résumé exécutif

La République Démocratique du Congo (RDC) a adopté depuis 2016 la stratégie de développement de la participation communautaire comme politique multisectorielle qui doit être matérialisée par un plan stratégique national de santé communautaire (PSN SACO). Ce dernier constitue donc l'unique cadre de référence pour la planification, la mise en œuvre et le suivi et évaluation de toutes les interventions à base communautaire en RDC.

Faisant suite à la première génération PSN SACO 2019-2022, l'élaboration du présent plan PSN SACO 2025-2030 a reposé sur une approche participative incluant toutes les parties prenantes (Gouvernement, PTF et OSC). Durant le processus de son élaboration, plusieurs techniques ont été utilisées (revue documentaire, collecte, traitement et analyse des données etc.). Ce qui a permis de circonscrire le profil du pays et de décrire l'organisation du système national de santé (définition, missions et attributions) en général, y compris celle du système de santé communautaire (historique et organes de participation communautaires) avec une mention particulière sur la gestion des urgences dans la communauté et l'organisation du contrôle citoyen.

Par ailleurs, le diagnostic sous-sectoriel de la santé communautaire a montré un niveau critique des indicateurs de performance du système de santé communautaire (état de santé et sécurité sanitaire de la population, principales causes et facteurs de risque, couvertures des interventions, …) ainsi que ceux des déterminants sociaux de la santé et des ODD y associés, nécessitant ainsi des nouvelles programmations pour espérer atteindre les objectifs mondiaux. Cependant, quelques approches innovantes implémentées au cours des années précédentes sont mises en évidences en vue de leur capitalisation comme leçons apprises à consolider dans ce nouveau plan. Par ailleurs, l'analyse des forces et faiblesses a permis d'identifier plusieurs problèmes regroupés en sept blocs des domaines comme étant des goulots d'étranglement du système de santé communautaire auxquels le pays fait face. Il s'agit des goulots en lien avec la gouvernance et leadership, le financement, les ressources humaines, les prestations, la gestion de la chaine d'approvisionnement, le système d'information sanitaire et la communication sur les risques, engagement communautaire.

Traduisant l'ambition du Gouvernement en matière de santé communautaire pour la période 2025-2030, ce plan définit les orientations stratégiques capables de remédier les faiblesses décelées liées à l'engagement communautaire avec comme vision à l'horizon 2030 « amener les communautés à être autonomes, autodéterminées, suffisamment responsables de leur santé et bien-être, et résilientes face aux urgences sanitaires pour un développement durable ». Le but étant d'améliorer la santé et le bien-être de la population congolaise par la mise en place d'un système de santé communautaire fort, résilient et équitable avec la pleine participation des communautés dans le cadre de la CSU et de la sécurité sanitaire.

Sur ce, le PSN SACO 2025-2030, aligné aux priorités nationales décrites dans le PNDS-PS 2024-2033 et sous-tendu par les engagements internationaux, fixe six axes stratégiques déclinés en interventions ou priorités stratégiques et actions prioritaires. Il s'agit des axes stratégiques suivants :

- Axe stratégique 1 : Promotion des pratiques familiales essentielles ;
- Axe stratégique 2 : Amélioration de l'offre des soins et services de santé au niveau communautaire ;
- Axe stratégique 3 : Renforcement de la prévention, préparation et riposte communautaire face aux urgences de santé publique et aux effets climatiques ;
- Axe stratégique 4 : Accroissement des financements et d'autres investissements en faveur de la santé communautaire ;

- Axe stratégique 5 : Développement du système d'information sanitaire communautaire et recherche opérationnelle appuyés par la digitalisation ; et
- Axe stratégique 6 : Renforcement de la gouvernance en santé communautaire.

Dans le souci de rendre explicite la logique devant conduire à des résultats souhaités d'ici à 2030, une théorie de changement basée sur la construction schématique a permis de décrire l'effet, les produits, les stratégies, les hypothèses et risques ainsi que le processus de changement pour l'atteinte des objectifs de ce PSN SACO 2025-2030.

De manière opérationnelle, la mise en œuvre des interventions de ce plan se fera selon un chronogramme étalé en 6 années avec des cibles annuelles et résultats bien déterminés. Dans ce contexte, ces interventions seront introduites progressivement avec un paquet complet d'activités communautaire bien définies où chaque intervenant est appelé à jouer pleinement son rôle et à assumer ses responsabilités. Les DPS identifiées comme regorgeant la charge la plus importante de la mortalité infanto-juvénile avec des faibles couvertures en SSC et en CAC, seront prioritairement bénéficiaires. L'optimisation des interventions menées par les ASC exigera impérativement d'amorcer le processus d'institutionnalisation de la santé communautaire et de leur professionnalisation suivant les recommandations de l'OMS.

Pour apprécier l'état d'avancement des interventions communautaires, le niveau de performance des résultats et mesurer l'impact, le PSN SACO 2025-2030 est assorti d'un cadre de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage avec des mécanismes et indicateurs définis par chaine des résultats. Le système de collecte et gestion des données sera hybride combinant progressivement selon les cas la numérisation et la digitalisation en vue de générer les informations et permettre une prise de décisions éclairées. Ainsi, trois modalités seront mises à contribution, à savoir : le suivi de routine, les revues sectorielles et les évaluations indépendantes avec une évaluation formative à mi-parcours en 2027 et une évaluation sommative finale en 2030. Outre cela, des enquêtes seront menées et porteront sur les approches innovantes ainsi que sur des problèmes essentiels à la mise en œuvre de ce plan.

Le budget estimatif global pour mettre en œuvre ce plan stratégique s'élève à 997 084 115,1 USD répartis en 6 ans. La répartition de ce budget par axe stratégique se présente comme suit :

- Promotion des pratiques familiales essentielles : 224 277 820,4 USD, soit 22,5% ;
- Amélioration de l'offre des soins et services de santé au niveau communautaire : 568 443 098,7 USD, soit 57,0% ;
- Renforcement de la prévention, préparation et riposte communautaire face aux urgences de santé publique et aux effets climatiques : 96 594 754,5 USD, soit 9,7% ;
- Accroissement des financements et d'autres investissements en faveur de la santé communautaire : 9 074 312,1 USD, soit 0,9% ;
- Développement du système d'information sanitaire communautaire et recherche opérationnelle appuyés par la digitalisation : 69 023 929,7 USD, soit 6,9%
- Renforcement de la gouvernance en santé communautaire : 29 670 199,6 USD, soit 3,0%.

Introduction

Contexte et justification

La République Démocratique du Congo (RDC) dispose depuis 2001 d'une Politique Nationale de Santé (PNS)[6] dont le but est de promouvoir l'état de santé de toute la population, en fournissant des soins de santé de qualité, globaux, intégrés et continus avec la participation communautaire, dans le cadre global de la lutte contre la pauvreté. Cette politique est fondée sur la stratégie de Soins de Santé Primaires (SSP) adoptée à la Conférence d'Alma Ata en 1978 où la participation de la communauté à la planification et à la gestion de leurs problèmes de santé a été optée comme un des principes directeurs. Par la suite, cette stratégie a été renouvelée en 2018 à travers la Déclaration d'Astana qui souligne l'importance des services de santé communautaire pour faire progresser la Couverture Santé Universelle (CSU).[7,8]

Pour renforcer son système de santé communautaire, le pays s'est engagé aux initiatives mondiales et nationales, entre autres l'engagement à l'institutionnalisation de la santé communautaire lors de la conférence de Johannesburg en décembre 2017, l'appel à action de Monrovia lors du 3ème symposium sur les ASC en mars 2023, la conférence des Partenaires de Cotonou pour l'atteinte de la couverture de santé universelle en avril 2024, la réunion d'Addis-Abeba sur la santé communautaire en mai 2024, la feuille de route pour l'institutionnalisation de la santé communautaire en novembre 2024, etc.[9,10,11,12]

En dépit de progrès encourageants accomplis au cours de dernières décennies dans ses missions de garantir le bien-être de la population, la RDC est loin de réaliser les cibles des Objectifs de Développement Durable (ODD) liés à la santé d'ici 2030. En 2020, le ratio de décès maternel a été estimé à 547 pour 100 000 naissances vivantes (NV)[13] , loin de la cible attendue de 70 pour 100 000 NV.[14] Selon l'EDS 2023-24, les taux de mortalité infanto-juvénile et néonatale ont été respectivement évalués à 92 et 24 décès pour 1 000 NV[15] par rapport à leurs cibles fixées à 25 et 12 décès pour 1000 NV.[16] En outre, les inégalités d'accès aux services et soins de santé persistent dans le pays avec un indice de couverture de services pour la CSU estimé en 2021 à 42%.[17]

L'éloignement des communautés des établissements de soins de santé (ESS), l'arrivée tardive et en détresse dans des ESS, la carence des médicaments de bonne qualité dans la communauté,

---

[6] RD Congo. Présidence de la République. "Politique national de la santé", 2001.

[7] OMS, UNICEF "Les soins de santé primaires : Rapport de la conférence internationale sur les soins de santé primaires, Alma-Ata (URSS, 6-12 septembre 1978 / rapport conjoint de l'OMS et l'UNICEF.

[8] OMS, "Déclaration d'Astana. 'Global Conference on primary health care'. Astan, Kazakhstan, Du 25 et 26 octobre 2018.," pp. 1–12, 2018.

[9] Task force Child Health. Institionnalizing Community Health: Critical principles. 27-30 march 2017, Johannesburg. South Africa.

[10] OMS, UNICEF. "Institutionnalisation de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance dans la communauté (PCIME) pour mettre fin aux décès évitables d'enfants : consultation technique et plan d'action par pays, 22-26 juillet 2019, Addis-Abeba."

[11] USAID, UNICEF, Last Mile Health-RDC. Programme pour l'Intégration de la Santé Communautaire Aperçu du pays : République Démocratique du Congo. Août 2021.

[12] RD Congo ; Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Feuille de route pour la santé communautaire, Mise à jour 2021 : Combler le fossé des OMD par des soins de santé primaires accélérés au niveau communautaire.

[13] OMS, UNICEF, UNFPA, BM, "Estimation des données 2020 établies selon un modèle de régression à partir de l'information sur la fécondité, les sages-femmes et la prévalence du VIH, 2020.,"

[14] Assemblée Générale des Nations Unies, "Résolution A/RES/70/1* : Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030", New York, du 25 au 27 septembre 2015.

[15] RDC-Institut National de la Statistique, École de Santé Publique de Kinshasa et ICF. 2024. RDC, Enquête Démographique et de Santé 2023–24 : Rapport des indicateurs clés. Kinshasa, RDC et Rockville, Maryland, USA : ICF.

[16] Idem 13

[17] WHO, "Tracking Universal Health Coverage 2023 Global Monitoring Report," 2023.

les premiers soins non appropriés ou l'automédication, l'ignorance des mères et des familles à reconnaitre les signes de danger et à adopter les pratiques clés favorables à la santé, les us et coutumes, l'inaccessibilité financière constituent autant des facteurs favorisants la mortalité qui survient à plus de 80% dans la communauté.[18]

Pour apporter des réponses stratégiques aux faiblesses liées à l'engagement communautaire, le Ministère de la santé avec ses partenaires techniques et financiers (PTF) et les Organisations de la société civile (OSC), ont adopté en 2016 la « Stratégie de développement de la participation communautaire » comme politique multisectorielle. Ainsi, pour opérationnaliser cette politique, un premier Plan Stratégique National de Santé Communautaire (PSN SACO) 2019 à 2022 a été élaboré. Au terme de sa mise en œuvre, et devant l'exigence de la redevabilité, une deuxième génération du PSN SACO 2025-2030 qui fait suite à l'évaluation du précédent plan est élaboré avec l'assistance technique de « ICHESS » (International Center for Health Systems Strengthening).

Ce nouveau plan stratégique est élaboré pour fournir des orientations aux destinataires concernés et contribue à la mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS-PS) 2024-2033 sur lequel il est aligné.

Objectif d'élaboration du plan

L'élaboration de ce document a pour objectif principal de doter le pays d'un instrument stratégique qui constitue le cadre unique de référence sous-sectorielle pour la planification, la mise en œuvre et le suivi et évaluation de toutes les interventions à base communautaire, d'une part ; et de disposer d'un outil formel de plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de la communauté, d'autre part.

Public cible

Ce document est destiné aux cadres des institutions gestionnaires des structures décisionnelles et acteurs communautaires du sous-secteur « santé communautaire » selon les responsabilités de chacun, dans le plaidoyer, ou dans la planification, dans la mise en œuvre et dans le suivi et évaluation. Il s'agit principalement des décideurs politiques, des cadres et prestataires à tous les niveaux, des organisations de la société civile et leaders communautaires pour le contrôle citoyen ainsi que des institutions de recherche et partenaires d'aide extérieure.

Processus d'élaboration

Pour conduire le processus d'élaboration dudit plan, un comité technique, dirigé par le Directeur Général de la DGOGSS sous le leadership de Monsieur le Secrétaire Général à la santé publique et hygiène, a été mis en place pour travailler avec ICHESS. Ce processus a été participatif et inclusif réunissant différents délégués des Programmes Spécialisés intervenant dans la Santé Communautaire, des PTF et de la Société Civile.

Ce processus a été conduit en plusieurs étapes notamment (i) les consultations des parties prenantes et collecte des attentes, (ii) l'élaboration du 1er draft du PSN (iii) les travaux de finalisation du PSN dans un cadre participatif, suivis du partage et recueil des feedbacks, (iv) l'intégration des feedbacks et la validation du PSN SACO 2025-2030.

Subdivision du document

Ce document est subdivisé en six (6) parties dénommées « cadres ».

- La première partie, intitulée « **cadre général du pays** », présente le profil du pays et l'organisation du système de santé en général et de la santé communautaire en particulier ;
- La deuxième partie, intitulée « **cadre analytique** », retrace la situation du niveau actuel de performance du système de santé, les déterminants sociaux de la santé et indicateurs des

[18] RD Congo ; MSPHP, "Plan d'extension des sites de soins communautaires en RDC 2023-2027.," 2022.

ODD y associés, les innovations et leçons apprises à capitaliser ainsi que l'analyse FFOM et les problèmes prioritaires auxquels le pays fait face ;

- La troisième partie porte sur le « **cadre stratégique** » qui détermine les axes, les interventions et actions prioritaires capables de corriger les faiblesses du système de santé communautaire en marge d'une théorie de changement pour atteindre les objectifs assignés du plan ;
- La quatrième partie, intitulée « **cadre de mise en œuvre** » montre la chronologie des activités par intervention et par axe ainsi que les modalités d'exécution pour y parvenir sur base d'un paquet d'activités préalablement défini ;
- La cinquième partie concerne le « **cadre de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage** ». Elle décrit les indicateurs à collecter selon une chaine des résultats, y compris les modalités de collecte et de gestion des données ; et
- La sixième partie, intitulée « **cadre budgétaire** », présente des estimations des coûts de la mise en œuvre par axe stratégique, par intervention et par action prioritaire.

I. Cadre général du pays

1.1. Contexte national

1.1.1. Situation géographique et administrative

La RDC est un pays africain situé en Afrique Centrale, à cheval sur l'Équateur et est compris entre 6° de latitude Nord et 14° de latitude Sud, et 12ème et 32ème de longitude Est. Avec sa superficie de 2 345 410 km², elle est le deuxième pays le plus vaste du continent africain.

Elle partage ses frontières d'une longueur de 9 165 km avec neuf pays, à savoir :

- Au Nord : la République Centrafricaine et le Soudan du Sud ;
- A l'Est : l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie ;
- Au Sud : la Zambie et l'Angola ; et
- A l'Ouest : la République du Congo et la Province Angolaise de Cabinda.[19]



Figure 1: Carte géographique de la RDC

Source : EDS III 2023-2024

La RDC est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.[20]

1.1.2. Situation démographique

Selon les estimations de l'Institut National des Statistiques (INS) en 2019, la RDC comptait 98 370 000 habitants avec un taux de croissance démographique de 3,2%[21]. Selon les projections démographiques, la population de la RDC s'élèverait à 117 837 369 habitants en 2025 et 135 726 214 en 2030 avec des taux de croissance démographique allant de 2,85% (2025 à 2026) à 2,72% (2029 à 2030).[22] Les statistiques de la Banque Mondiale (BM) ont estimé en 2023 à 53% la population congolaise vivant en milieu rural et 47% en milieu urbain.[23]

Au regard de sa superficie, la RDC est encore faiblement peuplée avec une densité de 49 habitants au Km² en 2024 pendant que le taux brut de natalité (TBN) est de 35,7 pour 1 000 individus avec un indice synthétique de fécondité (ISF) de 5,5.[24] Cependant, on note une forte disparité entre les provinces.

[19] Ministère du Plan. Institut national de la Statistique. Annuaire statistique RDC 2020, Mars 2021.
[20] Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Cabinet de la Présidence de la République. Constitution de la République. 52ème Année, Kinshasa 5 février 2011 Numéro Spécial
[21] Ministère du Plan. Institut national de la Statistique. Annuaire Statistique RDC 2020, Mars 2021.
[22] Projection des taux de croissance démographique réalisée par ICHESS, à partir des données de la BM 2024
[23] https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS?view=chart
[24] RDC-Institut National de la Statistique, École de Santé Publique de Kinshasa et ICF. 2024. RDC, Enquête Démographique et de Santé 2023–24 : Rapport des indicateurs clés. Kinshasa, RDC et Rockville, Maryland, USA : ICF.

Tableau 1: Projection démographique de la RDC de 2025 à 2030, par province

N°	Provinces	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Bas-Uele	1 497 374	1 541 343	1 586 068	1 631 542	1 677 752	1 724 690
2	Equateur	2 050 804	2 111 024	2 172 279	2 234 559	2 297 850	2 362 136
3	Haut-Katanga	6 442 303	6 631 475	6 823 901	7 019 544	7 218 362	7 420 307
4	Haut-Lomami	4 125 566	4 246 709	4 369 936	4 495 223	4 622 543	4 751 866
5	Haut-Uele	2 450 902	2 522 870	2 596 077	2 670 507	2 746 145	2 822 973
6	Ituri	4 801 181	4 942 163	5 085 570	5 231 375	5 379 545	5 530 046
7	Kasaï	3 791 352	3 902 681	4 015 925	4 131 063	4 248 069	4 366 915
8	Kasaï-Central	4 483 738	4 615 398	4 749 323	4 885 488	5 023 862	5 164 412
9	Kasaï-Oriental	4 313 636	4 440 301	4 569 146	4 700 145	4 833 269	4 968 487
10	Kinshasa	16 669 969	17 159 465	17 657 383	18 163 625	18 678 081	19 200 630
11	Kongo-Central	7 624 630	7 848 519	8 076 261	8 307 809	8 543 115	8 782 122
12	Kwango	2 894 125	2 979 108	3 065 553	3 153 443	3 242 760	3 333 481
13	Kwilu	7 389 842	7 606 837	7 827 565	8 051 984	8 280 043	8 511 691
14	Lomami	3 355 316	3 453 842	3 554 062	3 655 958	3 759 507	3 864 686
15	Lualaba	3 585 313	3 690 592	3 797 682	3 906 563	4 017 210	4 129 598
16	Maï-Ndombe	2 494 027	2 567 261	2 641 756	2 717 496	2 794 464	2 872 644
17	Maniema	3 179 225	3 272 580	3 367 541	3 464 089	3 562 204	3 661 862
18	Mongala	2 335 904	2 404 495	2 474 267	2 545 205	2 617 294	2 690 517
19	Nord-Kivu	9 072 890	9 339 306	9 610 306	9 885 836	10 165 837	10 450 242
20	Nord-Ubangi	1 707 007	1 757 131	1 808 118	1 859 957	1 912 638	1 966 147
21	Sankuru	2 895 323	2 980 341	3 066 822	3 154 749	3 244 102	3 334 861
22	Sud-Kivu	7 864 210	8 095 134	8 330 032	8 568 856	8 811 555	9 058 073
23	Sud-Ubangi	3 300 213	3 397 120	3 495 695	3 595 917	3 697 766	3 801 217
24	Tanganyika	4 276 501	4 402 076	4 529 812	4 659 683	4 791 661	4 925 715
25	Tshopo	3 092 976	3 183 798	3 276 183	3 370 112	3 465 565	3 562 520
26	Tshuapa	2 143 042	2 205 970	2 269 981	2 335 062	2 401 199	2 468 377
RDC		**117 837 369**	**121 297 541**	**124 817 246**	**128 395 791**	**132 032 399**	**135 726 214**

Source : Projection par ICHESS à partir des données de l'annuaire statistique 2020 (INS)

Le tableau ci-dessous présente la projection démographique par tranche d'âge.

Tableau 2: Projection démographique de la RDC de 2025 à 2030, par tranche d'âge

Tranche d'âge	2025	2026	2027	2028	2029	2030	$\bar{X}$ en %
0 à 4 ans	23 004 461	23 679 963	24 367 088	25 065 699	25 775 645	26 496 759	**19,52%**
5 à 9 ans	18 497 963	19 041 137	19 593 656	20 155 411	20 726 281	21 306 132	**15,70%**
10 à 14 ans	15 233 687	15 681 009	16 136 026	16 598 651	17 068 781	17 546 307	**12,93%**
15 à 19 ans	12 022 119	12 375 136	12 734 227	13 099 320	13 470 338	13 847 192	**10,20%**
20 à 24 ans	9 913 816	10 204 925	10 501 042	10 802 110	11 108 063	11 418 828	**8,41%**
25 à 29 ans	8 422 431	8 669 747	8 921 318	9 177 095	9 437 021	9 701 037	**7,15%**
30 à 34 ans	7 017 295	7 223 351	7 432 951	7 646 056	7 862 619	8 082 588	**5,96%**
35 à 39 ans	5 951 164	6 125 914	6 303 671	6 484 399	6 668 059	6 854 608	**5,05%**
40 à 44 ans	4 577 174	4 711 578	4 848 294	4 987 296	5 128 553	5 272 033	**3,88%**
45 à 49 ans	3 328 963	3 426 714	3 526 147	3 627 243	3 729 979	3 834 331	**2,83%**
50 à 44 ans	2 810 272	2 892 793	2 976 733	3 062 077	3 148 806	3 236 898	**2,38%**
55 à 59 ans	2 036 429	2 096 227	2 157 053	2 218 896	2 281 743	2 345 579	**1,73%**
60 à 64 ans	1 867 525	1 922 363	1 978 145	2 034 859	2 092 493	2 151 034	**1,58%**
65 à 69 ans	1 450 656	1 493 253	1 536 583	1 580 637	1 625 406	1 670 880	**1,23%**
70 à 74 ans	899 622	926 039	952 910	980 230	1 007 994	1 036 194	**0,76%**
75 ans et +	803 791	827 393	851 402	875 811	900 617	925 814	**0,68%**
RDC	**117 837 369**	**121 297 541**	**124 817 246**	**128 395 791**	**132 032 399**	**135 726 214**	**100%**

Source : Projection par ICHESS à partir des données de l'annuaire statistique 2020 (INS)

En outre, les femmes âgées de 15 à 49 ans (femmes en âge de procréer/FAP) représenteront en moyenne 21,99% de la population totale du pays et 43,43% de la population féminine ; soit respectivement de 2025 à 2030 ; 25 912 961 FAP, 26 673 868 FAP, 27 447 867 FAP, 28 234 805 FAP, 29 034 511 FAP et 29 846 797 FAP.[25]

La taille moyenne de ménages Congolais est estimée à 5,3 selon le MICS 2017-2018. Les projections de cette taille moyenne font état d'une diminution continue avec une estimation à 5,14 en 2025 et 5,07 en 2030. Le tableau ci-dessous présente les estimations des nombres des ménages par province.

[25] Projection par ICHESS à partir des données de l'annuaire statistique 2020 (INS)

Tableau 3: Projection nombre de ménage par province, de 2025 à 2030

Province	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bas Uele	291 156	300 540	310 125	319 910	329 895	340 080
Equateur	398 767	411 620	424 747	438 149	451 824	465 773
Haut Katanga	1 252 670	1 293 045	1 334 282	1 376 381	1 419 341	1 463 159
Haut Lomami	802 193	828 049	854 457	881 416	908 927	936 988
Haut Uele	476 564	491 925	507 613	523 629	539 972	556 643
Ituri	933 563	963 653	994 385	1 025 760	1 057 776	1 090 432
Kongo Central	1 482 567	1 530 352	1 579 157	1 628 982	1 679 826	1 731 686
Kasaï Oriental	838 763	865 797	893 408	921 597	950 362	979 702
Kwango	562 747	580 885	599 410	618 322	637 621	657 306
Kwilu	1 436 914	1 483 227	1 530 530	1 578 820	1 628 098	1 678 362
Kinshasa	3 241 383	3 345 857	3 452 561	3 561 495	3 672 656	3 786 040
Kasaï Central	871 838	899 938	928 639	957 939	987 838	1 018 335
Kasaï	737 207	760 968	785 237	810 012	835 294	861 082
Lualaba	697 144	719 614	742 564	765 993	789 901	814 287
Lomami	652 423	673 451	694 928	716 855	739 229	762 051
Mai Ndombe	484 950	500 580	516 544	532 842	549 473	566 437
Mongala	454 204	468 843	483 795	499 060	514 636	530 524
Maniema	618 183	638 107	658 458	679 233	700 433	722 057
Nord Kivu	1 764 173	1 821 035	1 879 110	1 938 399	1 998 901	2 060 611
Nord Ubangi	331 918	342 616	353 543	364 698	376 080	387 691
Sud Kivu	1 529 152	1 578 438	1 628 777	1 680 168	1 732 609	1 786 099
Sankuru	562 979	581 125	599 658	618 578	637 885	657 578
Sud Ubangi	641 708	662 391	683 516	705 082	727 089	749 536
Tanganyika	831 542	858 344	885 717	913 663	942 180	971 268
Tshopo	601 412	620 796	640 594	660 806	681 431	702 469
Tshuapa	416 703	430 133	443 851	457 855	472 146	486 722
RDC	**22 912 822**	**23 651 331**	**24 405 607**	**25 175 645**	**25 961 427**	**26 762 915**

Source : Projection par ICHESS à partir des données de l'annuaire statistique 2020 (INS), des EDS I et III et MICS 2017-2018

1.1.3. Situation socio-économique

La RDC est dotée de ressources naturelles exceptionnelles, notamment des minéraux tels que le cobalt, le cuivre, l'or, le diamant ainsi que d'autres minéraux rares utilisés dans la fabrication des technologies modernes ; un potentiel hydroélectrique, des terres arables importantes, une biodiversité immense et la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. La majorité des habitants de la RDC ne bénéficie pas de cette richesse. Une longue histoire de conflits, de bouleversements politiques et d'instabilité ont conduit à une grave crise humanitaire persistante, ayant pour conséquence des déplacements forcés de populations. Ce tableau n'a pas beaucoup changé depuis la fin des guerres du Congo en 2003. La RDC figure parmi les cinq nations les plus pauvres du monde. En 2024, environ 73,5% des Congolais vivent avec moins de 2,15 USD par jour.

Environ une personne sur six qui vit dans une extrême pauvreté en Afrique subsaharienne habite en RDC.[26]

Après avoir culminé à 8,9% en 2022, la croissance du PIB réel en RDC est restée robuste à 8,4% en 2023, soutenue par un secteur minier solide, qui a progressé de 18,2%, contribuant à plus de 70% à la croissance globale en 2023. La production agricole a ralenti pour s'établir à 2,2% en 2023 (contre 2,4% en 2022). Ce ralentissement est dû en partie aux maladies qui affectent les plantes comme les wilt bactériens, les mosaïques du manioc ; le changement climatique et la surexploitation du sol. Du côté de la demande, la croissance a été tirée par l'investissement privé et les exportations, tandis que les pressions inflationnistes ont entraîné une contraction de la consommation privée, ce qui a pu avoir un impact sur la réduction de la pauvreté. Le déficit du compte courant s'est détérioré à 5,7% du PIB en 2023, contre 4,8% en 2022, en raison de la hausse des prix à l'importation. Le taux de change s'est déprécié de 21,6% en 2023 et l'inflation s'est accélérée pour atteindre 19,9% en moyenne en 2023 (contre 9,3% en 2022). La croissance du PIB devrait ralentir à 4,9% en 2024 et se stabiliser autour de 4,8% sur 2025-26, en raison de la décélération du secteur minier. Le secteur agricole employant plus de 60% de la main-d'œuvre de la RDC, la vulnérabilité de l'économie liée aux risques du changement climatique (inondations, sécheresses) est importante.[27]

Le déficit budgétaire est passé de 0,5% du PIB en 2022 à 1,7% en 2023 en raison d'une augmentation de 56,4% des dépenses exceptionnelles (sécurité et élections), malgré une augmentation de 5,4% des recettes et des subventions en 2023 (13,6% du PIB). Le pays est confronté à un risque modéré de surendettement, le ratio dette publique/PIB passant de 22% en 2022 à 21,5% en 2023, et la dette extérieure passant de 14,8% du PIB en 2022 à 17,8% en 2023. Le déficit du compte courant s'est creusé, passant de 4,9% du PIB en 2022 à 6,3% en 2023, sous l'effet de la détérioration des termes de l'échange (–8,1%) et des importations élevées. Les réserves internationales ont augmenté de 18% pour atteindre 2,8 mois de couverture des importations en 2023. Avec le rétablissement des critères de crédit par la banque centrale, le ratio des prêts non productifs est passé de 7,4% en 2022 à 6,5% en 2023.[28]

La RDC se classe au 164ème rang sur 174 pays selon l'indice de capital humain 2020, conséquence de décennies de conflits, de fragilité et de développement compromis. L'indice de capital humain de la RDC s'établit à 0,37, en-dessous de la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne (0,40). Cela signifie qu'un enfant congolais né aujourd'hui ne peut espérer réaliser que 37% de son potentiel, par rapport à ce qui aurait été possible s'il avait bénéficié d'une scolarité complète et de qualité, et des conditions de santé optimales. Les principaux facteurs à l'origine de ce score sont le faible taux de survie des enfants de moins de cinq ans, le fort taux de retard de croissance des enfants et la faible qualité de l'éducation.[29]

1.1.4. Situation sécuritaire et humanitaire

La situation sécuritaire en RDC est préoccupante, mettant la pression sur l'augmentation des besoins humanitaires, en particulier dans quatre provinces de l'Est de la RDC (Nord-Kivu, Ituri, Sud-Kivu et Tanganyika) en proie à l'insécurité. Plus de 260 groupes armés locaux et étrangers sont présents et actifs en RDC. Les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Maniema et du Tanganyika abritent 252 groupes armés locaux et 14 étrangers.[30] Ces groupes armés non étatiques

[26] https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview consulté le 01-12-2024
[27] Idem
[28] https://www.afdb.org/fr/pays-afrique-centrale-republique-democratique-du-congo/perspectives-economiques-en-republique-democratique-du-congo consulté le 01-12-2024
[29] Ibidem BM
[30] https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Monde/RDC-266-groupes-armes-actifs-dans-cinq-provinces-orientales.html consulté le 01-12-2024

mènent des activités sporadiques dans différentes localités des provinces orientales, forçant les gens à quitter leurs maisons et affectant l'accès et les opérations humanitaires.

En outre, la crise née il y a déjà deux ans dans le territoire de Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe, s'est largement étendue dans les zones alentours créant d'importants mouvements de populations dans les provinces du Kwilu, du Kwango et des zones rurales de Kinshasa, suscitant des besoins humanitaires importants. Ce conflit a pris des formes multiples, notamment celle du banditisme armé.

Les autres provinces touchées par des poches d'insécurité sont la Tshopo, exposée depuis février 2023 à des violences intercommunautaires dues à un conflit foncier, qui a déjà fait plus de 700 morts et entraîné le déplacement de plus de 90 000 personnes. Les provinces de l'espace Kasaï (Kasaï, Kasaï-Central et Kasaï-Oriental) ont connu une augmentation des incidents de protection entre 2022 et 2024 en raison des actes de criminalité et la persistance des conflits en lien avec le pouvoir coutumier et des conflits fonciers. A cela s'ajoutent des ingérences politiques et la compétition pour le contrôle des ressources minières. Au cours de ces conflits, de nombreuses maisons sont incendiées, des morts et blessés sont enregistrés et des milliers de personnes déplacées.[31]

Les affrontements armés constituent la première cause de déplacement de population dans le pays. Le nombre d'incidents de protection est également étroitement corrélé à l'intensité des affrontements armés et des déplacements de population. Les civils subissent le plus gros des attaques, les combats ciblant souvent les camps informels et les centres urbains ou se déroulant à proximité des sites de déplacés.

La RDC compte plus de 6,4 millions de personnes déplacées internes (PDI), dont 2 millions de femmes enceintes et allaitantes (FEFA) selon le PNDS-PS 2024-2033, et 2,4 millions de PDI retournées dont environ 900 000 retournées entre août et octobre 2024. Cette tendance s'est aggravée depuis le début de l'année 2024 avec plus de 940 000 personnes déplacées entre janvier et avril 2024, la plupart étant contraints aux déplacements multiples.[32] Selon les dernières données, datant de février 2023, la RDC accueille 522 000 réfugiés et demandeurs d'asile, dont la majorité (74%) vit en dehors des camps de réfugiés.[33]

La crise en RDC est considérée comme l'une des crises les plus négligées au monde en raison de sa faible visibilité et de l'inaction mondiale à laquelle elle est confrontée. Sans une augmentation des capacités et des ressources humanitaires, la situation catastrophique que vit le pays continuera à s'aggraver.[34]

Ces événements ont entrainé des incidences néfastes, sur le système de santé en général, et sur les activités de santé communautaire en particulier.

1.1.5. Situation culturelle et linguistique

La RDC se caractérise par une grande diversité culturelle et linguistique avec plus de 40 ethnies et 400 tribus catégorisées en quatre principaux groupes ethniques, à savoir : les Bantous qui sont majoritaires, les Nilotiques, les Soudanais et les Pygmées. Le pays compte quatre langues nationales qui sont le Kikongo au Sud-Ouest, le Lingala à Kinshasa et au Nord-Ouest, le Swahili à l'Est, et le Tshiluba au Centre-Sud du pays. Le français étant la langue officielle de l'administration et de l'enseignement.

[31] Protection Cluster, Mise à jour sur la situation de protection en RDC : recrudescence de violence, épidémies et transition. 2024
[32] Ibidem rtn
[33] https://www.unhcr.org/be/aide-durgence/urgence-republique-democratique-du-congo consulté le 01-12-2024
[34] https://www.iom.int/fr/news/la-crise-humanitaire-alarmante-dans-lest-de-la-rdc-exige-des-mesures-urgentes-pour-proteger-les-populations-vulnerables consulté le 01-12-2024

1.1.6. Situation du genre et de l'équité

Il est évident que les femmes jouent un rôle significatif dans la vie quotidienne du ménage et participent activement à la sphère socio-économique. Sur ce, la constitution de la RDC garantit l'égalité de tous les Congolais (hommes et femmes), cependant, des obstacles socio-économiques et barrières culturelles ainsi que des pratiques sociales traditionnelles préjudiciables aux femmes et aux filles entretiennent des inégalités de genre telles que les mariages précoces, l'accès limité à la planification familiale (PF), les violences basées sur le genre (VBG), etc. Ces inégalités limitent l'accès aux soins de santé pour les femmes.

Selon le rapport d'analyse du genre réalisée en 2022, 85% des femmes déclarent avoir connu des limitations à l'accès aux services de santé dont 70% pour raison financière, 44% pour des problèmes de transport et 22% pour absence de permission du conjoint.[35] Cependant, la RDC se classe à la 151ème place sur 179 pays par rapport à l'Indice d'Inégalité de Genre de 2021 (IIG1), une mesure composite de l'inégalité de genre utilisant la santé reproductive, l'autonomisation et le marché du travail comme dimensions principales.

Les femmes se heurtent à des obstacles importants en matière de perspectives économiques et d'autonomisation et elles sont notamment confrontées à un niveau élevé de violences et de discriminations. Seulement 16,8 % des filles terminent l'école secondaire, soit environ deux fois moins que les garçons. Les mariages précoces et les taux de fécondité élevés posent des problèmes, le niveau de fécondité des femmes et adolescentes sans aucune éducation étant deux fois supérieur au taux observé chez celles qui ont achevé leurs études secondaires.

Le taux d'activité des femmes en RDC est estimé à près de 62%, la plupart d'entre elles travaillant dans l'agriculture. Bien que ce taux soit relativement élevé, les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes et possèdent moins d'actifs.[36]

La VBG reste un problème répandu en RDC, avec des taux alarmants de violence conjugale touchant près de la moitié des femmes en couple. Les cas signalés ont considérablement augmenté, passant de 47 502 en 2018 à 119 394 en 2022, ce qui reflète à la fois des campagnes de sensibilisation accrues et des améliorations du cadre juridique. Cependant, la persistance de VBG à l'encontre des adolescentes et des femmes est alimentée par divers facteurs, notamment les vulnérabilités exacerbées par les conflits et les déplacements, les normes sociales enracinées et les pratiques traditionnelles néfastes, les inégalités de genre généralisées et un système judiciaire faible qui entraîne souvent des retards dans les poursuites judiciaires.[37]

En RDC, il y a eu recrudescence des cas de VBG au cours du premier semestre 2024, 61 346 survivants ont été reçus dans les services de prise en charge holistique en fonction de leurs besoins. Près de la moitié de ces cas ont été signalés dans les provinces de l'Est, qui sont touchées par des conflits et des catastrophes naturelles. Parmi eux, 89% étaient des femmes et des filles et 11% des hommes. Il faut noter que 40% concernent des enfants (moins de 18 ans), 58% des adultes (18-59 ans) et 2% des personnes âgées (59 ans +).[38] Selon le PNDS-PS 2024-2033, 72 000 cas de VBG, y compris le viol, sont dans le besoin d'assistance humanitaire. Les provinces les plus affectées sont celles concernées par les conflits armés.

[35] Ministère du Genre, Famille et Enfant-EU-ONU Femmes-Groupe de la Banque Africaine de développement. Profil genre pays de la RDC : Rapport de mission. Avril 2022.
[36] https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview consulté le 01-12-2024
[37] https://drc.unfpa.org/fr/topics/mettre-fin-aux-violences-sexuelles-et-bas%C3%A9es-sur-le-genre consulté le 01-12-2024
[38] https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/republique-democratique-du-congo-bulletin-dinformation-du-gbv-aor-avril-juin-t2-2024-aout-2024 consulté le 01-12-2024

1.1.7. Situation des urgences et catastrophes

La RDC présente un potentiel élevé à développer les urgences de santé publique englobant les flambées épidémiques, les catastrophes et les crises humanitaires. Ce potentiel aux incidents s'exprime en termes des dangers, menaces et risques qui sont consécutifs à la vaste étendue du pays avec ses neuf portes d'entrées, aux écosystèmes favorables et à la large biodiversité. De plus, sa démographie sans cesse croissante associée à des facteurs socio-économiques précaires dans un contexte de menace climatique constitue pour le pays un foyer propice à l'éclosion des multiples incidents. Au niveau national, 12 risques, menaces et dangers ont été priorisés.[39]

Au cours des cinq dernières années, la RDC a riposté contre plusieurs incidents notamment les épidémies de rougeole, de méningite, de choléra, de peste, de fièvre jaune, de rage canine, de la Covid-19 ainsi que la contingence aux crises humanitaires (l'éruption volcanique de Nyiragongo et la fréquence élevée des accidents de Traffic).[40,41,42]

En 2024, le Centre d'Opérations d'urgences de santé publique (COUSP) a été activé pour plusieurs urgences de santé publique, notamment dont l'épidémie de Rougeole et l'épidémie de Mpox.

1.1.8. Changement climatique

Le changement climatique pourrait réduire à néant les gains durement acquis par la RDC en matière de capital humain, avec un impact disproportionné sur les pauvres, et en particulier sur les femmes et les populations exclues. Si la RDC reste sur sa trajectoire de croissance et qu'aucune mesure n'est prise, le changement climatique pourrait entraîner une perte de 4,7% à 12,9% du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2050. Selon le scénario climatique le plus pessimiste, 16 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté d'ici 2050, si le pays ne met pas en œuvre des investissements résilients au climat et des politiques inclusives supplémentaires pour parvenir à la croissance économique et à la durabilité des moyens de subsistance.[43]

Les jeunes vivant en RDC sont parmi les plus exposés aux effets du changement climatique : une situation qui menace leur santé, leur éducation et leur sécurité, et leur fait courir le risque de contracter des maladies mortelles selon un rapport de l'UNICEF « La crise climatique est une crise des droits de l'enfant : Présentation de l'Indice des risques climatiques pour les enfants », qui classe les pays selon le degré d'exposition et de vulnérabilité des enfants aux chocs climatiques et environnementaux, la RDC y figure en neuvième position.

1.2. Organisation du système de santé

1.2.1. Système de santé

L'ordonnance-loi n° 23/006 du 3 mars 2023, modifiant et complétant la loi n° 18/035 du 13 décembre 2018, fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, définit, en son article 4, le système national de santé comme un ensemble coordonné de structures, de personnes et d'activités visant à prévenir les maladies, maintenir, restaurer et promouvoir la santé de la population.

Le système de santé en RDC a pour missions : (i) garantir le bien-être de la population ; (ii) prévenir les incapacités, les maladies et les décès prématurés ; (iii) promouvoir un meilleur état de santé

[39] Rapport d'évaluation des risques et des capacités au niveau national avec l'outil THIRA.
[40] Rapport annuel de la Direction de Surveillance épidémiologique en 2022
[41] Rapport de situation : crise humanitaires et épidemies,rapport de situation semaine 47_2024
[42] Plan national multirisque 2024-2027 des urgences de santé publique en République Démocratique du Congo
[43] https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2023/11/15/changement-climatique-afe-1123-la-r-publique-d-mocratique-du-congo-doit-renforcer-ses-institutions- consulté le 11-12-2024

de la population et (iv) assurer la couverture, la qualité, l'efficacité des services et la satisfaction des besoins de santé.[29]

Ce système est structuré selon trois niveaux dont les attributions sont déterminées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance-loi ci haut référenciée.

Le **niveau central** définit les grandes orientations de la politique sanitaire nationale. Il édicte les directives, les normes, les stratégies d'intervention, les politiques et en assure le suivi et l'évaluation. Il comprend le Ministère ayant en charge la Santé Publique, Hygiène et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, le Secrétariat Général à la santé ainsi que l'Inspection Générale de la Santé. Les établissements publics du secteur de la santé sont des structures d'appui du niveau central.

Le **niveau intermédiaire** est chargé de la coordination, de l'appui, de l'encadrement, du contrôle, de la supervision, du suivi et de l'évaluation de l'ensemble des activités de santé sous sa juridiction. Il veille à l'application de la politique sanitaire, des directives, des normes et des stratégies sanitaires nationales. II comprend les provinces sanitaires qui sont les entités déconcentrées du pouvoir central, subdivisées en ZS. L'Inspection Générale de la santé est représentée en province par l'inspection provinciale de la santé qui assure l'inspection et le contrôle des services de santé. Un arrêté du Ministre ayant en charge la Santé Publique, Hygiène et la Prévoyance Sociale dans ses attributions crée et fixe l'organisation et le fonctionnement de la province sanitaire.

Le **niveau périphérique ou opérationnel** a pour mission la mise en œuvre de la stratégie des soins de santé primaires. Il comprend la ZS qui est subdivisée en aires de santé. La zone de santé est constituée du bureau central de la zone de santé, de l'hôpital général de référence, des centres de santé de référence, des centres de santé, des postes de santé, ainsi que d'autres établissements de santé publics et privés sous sa juridiction.

Le service public de santé englobe les institutions et établissements de services et soins de santé (ESS) relevant du pouvoir central, des provinces et des Entités Territoriales Décentralisées (ETD). Ces ESS relevant du pouvoir central fournissent des soins de 4ème échelon, qui sont des soins hautement spécialisés. Ils se chargent également de la formation supérieure et universitaire du personnel ainsi que de la recherche scientifique.

Les ESS relevant du pouvoir provincial offrent des soins de 3ème échelon, qui sont des soins spécialisés, et s'occupent aussi de la formation, de la supervision, de l'évaluation et de la recherche.

Les ESS relevant des ETD fournissent des soins de deux échelons : les soins de 1er échelon, constitués d'un paquet minimum d'activités offert par les centres de santé (CS), et les soins de 2ème échelon, comprenant un paquet complémentaire d'activités offert par les hôpitaux généraux de référence (HGR).

L'Aire de santé (AS), couverte par le Centre de Santé (CS), est le lieu de déconcentration des services des soins de santé pour rapprocher les soins auprès des communautés.

La politique nationale de santé (PNS), définie en 2001, repose sur la stratégie des soins de santé primaires. Elle est soutenue par la Stratégie de Renforcement du Système de Santé (SRSS), adoptée en 2006 et révisée en 2010. La mise en œuvre du PNS et de la SRSS se font à travers le plan national de développement sanitaire (PNDS), des plans stratégiques sous-sectoriels tel que le PSN SACO, des plans provinciaux de développement sanitaire (PPDS), des plans de développement des Zones de Santé (PDZS) et des plans d'actions opérationnels (PAO), alignés sur les différents financements disponibles et mobilisables dans le secteur.

1.2.2. Système de santé communautaire

Rappel historique de la participation/engagement communautaire en RDC

En RDC, les expériences sur l'implication de la communauté remontent d'avant l'indépendance. Ce sont ces expériences de Kisantu, Vanga, Katana, Bwamanda et Kasongo qui vont donner l'élan à la vision de « santé pour tous » que la Conférence d'Alma Ata endossera en 1978. Cette déclaration a affirmé "les soins de santé primaires" (SSP) comme étant une approche essentielle devant parvenir à un niveau de santé acceptable considérée comme un droit dans le cadre du développement empreint d'un véritable esprit de justice sociale. Depuis lors, le pays a reconnu l'importance de la participation communautaire dans la prestation des services de santé.

Les années 80 étaient marquées par quelques projets des soins de santé primaires en milieu rural dont SANRU et en milieu urbain à Kinshasa (SPT-K) qui ont structuré la participation communautaire autour des personnes bénévoles notamment les agents de santé villageoise et les « mama et tata Bongisa » en vue d'impliquer les communautés locales dans la gestion et la prestation des soins de santé de base. Ces agents ont été formés pour fournir des soins de santé de base, sensibiliser aux questions de santé et référer les cas si nécessités il y a vers les structures de santé.

En 2003, un premier manuel des procédures d'organisation et de fonctionnement des SSC a été produit. Depuis lors, des initiatives de développement de la participation communautaire (dynamique communautaire, SALT, PHAST, Communauté Championne, Nutrition à Assise Communautaire, Bulletin Communautaire de Performance, SSC etc.) ont montré leurs forces et leurs limites. Ce qui a permis de mettre en place des organes de participation communautaire. Très rapidement ces organes se sont vus inféodés aux structures du secteur de la santé par manque d'orientations stratégiques déclinant une vision claire et précise du renforcement du système communautaire en vue d'une autonomisation de la communauté.

Entre 2007 et 2014, quelques révisions sont intervenues certes pour tenter d'adapter l'approche, mais sans beaucoup de succès par le fait de l'absence d'une stratégie précise axée sur l'autonomisation des communautés. Avec l'avènement du document stratégique de la croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) en 2006, de la stratégie de renforcement du système de santé (SRSS), du PNDS et de la réforme basée sur la décentralisation, des idées se sont dégagées dans le sens d'une nécessité à disposer d'une stratégie devant servir d'orientations stratégiques sur la participation communautaire.

En 2016, le pays a élaboré la stratégie de développement de la participation communautaire qui s'inscrit dans une vision de concertation multisectorielle devant amener les communautés à être autonomes, autodéterminées et suffisamment responsabilisées pour un développement durable. Après la participation du pays au premier symposium international sur l'institutionnalisation de la santé communautaire, tenu en Afrique du Sud en avril 2017, une Sous-commission dénommée « Santé Communautaire » a été créée au sein de la Commission « Prestations, Mise en œuvre et Suivi-Evaluation » du Comité national de pilotage du secteur de la santé (CNP-SS) et dont le mandat est d'appuyer le développement, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des prestations des soins de santé primaires au niveau communautaire. Cette Sous-commission est portée par la DGOGSS conformément à l'arrêté ministériel du Comité national de pilotage du secteur de la santé (CNP-SS) n° 1250/CAB/MIN/SP/079/Nov.2009 du 03 novembre 2009.

Organisation du système de santé communautaire

La santé communautaire en RDC est l'un des sous-secteurs essentiels du secteur de la santé, visant à intégrer les communautés dans la gestion de leur propre santé. L'organisation du système de santé communautaire s'articule autour du système de santé et repose sur une structuration hiérarchisée, permettant une mise en œuvre efficace des interventions communautaires, depuis

le niveau central jusqu'aux villages les plus reculés. Selon le principe de la participation communautaire prônée dans la stratégie des soins de santé primaires, la communauté est placée au centre de l'action en tant que partenaire, acteur et bénéficiaire.

A ce jour, il n'existe pas un cadre légal instituant la santé communautaire en RDC. Toutefois, divers structures (Cellule d'animation communautaire ou CAC, Comité de développement de l'aire de santé ou CODESA, Organisation à assise communautaire ou OAC) et volontaires de santé communautaire spécifiques au programme existent dont la plupart sont connus sous le nom de relais communautaires (RECO). Il s'agit de : (i) RECO promotionnels » et (ii) RECO prestataires de sites de soins communautaires (RECOSITE).

Ces acteurs essentiels sont sélectionnés par les communautés locales pour la mobilisation, la sensibilisation, et l'éducation des populations sur les questions de santé de leur communauté. En assurant un lien direct entre les ménages et les services de santé de base, les RECO contribuent à l'extension de la couverture sanitaire et à l'amélioration de l'accès aux soins, même dans les zones les plus reculées. Par ailleurs, il existe également des acteurs communautaires spécifiques à un programme qui fournissent d'une part des services particuliers liés à des maladies et problèmes de santé particuliers, comme le VIH/SIDA , la distribution à base communautaire des contraceptifs (DBC/PF) et d'autre part les activités de masse (nutrition, paludisme et MTN).[44] Sans oublier ceux qui participent à la surveillance communautaire des maladies prioritaires par l'identification des cas afin de lancer les alertes et la recherche active des cas en période d'urgence sanitaire. A ce niveau, il est important de signaler également l'existence des agents communautaires qui œuvrent dans la surveillance des maladies des animaux domestiques et d'élevage appelés Agents Communautaires de la Santé Animale (ACSA). En effet, aujourd'hui la sécurité sanitaire n'est plus de l'apanage du seul secteur de la santé. Parce que les maladies émergentes et réémergentes qui constituent les épidémies, voire pandémies de ces dix dernières années sont pour la majorité d'origine zoonotique, l'approche « Une Santé » est aujourd'hui la norme pour améliorer la sécurité sanitaire de la population. Il est donc primordial dans le cadre de ce document, d'évoquer également cette catégorie d'acteurs communautaires.

[44] Raven J, Wurie H, Idriss A, et al. How should community health workers in fragile contexts be supported: qualitative evidence from Sierra Leone, Liberia and Democratic Republic of Congo. Human Resources for Health 2020. Disponible à l'adresse suivante : http://doi.org/10.1186/s12960-020-00494-8.

La figure ci-dessous schématise la combinaison entre les structures et les acteurs de la santé communautaire avec leurs interrelations.

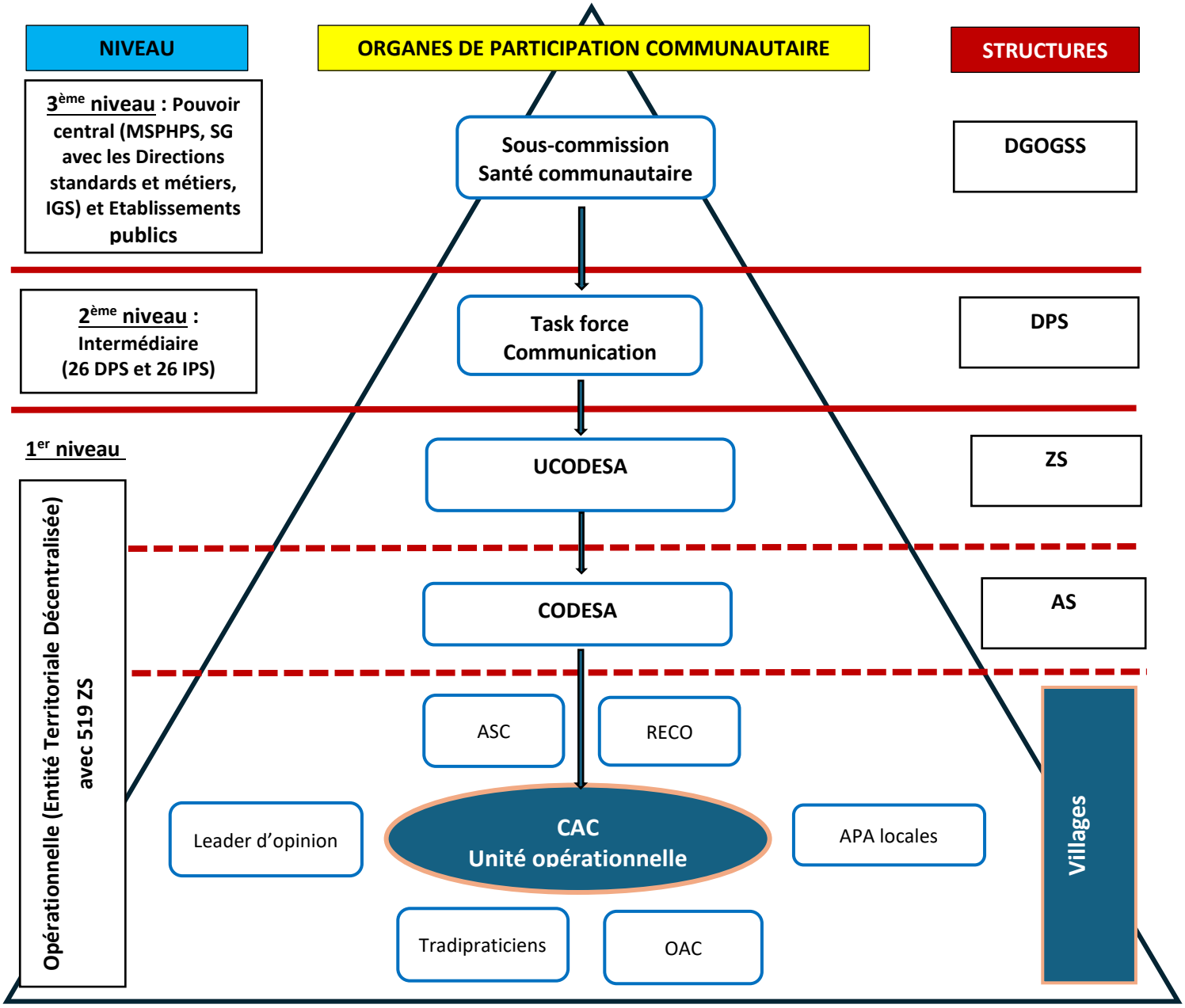


Figure 2: Ancrage de l'organisation du système de santé communautaire dans la pyramide sanitaire en RDC

Source : ICHESS, adapté du schéma de la pendule de santé communautaire décrite dans le PSN SACO 2019-2022

La santé communautaire est coordonnée à différents niveaux de la pyramide sanitaire comme suit :

- Au niveau central par la DGOGSS à travers la « Sous-commission Santé communautaire » ;
- Au niveau provincial, par la Division provinciale de la santé (DPS) à travers la « Task force communication » ; et
- Au niveau opérationnel par l'Équipe Cadre de la Zone de Santé (ECZS) à travers l'union des comités de santé (UCODESA) avec le soutien du Comité de développement de l'aire de santé (CODESA) au niveau de l'AS et de la Cellule d'animation communautaire (CAC) au niveau du village. Cette dernière constitue l'unité opérationnelle des activités au niveau de la communauté.

L'Institut National de Santé Publique (INSP) au travers le Centre des Opérations d'Urgence de Santé Publique (COUSP) joue des rôles cruciaux dans la santé communautaire en RDC. L'INSP est

au cœur de la gestion des urgences de santé publique en RDC. Il assure une réponse rapide et efficace aux crises sanitaires grâce à des stratégies et des plans bien définis. Les responsabilités du COUSP incluent :

- Coordination de la réponse aux épidémies, en mettant en place des systèmes de gestion des incidents ;
- Gestion des ressources et des équipements nécessaires pour la prise en charge des malades, comme les kits de prévention et de contrôle des infections ;
- Collaboration avec les partenaires internationaux, pour renforcer les capacités de réponse du système de santé, y compris la santé communautaire.

Les structures de participation communautaire sont chargées de mobiliser les membres de la communauté dans un éventail de services sociaux multisectoriels. Comme illustré dans la figure ci-dessus, outre les RECO, de nombreux autres acteurs de la santé communautaires sont rattachés à la CAC. Il s'agit notamment des tradipraticiens, les leaders d'opinion, les Autorités politico-administratives (APA) et les OAC.

Cependant, malgré le rôle important des RECO dans le rapprochement des services aux populations, leur professionnalisation constitue un défi, outre l'épineux problème de l'institutionnalisation de la santé communautaire. Ils sont, en effet, reconnus comme des bénévoles non rémunérés, bien que certains reçoivent des allocations minimales, des paiements basés sur les performances, des incitations à la formation ou des compensations en nature, souvent laissés à la discrétion des partenaires d'exécution.[45] Mais aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de la sécurité sanitaire en RDC selon l'approche « Une Santé », il a été constaté que l'organisation des ACSA est caractérisée par une faible structuration, ils restent au niveau opérationnel et travaillent de manière isolée, comparativement au RECO qui sont réunis au sein de CAC, CODESA et UCODESA. Un autre constat est qu'au niveau du secteur de la santé environnementale qui est le secteur clé à l'origine des maladies zoonotiques, le système de surveillance des maladies de la faune sauvage est faiblement organisé.

Les organes de participation communautaires (UCODESA, CODESA, CAC et les autres structures communautaires connexes) sont essentiels dans la mise en œuvre de la stratégie de participation communautaire sur laquelle repose actuellement le système de santé communautaire en RDC et doivent contenir aussi les acteurs communautaires des autres secteurs notamment ceux de la santé animale et environnementale afin d'assurer une meilleure mise en œuvre de la sécurité sanitaire en RDC.

1.2.3. Organisation de la gestion des urgences dans la communauté

La gestion des urgences de santé publique vise à protéger la santé des populations et les infrastructures face aux risques sanitaires à travers la prévention, la préparation et la riposte aux urgences sanitaires.

En RDC, l'ordonnance-loi n°23/006 du 03 mars 2023 modifiant et complétant la loi n°18/035 du 13 décembre 2018 ainsi que le décret n°22/16 du 09 avril 2022 ont créé INSP. Celui-ci est un établissement public, autonome sous tutelle du Ministre de la Santé avec dans ses attributions la coordination de la gestion des urgences de santé publique à travers le COUSP.

Le COUSP devra collaborer avec tous les acteurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire (y compris la santé animale etenvronnementale) en vue d'une collaboration étroite des actions communautaires dans le cadre de la gestion des urgences de santé publique. Cette collaboration tiendra compte des membres de la communauté, des autorités sanitaires à tous les niveaux, les programmes et Directtions centrales, des partenaires nationaux et internationaux. La gestion des

[45] Devlin K, Egan KF, Pandit-Rajani T. Community Health Systems Catalog Country Profile: DRC. 2017. Disponible à l'adresse suivante : https://www.advancingpartners.org/sites/default/files/catalog/ profiles/drc_chs_catalog_profile_0.pdf.

urgences de santé publique s'articule autour de plusieurs stratégies ou initiatives essentielles de mobilisation des ressources locales et des partenaires. Il s'agit de :

- Système de surveillance et d'alerte précoce ;
- Sensibilisation et communication sur les risques ;
- Renforcement des capacités des RECO ;
- Gestion des cas et isolation des malades ;
- Distribution de kits d'urgence et de matériels de protection ;
- Coordination avec les autorités sanitaires et partenaires ;
- Accès à des centres de traitement temporaires
- Renforcement des systèmes WASH ;
- Résilience.

En adaptant les principes directeurs internationaux, la gestion des urgences dans la communauté s'effectue en cinq étapes suivantes[46] :

Étape 1 : Détection

Elle consiste à tenir des discussions dans la communauté en vue de déterminer précisément quels risques la préoccupent le plus. Une liste restreinte de déclencheurs à signaler (des événements ou des définitions communautaires de cas) est établie afin d'assurer le suivi de ces risques. Il est recommandé de définir au moins quatre déclencheurs, et pas plus de huit, pour faciliter le travail de compte rendu par SMS des volontaires. Ces derniers informent les communautés qu'une alerte SMS a été envoyée et, le cas échéant, mènent des activités de promotion de la santé et de sensibilisation aux premiers secours à base communautaire

Étape 2 : Tri

L'étape du tri consiste à recueillir des informations par des moyens de communication disponibles (Internet, téléphone, fiches, radiophonie, messager, etc.) du responsable de la surveillance à base communautaire à un volontaire, suivi d'une visite dans la communauté par le responsable et un membre du personnel chargé des questions de santé. Ces derniers évaluent rapidement la situation qui a généré une alerte. Toutefois, Il est possible de recueillir suffisamment d'informations pour classer sans suite une alerte ne révélant pas de réel risque pour la santé publique, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'étape supérieure.

Étape 3 : Vérification des alertes par le personnel de santé local

Cette étape consiste à mobiliser une plus grande équipe de santé publique pour évaluer les risques dans le respect des principes de confidentialité en matière de santé. Elle comprend :

- Le recoupement d'informations, la conduite de nouveaux entretiens avec les interlocuteurs clés et la vérification de l'exactitude des faits ;
- Le renforcement des mesures de lutte contre les infections et de prévention, et la gestion communautaire des cas (conformément aux boîtes à outils relatives aux soins de santé et premiers secours à base communautaire et à la lutte contre les épidémies).

[46] Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Surveillance à base communautaire : Principes directeurs, Genève, 2017.

Étape 4 : Évaluation des risques

Elle consiste à identifier et prioriser les principales menaces des urgences de sante publique dans la communaute. Le COUSP réalise une enquête afin de déterminer si l'événement en présence est une épidémie qui requiert son activation en mode « réponse » et déterminer ainsi son niveau d'activation. Cette évaluation est réalisée en collaboration avec d'autres experts en matière d'évaluation.[47] En outre, le but de cette évaluation est de mieux cerner le risque, l'événement, la maladie, son potentiel de propagation, d'évaluer son impact sur les populations touchées et les communautés avoisinantes ainsi que d'identifier les éventuelles mesures d'atténuation.[48]

Étape 5 : Riposte

Cette étape consiste à intervenir de manière prompte et efficace pour lutter contre l'urgence sanitaire. Le COUSP en accord avec son concept des opérations (CONOPS) active le mode « réponse » avec un niveau d'activation qui sera fonction du niveau de risque.[49] Au cours de cette phase, le COUSP en collaboration avec toutes ses parties prenantes mettra en branle toutes les interventions de santé publique nécessaires pour la gestion efficace de l'urgence.

Ainsi, les ASC et RECO formés en surveillance à base communautaire peuvent être les premiers intervenants et, si la situation le justifie, prendre dès la 1ère étape des mesures visant à assurer autant que possible la sécurité de la communauté.

1.2.4. Organisation du contrôle citoyen

Du fait de leurs missions, les Organisations de la Société de Civile (OSC) sont les acteurs privilégiés pour assurer efficacement toutes les actions entrant dans le cadre du contrôle citoyen. En raison de leur présence à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, les OSC sont constituées en groupes, réseau, plateformes et faîtières ou coalition en vue de mutualiser leurs moyens et ressources pour entreprendre des initiatives et actions devant améliorer la fourniture des biens et services publics.

Dans le cadre de contrôle citoyen, ces OSC recourent au mécanisme de suivi dirigé par la communauté (Community Led Monitoring, CLM) pour collecter, analyser, utiliser et diffuser sous forme d'alerte les informations de façon continue afin d'améliorer l'accès et la disponibilité aux services ainsi que la qualité et l'impact de ces derniers en contraignant les prestataires de services et les décideurs à rendre des comptes. Le suivi communautaire dans le cadre de contrôle citoyen est entrepris par le biais de mécanismes selon lesquels les utilisateurs des services et les communautés réunissent des observations et des données quantitatives et qualitatives pour évaluer la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité, l'équité et la qualité des services reçus.

En revanche, le plaidoyer politique pour la mobilisation des ressources domestiques vise à prendre les desideratas de la communauté et les porter/présenter aux décideurs pour que ceux-ci trouvent des solutions idoines et durables. C'est une démarche menée par les OSC dans le but d'amener les autorités tant au niveau national que local à s'impliq hj-uuer/s'engager davantage aux problèmes sanitaires de la base ou d'une activité d'intérêt général.

Il sied de spécifier deux niveaux majeurs où le plaidoyer mené par la Coordination nationale de renforcement des systèmes communautaires (CNRSC) s'effectue de façon efficace. Ces plaidoyers consistent à assurer :

[47] Centre d'opérations d'urgence de santé publique Manuel du COUSP. Brazzaville : Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l'Afrique, 2021. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
[48] Handbook for developing a public health emergency operations centre. Part A: policy, plans and procedures. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
[49] Concept des Opérations d'urgence de Santé Publique du COUSP, 2024. https://insp.cd/wp-content/uploads/2024/08/CONOPS-02-Aout-2024_-GD.pdf

- La veille citoyenne en rapport avec la protection de certaines catégories de population victime de la stigmatisation/marginalisation, des violences basées sur le genre, des inégalités de droits humains etc. c'est donc l'observatoire qui est activée ;
- Le suivi communautaire de la mise en œuvre de certaines interventions notamment le respect de la norme et des engagements, la satisfaction des usagers, l'utilisation rationnelle des intrants et la redevabilité.

Cette partie a pour objectif d'analyser l'état du système de santé communautaire de la RDC dans l'optique d'identifier les problèmes réels de ce sous-secteur en vue d'orienter les solutions stratégiques. Pour ce faire, les analyses portent sur le niveau d'atteintes des performances du système de santé communautaire, l'influence des facteurs sociaux connexes à la santé, les leçons apprises à capitaliser ainsi que les forces et faiblesses du système de santé communautaire.

II. Cadre analytique

2.1. Revue des performances du système de santé

2.1.1. Etat de santé et sécurité sanitaire de la population

L'état de santé et la sécurité sanitaire de la population détermine l'ampleur des problèmes et des défis actuels auxquels les communautés de la RDC sont confrontées en vue de guider la mesure de la contribution de l'engagement communautaire suffisamment indispensable dans l'amélioration des résultats de la santé (humaine et animale), de l'éducation, de la protection, de la nutrition, de l'accès à l'eau et à l'assainissement, de l'environnement et du bien-être au niveau individuel et collectif.

- **Tendance de l'espérance de vie à la naissance**

Selon les données de l'OMS, la RDC a connu une accélération de l'amélioration de l'espérance de vie à la naissance au cours des dernières années passant de 56,8 ans en 2000 à 62 ans en 2020, puis un léger ralentissement à 61,6 ans en 2021. La modélisation ci-dessous indique que l'espérance de vie serait repartie à la hausse de 2022 à 2024 et cette tendance devrait se maintenir jusqu'en 2030. Il sied de noter que le très faible taux de variation annuelle estimé en moyenne à 0,7% ne permettra pas à la RDC d'atteindre une espérance de vie égale au seuil de prématurité des années potentielles de vie perdues (APVP), fixé à 75 ans à l'horizon 2030, pour cela, il faut qu'elle change son taux de variation annuelle moyenne et passer de 0,7% actuel à 2,7%.

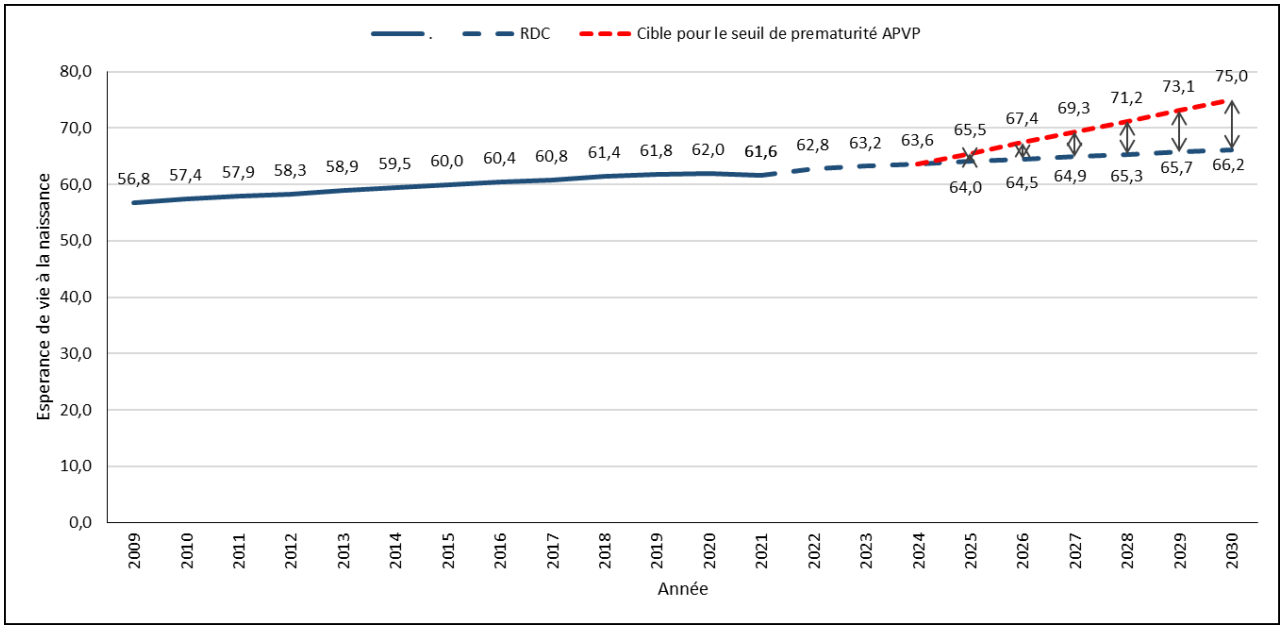


Figure 3: Tendance de l'espérance de vie à la naissance

Source : ICHESS, modélisation à partir des données de l'OMS 2024

- **Tendance du taux de mortalité brute**

La RDC présente des taux de mortalité brute supérieure à la moyenne Africaine au sud du Sahara et à celle des pays fragiles et affectés par un conflit. Cette tendance est restée presque inchangée depuis les années 1960, mais vers le début des années 2020, le taux de la RDC a tendance a rejoindre ceux des pays précités.

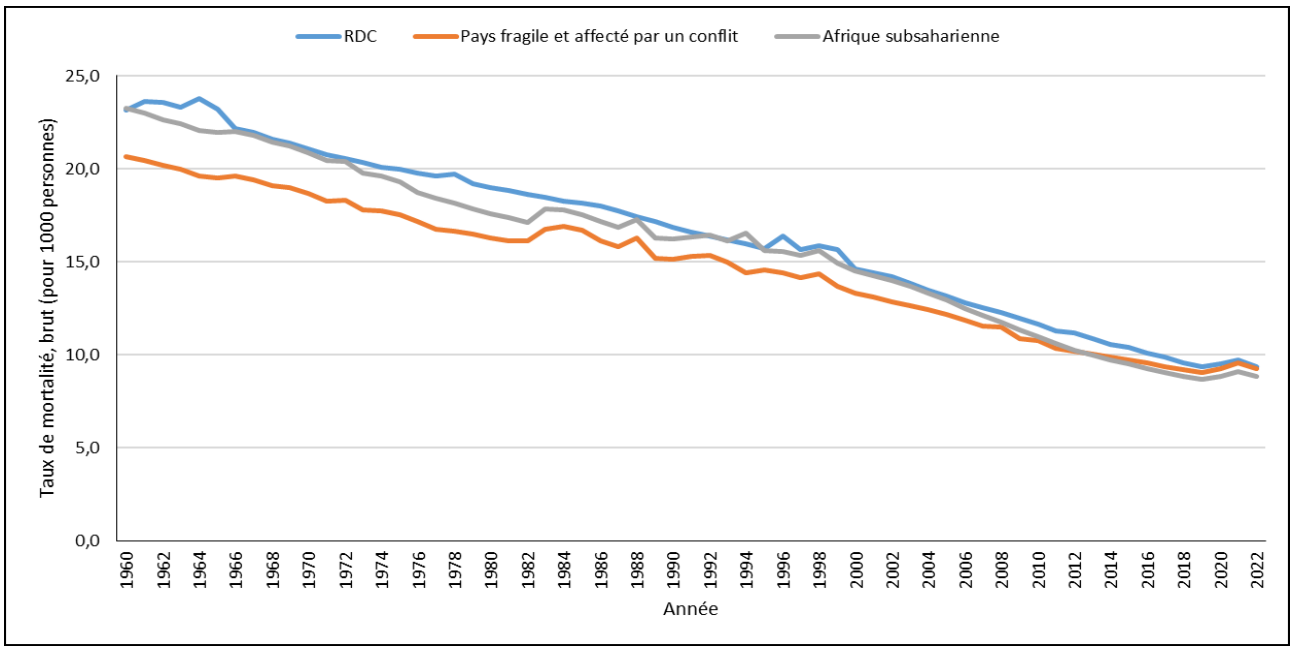


Figure 4: Tendance de mortalité brute

Source : ICHESS, à partir des données de la BM 2024

- **Mortalité maternelle**

En tenant compte du graphique fourni, la tendance du ratio de mortalité maternelle en RDC a globalement diminué entre 2010 et 2023, passant de 836 pour 100 000 naissances vivantes (NV) à 704 pour 100 000 NV. La modélisation indique que ce ratio devrait être de 605 pour 100 000 NV en 2025. Or, l'atteinte de la cible de l'ODD 3.1.1., fixée à 70 décès pour 100 000 NV d'ici 2030, nécessitera un taux de réduction annuel beaucoup plus prononcé que la tendance observée, comme l'illustre la forte pente de la ligne "Cible ODD" à partir de 2025.

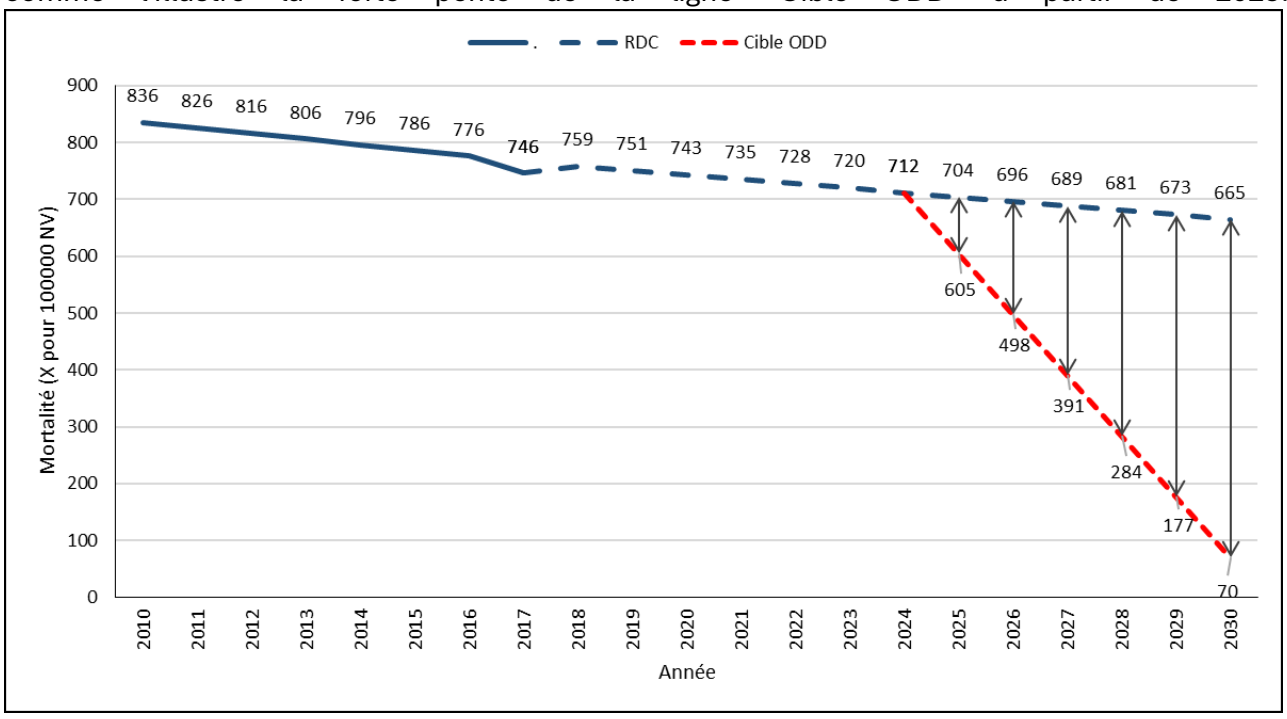


Figure 5: Tendance du ratio de mortalité maternelle

Source : ICHESS, modélisation à partir des données des EDS 2013-14 et 2023-2024

Le risque de mourir un jour d'une cause maternelle chez les jeunes filles congolaises (à l'âge de 15 ans) est parmi le plus élevé au monde. Estimé à 1/34, ceci est plus élevé que la moyenne de l'Africaine subsaharienne qui est de 1/38. L'écart existant d'avec les autres régions du monde est hallucinant, par exemple, ce risque est estimé à 1/3100 pour l'Amérique du Nord et 1/11700 pour l'Europe occidentale. Ainsi, la RDC est l'un des pays dans le monde où il est plus dangereux de donner naissance.

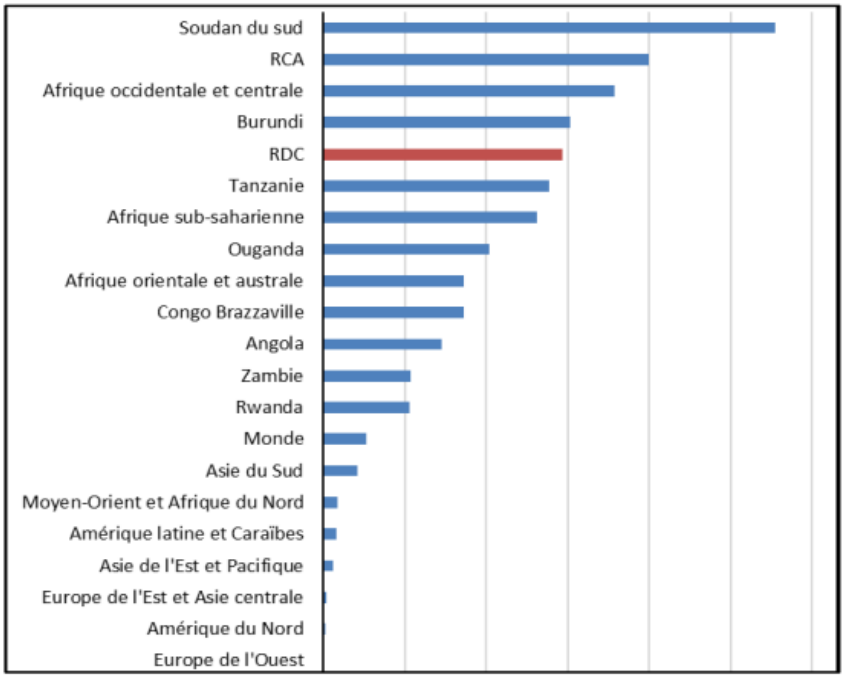


Figure 6: Risque de mortalité maternelle

Source : ICHESS, à partir des données de l'UNICEF 2023

- **Mortalité néonatale**

La RDC perd environ 96 000 nouveau-nés chaque année pour des causes liées aux complications de la malnutrition, aux infections néonatales et aux détresses respiratoires. [50] Selon les résultats de la modélisation réalisée à partir des données des EDS 2013-2014 et 2023-2024, la tendance du taux de mortalité néonatale est en amélioration progressive avec un taux moyen annuelle de seulement 1,5%. La modélisation réalisée indique que ce taux serait à 22 pour 1000 NV en 2024. A ce rythme, la RDC ne pourrait atteindre la cible de l'ODD 3.2.1, fixée à 12 décès pour 1000 NV qu'avec un taux moyen de réduction annuelle de 9,6%.

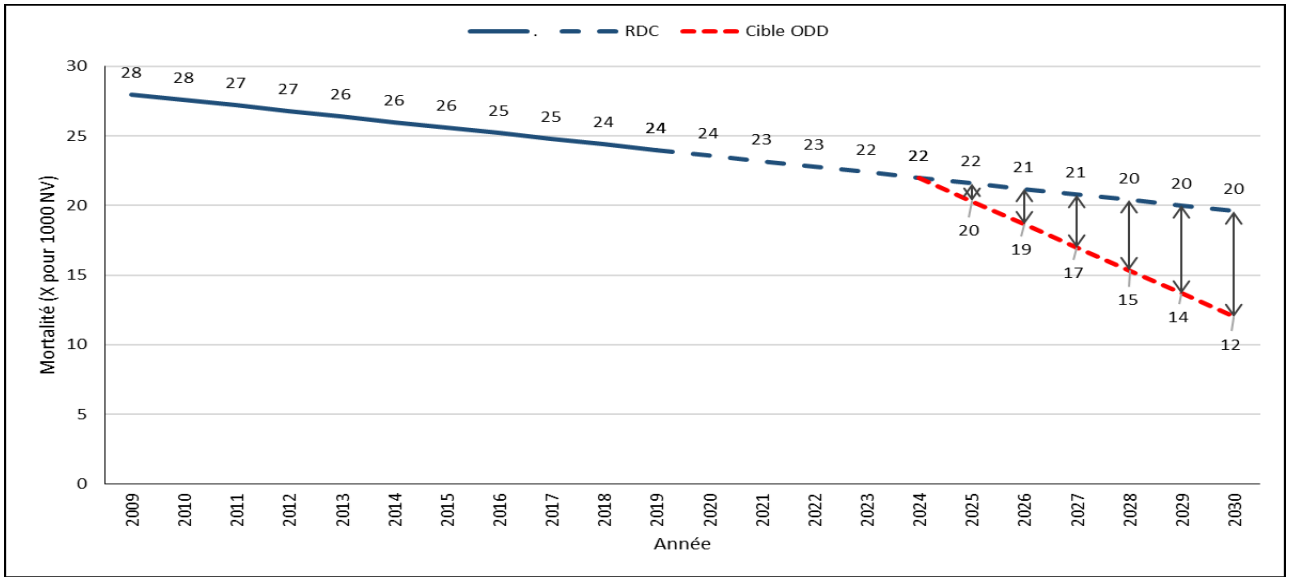


Figure 7: Tendance du taux de mortalité néonatale

Source : ICHESS, modélisation à partir des données des EDS 2013-14 et 2023-2024

[50] https://www.unicef.org/drcongo/communiqu%C3%A9s-de-presse/pour-chaque-enfant-une-chance-de-survivre consulté le 20-12-2024

- **Mortalité infanto-juvénile**

Selon les résultats de la modélisation réalisée à partir des données des EDS 2013-2014 et 2023-2024, la tendance du taux de mortalité infanto-juvénile est en amélioration progressive de 2009 à 2019, avec un taux moyen de variation annuelle de seulement 1,2%. La modélisation réalisée indique que ce taux serait à 86 pour 1000 NV en 2024. Ce qui montre que la RDC est loin d'atteindre la cible de l'ODD 3.2.1. fixée à 25 décès pour 1000 NV et qui nécessite un taux moyen de réduction annuelle de 18,4%.

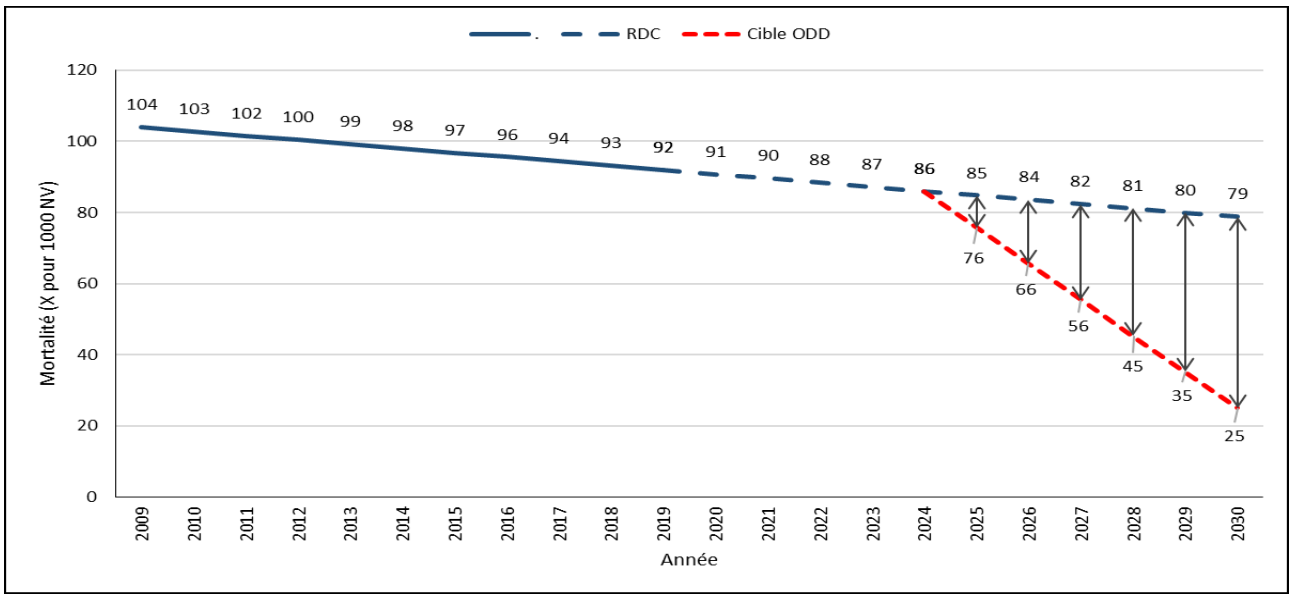


Figure 8: Tendance du taux de mortalité infanto-juvénile

Source : ICHESS, modélisation à partir des données des EDS 2013-14 et 2023-2024

- **Mortalité dans les autres tranches d'âge**

Selon les estimations des nations unis (United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. UN IGME 2022), la mortalité des enfants âgés de 5 à 14 ans est estimée à 20 décès pour 1000 enfants âgés de 5 ans (2021) et celle des adolescents (15 à 19 ans) est estimée à 17 décès pour 1000 enfants âgés de 15 ans (2021).

- **Autres taux de mortalité**

Tableau 4: Autres taux de mortalité

Autres taux de mortalité	Taux	Année	Source
Taux de mortalité routière (pour 100 000 habitants)	16,3	2021	OMS
Taux de mortalité attribué à la pollution de l'air ambiant et des ménages (pour 100 000 habitants)	211,9	2019	OMS
Taux de mortalité attribué à l'exposition à des services EHA dangereux (pour 100 000 habitants)	52,3	2019	OMS
Taux de mortalité par empoisonnement non intentionnel (pour 100 000 habitants)	2	2019	OMS
Taux de mortalité par homicide (pour 100 000 habitants)	12,8	2019	OMS
Taux de mortalité par suicide (pour 100 000 habitants)	6,7	2019	OMS

Source : ICHESS, à partir des données de l'OMS 2024

Encadré1 : En résumé, pour renverser les tendances des taux élevés de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, il est judicieux d'accroitre le financement des interventions communautaires et redoubler les efforts à la hauteur des taux annuels de réduction pour chaque cible. D'où l'importance d'une coordination efficace en santé communautaire (Gouvernement, partenaires, institutions de recherche et OSC) dans la perspective d'un « plan unique, budget unique, … ».

2.1.2. Principales causes et facteurs de risques de la mortalité

- **Causes de mortalité**

Tableau 5: Causes de mortalité

Maladies contagieuses, maternelles, néonatales et nutritionnelles
Maladies non contagieuses
Blessures

Cause	2013 rang	2023 rang	Évolution du nombre de décès pour 100 000 habitants, entre 2013 et 2023
Accidents de la route	5	1	↑ +21.7
Paludisme	1	2	↓ −38.3
IVRI	3	3	↓ −28.4
Tuberculose	2	4	↓ −35.3
Troubles néonatals	4	5	↓ −24.0
Accident vasculaire cérébral	6	6	↑ +2.8
La cardiopathie ischémique	10	7	↑ +7.7
Troubles maternels	9	8	↓ −13.6
Rougeole	16	9	↑ +5.4
Maladie pulmonaire obstructive chronique	12	10	↓ −0.7

Source : IHME 2025

Le tableau met en évidence une évolution marquante des principales causes de mortalité en RDC entre 2013 et 2023. La première observation majeure est la progression des accidents de la route, qui deviennent en 2023 la première cause de décès, alors qu'ils n'occupaient que le 5e rang en 2013. Cette hausse s'accompagne d'une augmentation significative du nombre de décès (+21,7 pour 100 000 habitants), illustrant une problématique croissante de sécurité routière.

À l'inverse, plusieurs maladies transmissibles enregistrent une baisse notable de la mortalité. Le paludisme, bien qu'il demeure la 2e cause de décès, connaît la plus forte diminution (–38,3). Les infections des voies respiratoires inférieures (IVRI) (–28,4), la tuberculose (–35,3) et les troubles néonatals (–24,0) suivent la même tendance. Cela suggère des améliorations dans certains domaines de prévention, de prise en charge ou d'accès aux soins, même si ces pathologies restent parmi les principales causes de décès.

Certaines maladies non transmissibles montrent une évolution inverse. L'accident vasculaire cérébral (AVC), qui reste au 6e rang, voit sa mortalité augmenter légèrement (+2,8). La cardiopathie ischémique progresse de la 10e à la 7e place et enregistre une hausse plus marquée (+7,7), indiquant une montée en importance des maladies cardiovasculaires.

Deux évolutions attirent également l'attention : la rougeole, passant du 16e au 9e rang, voit sa mortalité augmenter (+5,4), ce qui pourrait refléter des interruptions vaccinales ou des flambées épidémiques. Les troubles maternels, bien qu'en baisse (–13,6), restent une cause importante de décès (8e rang). Enfin, la maladie pulmonaire obstructive chronique recule légèrement en mortalité (–0,7) et se situe désormais au 10e rang.

Globalement, le tableau révèle une transition épidémiologique en cours : les maladies transmissibles restent prédominantes mais tendent à diminuer, tandis que les blessures et certaines maladies non transmissibles prennent une importance croissante. Cette dynamique souligne la nécessité pour la RDC de renforcer simultanément la prévention des maladies infectieuses, la sécurité routière et la prise en charge des pathologies chroniques.

- **Facteurs de risques de mortalité et de perte des années de vie corrigées d'incapacité (AVCI)**

Tableau 6: Principales facteurs de risque de mortalité et des AVCI

Risques métaboliques
Risques environnementaux/professionnels
Risques comportementaux

Risque	2013 rang	2023 rang	Évolution du nombre des AVCI pour 100 000 habitants, entre 2013 et 2023
Malnutrition	1	1	↓ –6,851.7
Pollution de l'air	2	2	↓ –1,677.1
Risques professionnels	5	3	↓ –204.7
Haute tension artérielle systolique	6	4	↑ +320.5
Eau, hygiène et assainissement	3	5	↓ –2,458.2
Glycémie à jeun élevée	7	6	↑ +95.5
Risques alimentaires	8	7	↑ +270.3
Indice de masse corporelle élevé	10	8	↑ +279.8
Fonction rénale altérée	11	9	↑ +126.1
Rapports sexuels non protégés	4	10	↓ –1,235.1

Source : IHME 2025

Le tableau présente l'évolution des principaux facteurs de risque associés aux années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) en RDC entre 2013 et 2023. Il met en évidence une double dynamique : une amélioration notable de certains risques environnementaux et comportementaux, et une montée en importance de plusieurs risques métaboliques.

La malnutrition demeure le premier facteur de risque en RDC en 2023, comme en 2013. Toutefois, elle enregistre la plus forte baisse d'AVCI (–6 851,7 pour 100 000 habitants), ce qui suggère une amélioration significative, même si son poids relatif reste très élevé. La pollution de l'air, deuxième facteur de risque, montre également une diminution substantielle (–1 677,1), confirmant une tendance positive mais insuffisante pour modifier son classement.

Les risques professionnels progressent du 5e au 3e rang, malgré une réduction de leur impact (–204,7), ce qui indique que leur poids relatif dans la charge de morbidité augmente. De même, le risque lié à l'eau, l'hygiène et l'assainissement recule à la 5e place mais affiche une forte diminution d'AVCI (–2 458,2), témoignant d'améliorations dans l'accès aux services essentiels.

À l'inverse, plusieurs risques métaboliques connaissent une évolution défavorable. La haute tension artérielle systolique, passant du 6e au 4e rang, augmente fortement (+320,5), soulignant la montée des maladies cardiovasculaires. L'indice de masse corporelle élevé gagne deux places (du 10e au 8e rang) et augmente de +279,8, tandis que la glycémie à jeun élevée (+95,5) et la fonction rénale altérée (+126,1) suivent la même trajectoire ascendante. Ces évolutions témoignent d'une transition épidémiologique où les facteurs de risque non transmissibles prennent de l'importance.

Les risques alimentaires (8e → 7e) augmentent également (+270,3), renforçant la tendance vers des modes de vie moins sains. À l'inverse, les rapports sexuels non protégés voient leur impact fortement diminuer (–1 235,1) et régressent du 4e au 10e rang, ce qui pourrait refléter des progrès en matière de prévention des infections sexuellement transmissibles.

En résumé, le tableau montre une nette amélioration de plusieurs risques environnementaux et comportementaux, mais une aggravation préoccupante des risques métaboliques. Cette situation illustre une transition sanitaire où les déterminants des maladies non transmissibles deviennent de plus en plus importants, nécessitant des interventions ciblées en matière de prévention, de modes de vie et de prise en charge des maladies chroniques.

Encadré 2 : Des progrès considérables devront être réalisés dans le sens de la réduction du fardeau des maladies infectieuses (VIH/SIDA, maladies diarrhéiques, paludisme, tuberculose et les infections des voies respiratoires inferieures) et des maladies maternelles, néonatales infanto juvénile et nutritionnelles. A cela, il s'avère indispensable de converger les efforts vers des actions multisectorielles pour lutter contre la malnutrition, la pollution de l'air et l'eau, l'hygiène et l'assainissement.

2.1.3. Principales causes des décès maternels, néonatals, infanto-juvénile et des adolescents en RDC

Les causes de la mortalité maternelle sont dominées par des causes obstétricales directes telles que les hémorragies (25%), l'hypertension artérielle (16%), les avortements (10%), le sepsis (10%), les embolies (2%) et les autres causes directes ; les causes indirectes représentant 29%.[51]

La mortalité néonatale est due aux causes liées à la prématurité (42%), asphyxies (25%), les infections (14%) et autres (19%). En revanche, les causes de la mortalité infanto-juvénile sont dominées principalement par quatre maladies qui sont responsables de 77% de tous les décès des enfants de moins de 5 ans notamment la rougeole (29%), le paludisme (25%), les IRA (13%) et la diarrhée (10%). Il sied de noter que les décès des nouveau-nés comptent pour 33,9% du total des décès des enfants de moins de 5 ans.[52]

La mortalité des enfants âgés de 5 à 9 ans est dominée par le paludisme (27%), la rougeole (16%), la diarrhée (11%), les IRA (7%), et les autres (39%). Contrairement aux enfants de moins de 5 ans, la rougeole occupe la deuxième position après le paludisme montrant ainsi qu'elle est d'abord une maladie de la petite enfance.[53]

La mortalité des adolescents de 10 à 14 ans est dominée par le paludisme (29%), les MNT (16%), les IRA (11%), la diarrhée (7%), la noyade (4%), le VIH/SIDA (3%) et les autres (30%). Contrairement aux enfants de 5 à 9 ans, les MNT, la noyade et le VIH/SIDA deviennent des causes importantes de décès chez les jeunes adolescents.[54]

[51] https://data.unicef.org/countdown-2030/country/Democratic-Republic-of-the-Congo/1/ consulté le 11-12-2024
[52] Idem
[53] Idem
[54] Idem

La mortalité des adolescentes de 15 à 19 ans est dominée par les MNT (28%), automutilation (11%), les causes maternelles (8%), la tuberculose (8%), les néoplasmes (6%), les blessures (5%), les maladies digestives (5%), les violences (4%), le VIH/SIDA (3%) et les autres (22%). Contrairement aux jeunes adolescents de 10 à 14 ans, les causes maternelles apparaissent à cause des grossesses précoces pendant que les MNT, les violences et les accidents prennent une place importante.[55]

En revanche, la mortalité des adolescents de 15 à 19 ans est dominée par les MNT (14%), IRA (9%), la tuberculose (7%), les blessures (6%), les automutilations (6%), les violences (5%), les néoplasmes (4%), les maladies digestives (4%), les noyades (3%), le VIH/SIDA (2%) et les autres (40%). Les adolescentes et les adolescents âgés de 15 à 19 ans ont un tableau épidémiologique similaire à l'exception des causes maternelles chez les adolescentes.[56]

2.1.4. Tendance des années de vie corrigées de l'incapacité

Chaque année, il y a environ 37,5 millions d'années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) perdues en RDC. Les AVCI se calculent en faisant la somme des années de vie perdues et celles vécues avec incapacité. Entre 2000 et 2020, le nombre total d'AVCI perdues a baissé de 22% allant de 48,5 à 37,5 millions. La part des maladies transmissibles et pathologies associées à la grossesse, l'accouchement et la nutrition a diminué de 76% en 2000 à 53% en 2020 pendant que les MNT, les blessures et les cancers ont augmenté passant de 18%, 7% et 2% à 33%, 9% et 3% respectivement.

2.1.5. Maladies à potentiel épidémique et urgences de santé publique

Le profil épidémiologique des maladies à potentiel épidémique (MAPEPI) se présente comme suit : Le nombre des cas cumulés des MAPEPI notifié par les ESS de 2018 à 2022 est marqué par la Rougeole (655 464), le Choléra (108 061), la Méningite (41 664), la MPox (25 959), la PFA (14 265), etc. Outre cela, la pandémie de la Covid-19 a été signalée sporadiquement dans quelques provinces ces dernières années. Il a été aussi observé en 2023, après une certaine accalmie, une poursuite des notifications des cas de peste dans la province de l'Ituri depuis 2020. Le choléra qui était jadis cantonnée dans les zones endémiques à l'est du pays, a tendance à perdurer dans l'Ouest depuis plus de 6 ans.[57]

Par ailleurs, le pays a connu l'émergence et la réémergence de certaines maladies infectieuses sous forme d'épidémies telles que la MVE et actuellement la MPox déclaré comme urgences de santé publique de portée internationale (USPPI) qui sévit dans plusieurs provinces forestières où les RECO jouent un rôle important dans la surveillance et la vaccination dans les communautés. Les conflits armés et les déplacements de population sont également les principaux facteurs d'insécurité alimentaire.

- **Morbidité proportionnelle des MAPEPI**

Selon le rapport annuel 2023 de la DSE, le paludisme reste la pathologie qui vient en tête parmi les motifs de consultation avec 76% de cas, suivi des IRA (12%), de la grippe (5%), de la fièvre typhoïde 4% et enfin de la diarrhée avec déshydratation chez les enfants de moins de cinq ans (2%). Les autres maladies ont contribué à moins de 1%.[58]

[55] Idem
[56] Idem
[57] Direction de la Surveillance épidémiologique-RDC, Rapport annuel 2023 des activités. Kinshasa, avril 2023.
[58] Idem

- **Mortalité proportionnelle des MAPEPI**

Le paludisme constitue la première cause de décès avec 60% suivi de la rougeole (21%), des IRA (5%), de diarrhée avec déshydratation chez les enfants de moins de 5 ans (4%), de la fièvre typhoïde (2%), la méningite (2%) et le choléra (2%). Les autres MAPEPI ont contribué à 4% des décès.[59]

- **Létalités globales des MAPEPI**

La maladie à virus d'Ebola (MVE) était la pathologie la plus meurtrière en 2023 avec une létalité très élevée, suivie de Tétanos néonatal avec 45%, de la rage avec 8,7%, de la méningite avec 7,5%, de la Mpox avec 4%, de la peste avec 2,45%, de la fièvre jaune avec 2,33%, de la rougeole avec 1,33% et enfin, des autres pathologies avec moins de 1%. Nous signalons qu'il a été déclaré la Mpox et la rougeole comme des urgences de santé publique de portée internationale et les activités dans ce cadre ont amélioré la surveillance et la notification autour de ces deux maladies.[60]

- **Surveillance à base communautaire des MAPEPI**

La surveillance à base communautaire est un processus actif de participation communautaire dans la détection, la notification, la réponse et le suivi relatifs aux événements de santé dans la communauté. Pour assurer une surveillance continue entre l'information sanitaire et le processus d'amélioration de la qualité des soins depuis la communauté jusqu'au niveau central, la RDC surveille prioritairement 41 maladies et état de santé. Mais ces dernières années, le pays a connu l'émergence et la réémergence de certaines maladies infectieuses sous forme d'épidémies. En effet, étant donné son écosystème complexe et extrêmement varié, la RDC connaît très souvent d'épisode d'épidémies des zoonoses.

De 1976 à ce jour, le pays a connu 15 épidémies de la maladie à virus Ebola dont la plus meurtrière, la dixièmieme (août 2018) à l'Est du pays a duré 2 années et fait 3 481 cas confirmés et probables dont 2299 décès selon les données rapportées dans la base des données de l'épidémie. A ce jour, le pays traverse une situation particulièreLe MPox, une autre maladie zoonotique, longtemps endémique dans certaines provinces du pays, connaît aujourd'hui une expansion dans des provinces jusque-là exemptées. L'expansion rapide de cette zoonose a conduit l'OMS à la déclarer comme une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

Ces différents épisodes des zoonoses sont notamment la résultante d'une faible opérationnalisation du système de surveillance à base communautaire de ces pathologies dans leur secteur d'origine à savoir la faune domestique et sauvage. En effet, le système de surveillance de la santé humaine ne détecte ces pathologies qu'une fois que celles-ci ont atteint les humains. Il est donc primordial pour le pays d'étendre ce système de surveillance communautaire aux zoonoses prioritaires en renforçant la mise en œuvre de l'approche « Une santé » au niveau de la communauté.

Outre la surveillance communautaire des maladies évitables par la vaccination (PFA, Rougeole, ...) et d'autres situations d'urgence, la RDC a fait du décès maternel et périnatal des événements à déclaration obligatoire et une priorité nationale en implémentant depuis 2015 la Surveillance des décès maternels, périnatals et riposte (SDMPR) dans le dispositif existant de la surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR).

Globalement, les méthodes de notification des décès pour toutes les MAPEPI dépendent du niveau de développement du système d'information et de communication, selon le contexte

[59] Idem
[60] Idem

(Radiophonie, téléphone, internet). Pourtant, dans les milieux reculés, la transmission de l'information se fait par les RECO à travers un message verbal ou une correspondance.

L'analyse situationnelle de la surveillance des décès maternels et périnatals à travers la notification au cours des dernières années (2020, 2021 et 2022)[61] a montré ce qui suit :

- Sur un total de 6 995 décès maternels notifiés, 4 196 décès maternels, soit 60% ont été notifiés au niveau de la communauté, une proportion largement supérieure à celle des ESS qui n'a été que de 2756. Et, tenant compte des estimations du ratio de mortalité maternelle à 547 pour 100 000 NV[62], les projections de décès maternels se situeraient à 22 865 par an ; soit une proportion de décès maternels notifiés de 31%.
- Cependant, pour les décès périnatals, il a été notifié 68 671 en 2022, tous au niveau des ESS. La quasi-totalité des organes communautaires sont restés silencieux.

Encadré 3 : Etant donné que la RDC, à cause de son écosystème, est particulièrement exposée aux zoonoses, il est important de mettre en place un système efficace de surveillance des maladies y compris celles de la faune domestique et sauvage ainsi que des facteurs environnementaux et climatiques dans lequel la communauté devrait jouer un rôle primordial. Considérant que c'est dans la communauté où se trouvent ces maladies que surviennent plus de 80% des décès, celle-ci représente la source d'information épidémiologique. Il est donc impérieux de focaliser les actions portant sur entre autres la consolidation de la surveillance à base communautaire à travers le renforcement des capacités des acteurs communautaires sur les alertes et la notification des cas, sur la recherche active des cas, le suivi des contacts ainsi que sur la communication des risques et l'engagement communautaire, etc.

2.1.6. Situation des maladies non transmissibles

Selon l'OMS, les MNT sont responsables de 23% des décès en RDC, ce qui est relativement bas comparé à d'autres régions du monde mais reste significatif.[63] Ces maladies sont essentiellement : les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, les maladies rénales chroniques, les maladies néoplasiques (le cancer) et les maladies respiratoires chroniques.

A ce jour, il n'y a pas encore de résultats d'une enquête nationale de type Step-Wise de l'OMS pour la mesure des risques cardio-vasculaires et métaboliques. Les résultats de l'EDS 2013-2014 indiquent que 9% de femmes de 15-49 ans, 14% d'hommes de 15-49 ans et 29% d'hommes de 50-59 ans ont été classés comme ayant de l'hypertension. S'agissant du diabète sucré, la même source indique que 4% de femmes âgées de 15-49 ans et d'hommes de 15-49 ans ainsi que 10% d'hommes de 50-59 ans ont été classés comme étant diabétiques.

2.1.7. Situation des personnes en situation de handicap

En RDC, l'absence des études nationales approfondies et d'une documentation appropriée sur le handicap, rend difficile l'appréhension de la problématique posée par les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap représenteraient environ 18% de la population de la RDC. Cette situation se justifie par plusieurs facteurs notamment les conflits armés à répétition et la résurgence des maladies handicapantes.[64]

[61] Programme national de Santé de la reproduction-RDC : Rapport annuel 2022 de la SDMPR, 2023.
[62] WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNIDESA/Population Division, report trends in maternel mortality 2000 to 2020
[63] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9575352/ Consulté le 30-01-2025
[64] http://rodra.co.za/countries/drc/49-countries/drc/182-revised-country-report-republique-democratique-du-congo-rdc-2019#:~:text=1.3%20Quel%20est%20le%20nombre,la%20population%20de%20la%20RDC. Consulté le 09-12-2024

Les personnes en situation de handicap en RDC font face à plusieurs défis :

- **Exclusion Sociale** : Elles sont souvent confrontées à une exclusion sociale profonde, avec plus de 85% d'entre elles sans emploi.[65]
- **Pauvreté** : Un risque accru de pauvreté monétaire affecte ces individus, aggravant leur vulnérabilité ;
- **Accès Limité aux Services** : Les services publics tels que les soins médicaux sont difficilement accessibles pour cette population. Une étude a montré que seulement une petite proportion bénéficie d'une réadaptation ou même d'une visite médicale régulière.[66]

2.1.8. Situation de la santé mentale

La RDC est confrontée à une crise de santé mentale aux proportions alarmantes. Environ 20 millions de Congolais souffrent de problèmes de santé mentale. Ce chiffre représente un défi majeur pour le système de santé du pays, d'autant plus que la couverture sanitaire pour les personnes atteintes de troubles mentaux reste extrêmement faible, à peine 5%.[67] Les troubles courants incluent la schizophrénie, les dépressions, les psychoses puerpérales et chroniques, ainsi que des troubles neurologiques comme l'épilepsie.[68] Par ailleurs, les conflits armés, la violence et les crises humanitaires qui ont secoué la RDC pendant des décennies ont laissé des cicatrices profondes sur la santé mentale de la population.[69]

Il existe une insuffisance significative d'infrastructures médicales spécialisées et un manque criant de psychiatres et autres professionnels formés en psychiatrie.[70] Les personnes souffrant de troubles mentaux sont souvent marginalisées et exclues de leur communauté, ce qui les empêche de rechercher l'aide dont elles ont besoin.

2.1.9. Situation des maladies tropicales négligées (MTN)

La situation des MTN en RDC est particulièrement préoccupante. Ces maladies affectent principalement les populations pauvres et marginalisées dans les zones rurales. Ces maladies entraînent des conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices. Elles sont souvent associées à un manque d'accès aux soins de santé adéquats.[71]

Il s'agit de la filariose lymphatique, les géo-helminthiases, l'onchocercose, les loase, schistosomiases, le trachome, la dracunculose, les leishmanioses et la lèpre, la peste bubonique/pneumonique/septicémique, le pian, la rage animale/humaine, la trypanosomiase humaine africaine et l'ulcère de Buruli et Noma.

2.1.10. Situation des maladies cancéreuses

La situation des maladies cancéreuses en RDC est marquée par une incidence croissante et une mortalité élevée. En 2022, environ 48 839 nouveaux cas de cancer ont été recensés, avec environ

[65] https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/243876/1/handicap%20bayonne%20daniel-ac-ak%202019.pdf
[66] https://fundinnovation.dev/projects/application-jeunes-situation-handicap-republique-democratique-du-congo Consulté le 30-01-2025
[67] https://www.radiookapi.net/2023/10/09/actualite/sante/environ-20-millions-de-congolais-souffrent-des-problemes-de-sante-mentale Consulté le 31-01-2025
[68] https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2023-01/kinshasa-rdc-centre-telema-malades-mentaux-soeurs-hospitalieres.html Consulté le 31-01-2025
[69] https://www.refugeecouncil.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Kongo_DR_Kinshasa/180619-drc-psych-erkrankungen-f.pdf
[70] https://www.alternatives-humanitaires.org/fr/2023/03/21/champs-dexclusion-masculinite-et-sante-mentale-en-republique-democratique-du-congo/ Consulté le 31-01-2025
[71] https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/neglected-tropical-diseases Consulté le 31-01-2025

34 812 décès attribués aux cancers.[72] Les cancers les plus fréquents incluent ceux du col de l'utérus, de la prostate, des seins, du foie et le cancer colorectal.[73]

2.1.11. Situation de la drépanocytose

La RDC compte entre 25% et 30% de porteurs du gène drépanocytaire (hétérozygotes AS) et environ 2% à 3% des nouveau-nés sont homozygotes SS, ce qui signifie qu'ils ont la forme sévère de la maladie.[74,75] Environ 50000 nouveau-nés sont touchés chaque année par cette forme sévère.[76]

Le manque de sensibilisation à la drépanocytose, le manque de ressources pour le dépistage et le traitement, ainsi que les obstacles culturels et socio-économiques contribuent à la faible prise en charge de la maladie en RDC. Le système sanitaire congolais souffre d'une faible couverture, ce qui limite l'accès aux soins pour les patients drépanocytaires.[77]

2.1.12. Situation de la couverture santé universelle en RDC

Le système de la CSU a été institué dans l'article 41 de l'Ordonnance-Loi n°23/006 du 03 mars 2023 modifiant et complétant la Loi n°18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique. Il se fonde sur les principes d'équité, d'assurance qualité des soins et de protection financière pour tous.

L'analyse de la situation de la CSU porte sur l'accès aux services, aux médicaments et aux vaccins essentiels de qualité et sur la protection contre les risques financiers qui sont exprimés respectivement par l'indice de couverture des services ou indice CSU (ODD 3.8.1) et l'incidence des dépenses catastrophiques en santé (ODD 3.8.2).

- **Indice de couverture des services de la CSU**

Le tableau ci-dessous présente la situation de la RDC sur les couvertures des services de santé essentiels de CSU. Ces couvertures, appelées « indice de la CSU » sont exprimées sous forme d'un score moyen de 14 indicateurs regroupés en 4 domaines.

[72] https://www.radiookapi.net/2023/02/04/actualite/sante/rdc-environ-34-812-deces-recenses-la-suite-des-cancers-en-2022 Consulté le 31-01-2025
[73] https://africa.biogaran.com/nos-actualites/lancement/biogaran-lance-ses-activites-a-lubumbashi-rdc/ Consulté le 31-05-2025
[74] https://www.cliniquesuniversitairekinshasa.net/2024/11/22/protocole-national-de-prise-en-charge-de-la-drepanocytose-en-rd-congo/ Consulté le 31-01-2025
[75] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8017361/ Consulté le 31-01-2025
[76] https://www.fondationpierrefabre.org/fr/programmes-en-cours/lutte-contre-la-drepanocytose/soutien-de-lunite-de-prise-en-charge-de-la-drepanocytose-du-centre-hospitalier-monkole/ Consulté le 31-01-2025
[77] file:///C:/Users/lubua/Downloads/TheseBenoitMBIYAMukinayi%20(1).pdf

Tableau 7: Composante de l'indice de couverture universelle des services de santé en RDC

Composante de l'indice de couverture universelle des services de santé		RDC-2019	RDC-2021
Santé reproductive et santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant	Demande satisfaite par une méthode moderne chez les femmes de 15 à 49 ans mariées ou vivant maritalement (%)	26	28
	Soins prénatals, quatre consultations ou plus (4CPN) (%)	52	56
	Les enfants de 1 an qui ont reçu 3 doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC3), (%)	57	65
	Comportement de recherche de soins pour les enfants suspectés de pneumonie (%)	34	34
	Total composante	40	43
Maladies infectieuses	Couverture thérapeutique eective contre la tuberculose (%)	63	70
	Personnes vivant avec le VIH recevant la thérapie antirétrovirale (TAR) (%)	64	≥80
	Population à risque dormant sous moustiquaires imprégnées d'insecticide (%)	56	58
	Ménages ayant au moins accès à des services d'assainissement de base (%)	16	16
	Total composante	44	48
Maladies non transmissibles	Prévalence de la tension artérielle normale, quelque soit le stade du traitement (%)	43	26
	Glucose plasmatique à jeun moyen (GPJ), (mmol/L)	≥80	≥80
	Adultes âgés d'au moins 15 ans non fumeurs de tabac depuis 30 jours (%)	≥80	≥80
	Total composante	70	60
Capacité des services et accès	Lits d'hôpitaux par habitant (avec utilisation d'un seuil)	44	44
	Professionnels de la santé par habitant (avec utilisation d'un seuil): médecins, psychiatres et chirurgiens	4	8
	Indice des principales capacités requises en vertu du Règlement sanitaire international	35	43
	Total composante	18	24
Indice de couverture des services de la CSU (ODD 3.8.1.)		**40**	**42**

Source : ICHESS, à partir des données du rapport OMS-CSU 2023

L'analyse de l'Indice de Couverture Universelle des Services de Santé (CSU) en RDC entre 2019 et 2021 révèle une progression très lente (de 40 à 42), masquant des dynamiques contrastées. Les domaines de la santé reproductive et infantile (40 à 43) et, surtout, des maladies infectieuses (44 à 48) ont connu des améliorations notables, suggérant une efficacité accrue dans la mise en œuvre de programmes verticaux pour le traitement du VIH/tuberculose et les soins préventifs de base. Cependant, le succès global est miné par une régression critique dans la composante des maladies non transmissibles (MNT), dont le score a chuté de façon alarmante de 70 à 60. Cette baisse significative est le signal d'un défaut de stratégie dans la gestion et le dépistage des affections chroniques, risquant de créer une charge de morbidité future non gérée.

Le principal obstacle structurel à l'atteinte de la CSU reste la capacité des services et l'accès, qui, malgré un gain de 6 points, stagne à un niveau extrêmement bas (24 en 2021). Ce score est le reflet direct du déficit chronique en ressources humaines qualifiées (médecins, chirurgiens) et en infrastructures de santé, constituant le goulot d'étranglement fondamental pour l'extension et la pérennité des soins. Pour accélérer l'atteinte de la CSU, la RDC doit impérativement rééquilibrer ses priorités en intégrant la gestion des MNT et en orientant massivement les investissements vers le renforcement des capacités et du personnel au niveau des soins de santé primaires.

Tableau 8: Evolution de l'indice de CSU en RDC

Pays/Region	Indice de couverture universelle des services de santé							$\bar{X}$ taux de variation annuel de l'indice			
	2000	2005	2010	2015	2017	2019	2021	2000-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2021
RDC	**21**	**23**	**30**	**37**	**40**	**40**	**42**	**1,8%**	**5,5%**	**4,3%**	**2,1%**
Global	45	50	58	65	67	68	68	2,1%	3,0%	2,3%	0,8%
Afrique	23	28	36	42	44	45	44	4,0%	5,2%	3,1%	0,8%
Afrique sub-saharienne	22	26	35	41	42	43	43	3,4%	6,1%	3,2%	0,8%
Angola	21	24	31	36	40	39	37	2,7%	5,3%	3,0%	0,5%
Burundi	19	24	33	40	40	42	41	4,8%	6,6%	3,9%	0,4%
RCA	18	19	26	30	30	31	32	1,1%	6,5%	2,9%	1,1%
Congo Brazzaville	21	25	30	38	36	39	41	3,5%	3,7%	4,8%	1,3%
Rwanda	19	26	39	44	48	47	49	6,5%	8,5%	2,4%	1,8%
Sounda du sud	18	19	23	27	30	31	34	1,1%	3,9%	3,3%	3,9%
Ouganda	22	28	36	43	46	48	49	4,9%	5,2%	3,6%	2,2%
Tanzanie	20	23	33	38	40	42	43	2,8%	7,5%	2,9%	2,1%
Zambie	28	34	45	52	53	54	56	4,0%	5,8%	2,9%	1,2%

Source : ICHESS, à partir des données de la BM 2024

La RDC améliore son indice de CSU mais reste encore faible et la vitesse est en décélération depuis 2011. Elle a un indice inférieur au niveau global, à l'Afrique et à l'Afrique subsaharienne. Comparativement à la plupart de ses voisins, l'indice de la RDC est parmi les plus faibles.

Tableau 9: Tendance de l'indice de CSU en RDC

Pays/Region	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
RDC	**45**	**46**	**47**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
Global	73	75	76	77	78	79,7	81	82
Afrique	50	51	52	53	55	56	57	58
Afrique sub-saharienne	49	50	51	52	53	54	56	57
Angola	43	44	45	46	47	48	49	50
Burundi	47	49	50	51	52	54	55	56
RCA	35	36	36	37	38	39	39,6	40
Congo Brazzaville	43	44	45	46	47	48	49	50
Rwanda	56	57	59	60	62	64	65	67
Soudan du sud	34	35	35	36	37	38	39	39
Ouganda	54	55	56	58	59	60	62	63
Tanzanie	47	49	50	51	52	53	55	56
Zambie	62	63	65	66	67	69	70	72

La modélisation de la tendance de l'indice de CSU indique une faible amélioration de cette dernière pour la RDC.

En effet, elle devrait demeurer au jaune, alors que certains de ses voisins passeraient en vert.

Source : ICHESS, modélisation à partir des données de la BM 2024

Depuis quelques années, la RDC continue à améliorer légèrement son indice de CSU mais ce dernier reste encore faible. Pour atteindre l'indice de CSU à 80 d'ici 2030, le pays doit accélérer son rythme en atteignant une moyenne de taux de variation annuel de 8,1% entre 2024 et 2030 (soit 4 fois la vitesse actuelle). Ce qui nécessite de renforcer la participation à travers l'engagement de la communauté dans leur responsabilisation à la mise en œuvre des interventions à base communautaire en vue d'assurer le continuum des soins et améliorer les prestations des services.

Selon une étude menée dans 4 provinces sur "Enjeux et défis de CSU en RDC"[78], il est noté que les trois facteurs couplés (caractère volontaire, faible niveau de revenu, prélèvements sur des rémunérations généralement basses) peuvent rendre hypothétique l'accroissement substantiel de la couverture des populations. Outre cela, l'enquête MICS 2018 a montré que la proportion des populations couvertes par un système d'assurance maladie est faible (à moins de 5%).[79]

- **Dépenses catastrophiques en santé**

Le graphique ci-dessous présente la tendance des dépenses de santé des ménages supérieures à 10% du budget total des ménages (dépenses catastrophiques), en effet selon les estimations de l'OMS, les ménages congolais dépenseraient le gros de leurs revenus dans la santé, ce qui a pour conséquence d'accentuation de la paupérisation de la population.

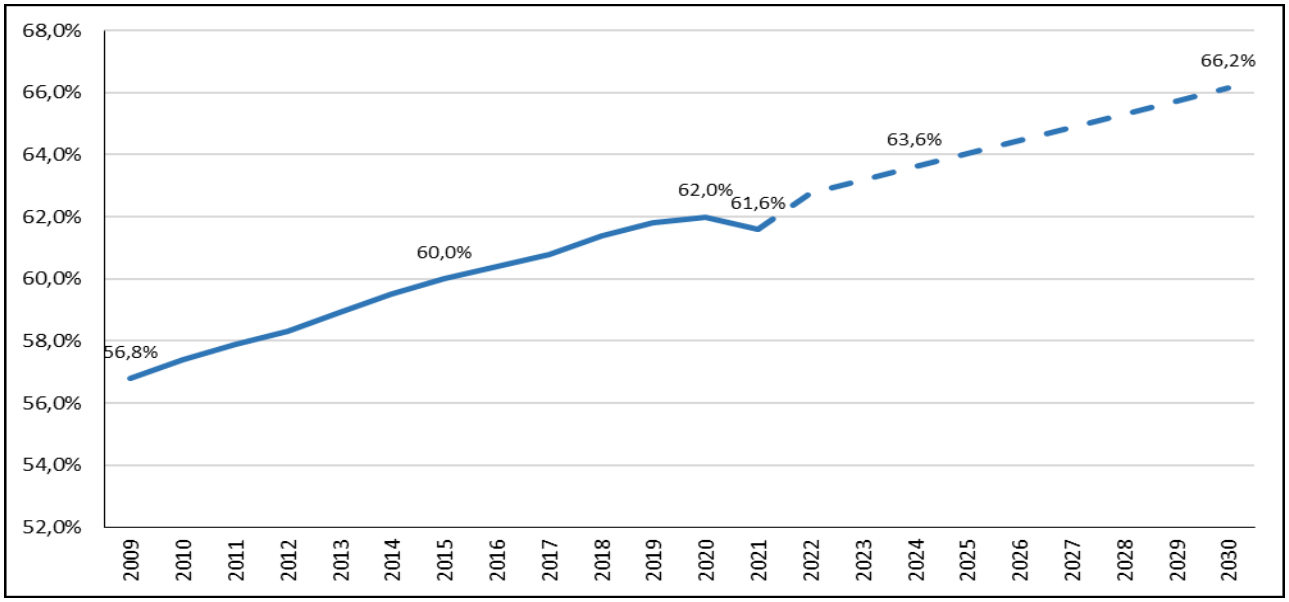


Figure 9: Tendance de la population des ménages avec des dépenses de santé à au moins 10% du budget total des ménages

Source : ICHESS, à partir des données de l'OMS 2024

[78] Jean-Bosco Kahindo M. et coll. Enjeux et défis de couverture santé universelle en RD Congo : Synthèse critique interprétative de la littérature. International Journal of Innovation and Scientific Research ISSN 2351-8014 Vol. 66 No. 1 Apr. 2023, pp. 42-56. http://www.ijisr.issr-journals.org/

[79] Ministère du Plan, Ministère de la Santé Publique. "Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS-Palu 2018" : Rapport final. Kinshasa, Décembre 2019.

- **Dépenses de santé et sources de financement**

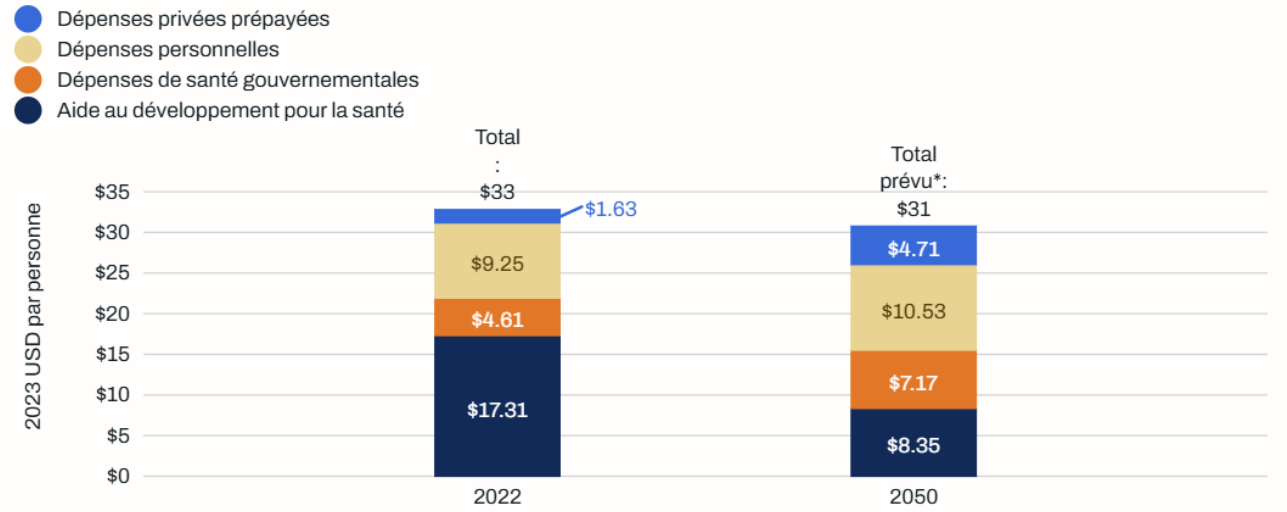


Figure 10: Dépenses de santé et sources de financement

Source : IHME 2025

Les dépenses de santé en RDC restent largement dominées par l'aide au développement pour la santé, qui constitue en 2022 la plus grande part du financement avec 17,31 USD par personne. Les dépenses personnelles représentent la deuxième source la plus importante (9,25 USD), suivies des dépenses de santé gouvernementales (4,61 USD). Les dépenses privées prépayées demeurent marginales (1,63 USD). Au total, les dépenses de santé atteignent 33 USD par personne en 2022.

Selon les projections pour 2050, cette structure de financement devrait se maintenir. Bien que les montants varient légèrement, l'aide extérieure resterait significativement élevée (8,35 USD par personne), tandis que les dépenses personnelles continueraient d'occuper une place importante (10,53 USD). Les dépenses gouvernementales augmenteraient à 7,17 USD, et les dépenses privées prépayées à 4,71 USD. La dépense totale projetée pour 2050 est de 31 USD par personne.

Ainsi, le graphique montre que la RDC restera, même à l'horizon 2050, fortement dépendante de l'aide extérieure, alors que les ménages continueront d'assumer une part notable du financement de la santé.

Encadré 4 : Il est nécessaire d'adapter le système de financement basé sur les mutuelles de santé communautaires comme levier pour progresser vers la CSU en développant des intervention sur (i) la sensibilisation des collectivités locales capables de capter les informations sur les ressources allouées à la santé, (ii) l'augmentation de la participation communautaire dans les actions de l'offre et de l'accès des services essentiels de santé ainsi que dans l'utilisation et la qualité des services, (iii) l'extension des mutuelles de santé existantes et leur professionnalisation, (iv) la promotion des unions et des fédérations des mutuelles de santé, (v) l'accroissement des investissements en santé et des subsides de fonctionnement des services de santé.

D'où la nécessité de renforcer les services de santé en mettant en place des stratégies d'accréditation ou d'autres stratégies innovantes telles que l'approche « village santé » que la RDC est appelée à expérimenter.

2.1.13. Disponibilité du personnel de santé

Tableau 10: Disponibilité du personnel de santé

Densité de personnel de santé	Densité	Année	Source
Densité des infirmiers et de sages-femmes (pour 1000 habitants)	1,19	2022	OMS
Densité des médecins (pour 1000 habitants)	0,19	2022	OMS
Densité des dentistes (pour 1000 habitants)	0,004	2022	OMS
Densité des pharmaciens (pour 1000 habitants)	0,0081	2022	OMS

La RDC a une densité en personnel de santé globalement faible. En effet, pour les SSP, la densité minimale recommandée par l'OMS est de 2,3 médecins, personnels infirmiers et sages-femmes pour 1000 habitants, alors que pour la CSU, la densité minimale recommandée est de 4,45. S'agissant de la repartition de ces professionnels de santé, il s'observe une tendance pléthorique des médecins et infirmiers dans les centres urbains, tandis que les milieux ruraux accusent souvent des déficits en personnel soignant.

2.1.14. Couverture sanitaire

La couverture sanitaire en ESS est estimée à 30%, cela veut dire qu'environ 60 000 000 des Congolais parcourent plus de 5 Km pour avoir accès au centre de santé le plus proche qui réponde plus ou moins aux normes en infrastructures et équipements médico-sanitaires.[80]

2.1.15. Analyse des interventions prioritaires

- **Santé de la reproduction**

Tableau 11: Analyse des interventions de la santé de la reproduction

Santé de la reproduction	Donnée EDS 2023-2024
Fécondité	
Indice Synthétique de Fécondité exprimé pour une femme (ISF)	5,5
Taux Global de Fécondité Générale exprimé pour 1 000 femmes de 15–44 ans (TGFG)	181
Taux Brut de Natalité exprimé pour 1 000 individus (TBN)	35,7
Planification familiale	
Prévalence contraceptive moderne chez les femmes en union (en %)	10,7
Prévalence contraceptive moderne chez les femmes non en union et sexuellement actives (en %)	23,6
Demande totale en planification familiale chez les femmes en union (en %)	50,6
Demande totale en planification familiale chez les femmes non en union et sexuellement actives (en %)	85,3
Soins prénatals	
Au moins une consultation prénatale (CPN 1) pour les NV et les mort-nés (en %)	83,4
Au moins quatre consultation prénatale (CPN 4) pour les NV et les mort-nés (%)	44,6
Accouchement et soins postnatals	
Accouchement par un prestataire qualifié pour les NV et les mort-nés (en %)	84,8
Accouchement s'est déroulé dans un ESS pour les NV et les mort-nés (en %)	83,1
Reçu des soins postnatals dans les 2 jours après la naissance pour les NV et les mort-nés (en %)	29,2

[80] Plan stratégique national pour la CSU 2020-2030

- **Vaccination des enfants**

La vaccination des enfants se dégrade de plus en plus en RDC. En effet, en comparant les différents résultats des trois dernières EDS, on constate que la proportion des enfants âgés de 12 à 23 mois complètement vaccinés est actuellement plus faible qu'en 2007 et l'évolution de la proportion des enfants de 12 à 23 mois n'ayant reçu aucun vaccin se fait en dents de scie.

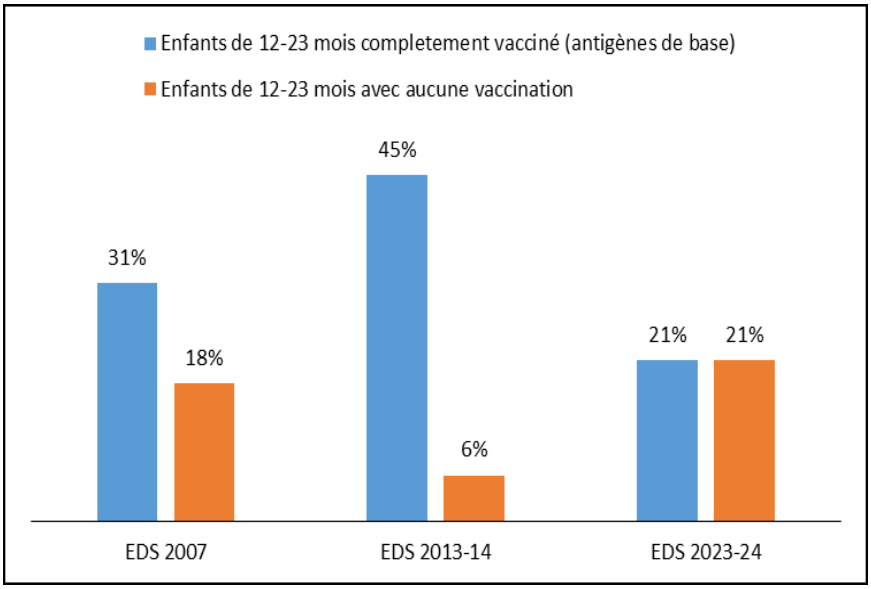


Figure 11: Vaccination des enfants

- **Recherche de soins et traitement des maladies des enfants**

Tableau 12: Recherche de soins et traitement des maladies des enfants

Maladies tueuses des enfants		Donnée EDS 2023-2024
IRA	Proportion d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes des IRA	2%
	Recherche des conseils ou traitement enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA	60%
Fièvre	Proportion d'enfants de moins de 5 ans avec fièvre	20%
	Recherche des conseils ou traitement parmi les enfants de moins de 5 ans avec fièvre	51%
Diarrhée	Proportion d'enfants de moins de 5 ans avec diarrhée	14%
	Recherche des conseils ou traitement parmi les enfants de moins de 5 ans avec diarrhée	45%
	Prise en charge de la diarrhée par le SRO	39%
	Prise en charge de la diarrhée par le zinc	9%
	Prise en charge de la diarrhée par le SRO + zinc	6%

- **État nutritionnel des enfants**

Au regard des résultats des différentes EDS, l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans ne s'est pas amélioré. Presque un enfant sur deux, souffre de la malnutrition chronique. Le retard de croissance est resté quasi-stagnant, il en est de même de l'émaciation et de l'excès pondéral.

En outre, les carences en vitamines et minéraux sont répandues en RDC.

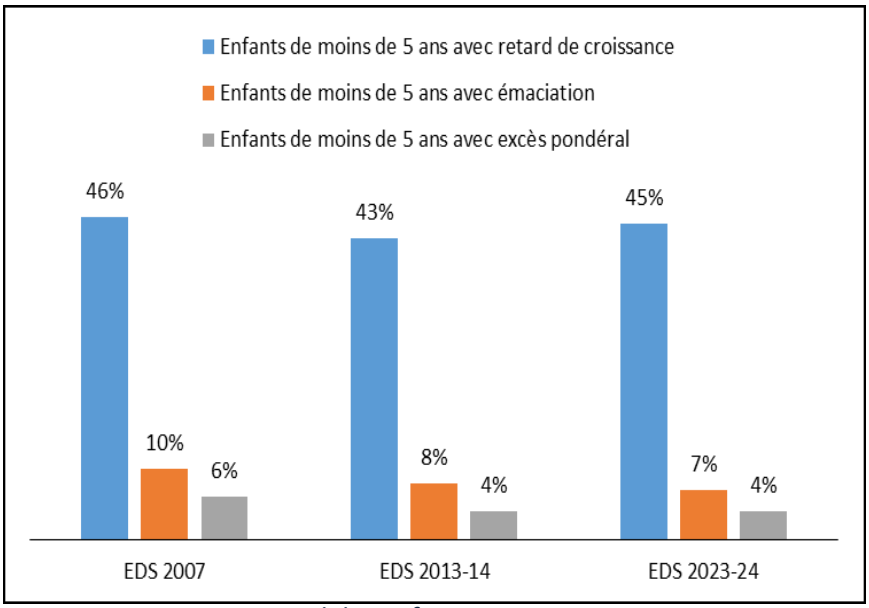


Figure 12: Etat nutritionnel des enfants

Selon les données de DRC National Anemia Profile, 59,8% des enfants de 6 à 59 mois en RDC souffrent de carences en fer, du fait combiné de causes nutritionnelles (régime alimentaire pauvre en fer, ou en vitamines B9 et B12), de causes sanitaires (paludisme, parasitoses intestinales, infections aigues, maladies chroniques telles que le cancer, le VIH, la tuberculose, ...) et de troubles physiologiques inhibiteurs de l'absorption du fer. La carence en zinc est également préoccupante en RDC, touchant environ 50% des enfants de 6 à 59 mois, selon l'enquête MICS de 2017-2018.

- **Alimentation du nourrisson et du jeune enfant**

Tableau 13: Alimentation du nourrisson et du jeune enfant

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE)	Donnée EDS 2023-2024
Enfants nés au cours des 2 dernières années qui ont été mis au sein dans l'heure qui a suivi la naissance	53,2 %
Enfants de 0–5 mois exclusivement nourris au lait maternel durant le jour précédent	52,5 %
Enfants de 6–23 mois ayant reçu des aliments et des liquides d'au moins 5 des 8 groupes d'aliments définis le jour précédent (en %)	13,9 %
Enfants de 6–23 mois qui ont reçu des boissons sucrées le jour précédent (en %)	21 %
Enfants de 6–23 mois nourris avec des aliments malsains le jour précédent (en %)	14,7 %

- **Prevention du Paludisme**

Tableau 14: Prevention du paludisme

Paludisme	Donnée EDS 2023-2024
Ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)	69 %
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview	57 %
Femmes enceintes de 15–49 ans dans tous les ménages dans tous les ménages ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview	60,4 %
Parmi les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance et/ou un mort-né au cours des deux années précédant l'enquête, avec au moins une dose de SP/Fansidar (traitement préventif intermittent (TPI) pendant la grossesse)	64 %
Parmi les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance et/ou un mort-né au cours des deux années précédant l'enquête, avec au moins deux doses de SP/Fansidar (traitement préventif intermittent (TPI) pendant la grossesse)	43,4 %
Parmi les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance et/ou un mort-né au cours des deux années précédant l'enquête, avec au moins trois doses de SP/Fansidar (traitement préventif intermittent (TPI) pendant la grossesse)	21,8 %

2.1.16. Analyse situationnelle du système de santé communautaire

- **Maturité du système de santé communautaire**

La maturité actuelle du système de santé communautaire en RDC est exprimée par le niveau de fonctionnalité globale de ce système constitué des éléments constitutifs dénommés « domaines » et dont les résultats détaillés sont affichés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 15 : Niveau de fonctionnalité du système de santé communautaire de la RDC par domaine.

Domaines du système de santé communautaire	Performance (en %)		Niveau de fonctionnalité
	Couverture	Goulot absolu	
Gouvernance et leadership en santé communautaire	72%	28%	Fonctionnel
Ressources humaines en santé communautaire	62%	28%	Fonctionnel
Gestion de la chaine d'approvisionnement en santé communautaire	73%	27%	Fonctionnel
Système d'information de santé communautaire	67%	33%	Fonctionnel
Communication sur les risques, engagement et mobilisation sociale en santé communautaire	76%	24%	Fonctionnel
Prestation de services de santé communautaire	83%	17%	Fonctionnel
Financement du système de santé communautaire	40%	60%	Partiellement fonctionnel
Niveau global de fonctionnalité du système de santé communautaire en RDC	**68%**	**32%**	**Fonctionnel**

Source : ICHESS, Rapport d'évaluation du PSN SACO 2019-2022.

L'analyse de la situation du système de santé communautaire de la RDC a montré une fonctionnalité avec un score de disponibilité de 68%. Ceci dénote que malgré des goulots mineurs, il existe, dans certaines composantes de bonnes pratiques à capitaliser pour la consolidation du cadre stratégique de ce nouveau plan stratégique.

Par ailleurs, il est évident que le financement du système de santé communautaire présente une faible fonctionnalité avec un goulot absolu évalué à 60%. Cette situation souligne l'importance d'une coordination efficace des interventions en santé communautaire (gouvernement, partenaires, organisations de la société civile) dans la perspective d'un « plan unique, budget unique… » et traduit deux grandes faiblesses du financement du système de santé communautaire notamment :

- La contribution quasi inexistante de la partie gouvernementale (Centrale, provinciale et ETD) comme source indispensable de financement dans les appuis budgétaires des interventions de la SACO. Ce qui pourrait entraver la mise en œuvre des interventions essentielles pour l'atteinte des cibles de la CSU ;
- Le faible alignement des appuis des partenaires au développement destinés aux priorités du pays en matière de la santé communautaire où plusieurs mécanismes de gestion et d'approches de mise en œuvre sont utilisés ; ce qui a rendu difficile le suivi de leur décaissement et l'évaluation en termes des résultats attendus.

Il ressort des informations fournies une panoplie d'actions découlant des stratégies de mitigation pour remédier aux faiblesses constatées pour chaque domaine de la santé communautaire.

- **Disponibilité des SSC et ASC (RECOSITE)**

Tableau 16: Besoin et Nombre de SSC existants

Province		Besoin en SSC	SSC existants		Gap	
			Nbre	%	Nbre	%
Bas Uele		1 066	390	36,6%	676	63,4%
Equateur		1 703	517	30,4%	1 186	69,6%
Haut katanga		2 336	241	10,3%	2 095	89,7%
Haut Lomami		2 202	359	16,3%	1 843	83,7%
Haut Uele		1 484	512	34,5%	972	65,5%
Ituri		1 846	903	48,9%	943	51,1%
Kasaï		3 309	67	2,0%	3 242	98,0%
Kasaï Central		3 571	447	12,5%	3 124	87,5%
Kasaï Oriental		1 606	370	23,0%	1 236	77,0%
Kinshasa		311	345	110,9%	-34	-10,9%
Kongo Central		1 627	412	25,3%	1 215	74,7%
Kwango		2 096	203	9,7%	1 893	90,3%
Kwilu		2 148	447	20,8%	1 701	79,2%
Lomami		1 289	314	24,4%	975	75,6%
Lualaba		1 763	202	11,5%	1 561	88,5%
Mai Ndombe		987	244	24,7%	743	75,3%
Maniema		933	505	54,1%	428	45,9%
Mongala		1 275	368	28,9%	907	71,1%
Nord Kivu		1 970	328	16,6%	1642	83,4%
Nord Ubangi		1 013	165	16,3%	848	83,7%
Sankuru		1 665	379	22,8%	1286	77,2%
Sud Kivu		4 660	237	5,1%	4423	94,9%
Sud Ubangi		2 294	459	20,0%	1835	80,0%
Tanganyika		2 780	869	31,3%	1911	68,7%
Tshopo		1 534	620	40,4%	914	59,6%
Tshuapa		1 438	209	14,5%	1229	85,5%
RDC	**Avec Kinshasa**	**48 906**	**10 112**	**20,7%**	**38 794**	**79,3%**
	Sans Kinshasa				**38 828**	**79,9%**

L'analyse du tableau sur l'écart entre le besoin et l'existence des SSC en RDC révèle un déficit national alarmant, avec seulement 20,7% des besoins couverts, laissant un Gap de 79,3% (38 794 SSC manquants). Cette insuffisance critique souligne que la majorité de la population, particulièrement en milieu rural, n'a pas accès au niveau de soins communautaire essentiel. Le déploiement des services de proximité est loin d'atteindre l'échelle requise.

Les disparités provinciales sont extrêmes et nécessitent une approche stratégique ciblée. Tandis que des provinces comme Maniema (54,1%) et Ituri (48,9%) affichent des taux de couverture significativement supérieurs à la moyenne nationale, d'autres provinces sont en situation de crise aiguë. Le Kasaï, avec seulement 2,0% de couverture (98,0% de déficit), et le Sud-Kivu, avec 5,1% de couverture (94,9% de déficit), présentent les écarts les plus massifs. Ces données impliquent que les futures phases du PSN SACO doivent impérativement prioriser la réallocation des ressources et des financements vers les provinces affichant les plus grands déficits numériques et proportionnels (notamment Kasaï, Sud-Kivu, Kwango et Haut-Katanga) afin de garantir une distribution plus équitable des services de santé à travers le territoire national.

- **Disponibilité des RECO**

Tableau 17: Nombre de RECO existants et opérationnels, et besoin en RECO

Provinces	RECO		Besoin en RECO					
	Existants 2023	Opérationnels 2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bas Uele	6 159	4 809	5 525	5 703	5 885	6 070	6 260	6 453
Equateur	15 668	9 180	7 760	8 010	8 265	8 526	8 792	9 064
Haut katanga	22 275	15 873	20 188	20 839	21 504	22 182	22 875	23 581
Haut Lomami	24 374	18 840	15 613	16 116	16 630	17 155	17 691	18 237
Haut Uele	5 017	3 590	9 531	9 838	10 152	10 473	10 799	11 133
Ituri	20 246	15 381	18 671	19 273	19 888	20 515	21 156	21 809
Kasaï	34 759	25 141	14 469	14 935	15 412	15 898	16 394	16 900
Kasaï Central	36 299	25 049	16 019	16 536	17 063	17 601	18 151	18 711
Kasaï Oriental	33 282	17 623	13 455	13 888	14 331	14 784	15 245	15 716
Kinshasa	18 455	13 013	46 136	47 623	49 141	50 692	52 274	53 888
Kongo Central	14 379	11 646	28 004	28 907	29 829	30 770	31 730	32 710
Kwango	13 054	8 864	11 255	11 618	11 988	12 366	12 752	13 146
Kwilu	27 178	18 892	27 369	28 251	29 152	30 072	31 011	31 968
Lomami	27 805	19 940	11 869	12 252	12 643	13 042	13 449	13 864
Lualaba	7 354	5 108	12 844	13 258	13 681	14 112	14 553	15 002
Mai Ndombe	6 633	4 935	9 699	10 012	10 331	10 657	10 989	11 329
Maniema	16 257	9 735	11 953	12 338	12 731	13 133	13 543	13 961
Mongala	9 740	5 474	9 084	9 377	9 676	9 981	10 293	10 610
Nord Kivu	37 478	28 017	33 328	34 402	35 499	36 619	37 762	38 928
Nord Ubangi	6 595	4 686	6 638	6 852	7 071	7 294	7 522	7 754
Sankuru	16 626	10 873	10 461	10 799	11 143	11 495	11 853	12 219
Sud Kivu	44 129	28 560	29 285	30 229	31 193	32 177	33 181	34 206
Sud Ubangi	15 024	10 700	12 834	13 248	13 670	14 102	14 542	14 991
Tanganyika	19 394	14 413	15 369	15 865	16 370	16 887	17 414	17 952
Tshopo	13 473	9 355	11 780	12 159	12 547	12 943	13 347	13 759
Tshuapa	6 882	3 886	8 334	8 603	8 877	9 157	9 443	9 734
RDC	**498 535**	**343 583**	**417 474**	**430 930**	**444 673**	**458 703**	**473 020**	**487 623**

Ce tableau dresse un état des lieux crucial de l'offre actuelle en RECO et projette les besoins futurs jusqu'en 2030, soulignant un déficit structurel dans la force de travail communautaire en RDC. En 2023, le nombre total de RECO existants était de 498 535, mais seulement 343 583 étaient jugés opérationnels. Cet écart de plus de 150 000 RECO non opérationnels représente déjà une perte d'efficacité significative des programmes de santé communautaire. Sur le plan des besoins futurs, la RDC devra maintenir un effort soutenu pour atteindre 487 623 RECO d'ici 2030, soit une augmentation d'environ 144 000 postes par rapport aux RECO opérationnels de 2023. Si l'on compare le nombre de RECO opérationnels de 2023 (343 583) au besoin projeté pour 2025 (417 474), le déficit initial est de près de 74 000 RECO supplémentaires à rendre opérationnels en deux ans, nécessitant un effort massif de recrutement, de formation et de motivation pour combler le manque de personnel de première ligne.

Les disparités provinciales dans la gestion de cette force de travail sont prononcées. Certaines provinces comme le Haut-Katanga (22 275 existants pour 15 873 opérationnels) et le Kasaï Central (36 299 existants pour 25 049 opérationnels) affichent un écart important entre le nombre de RECO formés et ceux effectivement actifs, soulevant des questions sur la maintenance et le soutien opérationnel de ce personnel. À l'inverse, des provinces comme Kinshasa et le Kongo Central verront leur besoin en RECO augmenter de manière exponentielle, Kinshasa passant de 13 013 RECO opérationnels en 2023 à un besoin projeté de 53 888 en 2030. Cette augmentation drastique du besoin dans les zones urbaines et semi-urbaines témoigne soit d'une révision à la hausse des critères de couverture communautaire pour ces zones, soit d'une croissance démographique très rapide. L'enjeu majeur pour les années à venir sera donc non seulement de recruter et former les RECO manquants, mais surtout d'assurer leur soutien, leur motivation et leur rémunération pour garantir leur fonctionnalité et leur rétention afin de répondre aux besoins projetés.

- **Mise en place et fonctionnalité des CAC**

L’évaluation du PSN SACO 2019-2022 a indiqué que ¾ des villages/cellules avaient des CAC existantes, ces CAC étaient plus présentes en milieu rural qu’urbain. Des normes de mise en place des CAC, seules 2 normes ont été respectées par plus de 80% des CAC existantes, il s’agit de la désignation des facilitateurs locaux et du plaidoyer auprès des APA locales. Les RECO membres de ces CAC sont généralement moins bien formés, avec seulement 4 sur 10 RECO formés en dynamique communautaire, il en est de même avec la dotation des RECO des CAC en matériels et outils de gestion. Les normes de genre dans la mise en place des CAC sont encourageantes, avec près de 70% des CAC ayant au moins 30% des femmes comme membres. S’agissant du respect des critères de fonctionnalité des CAC, seule la participation des délégués de CAC aux réunions de CODESA est respectée dans au moins 80% des CAC existantes.

Tableau 18: Mise en place et fonctionnalité des CAC

Mise en place et fonctionnalité des CAC		
Villages/cellules avec CAC existante ou constituée		**74,7%**
Respect des normes de mise en place des CAC	Désignation des facilitateurs locaux	**86,1%**
	Plaidoyer auprès des APA locales	**84,3%**
	Election des membres du bureau de la CAC par les RECO	**74,0%**
	Convocation de l'assemblée villageoise	**73,7%**
	Représentativité des leaders locaux dans la CAC	**72,6%**
	Investiture des membres du bureau de la CAC par l'APA locale	**68,8%**
	Election des RECO au cours de l'assemblée villageoise	**53,2%**
	Dotation de la CAC en matériels et outil de gestion	**41,4%**
	Formation des RECO sur la dynamique communautaire	**40,2%**
	Respect de la norme d'au moins 30% de femmes dans la composition de la CAC	**68,6%**
Respect des critères de fonctionnalité des CAC	Participation des délégués de CAC aux réunions de CODESA	**83,4%**
	Rapportage au CODESA	**78,8%**
	Réalisation des activités de promotion, prestation et suivi communautaire	**75,3%**
	Tenue des réunions mensuelles	**73,6%**
	Réalisation du dénombrement initial	**70,2%**
	Elaboration du plan d'actions communautaires	**51,6%**
	Actualisation mensuelle des données de dénombrement	**49,0%**
	Mise en œuvre du PAC	**34,9%**
	CAC bénéficiant des supervisions mensuelles	**46,0%**
	CAC bénéficiant d'un appui financier	**51,0%**

Source : ICHESS, Rapport d'évaluation du PSN SACO 2019-2022

Selon les données de Unicef RDC, le besoin en CAC, soit 1 CAC par village ou cellule (avenue, rue, bloc, localité) est estimé à **118 254** pour l'ensemble du pays. Avec l'estimation des besoins en RECO, on devrait avoir une moyenne de 4 RECO par CAC de 2025 à 2030.

- **Mise en place et fonctionnalité des CODESA**

L'évaluation du PSN SACO 2019-2022 a indiqué que près de la totalité des AS ont des CODESA, seules 2 normes ont été respectées par plus de 80% des CODESA existants, il s'agit du dépôt des candidatures et de l'élection des membres du bureau par les délégués des CAC. S'agissant de la fonctionnalité des CODESA, deux critères ont été respectés par au moins 80% des CODESA existants, il s'agit de la tenue des réunions mensuelles et de la participation à la planification, gestion et suivi des activités du CS.

Tableau 19: Mise en place et fonctionnalité des CODESA

Mise en place et fonctionnalité des CODESA		
AS avec CODESA existant ou constitué		**98,0%**
Respect des normes de mise en place des CODESA	Dépôt des candidatures	**84,0%**
	Election des membres du bureau par les délégués des CAC	**80,6%**
	Installation du bureau par l'APA locale	**66,3%**
	Election des responsables des commissions	**63,8%**
	Dotation en matériels et outils de gestion	**45,6%**
	Formation des membres du CODESA en dynamique communautaire	**38,7%**
	Respect de la norme d'au moins 30% de femmes dans la composition de CODESA	**54,3%**
Respect des critères de fonctionnalité des CODESA	Tenue des réunions mensuelles	**90,1%**
	Participation à la planification, gestion et suivi des activités du CS	**87,3%**
	Elaboration de micro plan	**60,1%**
	Mise en œuvre du micron plan	**50,4%**

Source : ICHESS, Rapport d'évaluation du PSN SACO 2019-2022

Encadré 5 : Il en résulte que sur les 7 domaines de la santé communautaire, seul le domaine « financement » a encore un niveau de fonctionnalité partielle, traduisant un goulot moyen évalué à 40%. Ainsi, des actions fortes devront être entreprises sur ce dernier pour renforcer le système de santé communautaire. Par ailleurs, le domaine « prestations » est celui qui a le niveau de fonctionnalité le plus élevé avec 83% suivi de la communication (76%), la gestion de la chaine d'approvisionnement (73%), la gouvernance (72%) puis le SNIS (67%). Une attention particulière devrait être mise sur le domaine « ressources humaines » (62%) à travers la fidélisation des acteurs communautaires par des mesures incitatives dans un cadre règlementaire et normatif bien défini ainsi que par leur renforcement des capacités dans la dynamique communautaire.

2.2. Déterminants sociaux de la santé et autres indicateurs des ODD

En abordant les déterminants sociaux de la santé dans le cadre des ODD, l'objectif est d'améliorer de manière intégrée la santé et le bien-être des populations, tout en réduisant les inégalités et en assurant un développement durable. Ils sont souvent interconnectés avec les ODD. Ainsi par exemple, la pauvreté (ODD 1) influence sur l'accès aux soins de santé (ODD 3), tandis que l'éducation (ODD 4) impacte sur la capacité à obtenir un emploi décent (ODD 8).

2.2.1. Education

L'accès à l'éducation s'est considérablement amélioré au cours des deux dernières décennies, en particulier chez les filles et les plus jeunes. Selon l'Institut de statistique de l'UNESCO (données de l'ISU), le taux d'achèvement de l'enseignement primaire était de 79% en 2021 pour les filles et de 86% pour les garçons. Cependant, les taux bruts de scolarisation dans l'enseignement secondaire révèlent un écart entre les sexes avec 44% de filles scolarisées contre 70% de garçons. Le faible niveau d'éducation, en particulier pour les filles, est dû en partie au nombre relativement élevé de mariages d'enfants et de grossesses précoces. Le taux brut d'inscription dans l'enseignement supérieur était de 5% pour les femmes en 2020, contre 8% pour les hommes.

2.2.2. Eau, hygiène et assainissement

De manière plus générale, l'accès à l'eau de qualité et à des conditions sanitaires et d'hygiène adéquates permettent la prévention de multiples autres maladies d'origine hydrique.

En RDC, le diagnostic du secteur de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement (EHA) révèle que les populations peinent à s'approvisionner en eau potable, n'ont pas accès aux services d'assainissement adéquats et encore moins à la maitrise de bonnes pratiques d'hygiène et ce, malgré ses potentiels énormes en ressources hydrologiques et hydrogéologiques. Par ailleurs, malgré ses forts potentiels en ressources en eau (52% des réserves d'eau douce d'Afrique), la RDC connait des difficultés d'accès à l'eau, à l'assainissement et aux bonnes pratiques d'hygiène évalués respectivement à 33,6%, 13,5% et 21,4%.[81] Le taux d'accès à au moins un point d'eau de base était de 14% en milieu rural et 59% en milieu urbain alors que le taux d'accès à au moins un point d'assainissement de base était de 11% (rural) et 22% (urbain).[82]

Ces faibles taux évoqués ci-hauts, couplés à des mauvaises pratiques d'hygiène, sont à la base de la propagation des épidémies à répétition que connait la RDC ces dernières années entre autres : le choléra, la MVE, la Covid-19, les crises nutritionnelles et le retard de croissance.

2.2.3. Accès à l'électricité

L'approvisionnement de qualité en énergie en particulier en électricité est un facteur majeur de la couverture sanitaire universelle. La RDC figure parmi les pays ayant le plus faible taux d'électrification. Moins de 10% de la population congolaise dispose d'un accès à l'électricité, 35% dans les zones urbaines (50% à Kinshasa) et moins de 1% dans les zones rurales[83]. En 2021, le taux d'accès à l'électricité était de 21,5% selon la Banque mondiale.

2.2.4. Accès aux technologies de l'information et de la communication

Selon l'enquête par grappes a indicateurs des ODD 2020 (EGI-ODD 2020), l'usage du téléphone portable est faible en RDC, soit 30,8% avec des disparités selon le milieu de résidence. Les résultats selon le milieu de résidence mettent aussi en évidence des disparités importantes : 12,4% de la population vivant dans le milieu rural a utilisé un téléphone portable contre 59,9% de la population vivant dans le milieu urbain. 67% de la population vivant à Kinshasa a utilisé un téléphone portable.

Selon l'observatoire du marché de fourniture des services internet (Rapport S1 2023) de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC), le taux de pénétration de l'Internet est estimé à 0,017% pour l'Internet fixe et à 30,08% pour l'Internet mobile.

2.2.5. Enregistrement à l'état civil

En RDC, 4 enfants sur 10 sont enregistrés à l'Etat civil. Le taux d'enregistrement des enfants de moins de 1 an est de 38%, tandis qu'il est de 40% pour les enfants de moins de 5 ans. D'où le projet de digitalisation du registre de vaccination incluant l'enregistrement des naissances à l'Etat civil. Ce projet permet de à fournir au personnel de santé et aux décideurs des informations précises et en temps réel sur la vaccination et les statistiques vitales.

[81] Ministère du Plan, Ministère de la Santé Publique. "Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS-Palu 2018" : Rapport final. Kinshasa, Décembre 2019.
[82] https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_fiche_pays_republique_democratique_du_congo_rdc_2023.pdf
[83] PNSD 2019-2023

2.2.6. Autres indicateurs des ODD

Les ODD visent à aborder divers aspects des déterminants sociaux de la santé. Voici quelques ODD clés et leurs indicateurs pertinents :

ODD 1 : Pas de pauvreté

En RDC, la pauvreté demeure importante, voire prépondérante. Les estimations les plus récentes de l'Observatoire Congolais du Développement Durable (OCDD) montrent que la pauvreté est en recul timide, passant de 74,7% en 2020 à 72,3% au seuil international de 1,9 USD par jour. Cependant, cette baisse n'annule pas l'ampleur du problème qui demeure très élevée. D'ailleurs, en dépit de cette faible diminution, le nombre de pauvres a augmenté en moyenne de 1,2 million par an. Ce niveau de pauvreté place le pays au troisième rang des pays aux taux de pauvreté parmi les plus élevés en Afrique sub-saharienne.[84]

ODD 2 : Faim zéro

L'insécurité alimentaire continue de sévir en RDC. Selon l'analyse du Cadre intégré de classification alimentaire (IPC) de 23ème cycle, pour la phase actuelle (Juillet 2024- Juin à décembre 2025), 25,6 millions (23% de la population), font face à une insécurité alimentaire aiguë élevée (Phase 3 de l'IPC ou plus) : Parmi ces 25,6 millions de personnes, près de 22,4 millions sont classées en Crise (Phase 3 de l'IPC) et 3,1 millions sont en insécurité alimentaire d'Urgence (Phase 4 de l'IPC). Sur les 188 zones analysées, 64 ont été classées en situation de stress (Phase 2 de l'IPC) contre 124 classées en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l'IPC). Il en est de même de la sous-alimentation chronique : 45% d'enfants de moins de 5 ans étaient en 2023 en retard de croissance. La situation d'insécurité alimentaire constitue un réel problème d'autant plus que les zones de santé en alerte continuent tendanciellement à augmenter.[85]

ODD 4 : Éducation de qualité

Le secteur éducatif est caractérisé par un faible accès à l'éducation avec des inégalités croissantes en matière d'éducation entre le garçon et la fille, entre les milieux urbain et rural. Dans les milieux ruraux les plus reculées, le taux d'analphabétisation des femmes et des filles est estimé à 90%. Ce faible niveau d'éducation et d'alphabétisation en général et de la femme en particulier est un déterminant majeur de mauvaise santé en RDC. La perception des risques sanitaires des individus et des communautés et leur responsabilisation vis-à-vis de leur santé s'en trouvent limitées. Les besoins prioritaires concernent l'accès à l'éducation dans un environnement d'apprentissage sûr et protecteur.

ODD 6 : Eau propre et assainissement

En RDC, le défi d'un accès universel à une source d'eau améliorée se pose avec acuité, principalement en milieu rural. Les dernières données indiquent une forte disparité en termes d'accès à une source améliorée d'eau potable. Moins de 58% des Congolais ont accès à une source améliorée d'eau potable, dont seulement moins de 40% dans les 30 minutes aller-retour. Par ailleurs, plus de 8 ménages sur 10 consomment une eau de boisson contaminée, essentiellement par la bactérie E-Coli.[86] Cette contamination expose la population, particulièrement pauvre, à un risque permanent. L'eau, l'assainissement et l'hygiène constituent toujours le troisième facteur de risque associé à des décès ou à des invalidités dans le pays.[87]

[84] RDC-Ministère du plan. PNUD : Rapport d'examen national volontaire des ODD. RDC, 2023.
[85] IPC Insécurité alimentaire 23ème cycle 2024.
[86] RDC-Ministère du plan. PNUD : Rapport d'examen national volontaire des ODD. RDC, 2023.
[87] IHME, Université de Washington, 2021. https://vizhub.healthdata.org/lbd/wash.

ODD 8 : Travail décent et croissance économique

La croissance du PIB a été, en 2022, la plus élevée depuis le lancement de l'Agenda 2030 soit 8,5%, avec comme corollaire une variation également importante du PIB per capita (5,4%). La reprise de la demande mondiale a stimulé davantage le secteur minier, avec des exportations encore plus importantes. Couplé notamment à la hausse des prix mondiaux des matières de base imputable à la guerre russo-ukrainienne, le secteur minier a apporté une contribution non négligeable de l'ordre de 5,5 points de pourcentage dans la croissance totale.

ODD 10 : Inégalités réduites

Avec un coefficient de Gini de 0,45 en 2023 contre 0,51 en 2020, les inégalités sont en augmentation en RDC. De manière désagrégée, cette augmentation s'observe également au niveau provincial.[88]

ODD 11 : Villes et communautés durables

Les données récentes montrent que 57,1% de la population urbaine vit dans des logements construits avec des matériaux de qualité et 22,5% vit dans des ménages avec au plus deux personnes par pièce. On estime à 90,5% la proportion urbaine vivant dans des quartiers de taudis ou logements inadéquats. Les différences sont négligeables selon que l'on est un homme ou une femme. A Kinshasa, cette proportion est estimée à 87%. Dans les provinces du Haut Katanga (79%), du Kongo central (83%) et du Lualaba (83,8), un peu plus de huit personnes sur dix vivant dans le milieu urbain habitent dans des quartiers de taudis ou des logements inadéquats.[89]

ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces

En proie aux conflits armés et des guerres à répétition, la RDC fait face aux risques permanents des violences faites aux femmes. Les conditions de vie précaires dans les centres collectifs et autres milieux d'hébergement ainsi que la destruction des mécanismes communautaires de protection des femmes et des filles augmentent les risques de violences basées sur le genre (VBG).[90]

Encadré 6 : Les déterminants sociaux de la santé et les indicateurs des ODD sont cruciaux pour comprendre les facteurs qui influencent la santé et le bien-être des populations. Pourtant, ces facteurs défavorables des formes multiples (pauvreté, manque d'instruction, chômage ou emploi précaire ou encore dangereux, mauvaises conditions de logement, etc.) constituent des défis à cibler pour améliorer les conditions de vie et réduire les inégalités à travers l'approche « One health ou une seule santé », qui encourage la collaboration intersectorielle et la synergie de tous les secteurs et acteurs dont les actions peuvent avoir un impact positif sur la santé. Car, plus les gens vivent longtemps dans des conditions économiques et sociales stressantes, plus l'usure physiologique est grande et moins ils ont de chances de vivre en bonne santé.[91]

[88] https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.GINI

[89] Observatoire Congolais du Développement Durable et Institut National de la Statistique. 2021. Enquête par Grappes à Indicateurs des ODD, 2020 : Rapport final. Kinshasa, République Démocratique du Congo.

[90] Programme National Multisectoriel de Lutte Contre le Sida (2021), Rapport annuel 2020, Kinshasa, RDC.

[91] R. Wilkinson & M. Marmot, Les déterminants sociaux de la santé : les faits. Deuxième édition. OMS 2004, pp 8 et 11

2.3. Quelques approches de santé communautaire

A l'instar d'innombrables bonnes pratiques implémentées aussi bien en RDC qu'ailleurs, il importe de capitaliser dans ce plan les approches ayant montré leurs efficacités. Par ailleurs, d'autres approches non expérimentées au pays feront l'objet d'études pilotes en vue d'en tirer les bonnes leçons évidentes lors du recadrage du présent plan stratégique.

2.3.1. Child Friendly Communities and Real Time Monitoring ou « Communautés Amies des Enfants et Suivi en Temps Réels »

Lancée en 2017 par l'UNICEF avec la subvention de BMGF, l'approche innovante « Child Friendly Communities and Real Time Monitoring (CFC-RTM) » ou « Communautés Amies des Enfants et monitorage en temps réel » avait comme objectif programmatique de fournir un ensemble intégré d'interventions multisectorielles centrées sur l'enfant au niveau des structures communautaires afin de corriger les multiples privations lui infligées. Il s'agit d'interventions communautaires en lien avec la santé, la nutrition, le développement de la petite enfance, la lutte contre le VIH, la promotion de l'EHA, la protection de l'enfant et la communication pour leur développement.

Cette approche a été implémentée dans 13 ZS reparties en 7 provinces (Kongo-Central avec la ZS de Mbanza-Ngungu ; Kinshasa avec la ZS de N'sele ; Kasaï Oriental avec la ZS de Miabi ; Kwango avec les ZS de Kenge, Boko, Popo-Kabaka et Kimbau ; Nord-Kivu avec les ZS de Beni, Kalunguta et Butembo ; Kwilu avec la ZS de Mosango et Ituri avec les ZS de Komanda et Ariwara).

Dans le cadre de l'implémentation de l'approche CFC-RTM, quelques leçons sont retenues. On note entre autres :

- L'amélioration de la coordination intersectorielle a permis une meilleure convergence des interventions, y compris la formalisation de la CAC comme structure multisectorielle de coordination des initiatives communautaires ;
- Les communautés sont à l'origine de la demande de services et leur engagement est essentiel pour la fourniture de services de qualité à travers la mobilisation des ressources et leur contribution à la construction des infrastructures (maternité, CS), achat de plantations, aménagement des sources d'eau, élevage de gros et petit bétail, pisciculture, soutien aux réunions, achat des fournitures et des médicaments, reprographie de certains des outils et autonomisation des agents communautaires par les AGR (Activités Génératrices des Revenus) ;
- La décentralisation au niveau communautaire des activités nutritionnelles clés a permis d'améliorer l'accès aux services de nutrition et la détection rapide des cas de malnutrition dans la communauté ;
- L'intégration de l'enregistrement des naissances dans les services de vaccination dans les CS a permis de faire le suivi systématique sur la carte de vaccination de l'enfant et d'identifier les enfants non enregistrés (Cas de la ZS de N'Sele) ;
- Le soutien aux services de prévention et de réponse à la violence liée au sexe a permis aux femmes et aux filles ciblées d'accéder à des soins de qualité grâce à l'amélioration des systèmes d'orientation ;
- La recherche sur les "déterminants du genre dans l'anémie à N'sele" a permis, le cas échéant, de réajuster/planifier de nouvelles stratégies d'intervention en tenant compte des besoins spécifiques et de participer au résultat global ;
- La recherche systématique de des enfants moins de 5 ans et femmes enceintes n'ayant pas bénéficié des services leur offerts, a permis de réduire la pente des privations jadis observées dans la communauté ;

- Le suivi-évaluation formalisé au niveau communautaire à travers le monitorage mensuel régulier au niveau des CAC vient poser le jalon du développement du SNIS communautaire ;
- La ventilation des données par sexe et par âge, les consultations systématiques avec les femmes et filles ont mis en évidence leurs problèmes, les contraintes et leurs besoins spécifiques, ce qui a permis d'améliorer l'accès aux services de soutien.

2.3.2. Renforcement du système de santé communautaire avec SANRU-FM, cas du Maniema

La province du Maniema, à l'instar des provinces de Kinshasa et Kongo-central, a bénéficié du financement de Fonds Mondial à travers SANRU Asbl pour la mise en œuvre de sa stratégie d'appui à la santé communautaire, particulièrement dans la lutte contre la Tuberculose, le VIH et le Paludisme. Des évaluations de démarrage et de fin du projet, réalisées dans 10 ZS de mise en œuvre et 2 ZS contrôles, indiquent une nette amélioration de l'organisation des organes de participation communautaire dans les ZS de mise en oeuvre, au travers (i) des CAC et CODESA dynamiques (mise en place et fonctionnalité respectant les normes) et (ii) une meilleure appropriation des RECO par la population.

Plusieurs leçons sont à retenir, à savoir :

- Acquisition des meilleures connaissances de certaines pathologies, des pratiques familiales essentielles et des signes de danger des mères et des enfants grâce au RECO ;
- Amélioration des indicateurs de mise en place et de fonctionnalité des CODESA dans les ZS de mise en œuvre ;
- Le modèle d'accompagnement apporté par SANRU asbl au Maniema privilégie le travail avec les OSC locales qui ont le statut de sous-récipiendaires ; facilitant l'acceptation de ces dernières par les populations bénéficiaires et favorisant l'appropriation des bénéficiaires.

2.3.3. Amélioration de la qualité de référence dans les foyers pour enfants avec de l'artésunate rectal pour le paludisme (Community Access to Rectal Artesunate for Malaria/CARAMAL)

De 2019 à 2021, le Projet CARAMAL financé par UNITAID et mise en œuvre simultanément dans trois ZS, à savoir les Zones de Santé de Kingandu, Ipamu et Kenge, grâce au concours de la Clinton Health Access Initiative (CHAI), l'UNICEF et l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH) a fourni l'artésunate recto-capsule (ARC). Ce Projet consiste essentiellement à l'introduction responsable de l'Artésunate suppositoire et générer les évidences de son utilisation rationnelle comme traitement pré référentiel dans la prise en charge du paludisme grave chez les enfants de moins de 6 ans au niveau communautaire et périphérique.

La grande leçon retenue au cours de la mise en œuvre de ce projet est le fait que les gestionnaires de santé et ceux du projet ont su profiter de cette opportunité de financement pour mieux organiser le système de santé communautaire au niveau opérationnelle. Le niveau de supervision des SSC et des CAC ainsi que la tenue des réunions régulières qui étaient quasiment nuls au début du projet sont nettement amélioré en son cours. Aussi, le suivi continu des activités des SSC a permis d'en améliorer la qualité des soins et services offerts.

2.3.4. Amélioration du dépistage et du traitement de la Tuberculose pédiatrique par les ASC/RECO (Tuberculosis Implémentation Framework Agreement)

Le projet « Tuberculosis Implementation Framework Agreement », TIFA en sigle, est un accord quinquennal de coopération (2019-2024) financé par l'Agence des États-Unis pour le

Développement International (USAID) et mis en œuvre par l'organisation « John Snow, Inc » (JSI) en partenariat avec Open Development.

Ayant utilisé les subventions d'engagement de lutte contre la tuberculose (TCG) pour financer le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), TIFA a permis d'améliorer les soins antituberculeux et le dépistage des cas de tuberculose dans 17 ZS dont 48 ESS (CSDT/CST) et 96 SSC de la DPS de Kinshasa avec comme objectifs de renforcer les capacités des ASC/RECO de 96 SSC à l'orientation des cas de TB pédiatrique et de rechercher activement la Tuberculose chez l'enfant.

2.3.5. Suivi communautaire dans le cadre de contrôle citoyen par les OSC

Quelques leçons sont à retenir dans le cadre de contrôle citoyen par les OSC, à savoir :

- **Observatoire communautaire de la prise en charge du VIH/TB, avec l'Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH (UCOP+)**

Il s'agit d'un dispositif de veille des OSC de lutte contre le VIH et la TB qui, à travers le plaidoyer sur l'amélioration de la qualité des soins offerts aux bénéficiaires permet le suivi de (i) la disponibilité en intrants stratégiques (ARV, anti-TB, Cotrimoxazole, Fluconazole, etc.) ; (ii) l'accessibilité financière (user fees) et la lutte contre la stigmatisation et discrimination (violations des droits) des PvVIH. Grâce à un suivi continu et des feedbacks réguliers (mensuel, trimestriel et annuel) aux institutions officielles de lutte contre le VIH/TB, l'observatoire a permis de réaliser des avancées dans la lutte contre le VIH/TB.

- **Suivi communautaire des activités de VIH, TB, paludisme et autres problèmes de santé publique, avec le CNRSC** :

Le suivi communautaire dans le cadre de contrôle citoyen depuis 2022 à ce jour porte sur la disponibilité, l'accessibilité, l'abordabilité, l'acceptabilité et la prestation de soins et de services de qualité, réalisé en temps opportun par les acteurs communautaire membres de la SC dans les 7 Zones de Kinshasa et 6 Zones du Kongo Central avec implémentation de la digitalisation dans 2 ZS (Binza Ozone à Kinshasa et Boma au Kongo-Central), suivi des remontée des dysfonctionnements constatés/identifiés auprès des autorités sanitaires et politiques dans le cadre de plaidoyer pour contribuer à amélioration de la qualité des soins et des services.

Les acteurs sensibilisent par la même occasion les ménages et la communauté (personnes vivant avec le VIH, des groupes KP, des jeunes, des femmes enceintes, des adolescents et d'autres communautés touchées), affectées dans le but de soutenir la création de la demande, d'une part ; et la mise en œuvre des changements visant à améliorer la prestation des services de lutte contre le VIH/SIDA, la TB, le Paludisme et autres problèmes de santé, d'autre part.

Le renforcement de suivi des activités de mobilisation sociale et vérification de l'effectivité de la distribution de masse des MILD depuis 2018 à ce jour dans un échantillon des 5% des ménages en déterminant le niveau de couverture et de respect de norme pendant la distribution dans le but de contribuer à l'amélioration de la qualité du dénombrement /distribution de masse des MILD dans les ménages avec l'appui du Fonds Mondial à travers SANRU Asbl.

2.3.6. Developpement des documents de politique, stratégiques et normatifs de communication sur les risques et engagement communautaire

Dans le cadre de renforcement de la communication sur les risques et engagement communautaire (CREC), le PNCPS, comme un des organes d'accompagnement de la mise en œuvre du plan stratégique national de la santé communautaire 2019-2022 a eu à produire ou réviser plusieurs documents de référence entre autres : (i) la Stratégie nationale de communication pour la promotion de la planification familiale ; (ii) la Stratégie nationale de

communication pour le changement social et de comportement pour la promotion de la santé ; (iii) la Stratégie nationale multisectorielle de communication médiatique proactive dans le cadre du RSI 2005 et la gestion des urgences de santé publique ; (iv) le Plan national multisectoriel de communication sur les risques et engagement communautaire pour la gestion des urgences de santé publique et la lutte contre les maladies zoonotiques dans une perspective inclusive et intégrée fondée sur l'approche « Une Santé » ; (iii) la Gestion des rumeurs, des perceptions de risques, de l'infodémie, des plaintes et des feedbacks des communautés et la Politique nationale multisectorielle de CREC dans le cadre du RSI 2005 et des Urgences de Santé Publique ; etc.

2.3.7. Engagement communautaire dans la gestion des épidémies

L'engagement de la communauté durant la riposte à la 10ème flambée d'épidémie du virus Ébola dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu a porté ses fruits grâce aux approches communautaires telles que :

- La communication sur les risques, mobilisation sociale et participation communautaire des RECO ;
- La communication sur les risques et engagement communautaire (CREC) essentielle pour la surveillance, la détection des cas, la recherche, les enterrements sûrs et dignes, les soins aux malades et les soins cliniques, la vaccination et l'utilisation compassionnelle du vaccin expérimental Ebola, la mobilisation des soutiens locaux pour les besoins logistiques et opérationnels de l'intervention, le soutien aux survivants et leur réintégration dans les communautés par les RECO, etc. Elle a aidé à instaurer la confiance des populations dans la réponse sanitaire et augmenter la probabilité que les conseils en matière de santé soient suivis. Elle a en outre aidé à minimiser et gérer les fausses rumeurs et la désinformation.

L'engagement communautaire dans la lutte contre la Covid-19 a permis de :

- Impliquer l'activation et la mobilisation des communautés pour participer activement à la surveillance des maladies à travers la collecte de données sur les symptômes, les contacts et déplacements des personnes malades ou potentiellement exposées.
- Mettre à contribution les ONG locales pour la mise en œuvre des activités communautaires, y compris le WASH en coordination avec les ECZS et les DPS. Il s'agissait entre autres de mener des actions préventives pour la promotion de l'hygiène personnelle, du lavage des mains, de la distribution et l'utilisation de masques etc. La sensibilisation accrue et la promotion de la participation communautaire ont contribué au ralentissement de la propagation de la pandémie.

2.3.8. Approche « VIVA » ou Famille en bonne santé ou Famille épanouie

Pour repositionner la santé comme maillon clé dans l'épanouissement des familles, des communautés et pays, Breakthrough Action (BA) a mis en œuvre de 2020 à 2023, une approche dénommée « VIVA », financée par l'USAID dans 8 ZS situées dans 3 provinces (Sud Kivu, Kasaï Oriental et Haut Lomami). Il s'agit d'une approche de changement social et de comportement pour accroître les pratiques familiales essentielles de santé et l'utilisation des services de santé.

Les leçons ci-après sont à retenir :

- Accès facile aux soins de santé à la suite des épargnes réalisées ;
- Espacement des naissances et début des consultations prénatales très tôt'' ;
- Accompagnent des femmes par leurs maris à la consultation prénatale et adhésion à la Planification Familiale ;
- La comparaison de prix, a permis aux bénéficiaires de comprendre que le traitement au CS coûte moins cher que celui des pharmaciens de la cité qui ne sont pas expérimentés".

2.3.9. Approche « Bulletin Communautaire de Performances » (BCP)

Pour renforcer la responsabilité des détenteurs de pouvoir rendre compte à travers l'engagement communautaire, une approche de redevabilité sociale dénommée « Bulletin communautaire de performances » a été mise en place avec comme objectifs de :

- Donner à la communauté l'opportunité de s'exprimer en relation avec la qualité et la gamme des soins qu'elle reçoit ;
- Permettre aux prestataires de sonder l'opinion de la communauté en relation avec la qualité et la gamme des soins qu'ils lui administrent ;
- Donner aux deux parties la possibilité de corriger par le dialogue participatif les déficiences identifiées par l'exercice.

Constitué de trois composantes (Accès à l'information, mobilisation de la voix de la communauté, et négociation pour le changement et l'amélioration des services), le BCP est un outil qui permet à la communauté bénéficiaire d'exprimer sa perception sur la qualité des services lui offert en vue d'une amélioration en utilisant des indicateurs préalablement identifiés par la communauté.

Mis en œuvre et appuyé par IMA et PROSANI/USAID dans respectivement 5 et 9 provinces, le BCP a amélioré la gouvernance, a apporté l'appropriation, l'implication et la participation des communautés dans les activités du CS, y compris la résolution des problèmes liés à l'offre de soins de santé, la redevabilité des prestataires vis-à-vis de la communauté et la congestion dans les CS entre les prestataires et les membres de CODESA.

2.3.10. Approche Nutrition à assise communautaire (NAC)

La NAC se focalise sur les actions au niveau de la famille et de la communauté et permet à ces derniers de : (i) Mobiliser les ressources communautaires pour atteindre l'objectif commun de réduire la prévalence de la malnutrition, (ii) S'approprier les interventions à haut impact sur la nutrition, (iii) Amener les différents secteurs sensibles à travailler ensemble, pour accompagner les familles à prévenir de manière durable la malnutrition sous toutes ses formes. Ces secteurs sont la santé, agriculture, éducation, eau- hygiène assainissement, environnement etc.

2.3.11. Approche « Village Santé » / Triade Communautaire

L'approche « Village Santé », également appelée Triade Communautaire, est un modèle conçu pour accompagner de manière pratique et opérationnelle la mise en œuvre du PSN SACO 2025–2030. Le PSN SACO fixe les grandes orientations nationales pour renforcer la santé communautaire, améliorer la qualité de l'offre de services et consolider la participation communautaire. L'approche Village Santé se positionne comme un cadre innovant permettant de traduire ces orientations dans la réalité quotidienne des communautés.

Elle vise à rapprocher davantage les services de santé des populations, à renforcer les capacités locales, et à favoriser une dynamique communautaire intégrée où les dimensions sanitaires, sociales et économiques interagissent pour produire un mieux-être durable. Le modèle apporte ainsi une réponse à plusieurs défis majeurs : faible accessibilité physique aux structures, insuffisance du personnel de première ligne, vulnérabilité économique des ménages, déficit de coordination des interventions, ainsi que faible appropriation locale des actions de santé publique.

L'approche s'appuie sur **trois piliers complémentaires**, décrits ci-dessous, qui fonctionnent ensemble pour renforcer l'efficacité de la santé communautaire.

1. **Renforcer l'accès à des soins de santé primaires centrés sur la personne**

Le premier pilier vise à organiser les soins de santé primaires dans une logique centrée sur la personne et la famille, avec une attention particulière à la continuité des soins, à la proximité, à la qualité et à la prévention. Dans cette optique, le Village Santé repose sur la constitution d'équipes multidisciplinaires regroupant un médecin ou un infirmier de famille, des ASC, des RECO et des hygiénistes.

Cette équipe de proximité facilite :

- La prise en charge précoce des maladies courantes ;
- La surveillance de la santé maternelle et infantile ;
- La prévention des maladies transmissibles et non transmissibles ;
- L'éducation sanitaire adaptée aux réalités locales ;
- Le suivi régulier des familles, notamment les plus vulnérables.

Approche centrée sur la personne et la famille

L'objectif est de passer d'un modèle de soins sporadique à un accompagnement continu et personnalisé. L'équipe devient un interlocuteur familier pour les ménages, ce qui renforce la confiance et réduit les retards de consultation.

Utilisation des technologies numériques

Le Village Santé encourage l'adoption d'outils digitaux simples et adaptés, tels que :

- Des applications de collecte de données ;
- Des tableaux de bord communautaires ;
- La digitalisation des suivis familiaux ;
- Des outils pour renforcer la coordination entre les agents communautaires et les centres de santé.

Ces outils améliorent la fiabilité des informations, facilitent la prise de décision et soutiennent une meilleure planification locale.

Financement adapté et durable

Une attention particulière est accordée à l'élaboration de mécanismes permettant de soutenir financièrement les activités du Village Santé. Cela inclut la recherche de solutions de financement adaptées au contexte (ex. contribution locale, appui externe, mécanismes communautaires). L'objectif est d'assurer un fonctionnement stable, une disponibilité continue des intrants, et une qualité soutenue des interventions.

2. **Renforcement, professionnalisation et supervision du personnel communautaire**

Ce pilier reconnaît le rôle fondamental du personnel communautaire dans la mise en œuvre du PSNSC 2025–2030. Les RECO, ASC et hygiénistes sont les acteurs les plus proches des ménages. Ils constituent le lien essentiel entre les communautés et les structures sanitaires.

Recrutement ancré dans les communautés

L'approche encourage un recrutement participatif, mené en collaboration avec les communautés et les autorités sanitaires locales. Le choix d'acteurs issus du milieu favorise :

- Une meilleure acceptabilité sociale,

- Une communication plus fluide,
- Une connaissance fine des dynamiques locales,
- Et une plus grande disponibilité.

Formation initiale et continue

Le modèle prévoit un dispositif de formation adapté aux responsabilités de chaque catégorie d'acteurs communautaires. La formation initiale est complétée par :

- Des sessions régulières de renforcement des compétences,
- Des mises à niveau selon les besoins locaux,
- La formation aux outils numériques et aux techniques de communication,
- Des pratiques participatives de partage d'expérience.

Supervision rapprochée et accompagnement par les Centres de Santé

La supervision est un élément clé du pilier. Elle permet de :

- Garantir la qualité des services rendus ;
- Soutenir les agents communautaires dans l'exécution de leurs activités ;
- Corriger rapidement les difficultés rencontrées ;
- Renforcer leur motivation et leur valorisation.

L'approche encourage une collaboration étroite entre les agents communautaires et le personnel des Centres de Santé, en favorisant des réunions régulières, des mécanismes de rétroaction et un travail d'équipe structuré.

Motivation et valorisation

Pour assurer la stabilité du personnel, l'approche insiste sur :

- Des rémunérations justes selon les possibilités du contexte,
- Des incitations non financières (reconnaissance, équipements, certification),
- Un environnement de travail motivant.

3. Développement économique local et résilience des ménages

Le troisième pilier reconnaît que la santé est profondément influencée par les conditions de vie. La vulnérabilité économique limite la capacité des familles à accéder aux soins, à adopter des pratiques préventives, ou à suivre des traitements. C'est pourquoi le Village Santé intègre un volet explicitement orienté vers le renforcement économique des ménages.

Le Programme de Promotion de la Famille Paysanne (PFP)

Le PFP ou tout autre modèle économique local approprié constitue le socle de ce pilier. Il soutient les familles à travers :

- Des activités génératrices de revenus ;
- Des systèmes communautaires de microfinance ;
- La promotion de l'agriculture familiale durable ;
- Des initiatives de sécurité alimentaire ;
- Le renforcement de la résilience face aux chocs économiques.

Ce pilier améliore la capacité des ménages à répondre à leurs besoins essentiels, réduit les risques de malnutrition, et favorise leur autonomie financière.

Approche multisectorielle

L'approche encourage la collaboration avec divers acteurs de développement :

- Associations locales,
- Coopératives agricoles,
- Organisations de microfinance,
- Structures communautaires.

Cette collaboration crée un environnement où santé et développement économique se renforcent mutuellement.

Phase pilote : tester, apprendre et adapter

Avant toute mise à l'échelle, l'approche Village Santé sera testée dans une sélection ZS pilotes. Cette phase est indispensable pour vérifier la faisabilité réelle du modèle sur le terrain.

Objectifs de la phase pilote

- Tester l'organisation des équipes communautaires ;
- Évaluer l'acceptabilité du modèle par les communautés ;
- Analyser la capacité opérationnelle locale ;
- Tester les outils numériques ;
- Évaluer les mécanismes de supervision ;
- Examiner les coûts et les ressources nécessaires.

Cycles d'apprentissage rapide et démarche itérative

Le modèle privilégie une dynamique d'apprentissage continu. Les interventions seront régulièrement analysées et ajustées afin d'adapter le modèle aux spécificités locales. Ce processus garantit que la mise en œuvre à plus grande échelle se fera sur la base de pratiques éprouvées et optimisées.

En somme, l'approche **Village Santé / Triade Communautaire**, conçue pour soutenir la mise en œuvre du **PSNSC 2025–2030**, constitue un modèle robuste, intégré et pragmatique pour renforcer la santé communautaire en RDC. En misant simultanément sur l'amélioration de la prestation des soins, la professionnalisation du personnel communautaire et le développement économique local, elle crée une dynamique globale favorable à l'amélioration durable des indicateurs de santé.

Sa mise en œuvre progressive, fondée sur une phase pilote et un apprentissage continu, facilitera son intégration harmonieuse dans le système de santé et renforcera l'impact des interventions communautaires au niveau national.

2.3.12. Quelques modèles des systèmes de santé communautaire dans le monde

La santé communautaire implique l'engagement actif des membres d'une communauté pour identifier et résoudre leurs problèmes de santé prioritaires. Contrairement aux approches traditionnelles axées sur les soins curatifs, elle se concentre sur la prévention et la promotion de la santé, en tenant compte des besoins spécifiques et des réalités culturelles locales. Sa mise en œuvre repose sur une collaboration étroite avec la communauté pour identifier les

comportements à risque.[92] Étudier les modèles de santé communautaire efficaces dans d'autres pays peut aider à les adapter au contexte de la RDC.

En Éthiopie, le Programme de soins communautaires intégrés « Integrated Community-Based Health Services » (ICBHS) est un exemple réussi de système de santé communautaire, visant à améliorer la santé des populations rurales grâce à des travailleurs de santé Les Community Health Workers (CHW) formés localement. Ce programme a significativement réduit la mortalité maternelle et infantile et amélioré le contrôle des maladies transmissibles comme le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose. En mettant l'accent sur la prévention et la promotion de la santé, le HEP renforce les capacités des populations à gérer leur santé via l'éducation et l'accès à des soins de qualité. Cette approche intégrée et décentralisée a transformé les indicateurs de santé publique en Éthiopie. [93,94]

Au Nigéria, le programme CHIPS (Community Health Influencers, Promoters, and Services) est un modèle efficace de santé communautaire, visant à rapprocher les services de soins primaires des ménages, surtout en milieu rural. Les agents CHIPS effectuent des visites à domicile pour encourager l'utilisation des services de santé locaux et sensibiliser aux soins préventifs, notamment la vaccination, la planification familiale et la santé infantile. Grâce à cette amélioration de l'accès aux soins de santé primaires, le Nigéria a enregistré des progrès significatifs en santé publique, contribuant à l'objectif de couverture sanitaire universelle.[95]

Au Botswana, la santé communautaire s'appuie sur un vaste réseau de travailleurs de santé communautaire pour fournir des soins de santé de base au niveau local. Pionnier dans l'accès universel aux traitements antirétroviraux (ARV), le pays a renforcé cette approche décentralisée par une collaboration multisectorielle. Les travailleurs communautaires suivent les patients sous ARV et participent aux campagnes de prévention et à l'éducation en santé publique. Cette stratégie a permis au Botswana de mieux répondre aux besoins de ses communautés, notamment dans la lutte contre le VIH/sida et d'autres maladies transmissibles, tout en poursuivant les objectifs de couverture sanitaire universelle et les Objectifs de développement durable (ODD).[96]

En Amérique du Sud, des pays comme Cuba, le Brésil et la Colombie ont développé des systèmes de santé communautaire avec des médecins de famille au cœur de leur approche.

À Cuba, chaque famille est suivie par un médecin et une infirmière, ce qui permet un suivi régulier et personnalisé. Cette méthode préventive, axée sur l'éducation à la santé, a contribué à des taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus bas du continent.

En Colombie, la triade communautaire, composée de médecins, d'infirmières et d'agents de santé communautaire, offre une approche intégrée pour améliorer l'accès aux soins et renforcer la prévention des maladies. Ces modèles ont non seulement amélioré les indicateurs de santé, mais ont aussi aidé à mieux gérer les conditions de santé chroniques au sein des communautés.[97]

En conclusion, les systèmes de santé communautaire les plus performants à travers le monde partagent des caractéristiques communes : une approche décentralisée, une forte implication communautaire, et un accent marqué sur la prévention. Ces initiatives montrent qu'en adaptant

[92] Patrick Marx, « La santé communautaire : un levier pour faciliter l'accès à la couverture maladie universelle ? – Focus sur plusieurs expériences internationales de soins communautaires », (2020).
[93] Federal Ministry of Health Ethiopia, "Health Sector Transformation Plan II (HSTP II) 2020/21 - 2024/25," 2020.
[94] Assefa, Y., et al., "Successes and challenges of the Health Extension Program in Ethiopia: A review of the evidence," Journal of Global Health, 2019.
[95] Community Health Influencers, Promoters and Services (CHIPS) – NPHCDA [Internet]. [cité 23 août 2024]. Disponible sur: https://nphcda.gov.ng/chips/
[96] OMS | Bureau régional pour l'Afrique Botswana's investment in primary health care enhances access and quality of health care in the country. 2024
[97] Mosquera, P. A., Decat, P., Zapata, Y., Borghi, J., & De Paepe :" Experiences in community health promotion in Buenaventura, Colombia". Salud pública de méxico, P. 2018

les services de santé aux réalités locales et en renforçant les capacités des communautés, il est possible d'améliorer significativement les indicateurs de santé, même dans les environnements les plus défavorisés.

2.4. Analyse FFOM du système de santé communautaire

Les forces et opportunités ainsi que les faiblesses et les menaces qui ont constitué respectivement les facteurs de succès et les obstacles ou goulots d'étranglement rencontrés au cours des années précédentes sont analysées par domaines stratégiques du système de santé communautaire en lien avec les axes stratégiques du PNDS 2019-2022.

Le premier domaine est en lien avec l'axe stratégique du PNDS 2019-2022 relatif à l'amélioration des prestations de services de santé et continuité des soins de qualité aux différents niveaux du système de santé.

Le deuxième domaine est en lien avec l'axe stratégique du PNDS 2019-2022 relatif à l'appui aux piliers du système de santé pour l'amélioration de la disponibilité et l'accès aux soins de qualité.

Le troisième domaine est lien avec l'axe stratégique du PNDS 2019-2022 relatif au renforcement de la gouvernance et du système de santé.

Tableau 20: Matrice d'analyse FFOM du système de santé communautaire de la RDC

Environnement interne et externe	Domaines stratégiques du système de santé communautaire		
	Prestations des services de santé communautaires	Ressources en santé communautaire (RH, Financement, SNIS, Gestion de la chaine d'approvisionnement, y compris CREC)	Gouvernance et leadership en santé communautaire
Forces	– La plupart d'interventions de lutte contre le paludisme, la TB, le VIH, la planification familiale, la SMNE sont intégrées dans le paquet de soins et services de santé communautaire – La politique de la santé communautaire soutient clairement la polyvalence des ASC et RECO	– Existence de quelques formes d'incitations financières en faveur des ASC et RECO – Processus de digitalisation des données DHIS-2 communautaire en cours de développement	– Prise en compte de la promotion de la Particom dans les documents de planification (PNDS-PS) – Les soins et services de SACO sont offerts gratuitement – Existence des quelques structures dynamiques de coordination – Les membres des organes de Particom sont élus par la communauté et sont redevables vis à vis d'elle – Existence d'une collaboration entre les organes de particom et les ESS – Existence d'un guide de surveillance de la faune domestique et d'élevage
Faiblesses	– Faible respect des normes de mise en place des CAC et des CODESA, – Faible fonctionnalité des CAC et CODESA marquée surtout par le manque de dénombrement des populations cibles et la faible disponibilité d'un PAC et micro plan souvent non mis en œuvre ; – Faible supervision mensuelle inferieure à la moitié des CAC (47,2%) et des CODESA ; – Une très faible couverture (1/6) des sites des soins pour la prise en charge des maladies ; – Faible performance du système de surveillance communautaire des maladies de la faune domestique et sauvage	– Insuffisance quantitative et qualitative des ASC et RECO souvent dépourvus des matériels et outils de gestion – Contribution quasi inexistante de la partie gouvernementale (Centrale, provinciale et ETD) comme source indispensable de financement dans les appuis budgétaires des interventions de la santé communautaire. – Faible alignement des appuis des partenaires au développement destinés aux priorités du pays où plusieurs mécanismes de gestion et approches de mise en œuvre sont utilisés – Les normes en place du pays ne recommandent pas l'accréditation des ASC et RECO – Les données communautaires ne sont pas facilement accessibles aux intervenants – Faible coordination des ACSA – Absence participation de la communauté dans la surveillance de la faune sauvage (membres de la communauté en contact permanent avec la faune, chasseur, pêcheur etc.)	– Inexistence d'une politique nationale sur la rémunération des ASC et RECO – Absence d'une ligne budgétaire gouvernementale ni d'investissements nationaux cohérents en faveur de la santé communautaire – Absence des textes et politiques sur la professionnalisation des ASC et RECO – Absence des textes réglementaires sur l'institutionnalisation de la SACO – Inexistence d'un guide de surveillance des maladies de la faune sauvage – Absence d'un guide de surveillance des facteurs environnementaux et climatiques

Environnement interne et externe	Domaines stratégiques du système de santé communautaire		
	Prestations des services de santé communautaires	Ressources en santé communautaire (RH, Financement, SNIS, Gestion de la chaine d'approvisionnement, y compris CREC)	Gouvernance et leadership en santé communautaire
Opportunités	– Mise en œuvre effective de la gratuité de soins prénatals, d'accouchement et des soins du nouveau-né – Existence d'un système d'évaluation (MAA au niveau communautaire) à l'absence des enquêtes	– Extension du réseau de médias de proximité (Radio-télévision) et diversification des formats de médias participatifs – Existence d'une politique de la décentralisation comme mode de gestion dans les Entités Territoriales Décentralisées (ETD) – Entame de la réforme de l'administration publique avec le mode budget-programme – Intégration des ACSA	– La prise en compte des questions du genre est également consacrée dans la constitution, ce qui pose le fondement pour une implication des femmes comme partie prenante dans les approches communautaires. – Existence des organes de facilitation/pilotage de la CSU. – Existence des plateformes multisectorielles de coordination des programmes prioritaires
Menaces	– US et coutumes défavorables à l'accès aux services de santé communautaire dans certaines communautés	– Pauvreté multidimensionnelle de la population – Forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour le financement	– Guerres et insécurité récurrentes dans certaines provinces du pays – Emergence et réémergence des maladies épidémiques (Covid ; MPOX, MVE, Cholera, etc. – Insuffisance de textes réglementaires et législatifs protégeant le droit des populations vulnérables (enfant)

2.5. Problèmes prioritaires du système de santé communautaire

Les problèmes prioritaires du système de santé communautaire découlent des analyses de la revue des performances du système de santé communautaire en tenant compte d'autres déterminants sociaux de la santé. Ces problèmes sont identifiés selon les domaines suivants de la santé communautaire : (i) la gouvernance ou leadership, (ii) le financement, (iii) les ressources humaines, (iv) les prestations, (v) la gestion de la chaine d'approvisionnement, (vi) le système d'information sanitaire et (vii) la communication sur les risques, engagement communautaire.

2.5.1. Problèmes prioritaires liés à la gouvernance et au leadership

- Absence d'un cadre légal pour l'institutionnalisation de la santé communautaire ;
- Absence d'une politique de la santé communautaire qui tiendra compte de la collaboration intra et intersectorielle en mettant un accent sur l'approche « Une santé » ;
- Faible fonctionnalité de la coordination stratégique et opérationnelle généralement liée :
  - A l'absence de l'alignement des intervenants dans une équipe, un plan, un budget et un cadre de suivi et évaluation en faveur de la santé communautaire ;
  - A la non-actualisation du dénombrement des populations cibles (49% pour les CAC) et une faible disponibilité et mise en œuvre d'un Plan d'action communautaire (34,9% pour CAC et 50% pour CODESA) ;
  - Au faible respect des normes de mise en place des CAC et des CODESA, dont plus de la moitié n'ont reçu ni formation adéquate ni dotation en matériels et outils de gestion ;
  - Au déficit ou même caducité de quelques éléments fondamentaux pour une assise réglementaire, politique, stratégique et normative.
- Faible capacité institutionnelle des programmes œuvrant dans la santé communautaire ;

- Inexistence d'une planification opérationnelle déclinée du plan stratégique de la santé communautaire et du suivi régulier intercalé des revues ou évaluations périodiques à la suite du faible niveau de vulgarisation du plan stratégique de la santé communautaire ;
- Faible partenariat et collaboration intra et multisectoriel lié à la non consolidation/mise en place des cadres de concertations et de redevabilité, adaptés aux réformes amorcées au pays et en international.

2.5.2. Problèmes prioritaires liés au financement en santé communautaire

- Inexistence d'une ligne budgétaire en faveur de la santé communautaire dans le budget national ;
- Inexistence d'un dossier d'investissement avec plan à long terme de viabilité financière de la santé communautaire ;
- Inexistence de cartographie annuelle des ressources financières de la santé communautaire ;
- Utilisation inefficiente des ressources existantes souvent fragmentées et non incluses dans les appuis budgétaires et faiblement alignés aux priorités du système de santé par suite de la multiplicité des mécanismes de gestion et approches de mise en œuvre à l'absence d'un basket fund (mise en commun). Ce qui rend difficile le suivi de leur décaissement et l'évaluation en termes des résultats attendus ;
- Insuffisance des mécanismes innovants de financement durable du système de santé communautaire (mutuelle de santé, tiers payant, tarification subsidié, subvention de l'Etat, etc.).

2.5.3. Problèmes prioritaires liés aux ressources humaines en santé communautaire

- Non professionnalisation des acteurs communautaires (ASC et RECO) liée à l'absence d'un cadre réglementaire de formation continue sans certification officielle et au faible niveau de supervision formative pour un renforcement continu des compétences.
- Faible motivation et fidélisation des ASC et RECO liée au statut de volontaire en dépit de la reconnaissance sociale par les membres de la communauté et des collations ponctuelles comme lors des activités de masse (campagnes de vaccination ou distribution de la MILD).
- Inexistence d'un plan de développement et de déploiement des ASC et RECO et cadres dédiés à la santé communautaire pour une couverture nationale équitable.
- Non actualisation de la cartographie des ASC et RECO avec géoréférencement et liste maitresse nationale pour en assurer une distribution équitable sur l'étendue nationale
- Faible structuration des acteurs communautaires de surveillance des animaux domestiques et d'élevage (ACSA) ;
- Inexistence des agents communautaires de surveillance de la faune sauvage (chasseurs, pêcheurs, etc.).

2.5.4. Problèmes prioritaires liés aux prestations des services en santé communautaire et à la résilience du système de santé face aux urgences et risques sanitaires

- Inadéquation ou non intégration du paquet des soins et services de santé communautaire avec la CSU et les interventions liées à la sécurité sanitaire pour faciliter la réalisation des objectifs de développement durable.
- Faible couverture de l'offre et de l'accès aux services de santé communautaires de qualité et équitable en lien avec l'implémentation ou l'extension, la supervision et le suivi des interventions clés à base communautaire.
- Absence des recherches opérationnelles thématiques d'envergure nationale (étude pilote sur certaines innovations telles que la triade communautaire, AGR, supervision formative

intégrée, modèle de gouvernance multisectorielle, etc.) susceptible de développer des modèles de santé communautaire adaptés à la RDC pour une bonne prise de décision.

- Faible extension et appui au fonctionnement des sites des soins communautaires existants pour une couverture totale des populations au-delà de 5 kilomètres des ESS.
- Faible participation des acteurs communautaires dans la surveillance épidémiologique à base communautaire lors de la gestion des urgences de santé publique (prévention préparation, riposte et résilience).
- Faible opérationnalisation de la surveillance communautaire des maladies de la faune domestique et sauvage ainsi que des facteurs environnementaux et climatiques.

2.5.5. Problèmes prioritaires liés à la gestion de la chaine d'approvisionnement et au système d'information en santé communautaire

- Non maitrise de besoins et de gestion des médicaments et autres produits traceurs de santé communautaire ;
- Non intégration des informations communautaires dans le système d'Information en Gestion Logistique (SIGL) ;
- Fonctionnalité non effective du SNIS communautaire pour améliorer la transformation digitale et la surveillance à base communautaire devant faciliter la remontée des informations communautaires en temps réel, liée à la faible dotation des organes de participation communautaire en équipements numériques ;
- Suivi peu rapproché de la mise en œuvre des interventions de qualité à base communautaire à tous les niveaux de la pyramide sanitaire à travers des approches de monitorage en temps réels de l'offre et de la qualité des services de santé communautaire par des modèles comme le MAA ;
- Absence de production des cartes de score/tableaux synoptiques communautaire à différents niveaux des organes de participation communautaire ;
- Insuffisance de production et de diffusion des rapports d'activités à différents niveaux ainsi que des bulletins d'information sanitaire de la santé communautaire.

2.5.6. Problèmes prioritaires liés à la communication sur les risques et à l'engagement communautaire

- Cartographie des organisations à assise communautaires non mis à jour ;
- Faible appui aux ASC/RECO et aux organes de participation communautaires dans la planification, la logistique et la sensibilisation ;
- Faible participation communautaire dans le développement des mécanismes d'appropriation de l'action sanitaire et du marketing social.

III. Cadre stratégique

3.1. Fondement de la santé communautaire

Pour bâtir son système de santé communautaire, la RDC a souscrit aux engagements aux niveaux international, régional, sous régional et national, et a mis en place quelques instruments règlementaires, politiques et stratégiques.

3.1.1. Engagements au niveau international, régional et sous régional

Sur le plan international, régional et sous régional, le Plan stratégique de santé communautaire 2025-2030 s'appuie principalement sur les engagements ci-après :

- La Déclaration d'Alma-Ata tenue en septembre 1978 qui affirme les soins de santé primaires comme stratégie sanitaire avec la communauté placée au cœur de l'action en tant que partenaire, acteur et bénéficiaire ;
- La Conférence de Kinshasa en 1990 sur le financement de la santé communautaire ;
- La Conférence de Brazzaville en 1992 sur la promotion du développement de la santé communautaire ;
- La Décision des Chefs d'États de l'Union africaine en 2004 sur l'accélération des initiatives sur la survie de l'enfant ;
- Le Règlement sanitaire international 2005 ;
- La Déclaration d'Addis-Abeba en 2006 sur la santé communautaire dans la région africaine pour garantir l'accès universel à des soins de santé de bonne qualité et un avenir plus salutaire aux populations africaines ;
- Le 3ème Forum mondial sur les ressources humaines pour la santé, tenu en 2013 à Recife au Brésil concluant que les ASC, de même que les agents de soins de santé primaires intervenant en première ligne, « jouaient un rôle unique, qui pouvait se révéler essentiel pour accélérer la réalisation des OMD et CSU » ;
- Stratégie africaine de la santé 2016-2030 ;
- La conférence sur l'institutionnalisation de la santé communautaire tenue Johannesburg en décembre 2017 ;
- Les orientations et recommandations de l'OMS sur la professionnalisation des ASC et la nécessité de s'appuyer sur la constitution d'un « Pipeline rural » afin de fidéliser les acteurs majeurs locaux de la santé communautaire ;
- La Stratégie régionale pour la sécurité sanitaire et la gestion des situations d'urgence 2022-2030 ;
- Appel à l'action de Monrovia au Libéria tenu en mars 2023 lors du 3ème Symposium international sur les ASC recommandant de faire des ASC professionnels la norme ;
- Consultation par pays pour des soins de santé primaires plus solides et plus équitables, et la préparation et intervention en cas d'urgence, tenue à Addis-Abeba en 2024 pour l'institutionnalisation des ASC dans le cadre du renforcement des systèmes de santé résilients et numérisés ;
- Les Priorités stratégiques quinquennales du CDC Afrique en matière de santé communautaire (2024-2028) ;
- Les Résolutions de l'Agenda 2030 des ODD qui souligne l'importance d'un Programme du peuple, par le peuple et pour le peuple pour une meilleure garantie de succès ;
- La Déclaration d'Astana en 2018 qui réaffirme l'urgence et la pertinence des Soins de Santé Primaires pour atteindre la CSU et les ODD ;
- Stratégie africaine de la santé 2016-2030 ;

- Les Directives de l'OMS en 2018 sur la politique de santé et l'accompagnement au sein du système en vue d'optimiser les programmes relatifs aux agents de santé communautaire ;
- La Déclaration et recommandations sur les Soins de santé primaires, la participation communautaire et l'institutionnalisation des approches communautaires dans le contexte de la CSU pour atteindre les ODD ;

3.1.2. Engagements au niveau national

Sur le plan national, ce plan stratégique tire ses fondements des sources suivantes :

- La Constitution de la RDC dans son article 47, garantit le droit à la santé et à la sécurité alimentaire pour toute la population Congolaise ;
- La Stratégie de développement sur la participation communautaire d'octobre 2016 ;
- Le plan d'actions national 2018 pour la sécurité sanitaire qui consacre l'engagement communautaire comme axe d'interventions dans le cadre de la préparation, riposte et résilience dans la gestion des épidémies et autres urgences de santé publique ;
- L'ordonnance-loi n° 23/006 du 3 mars 2023, modifiant et complétant la loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique et institue dans son article 4, le système national de santé pour prévenir les maladies, maintenir, restaurer et promouvoir la santé de la population ;
- La Vison du Chef de l'Etat qui fait de la santé, un des piliers de ses programmes d'action notamment la CSU, intimement liée à la santé communautaire ;
- Le PNSD 2024-2028 qui prend en compte la promotion de la participation communautaire comme un des piliers ;
- Le Programme d'Action du Gouvernement (PAG) 2024-2028 ;
- Le Plan Stratégique National-CSU 2021-2030 ;
- La Vision du Ministre de la santé sur l'introduction de l'approche « Triade communautaire » ;
- Le PNDS-PS 2024-2033 qui définit les grandes priorités du secteur dans le domaine de l'amélioration des prestations des services de santé de qualité et continuité des soins dans une approche de soins de santé primaires avec un focus sur la santé communautaire ;
- Les plans stratégiques sous sectoriels en rapport avec principalement la PCIMNE, le VIH/Sida, la Tuberculose et le Paludisme, y compris la Nutrition, etc. ;
- Le Plan d'extension des SSC 2024-2028 qui définit les priorités de mise en œuvre des SSC ;
- Le Guide de mise en œuvre des SSC en avril 2023 donne des orientations à différentes étapes allant de l'identification et sélection des SSC à la formation, suivi post-formation et supervision des activités en passant par la liste recommandée des équipements, matériels, médicaments et outils ainsi que la sélection des RECOSITES et membres des CAC ;
- Le Plan de digitalisation de la santé communautaire en RDC, 2025 – 2030 (en cours de finalisation). Ce plan constitue une opportunité pour renforcer les capacités des ASC par l'intégration des technologies numériques dans le système de gestion des données.

3.2. Vision, mission, principes directeurs et valeurs

3.2.1. Vision

A l'horizon 2030, la vision de la RDC en matière de la santé communautaire est « d'amener les communautés à être autonomes, autodéterminées, suffisamment responsables de leur santé et bien-être, et résilientes face aux urgences sanitaires pour un développement durable ».

3.2.2. Mission

La mission de la RDC en matière de santé communautaire est d'assurer la promotion de développement des communautés dans un esprit d'auto-détermination, d'autonomisation,

d'auto-responsabilisation et de pleine participation visant l'accès aux services sociaux de base appropriés dans l'optique des missions du système national de la santé.

3.2.3. Principes directeurs et valeurs

Pour assurer l'efficacité, la durabilité et l'impact positif de la santé communautaire, la mise en œuvre de ce plan sera principalement guidée par les principes directeurs ci-après :

L'engagement et la participation communautaire : Un accent devrait être mis sur l'auto-responsabilisation des communautés qui doivent être placées au cœur de l'action dans la planification et gestion des interventions sanitaires en tant que partenaires, acteurs et bénéficiaires. Ce principe est fondamental dans le cadre de contrôle citoyen par les OSC pour rénover leur engagement dans le suivi communautaire.

La coordination et leadership : Ce principe suppose que tous les efforts des parties prenantes doivent être harmonisés et alignés par rapport à la vision du pays autour des objectifs communs ; ce qui nécessite un leadership politique et technique agissant.

Le partenariat efficace et la collaboration multisectorielle : Il importe de renforcer le partenariat avec les acteurs du secteur de la santé et d'autres secteurs selon l'approche "Une seule santé".

L'intégration des interventions : Pour améliorer l'efficience et l'efficacité des prestations communautaires (curatifs, préventifs, promotionnels et ré adaptatifs), il est judicieux d'utiliser une approche globale et intégrée grâce à un personnel polyvalent et compétent.

L'équité et le genre : Pour s'assurer que nul n'est laissé pour compte, il est nécessaire de porter toute l'attention voulue à toutes les tranches d'âge, quel que soit le sexe ; de même qu'aux populations vulnérables et marginalisées, en utilisant une démarche ancrée sur les droits de l'homme et respectueuse des spécificités de chaque sexe.

La redevabilité : Pour renforcer la confiance entre les acteurs, il importe de s'assurer, d'une part, des résultats, des ressources et des droits ainsi que la dignité et la sécurité des personnes touchées, et d'autre part, de l'obligation mutuelle de rendre compte. Quant à la redevabilité, elle implique que les responsables s'acquittent de leur responsabilité à travers une transparence dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation.

L'innovation et l'emploi des technologies : Dans un contexte caractérisé par des ressources limitées, il convient d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) pour améliorer la couverture des services, en particulier dans les zones d'accès difficiles.

Les principes directeurs ci-dessus décrits exigeront deux valeurs essentielles, à savoir la **compétence** et l'**éthique**

3.3. But, objectifs stratégiques et résultats attendus

3.3.1. But

Le but est d'améliorer la santé et le bien-être de la population congolaise par la mise en place d'un système de santé communautaire fort, résilient et équitable avec la pleine participation des communautés dans le cadre de la CSU et de la sécurité sanitaire à l'horizon 2030.

3.3.2. Objectif stratégique général

Contribuer aux efforts sectoriels relatifs à la réduction de la morbidité, de la mortalité, du handicap et à la résilience des communautés face aux situations d'urgences et risques sanitaires ainsi qu'à leur protection contre le risque financier d'ici à 2030.

3.3.3. Objectifs spécifiques

Six objectifs spécifiques permettront d'atteindre l'objectif général assigné, à savoir :

1. Promouvoir les pratiques familiales essentielles favorables à la santé et au bien-être dans au moins 80% des communautés de chaque village/cellule d'ici à 2030 ;
2. Accroitre la couverture des SSC à au moins 50% dans les villages/cellules éligibles (n'ayant pas accès facile aux ESS) d'ici à 2030 ;
3. Renforcer les capacités de prévention, préparation et riposte d'au moins 80% des communautés de chaque village/cellule face aux urgences de santé publique et aux effets du changement climatique d'ici à 2030 ;
4. Accroître les financements et les investissements en faveurs de la santé communautaire d'ici à 2030 ;
5. Développer un système d'information sanitaires communautaire et de la recherche opérationnelle axé sur la transformation digitale d'ici à 2030 ;
6. Renforcer la gouvernance en santé communautaire pour garantir l'offre et l'utilisation des services de santé de qualité d'ici à 2030.

3.3.4. Résultats et cibles attendus

- **Cible 1** : D'ici à 2030, au moins 80% des communautés de chaque village/cellule adoptent des comportements favorables à leur santé et bien-être ;
- **Cible 2** : D'ici à 2030, au moins 50% des SSC sont utilisés par les communautés de chaque village/cellule ayant un accès difficile aux ESS ;
- **Cible 3** : D'ici à 2030, au moins 80% des communautés de chaque village/cellule sont résilientes face aux urgences de santé publique (épidémies et catastrophes naturelles) et aux effets climatiques ;
- **Cible 4** : D'ici à 2030, au moins 60% des communautés sont protégées contre les dépenses catastrophiques de santé découlant de l'accès aux services de santé et de leur utilisation ;
- **Cible 5** : D'ici à 2030, le sous-secteur « Santé communautaire » dispose d'un système d'information sanitaire fonctionnel à au moins 80%, appuyée par des recherches opérationnelles ;
- **Cible 6** : D'ici à 2030, tous les organes de gouvernance de la santé communautaire assurent une gestion optimale et jouent pleinement leurs rôles de coordination synergique à tous les niveaux pour garantir l'offre de qualité des services à base communautaires » et l'utilisation des services de santé.

3.4. Axes ou priorités stratégiques, interventions et actions prioritaires

La mise en œuvre du présent plan stratégique prendra en compte les priorités internationales et nationales ainsi que les réformes en cours, dont celle de l'Administration publique.

Ainsi pour atteindre chaque cible attendue de ce plan, les axes ou priorités stratégiques ainsi que les interventions et actions prioritaires qui en découlent sont formulés de manière à répondre efficacement aux défis majeurs ou problèmes ci-haut identifiés. Pour y parvenir, six axes stratégiques sont retenus dont les quatre premiers sont des axes de base et les deux derniers des axes d'appui. Il s'agit de :

- Axe stratégique 1 : Promotion des pratiques familiales essentielles ;
- Axe stratégique 2 : Amélioration de l'offre des soins et services de santé au niveau communautaire ;
- Axe stratégique 3 : Renforcement de la prévention, préparation et riposte communautaire face aux urgences de santé publique (épidémies et catastrophes naturelles) ;

- Axe stratégique 4 : Accroissement des financements et d'autres investissements en faveur de la santé communautaire ;
- Axe stratégique 5 : Développement du système d'information sanitaire communautaire et recherche opérationnelle appuyés par la digitalisation ;
- Axe stratégique 6 : Renforcement de la gouvernance en santé communautaire.

3.4.1. Axe stratégique 1 : Promotion des pratiques familiales essentielles

La mise en œuvre de cet axe stratégique vise à amener les communautés à adopter des pratiques familiales essentielles (PFE) comme modes de vie sains et des comportements favorables à la santé. Pour y parvenir, trois interventions sont retenues, à savoir :

- Appui aux prestations préventives et promotionnelles des organes de participation communautaires ;
- Suivi de la mise en œuvre des actions et prestations communautaires (prévention et promotion) ;
- Communication pour changement social et de comportement des communautés (CCSC).

Intervention 1.1 : Appui aux prestations préventives et promotionnelles des organes de participation communautaires

Cette intervention vise l'amélioration de la disponibilité et l'accès aux services essentiels (promotionnels, préventifs, réadaptation) d'au moins 80% des communautés de chaque village. Ainsi, les actions spécifiques à implémenter pour atteindre cet objectif porteront sur :

- Elaboration /actualisation des documents de formation sur le paquet intégré d'activités communautaires ;
- Mise en place des pools de formateurs nationaux et provinciaux ;
- Appui à la formation des membres des organes de participation communautaires du niveau opérationnel sur le paquet intégré d'activités communautaires préventives et promotionnelles ;
- Dotation en matériels, équipements et outils de gestion et de communication.

De manière opérationnelle, neuf (8) documents identifiés seront élaborés et/ou actualisés pour servir d'outils de formation des acteurs communautaires sur le paquet intégré au cours des ateliers, il s'agit de (i) module intégré de formation des RECO, (ii) module intégré de formation des ASC, (iii) module de supervision ASC, PRESICAC et AC, (iv) module de formation sur le rapportage SNIS, (v) module de formation sur le suivi et évaluation, (vi) module de formation sur la gestion des AGR, (vii) module de formation en faveur des acteurs communautaires sur le suivi/contrôle citoyen, (viii) module de formation sur le mentorat). Parmi ces acteurs, on note un pool national d'au moins 25 experts et 26 pools provinciaux (5 cadres par province). Au niveau périphérique, l'appui à la formation concernera 5 membres des 519 UCODESA, 5 membres des 11 689 CODESA et 4 membres des 118 254 CAC.

Quant à la dotation des CODESA et CAC, ils seront approvisionnés en outils de collecte et transmission des données, y compris ceux de gestion ; en matériels et équipements des prestations, supports de communication (boite à image) et en médicaments et intrants (Cfr liste détaillée en annexe).

Intervention 1.2 : Suivi de la mise en œuvre des actions et prestations communautaires (prévention et promotion)

L'objectif est de s'assurer de la bonne marche des prestations à caractère préventif et promotionnel ainsi que les approches capitalisées conduites par les organes de participation communautaires.

Pour y parvenir, les actions suivantes seront implémentées ; à savoir :

- Suivi post formation des membres des organes de Particom sur le paquet intégré d'activités communautaires ;
- Suivi communautaire intégré des cibles prioritaires au niveau des ménages.

Les membres des organes de Particom formés seront suivis par les structures hiérarchiques immédiatement supérieures selon le rythme fixé par les normes et directives en vigueur relatives à la professionnalisation des ASC et RECO et cela, pendant 3 mois pour un encadrement de 7 jours par mois. En outre, toutes les approches communautaires intégrées ciblant les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les ménages feront l'objet d'un suivi continue de la part des RECO **(suivi longitudinal et personnalisé des ménages)** alors que les supervisions formatives intégrées seront mensuelles, il s'agira des supervisions des ASC ou PrésiCAC auprès des RECO des CAC et des IT auprès des CODESA.

Intervention 1.3 : Communication pour le changement social et de comportement des communautés (CCSC)

La communication dans le cadre de cette intervention vise à promouvoir un changement durable des communautés en influençant de manière positive les attitudes, comportements et normes sociales dans un processus inclusif valorisant leurs connaissances, leurs expériences et leur pouvoir d'agir.

Il s'agira de mettre en œuvre les actions suivantes :

- Élaboration du plan d'action opérationnel de santé communautaire (PAO SACO) avec plan d'action intégré de communication (PAIC) sur les PFE ;
- Promotion de l'approche "Accroître la communication de qualité dans les services de santé" (ACQUASS) à travers le marketing social et la communication pour la santé.

Il s'agira d'un exercice de routine pour opérationnaliser la PSN SACO 2025-2030, au travers l'élaboration et la mise en œuvre des PAO SACO (qui intègrent le PAIC).

Pour ce qui concerne l'approche "ACQUASS", il sied de rappeler qu'elle consiste à mettre en œuvre un paquet d'interventions ciblées et combinées pour le changement social et de comportement dans la communauté. Parmi ces interventions, on note les émissions radio ou télévisées, les visite à domicile, les causeries éducatives, les quiz au marché, les vidéo forum et l'arbre à palabre au village, etc.

3.4.2. Axe stratégique 2 : Amélioration de l'offre des soins et services de santé au niveau communautaire

Cet axe stratégique vise l'amélioration de l'accès aux soins de qualité aux populations n'ayant pas un accès facile aux ESS. Les interventions y afférentes devront se focaliser sur le besoin des SSC à combler dans les AS où l'accès géographique au CS constitue un obstacle majeur, d'une part ; et de renforcer les compétences des ASC dans un cadre réglementaire de motivation et de formation continue certifiante.

Ces SSC seront rationalisés progressivement selon une priorisation qui tiendra compte des emplacements optimisés. Les ASC seront dédiés en vue d'assurer un paquet intégré allant de l'identification à la prise en charge précoce des cas simples. Les cas graves et ceux nécessitant les interventions spécifiques étant orientés immédiatement vers les CS.

Les interventions spécifiques à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif sont :

- Accroissement de la couverture des SSC fonctionnels de 21% à 50% ;
- Appui à l'offre des paquets intégrés des interventions curatives ;
- Professionnalisation des ASC.

Intervention 2.1 : Accroissement de la couverture des SSC fonctionnels de 21% à 50%

Cette intervention vise à augmenter la proportion des SSC parmi les existants, passant ainsi de 21% à 50%, soit un passage de 10 112 en 2022 à 24 453 SSC en 2030 sur un besoin estimé à 48 906 SSC. Il sera question de s'assurer que les SSC puissent être installés aux endroits répondant aux critères définis dans le guide de mise en œuvre.

Pour ce faire, les actions ci-dessous sont envisagées :

- Estimation des besoins de SSC par le modèle cartographique avec géoréférencement (tous les 3 ans) ;
- Installation des nouveaux SSC suivant l'emplacement optimisé et révisitation de l'emplacement des anciens SSC ;
- Élaboration/actualisation annuelle de la cartographie des ASC et RECO avec liste maîtresse nationale géoréférencée ;
- Élaboration du plan de développement et de déploiement des ASC et RECO (PDD ASC et RECO) pour une couverture nationale équitable (y compris le volet logistique).

Intervention 2.2 : **Appui à l'offre des paquets intégrés des interventions curatives**

Cette intervention vise à améliorer le contenu de l'offre de services de prise en charge au niveau communautaire avec un paquet d'intervention tout en tenant compte de l'actuel statut des ASC/Recosites. Elle sera focalisée sur les actions suivantes :

- Rationalisation des intervenants dans les provinces des convergences et identification des synergies d'actions dans la mise en œuvre du paquet intégré d'interventions ;
- Dotation des SSC en médicaments, intrants traceurs, supports et petits matériels ;

Intervention 2.3 : Professionnalisation des ASC

Cette intervention vise l'amélioration de la qualité du travail des ASC et l'impact des services de santé en les intégrant comme agents certifiés avec comme conséquences la rémunération et la redevabilité.

Les actions suivantes seront implémentées :

- Plaidoyer auprès de la fonction publique pour l'admission des ASC/Recosites certifiés comme étant des agents sous contrat ;
- Mise en place des mécanismes d'incitation financière en faveur des acteurs communautaires (ASC et RECO) ;
- Elaboration du manuel des procédures de contractualisation des ASC ;
- Suivi-supervision formatives périodiques intégrés.

3.4.3. Axe stratégique 3 : Renforcement de la prévention, préparation et riposte communautaire face aux urgences de santé publique (épidémies et catastrophes naturelles) et aux effets climatiques

La mise en œuvre de cette priorité stratégique vise à développer la résilience des communautés, à garantir une réponse rapide et efficace en cas d'urgence, catastrophes et effets climatiques afin de minimiser leurs impacts sanitaires. Les interventions y relatives permettront de réduire les risques sanitaires et environnementaux auxquels les communautés sont exposées avant qu'ils ne se transforment en crises majeures.

Ainsi, deux interventions essentielles seront menées, à savoir :

- Renforcement des capacités des acteurs et organes de participation communautaires à tous les niveaux pour la préparation et riposte ;
- Appui aux prestations des services de santé essentiels de qualité et au partenariat stratégique ainsi qu'à la synergie d'action selon l'approche "Une santé".

Intervention 3.1 : Renforcement des capacités des acteurs et organes de participation communautaire à tous les niveaux pour la préparation et riposte

L'objectif pour cette intervention est de renforcer les capacités des acteurs communautaires à détecter précocement les événements inhabituels et tout cas suspect, d'une part ; et à riposter efficacement, d'autre part.

Les actions suivantes seront menées :

- Appui à l'élaboration/mise à jour de la cartographie des risques (tous les 2 ans) ;
- Appui à la surveillance à base communautaire par la mise en place d'un système d'alerte précoce ;
- Appui à l'élaboration des plans de préparation et de riposte multirisques ;
- Mise en place des pools de formateurs nationaux et provinciaux sur le système d'alerte précoce et de surveillance intégrée à base communautaire, y compris sur la préparation et riposte communautaire aux urgences de santé publique selon l'approche « Une Santé »
- Appui à la formation des acteurs communautaires sur la SIMR 3ème édition et la gestion des urgences de santé publique selon l'approche « Une Santé »
- Dotation des CODESA et CAC en matériels et outils traceurs pour la détection précoce des maladies sous surveillance communautaire.

Intervention 3.2 : Appui aux prestations des services de santé essentiels de qualité et au partenariat stratégique et à la synergie d'action selon l'approche « Une seule santé »

Cette intervention vise à appuyer la bonne marche des prestations et du partenariat lors des urgences et catastrophes. Sa mise en œuvre exigera les actions suivantes :

- Appui à l'assurance de la couverture vaccinale requise de la population contre les risques posés par les maladies à prévention vaccinale ;
- Appui des Task Forces multisectorielles provinciales de communication à l'élaboration d'une feuille de route « Une seule santé » en vertu du RSI et de la sécurité sanitaire ;
- Appui à l'intégration des approches multisectorielles à base communautaire à travers les CAC ;
- Suivi de mise en œuvre de la feuille de route « Une seule santé » dans les DPS.

3.4.4. Axe stratégique 4 : Accroissement des financements et d'autres investissements en faveur de la santé communautaire

L'objectif poursuivi dans cet axe stratégique est de réduire le risque financier aux services de santé de base et d'améliorer les performances du système de santé communautaire. La proportion des populations protégées contre les dépenses catastrophiques devrait s'accroître au moyen d'un financement innovant. Les populations vulnérables devraient être identifiées en fonction du revenu, de l'incapacité, du genre, de l'âge, du statut social ; et leurs dépenses de santé devraient être surveillées.

Trois interventions seront mises en œuvre pour assurer un soutien efficace et équitable des programmes durables de la santé communautaire. Il s'agit de :

- Mobilisation des ressources en faveur de la santé communautaire ;
- Développement des mécanismes de partage des risques existants et innovations du financement durable du système de santé communautaire ;
- État des lieux des populations vulnérables en vue de leur sécurisation face aux dépenses catastrophiques de santé.

Intervention 4.1 : Mobilisation des ressources en faveur de la santé communautaire

Cinq actions essentielles devront concourir à l'atteinte de cette intervention. Il s'agit de :

- Elaboration/actualisation de la cartographie annuelle des ressources financières et autres investissements en faveur de la santé communautaire ;
- Élaboration d'un dossier d'investissement (DI) pluriannuel avec plan de viabilité financière de la santé communautaire ;
- Organisation de forums de mobilisation des ressources financières et investissements nécessaires pour la mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030 à tous les niveaux ;
- Élaboration d'un plan de plaidoyer auprès des cibles primaires (Gouvernement, Parlement) au niveau national et provincial ;
- Organisation des séances de plaidoyer auprès des cibles primaires (Gouvernement, Parlement) au niveau national et provincial pour l'inscription d'une ligne dans le budget de l'Etat, y compris les financements innovants pour la santé communautaire.

Intervention 4.2 : - Développement des mécanismes de partage des risques existants et innovations du financement durable du système de santé communautaire

Plusieurs mécanismes de financement devront être mis en place tel que les mutuelles de santé, la création des AGR, la mise en place d'une caisse de solidarité, la subvention de l'Etat, etc. L'objectif étant d'améliorer l'accès des communautés aux services de santé de base.

Pour ce faire, les actions suivantes seront mises en œuvre :

- Mise en place d'un basket fund (panier commun) virtuel de tous les financements de la santé communautaire ;
- Plaidoyer auprès des APA (nationales et provinciales) pour les financements innovants en faveur de la santé communautaire ;
- Appui à la formation des CODESA sur les initiatives communautaires des mutuelles de santé (MUSA) ;
- Appui des CODESA au développement des activités génératrices de revenu (AGR) sous forme de coopérative.

Intervention 4.3 : État des lieux des populations vulnérables en vue de leur sécurisation face aux dépenses catastrophiques de santé

Cette intervention vise à sécuriser les populations vulnérables face aux dépenses catastrophiques. Pour ce faire, les actions porteront sur :

- Cartographie des populations vulnérables (ménages vivant en situation d'extrême pauvreté et n'ayant pas une bonne abordabilité financière aux soins et services de santé), tous les 2 ans ;
- Mise en place d'un mécanisme d'accroissement de l'abordabilité financière aux soins et services de santé de santé de base.

3.4.5. Axe stratégique 5 : Développement du système d'information sanitaire et recherche opérationnelle axés sur la digitalisation

Cette priorité constitue un axe stratégique transversal qui vise l'amélioration de la production, de l'utilisation et de la diffusion de l'information sanitaire communautaire à tous les niveaux pour une meilleure prise des décisions. Ainsi, la transformation digitale de l'information sanitaire se fera à travers des nombreuses initiatives de digitalisation qui devront être mises en place pour intégrer des outils numériques dans la mise en œuvre de certains aspects de prestation des services de santé au niveau communautaire.

Pour y parvenir, trois interventions devront être implémentées, à savoir :

- Formalisation du SNIS communautaire ;
- Appui à la digitalisation de la production et diffusion de l'information sanitaire communautaire de qualité pour faciliter la remontée des données en temps réel ;
- Documentation des bonnes pratiques, recherche opérationnelle ;
- Renforcement des mécanismes de suivi-évaluation et de redevabilité à tous les niveaux.

Intervention 5.1 : Formalisation du SNIS Communautaire

La formalisation du SNIS communautaire est un processus complexe qui nécessite une planification minutieuse, des ressources adéquates et une collaboration étroite entre les différents acteurs du secteur de la santé. Cette intervention vise à améliorer la collecte, l'analyse et la production ainsi que l'utilisation des données pour soutenir la prise de décision, la planification et la gestion des services de santé communautaire.

Différentes étapes devront être mises à contribution, à savoir : une évaluation initiale, la définition des indicateurs clés répondant aux priorités du pays, le développement d'une architecture adaptée avec des équipements nécessaires, tels que les serveurs, les ordinateurs et les réseaux de communication avant de mettre en place les utilisateurs appropriés en vue de faciliter l'accès aux données et de produire des rapports périodiques.

Pour ce faire, les actions suivantes sont retenues. Il s'agit de :

- Mise en place d'un cadre normatif du SNIS communautaire ;
- Vulgarisation du cadre normatif du SNIS communautaire à tous les niveaux (Sous-commission SACO, 26 Task forces provinciales, 519 UCODESA) ;
- Finalisation du développement du SNIS communautaire ;
- Formation des cadres et acteurs communautaires sur l'utilisation des outils numériques SNIS communautaire ;

- Dotation des 519 ZS en matériels et kit de communication pour l'utilisation numérique de la plateforme DHIS2-communautaire (Tablettes, panneaux solaires, modem, et autres fournitures) ;
- Production des bulletins trimestriels et annuaires d'informations de la santé communautaire ;
- Appui aux réunions mensuelles pour l'organisation des monitorages des interventions à base communautaire.

Intervention 5.2 : Appui à la digitalisation des prestations communautaires

La digitalisation des prestations communautaires vise à transformer et à optimiser la façon dont les services communautaires sont fournis, suivis et gérés grâce à l'utilisation des outils numériques. Cette transformation permet d'améliorer l'accès, l'efficacité et l'impact des soins notamment dans les zones rurales et mal desservies.

Ainsi, cette intervention sera mise en œuvre progressivement à travers les actions prioritaires suivantes :

- Finalisation et validation d'un plan de la digitalisation du SNIS communautaire 2025-2030 en adéquation avec le PSN SACO 2025-2030 ;
- Développement et pré test des outils numériques du SNIS communautaire ;
- Mise en place des mécanismes de connectivité adaptés au contexte du pays ;
- Développement du portail Web de santé communautaire pour assurer la diffusion continuelle des informations ;
- Intégration du portail Web de santé communautaire dans celui du ministère de la santé.

Intervention 5.3 : Documentation des bonnes pratiques et recherche opérationnelle

Les bonnes pratiques et expériences identifiées au cours de la mise en œuvre de ce PSN SACO 2025-2030 à tous les niveaux feront l'objet de la capitalisation et serviront d'évidences pour alimenter les politiques, stratégies et normes en santé communautaire.

Les actions ci-après seront envisagées :

- Recherche-action sur l'approche village santé (toute la période de mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030) ;
- Recherche-action sur les thématiques en lien avec les défis persistants de la santé communautaire ;
- Étude sur les approches ou thématiques spécifiques (exemple AFASAC) ;
- Documentation et capitalisation des bonnes pratiques de mise en œuvre des approches telles que la « ligne verte » de redevabilité et de dénonciation des abus et des fraudes commis dans la communauté, le suivi dirigé par la communauté, la mise en place des CAC et CODESA, etc. ;
- Extension des bonnes pratiques mises en œuvre et documentées (ligne verte, suivi dirigé) ;
- Organisation des missions annuelles de partage d'expériences à l'étranger sur la santé communautaire ;
- Organisation des forums internationaux et inter provinciaux d'échange d'expériences par an sur la santé communautaire.

Intervention 5.4 : Renforcement des mécanismes de suivi-évaluation et de redevabilité à tous les niveaux

Cette intervention envisage d'améliorer l'efficacité, la transparence et l'impact des interventions en mesurant les progrès réalisés, en identifiant les défis et en s'assurant que les parties prenantes sont responsables des résultats obtenus à travers les actions suivantes :

- Suivi semestriel des interventions communautaires en cours de la mise en œuvre de ce plan à l'aide de l'outil MAA dans 26 DPS ;
- Organisation des revues annuelles nationale et provinciales ;
- Organisation des évaluations du PSN SACO 2025-2030 (à mi-parcours et finale).
- Organisation des évaluations sur le niveau de mise en place et fonctionnalité des organes de participation communautaire (CAC, CODESA et UCODESA) et les SSC (tous les 2 ans) ;
- Organisation des évaluations des services et prestations des ASC et RECO ;
- Organisation des évaluations du niveau des connaissances, attitudes et pratiques des communautés par rapport aux pratiques familiales essentielles, les signes de danger et d'alertes de la mère et de l'enfant dans la communauté, la prévention et le recours aux soins et services ;
- Organisation de l'étude sur la contribution de la santé communautaire sur les indicateurs de CSU.

3.4.6. Axe stratégique 6 : Renforcement de la gouvernance en santé communautaire

Cet axe transversal vise à assurer un leadership à tous les niveaux et permettre aux organes de coordination de la santé communautaire de jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre des actions intra et intersectorielles en vue du progrès vers l'atteinte des ODD liés à la santé.

Les interventions envisagées sont regroupées autour des actions prioritaires suivantes :

- Accroissement de la couverture des organes de participation communautaire ;
- Renforcement de la coordination et leadership intra et intersectorielle à tous les niveaux du système pour la mise en place et la redynamisation de la fonctionnalité des structures de participation communautaires, d'une part, et d'autre part pour l'élaboration ou l'actualisation des textes réglementaires, politiques, stratégiques et normatifs déficitaires ou des textes caducs en santé communautaire ;
- Renforcement des capacités institutionnelles à tous les niveaux ;
- Renforcement des mécanismes de suivi-évaluation et de redevabilité à tous les niveaux ;
- Suivi semestriel de la mise en œuvre de la digitalisation des interventions communautaires dans les 26 DPS ;
- Renforcement du partenariat et collaboration intra et multisectorielle (consolidation/mise en place des cadres de concertations et de redevabilité, adaptés aux réformes amorcées au pays et en international) ;
- Renforcement du mécanisme du contrôle citoyen par les OSC ;
- Suivi dirigé par la communauté dans le cadre de contrôle citoyen par les OSC ;
- Renforcement du suivi de la fonctionnalité des structures de participation communautaire par les OSC.

Intervention 6.1. Accroissement de la couverture des villages/rue/avenue avec des CAC correctement mises en place et effectivement fonctionnelles

Cette intervention vise à renforcer la participation communautaire et à promouvoir le développement social et sanitaire au niveau local à travers la mobilisation des membres des communautés pour la résolution de leurs propres problèmes de santé, d'éducation, d'environnement et de développement. Pour ce faire, deux actions sont envisagées, à savoir :

- Redynamisation des CODESA existants ;
- Extension de la couverture des villages en CAC fonctionnelles.

La modélisation faite avec le logiciel Access MOOD avec l'appui de l'Université de Genève, a montré que sur un besoin estimatif de 118 254 CAC, 92 407 sont répertoriées, 55 039 sont actives, soit un gap de 25 847 à combler d'ici à 2030.

Intervention 6.2. Renforcement de la coordination et du leadership à tous les niveaux

Le renforcement de la coordination et du leadership en santé communautaire vise à garantir une gestion efficace, harmonisée et pérenne des activités de santé communautaire, tout en maximisant leur impact. Sur ce, trois actions devront être mises en œuvre. Il s'agit de :

- Élaboration des avant-projets des textes légaux et réglementaires sur la professionnalisation des ASC pour une assise légale ;
- Vulgarisation du PSN SACO 2025-2030 et autres documents normatifs à tous les niveaux ;
- Élaboration /actualisation des documents de politique, stratégies et directives : (i) politique nationale de santé communautaire, (ii) normes de mise en place et de fonctionnement des organes de participation communautaire, (iii) guide de mise en place et fonctionnement des SSC, (iv) guide de prise en charge et offre des services de santé au niveau des SSC ;
- Consolidation trimestrielle des capacités institutionnelles à tous les niveaux.

Intervention 6.3. Institutionnalisation de la santé communautaire

L'institutionnalisation de la santé communautaire désigne le processus d'intégration formelle et durable de la santé communautaire dans le système national de santé. Elle vise la reconnaissance d'un cadre officiel avec des ressources pérennes pour règlementer les interventions communautaires. Pour y parvenir, deux actions sont nécessaires, à savoir :

- Plaidoyer pour adoption d'un avant-projet du texte légal sur l'institutionnalisation de la santé communautaire ; et
- Mise en place d'un organe formel de coordination des interventions et intervenants en santé communautaire.

Intervention 6.4. Renforcement du partenariat et collaboration intra et multisectorielle

Pour renforcer le partenariat et la collaboration intra et multisectorielle, il sera question de réaliser les actions suivantes :

- Élaboration du vadémécum du partenariat dans le sous-secteur santé communautaire ;
- Organisation des réunions de concertation avec les différents acteurs impliqués dans la santé communautaire (OSC, PTF, APA, …) ;
- Mise en place d'un cadre multisectoriel d'échanges avec les secteurs connexes (Environnement, Éducation, Développement rural, Agriculture, pêche et élevage etc.)
- Célébration des Journées portes ouvertes de la santé communautaire.

Intervention 6.5. Renforcement du mécanisme du contrôle citoyen par les organisations de la société civile.

Le contrôle citoyen en santé communautaire joue un rôle déterminant, similaire aux attributions d'inspection-contrôle visant à garantir l'efficacité, la transparence et la redevabilité des interventions communautaires. Dans le cadre de ce plan, quatre actions essentielles concourent à l'atteinte de cette intervention, à savoir :

- Organisation de la cartographie des OSC (OAC) ;

- Appui à la mise en œuvre des actions et prestations du contrôle citoyen par les acteurs communautaires de la société civile (formation, dotation en outils et équipements, fonctionnement, etc.) ;
- Accompagnement des structures de participation communautaire dans l'élaboration de PAC ;
- Organisation de l'approche BCP dans les AS ciblées.

3.5. Théorie de changement

La théorie du changement ci-dessous décrit l'effet, les produits, les stratégies, les hypothèses et risques ainsi que les processus de changement pour l'atteinte des objectifs du PSN SACO 2025-2030. Elle est basée sur la construction suivante :

- Si le Gouvernement a les capacités d'opérationnaliser le PSN SACO 2025-2030 (dynamisation de la gouvernance) à tous les niveaux ;
- Si le Gouvernement a la capacité de mobiliser des financements pérennes internes et externes ;
- Si les données de la santé communautaire (y compris la surveillance à base communautaire) sont intégrées ;
- Si les capacités des ressources humaines de santé communautaire (ASC et RECO) sont renforcées ;
- Si les acteurs au niveau opérationnel intervenant dans les secteurs spécifiques et sensibles de la santé communautaire ont les capacités d'offrir des services de qualité ;
- Si les équipes de gouvernance de la santé communautaire, les OSC, les prestataires des ESS et les communautés adhèrent davantage aux pratiques recommandées et aux normes sociales favorables à la santé de la mère, de l'enfant et aux normes et procédures ;
- Si le Gouvernement et les PTF mettent à la disposition du MSPHPS les moyens logistiques et financiers pour la santé communautaire ;

Alors les populations vulnérables, particulièrement celles à plus de 5 km d'une ESS, augmenteront équitablement leur utilisation des services de qualité spécifiques et sensibles de santé communautaire, dans un environnement politique et multisectoriel favorable.

Pour ainsi réduire la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile ;

Parce que (i) la responsabilisation et la coordination de la santé communautaire sont assurées à tous les niveaux du système de santé ; (ii) l'accès aux soins et services de santé est augmenté à travers les ASC et RECO ; (iii) la qualité des soins et services au niveau des SSC et RECO ; (iv) la prise des décisions est guidée par une meilleure utilisation des données communautaire.

Les enjeux de santé communautaire ne sont donc pas seulement une question de santé publique mais une question de développement liée à plusieurs autres secteurs (multisectorialité), notamment : Santé, Agriculture, Eau, Hygiène et Assainissement, Education, Autonomisation de la femme, Développement du Jeune Enfant, Protection Sociale, Commerce, Emploi et Travail, Réduction de la Pauvreté etc.

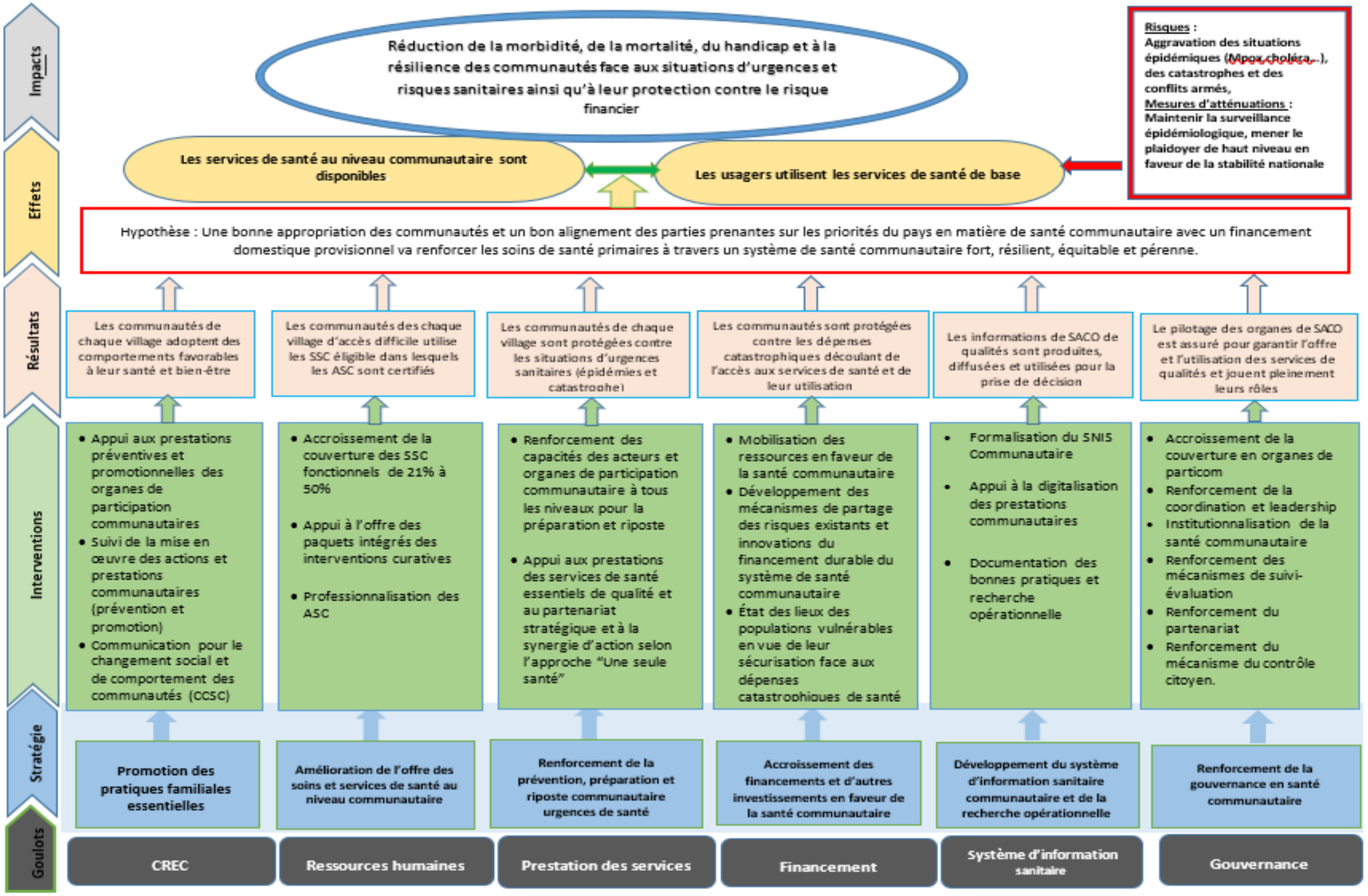


Figure 13 : Théorie de changement

La théorie de changement élaborée dans le cadre du renforcement de la santé communautaire en RDC constitue un instrument stratégique fondamental, à la fois structuré, holistique et ancré dans le contexte spécifique du pays. Elle propose une lecture systémique de la transformation attendue du système de santé communautaire, à travers une chaîne logique qui part de l'identification des goulots d'étranglement jusqu'à la réalisation des impacts souhaités. L'impact ultime recherché est clair : il s'agit de réduire la morbidité, la mortalité et le handicap, tout en renforçant la résilience des communautés face aux urgences sanitaires, aux catastrophes, aux épidémies et aux risques financiers liés à l'accès aux soins. Ce résultat ambitieux traduit l'engagement du système de santé communautaire à contribuer efficacement à la CSU et aux ODD, en mettant l'accent sur l'équité, la résilience, la solidarité et la protection sociale.

Cette ambition repose sur deux effets fondamentaux à atteindre. D'une part, les services de santé au niveau communautaire doivent être effectivement disponibles, c'est-à-dire accessibles, fonctionnels, bien équipés, avec du personnel formé et des interventions adaptées aux besoins locaux. D'autre part, ces services doivent être utilisés de manière optimale par les populations, ce qui implique un haut niveau d'appropriation, de confiance, de sensibilisation et d'engagement communautaire. Ces deux effets ne peuvent être dissociés : la disponibilité sans utilisation est inefficace, et l'utilisation sans qualité est contre-productive. La théorie émet une hypothèse stratégique forte : une bonne appropriation par les communautés, associée à une convergence des efforts des parties prenantes autour des priorités nationales, et appuyée par un financement domestique prévisionnel, constitue la condition sine qua non pour le renforcement durable du système de santé communautaire.

Les résultats intermédiaires identifiés dans cette théorie de changement sont multiples, cohérents et interconnectés. Ils traduisent des changements attendus dans le comportement des communautés, dans l'accès aux soins, dans la protection financière, dans la gouvernance, dans la gestion de l'information, dans la préparation aux urgences, et dans l'amélioration continue de la qualité. Ces résultats visent à ce que chaque communauté adopte des comportements favorables à sa santé et à son bien-être, qu'elle ait accès à des services fonctionnels via des agents communautaires qualifiés, qu'elle soit protégée contre les épidémies et catastrophes, contre les dépenses de santé appauvrissantes, et qu'elle dispose d'informations de qualité utilisées pour une prise de décision éclairée. Ils incluent également l'assurance que les structures communautaires sont bien pilotées, coordonnées, participatives, et qu'elles jouent pleinement leur rôle.

Cependant, ces résultats sont fortement tributaires de plusieurs obstacles critiques identifiés dans les analyses de performance du système de santé communautaire. Sur le plan de la gouvernance, le système souffre de l'absence d'un cadre légal formel consacrant l'institutionnalisation de la santé communautaire. Il n'existe pas encore de politique nationale spécifique intégrant les approches multisectorielles et intersectorielles, notamment l'approche « Une santé » qui prend en compte les interactions entre la santé humaine, animale et environnementale. La coordination stratégique et opérationnelle reste fragmentée, souvent paralysée par l'absence d'un alignement des parties prenantes autour d'un plan, d'un budget et d'un système de suivi partagés. La fonctionnalité des organes communautaires (CODESA, CAC) est également compromise par un faible taux de formation, une dotation insuffisante en outils, et l'absence d'un suivi structuré des plans d'action communautaires.

Sur le plan du financement, la situation est critique. La santé communautaire ne bénéficie d'aucune ligne budgétaire spécifique dans la loi de finances nationale. Il n'existe pas de dossier d'investissement à long terme, ni de mécanismes de mutualisation des ressources comme un fonds commun. Le financement actuel repose sur des appuis externes fragmentés, peu alignés aux priorités nationales, difficilement traçables, et souvent non pérennes. Ce manque de financement structurant affaiblit la capacité de planification, la supervision des interventions, la mise à l'échelle des innovations, ainsi que la motivation des agents communautaires.

Les ressources humaines communautaires constituent un autre maillon faible du système. Les ASC et les RECO, bien qu'ils soient au cœur de l'offre de services communautaires, ne sont ni professionnalisés, ni suffisamment motivés. Leur statut de volontaire, en dépit d'une reconnaissance sociale de la part des communautés, limite leur fidélisation. Ils ne bénéficient pas d'un cadre formel de formation continue certifiée, ni d'un accompagnement régulier par supervision formative. À cela s'ajoute l'absence d'un plan national de développement et de déploiement des agents, ainsi qu'une cartographie non actualisée, ce qui limite la couverture équitable du territoire. La surveillance communautaire des maladies animales (via les ACSA) et des espèces sauvages n'est pas encore intégrée dans le système, créant une faiblesse majeure dans la détection des zoonoses et des risques sanitaires émergents.

La qualité et l'extension des prestations sont encore insuffisantes. Les paquets d'interventions de santé communautaire ne sont pas toujours intégrés ni alignés à ceux de la CSU. La couverture des zones éloignées reste faible, malgré la présence de SSC qui manquent de supervision, de dotation en intrants et d'appui technique. Les interventions de résilience, de préparation et de réponse communautaire aux urgences sont souvent limitées à des actions ponctuelles, sans stratégie systémique. Par ailleurs, l'innovation et la recherche opérationnelle sont très peu mobilisées pour adapter les modèles à la réalité congolaise. Des approches prometteuses comme la triade communautaire (village santé), les AGR communautaires, la supervision formative intégrée ou encore les modèles de gouvernance communautaire restent à documenter, à tester et à institutionnaliser.

En matière de chaîne d'approvisionnement, les besoins en médicaments et produits essentiels au niveau communautaire ne sont pas bien estimés ni bien suivis. Les données communautaires ne sont pas intégrées dans le système d'information logistique (SIGL), ce qui limite la visibilité et la planification. Le SNIS communautaire est encore peu fonctionnel, en raison d'un déficit en équipements numériques, de la faible capacité des structures communautaires à collecter, analyser et transmettre les données, et d'un manque de culture de l'usage des données pour la décision. Cela se traduit par une absence de tableaux de bord communautaires, de cartes de score, et de bulletins réguliers d'information sanitaire. Les mécanismes de monitorage en temps réel, tels que le MAA, sont très peu mis en œuvre à grande échelle.

Enfin, l'engagement communautaire et la communication sur les risques restent encore largement sous-développés. Les organisations à assise communautaire ne sont pas régulièrement cartographiées ni intégrées dans les processus de planification. Le soutien logistique, technique et financier aux organes communautaires pour la mise en œuvre de leurs activités est faible. La participation des populations à l'élaboration des messages, à la promotion de comportements sains et à l'appropriation des interventions sanitaires est limitée, ce qui affecte l'efficacité des campagnes de sensibilisation, du marketing social, et des mécanismes de redevabilité sociale. Cette faible implication communautaire affaiblit la pérennité des changements comportementaux et la légitimité des services de santé.

Face à ces multiples défis, les stratégies formulées dans la théorie de changement apportent des réponses claires et ciblées. Elles couvrent les six domaines fondamentaux du renforcement du système : la promotion des pratiques familiales essentielles, l'amélioration de l'offre de soins, la préparation et la riposte communautaire, le financement durable, le système d'information sanitaire communautaire, et la gouvernance participative. Chaque stratégie est accompagnée d'un ensemble d'interventions précises, cohérentes avec les problèmes identifiés, et orientées vers les résultats attendus. Ces interventions incluent la professionnalisation des ASC, le développement de mécanismes de financement innovants, la digitalisation des données, l'appui à la formalisation du SNIS communautaire, la documentation des bonnes pratiques, le

renforcement du partenariat multisectoriel, la participation citoyenne, et la responsabilisation des structures de gouvernance.

En définitive, cette théorie de changement présente une vision claire, ambitieuse et intégrée de la transformation du système de santé communautaire en RDC. Elle reconnaît explicitement les faiblesses actuelles, identifie les leviers de changement, et propose des solutions réalistes et fondées sur les principes d'équité, de résilience et d'appropriation locale. Sa réussite dépendra cependant de la mise en place d'un leadership fort, de mécanismes de coordination efficaces, d'un engagement politique durable, d'un financement adéquat et prévisible, ainsi que d'un partenariat stratégique avec les communautés et les autres secteurs du développement. Ce n'est qu'à ces conditions que la santé communautaire pourra pleinement jouer son rôle de fondement du système de santé, au service des plus vulnérables, et dans le respect du droit à la santé pour tous.

IV. Cadre de mise en œuvre

4.1. Opérationnalisation du plan stratégique

4.1.1. Ancrage et contribution du PSN SACO 2025-2030 dans le PNDS 2024-2033

Tableau 21: Ancrage et contribution du PSN SACO 2025-2030

Axes stratégiques, interventions et actions du PNDS-PS 2024-2033		Axes stratégiques (AS), interventions et actions prioritaires du PSN SACO 2025-2030					
		AS.1	AS.2	AS.3	AS.4	AS.5	AS.6
Axe stratégique 1 : Amélioration des prestations des services de santé de qualité et continuité des soins dans une approche de soins de santé primaires avec un focus sur la santé communautaire							
Interventions et actions du PNDS		**Interventions et actions du PSN SACO**					
Extension de la couverture sanitaire	Offre PMA de qualité avec focus SRMNEA-Nut		Intervention 2.1 : Action 2				
	Offre PCA de qualité						
	Prévention des maladies évitables par la vaccination						
	Lutte contre Palu, VIH, TB, Hépatites						
	Lutte contre les MNT, mentales et traumatismes						
	Mécanismes de l'hygiènes et assainissement						
	Système de Laboratoire SP						
	Participation de la population au diagnostic	Intervention 1.1 : Actions 1, 2, 3 et 4	Intervention 2.2 : Actions 1 et 2	Intervention 3.2 : Action 3		Intervention 5.1 : Actions 4 et 5	Intervention 6.1 : Actions 1 et 2
	Mise en place de la stratégie de communication	Intervention 1.3 : Action 2					
Renforcement de la disponibilité des vaccins, médicaments, matériels de diagnostic et autres produits de santé de qualité	Approvisionnement en médicaments et réglementation						
	Règlementation des prix des médicaments et des tarifs des services						
	Centralisation des achats des médicaments						
	Assurance qualité de médicaments et autres produits de santé						
	Système de distribution de médicaments jusqu'au dernier kilomètre						
Construction, réhabilitation, équipement, digitalisation	Développer les infrastructures et dispositifs médicaux						
	Développer un système de maintenance préventive et curative						
Renforcement du SIS	Actualiser le cadre normatif du SNIS					Intervention 5.1 ; Actions 1,2 et 3	
	Renforcer la production, l'utilisation et la diffusion					Intervention 5.1 ; Actions 6, 7	

	des informations stratégiques						
	Digitaliser l'information sanitaire					Intervention 5.2 : Actions 1, 2, 3, 4 et 5	
Axe stratégique 2 : Amélioration de la résilience du système de santé aux urgences et risques sanitaires							
Interventions et actions du PNDS		**Interventions et actions du PSN SACO**					
Renforcement des capacités du domaine du RSI	Gestion des épidémies et urgences en milieu de soins						
	Mise en place d'un fonds d'urgence sanitaire						
	Mise en œuvre du RSI et sécurité sanitaire						
	Gestion des urgences transfrontalières						
	Appui à la mise en œuvre d'un plan d'urgence						
Résilience des communautés aux effets climatiques et urgence	Préparation et riposte contre les épidémies, urgences et catastrophes			Intervention 3.1 : Action 3			
	Prévention (surveillance) des maladies évitables par la vaccination			Intervention 3.2 : Action 1			
	Renforcement de la Particom			Intervention 3.1 : Actions 1, 2,3,4,5 et 6 Intervention 3.2 : Actions 4			
Axe stratégique 3 : Accroissement des financements et d'autres investissements pour une meilleure performance du SS							
Interventions et actions du PNDS		**Interventions et actions du PSN SACO**					
Renforcement des mécanismes de financement pour la santé	Développer les comptes de la santé				Intervention 4.1 : Action 1		
	Mobiliser et affecter des ressources (Etat, extérieur et financements innovants)				Intervention 4.1 : Action 2		
	Plaidoyer pour augmenter les allocations de fonctionnement et d'investissement				Intervention 4.1 : Actions 3,4,5 Intervention 4.2 ; Action 2		
	Partage des risques et subventionnement des coûts de soins et de la tarification				Intervention 4.2 ; Actions 1,3,4 Intervention 4.3 : Actions 1,2,3		
Axe stratégique 4 : Extension de la protection sociale et de la mitigation du risque financier							
Interventions et actions du PNDS		**Interventions et actions du PSN SACO**					
Extension de la protection contre les	Régimes d'assurance maladie obligatoire						
	Mécanisme de financement de l'assistance médicale de l'État aux vulnérables						

	Développement des mutuelles de santé et autres mécanismes assurantiels						
	Assurance maladie obligatoire des travailleurs indépendants/informels						
	Institutionnalisation du métier de médecin conseil des assurances santé						
Axe stratégique 5 : Amélioration de la fonctionnalité des industries de santé et création d'emplois en collaboration avec les autres secteurs							
Interventions et actions du PNDS		**Interventions et actions du PSN SACO**					
Industrie et création d'emplois avec les secteurs privés	Production locale des médicaments et des produits de santé de qualité						
	Appui à la création d'emplois à travers le SS						
Axe stratégique 6 : Renforcement de la gouvernance du système de santé et de la prévoyance sociale							
Interventions et actions du PNDS		**Interventions et actions du PSN SACO**					
Renforcement de la Gouvernance du système de santé pour une meilleure redevabilité	Préparer un document d'engagement pour le NC						
	Préparer un contrat unique d'engagement au NI, NO						
	Assurer le suivi de la mise en œuvre des réformes et la décentralisation dans le SS						
	Planification, S&E des stratégies et redevabilité	Intervention 1.2 : Actions 1 et 2 Intervention 1.3 : Action 1	Intervention 2.1 : Actions 1, et 3 Intervention 2.3 : Action 4	Intervention 3.2 : Actions 2 et 4			Intervention 6.4 : Actions 1, 2, 3, 4, 5 et 6
	Renforcer les mécanismes d'inspection-contrôle					Intervention 5.3 : Actions 4 et 5	Intervention 6.6 : Actions 1, 2, 3 et 4
	Redynamiser la collaboration intra et intersectorielle						Intervention 6.1 ; 6.2, 6.3 et 6.5
	Élaborer/actualiser les textes réglementaires, politiques, stratégiques et normatifs		Intervention 2.3 : Action 3				Intervention 6.2 : Action 3 Intervention 6.5 ; Action 1
	Elaborer et appliquer le texte régissant la santé communautaire		Intervention 2.3 : Action 1				Intervention 6.2 : Actions 1 et 2
Création d'un cadre managérial et institutionnel favorable aux RHS	Elaborer/actualiser les plans de développement des établissements de formation en santé et gestion des RHS		Intervention 2.1 : Action 4				
	Développer une politique de rémunération équitable, incitative pour les RHS						
	Développer une politique de rémunération équitable, incitative et prenant en compte les prestataires communautaires		Intervention 2.1 ; Action 4 Intervention 2.3 : Action 2				

	Mettre en place des mécanismes d'accréditation des institutions de formation et certifier les Prosanté						
	Renforcement des capacités de gestion du programme						Intervention 6.2 : Action 4
	Appui au développement du capital humain du programme					Intervention 5.3 : Actions 6 et 7	
Renforcement de la coordination de la recherche en santé	Recherches-actions sur des thématiques spécifiques en lien avec les missions des programmes					Intervention 5.3 : Actions 1 et 2	
	Recherche-action par thématique					Intervention 5.3 : Action 3	Intervention 6.4 : Action 7

4.1.2. Cadre programmatique

Le présent plan stratégique de la santé communautaire sera mis en œuvre à travers les activités selon un chronogramme étalé en 6 années (2025 à 2030) comme décrit dans le tableau ci-dessous.

Tableau 22: Chronogramme de mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030 par axes stratégiques, par interventions et par actions

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Résultats attendus		Cibles annuelle attendues						Responsables
			Unités	Total	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Axe 1	**Promotion des pratiques familiales essentielles**										
Intervention 1.1	**Appui aux prestations préventives et promotionnelles des organes de participation communautaires**										
Action 1.1.1	Elaboration/actualisation des documents de formation sur le paquet intégré des activités communautaires	NC	Modules de formation	8	8	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
Action 1.1.2	Mise en place des pools de formateurs nationaux et provinciaux	NC	Pool national	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, DPS, PTF
		NI	Pool provincial	26	9	9	8	0	0	0	
Action 1.1.3	Appui à la formation des membres des organes de participation communautaire du niveau opérationnel sur le paquet intégré d'activités communautaires préventives et promotionnelles	NO	UCODESA	519	180	180	159	0	0	0	MSPHPS, DPS, ZS, PTF
			CODESA	11 689	4 046	4 046	3 597	0	0	0	
			CAC	118 254	40 934	40 934	36 386	0	0	0	
Action 1.1.4	Dotation des CODESA et CAC en matériels, équipements et outils de gestion et de communication	NO	CODESA	11 689	4 046	4 046	3 597	0	0	0	MSPHPS, DPS, ZS, PTF
			CAC	118 254	40 934	40 934	36 386	0	0	0	
Intervention 1.2	**Suivi de la mise en œuvre des actions et prestations communautaires (prévention et promotion)**										
Action 1.2.1	Suivi post formation des membres des organes de Particom sur le PAIC	NO	CODESA	11 689	4 046	4 046	3 597	0	0	0	MSPHPS, DPS, ZS, PTF
			CAC	118 254	40934	40934	36386	0	0	0	
Action 1.2.2	Suivi communautaire intégré des cibles prioritaires au niveau des ménages (Suivi longitudinal et personnalisé des ménages)	NO	Ménages	148 869 747	22 912 822	23 651 331	24 405 607	25 175 645	25 961 427	26 762 915	DPS, ZS, PTF
Intervention 1.3	**Communication pour le changement social et de comportement des communautés (CCSC)**										
Action 1.3.1	Élaboration du plan d'action opérationnel de santé communautaire (PAO SACO) avec plan	NC	PAO SACO intégrant le PAIC	6	1	1	1	1	1	1	MSPHPS, PTF

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Résultats attendus		Cibles annuelle attendues						Responsables
			Unités	Total	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	d'action intégré de communication (PAIC) sur les PFE	NO	Micro plan SACO AS	70 134	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	DPS, ZS, CODESA, PTF
			PAC CAC	709 524	118 254	118 254	118 254	118 254	118 254	118 254	CODESA, CAC
Action 1.3.2	Promotion de l'approche "Accroître la communication de qualité dans les services de santé" (ACQUASS) à travers le marketing social et la communication pour la santé	NI	Émissions radio ou télévisées	8 112	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	DPS, PTF
		NO (village)	Campagne de sensibilisation	2 270 472	378 412	378 412	378 412	378 412	378 412	378 412	DPS, ZS, AS, CAC
			VAD/Causeries éducatives	6 811 416	1 135 236	1 135 236	1 135 236	1 135 236	1 135 236	1 135 236	
Axe 2	**Amélioration de l'offre des soins et services de santé au niveau communautaire**										
Intervention 2.1	**Accroissement de la couverture des SSC fonctionnels de 21% à 50%**										
Action 2.1.1	Estimation des besoins en SSC par le modèle cartographique avec géoréférencement	NC	Estimation des besoins en SSC	2	1	0	0	1	0	0	MSPHPS
Action 2.1.2	Installation des nouveaux SSC suivant l'emplacement optimisé et révisitation de l'emplacement des anciens	NO	Nouveaux SSC	14 341	2 408	2 396	2 396	2 349	2 396	2 396	MSPHPS, DPS, ZS
Action 2.1.3	Élaboration/actualisation annuelle de la cartographie des ASC et RECO avec liste maîtresse nationale géoréférencée	NC	Liste maitresse	6	1	1	1	1	1	1	MSPHPS
Action 2.1.4	Élaboration du plan de développement et de déploiement des ASC et RECO (PDD ASC-RECO) pour une couverture nationale équitable (y compris le volet logistique)	NC	Plan de déploiement	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS
		NO	ASC	48 906	25 040	29 832	34 624	39 322	44 114	48 906	MSPHPS, DPS
			RECO	487 623	417 474	430 930	444 673	458 703	473 020	487 623	
Intervention 2.2	**Appui à l'offre des paquets intégrés des interventions curatives**										
Action 2.2.1	Rationalisation des intervenants dans les DPS des convergences et identification des synergies d'actions	NI	Plan de couverture	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS
Action 2.2.2	Dotation des SSC en médicament, intrants traceurs, supports et petits matériels	NO	SSC	24 453	12 520	14 916	17 313	19 660	22 057	24 453	MSPHPS, PTF

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Résultats attendus		Cibles annuelle attendues						Responsables
			Unités	Total	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Intervention 2.3	**Professionnalisation des ASC**										
Action 2.3.1	Plaidoyer auprès de la fonction publique pour l'admission des ASC certifiés comme étant des agents sous contrat	NC	Réunions de plaidoyers	8	8	0	0	0	0	0	MSPHPS
Action 2.3.2	Mise en place d'un mécanisme d'incitation financière en faveur des acteurs communautaires (ASC et RECO)	NC	Mécanisme d'incitation financière	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
Action 2.3.3	Elaboration du manuel des procédures de contractualisation des ASC	NC	Manuel des procédures	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
Action 2.3.4	Suivi-supervision formatives périodiques intégrés	NC	Visites de suivi aux DPS (semestriel)	312	52	52	52	52	52	52	MSPHPS, PTF
		NI	Visites de suivi trimestriel /ZS	12 456	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	DPS, PTF
		NO	Visites de suivi mensuel/AS	841608	140 268	140 268	140 268	140 268	140 268	140 268	ZS, PTF
			Visites de suivi aux CAC (mensuel)	8 514 288	1 419 048	1 419 048	1 419 048	1 419 048	1 135 238	1 135 238	AS, Villages/cellules, PTF
Axe 3	**Renforcement de la prévention, préparation et riposte communautaire face aux urgences de santé publique (épidémies et catastrophes naturelles) et effets climatiques**										
Intervention 3.1	**Renforcement des capacités des acteurs et organes de participation communautaire à tous les niveaux pour la préparation et riposte**										
Action 3.1.1	Appui à l'élaboration de la cartographie des risques (tous les 2 ans)	NC	Cartographie	3	1	0	1	0	1	0	MSPHPS, PTF
Action 3.1.2	Appui à la surveillance à base communautaire à travers la promptitude et complétude des rapports MAPEPI	CAC	Rapport MAPEPI	709 524	118 254	118 254	118 254	118 254	118 254	118 254	MSPHPS, DPS, PTF
		CODESA	Rapport MAPEPI CODESA	70 134	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	
		NO	Rapport MAPEPI	3 114	519	519	519	519	519	519	
		NI	Rapport MAPEPI	156	26	26	26	26	26	26	
Action 3.1.3	Appui à l'élaboration des plans de préparation et de riposte communautaire multirisque (PPRCM)	NC	PPRCM national	6	1	1	1	1	1	1	MSPHPS, PTF,
		NI	PPRCM provinciaux	156	26	26	26	26	26	26	MSPHPS, DPS PTF
Action 3.1.4		NC	Pool national	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Résultats attendus		Cibles annuelle attendues						Responsables
			Unités	Total	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Mise en place des pools de formateurs nationaux et provinciaux sur la préparation et riposte aux urgences de santé publique	NI	Pools provinciaux	26	9	9	8	0	0	0	MSPHPS, DPS, PTF
Action 3.1.5	Appui à la formation des acteurs des organes de Particom du niveau opérationnel sur la préparation et riposte	NO	UCODESA	519	180	180	159	0	0	0	MSPHPS, DPS, ZS, PTF
			CODESA	11 689	4 046	4 046	3 597	0	0	0	
			CAC	118 254	40 934	40 934	36 386	0	0	0	
Action 3.1.6	Dotation en matériels et outils traceurs pour la détection précoce des maladies sous surveillance communautaire	NO	CODESA	11 689	4 046	4 046	3 597	0	0	0	MSPHPS, DPS, ZS, PT
			CAC	118 254	40 934	40 934	36 386	0	0	0	
Intervention 3.2	**Appui aux prestations des services de santé essentiels de qualité et au partenariat stratégique et à la synergie d'action selon l'approche "Une seule santé"**										
Action 3.2.1	Appui à l'assurance de la couverture vaccinale requise de la population contre les risques posés par les maladies à prévention vaccinale	NI	Task forces	156	26	26	26	26	26	26	MSPHPS, DPS, ZS, PT
		NO	UCODESA	3 114	519	519	519	519	519	519	
			CODESA	70 134	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	
			CAC	709 524	118 254	118 254	118 254	118 254	118 254	118 254	
Action 3.2.2	Appui des Task forces multisectorielles provinciales de communication à l'élaboration d'une feuille de route « Une seule santé »	NI	Task forces provinciales	156	26	26	26	26	26	26	MSPHPS, PNCPS, DPS PTF
Action 3.2.3	Appui à l'intégration des approches multisectorielles à base communautaire à travers les CAC	NO	CAC	118 254	19 724	19 709	19 709	19 709	19 709	19 709	MSPHPS, DPS, ZS, PTF
Action 3.2.4	Suivi de la mise en œuvre de la feuille de route provinciale « Une seule santé »	NI	Visites de suivi	156	26	26	26	26	26	26	MSPHPS, DPS PTF
Axe 4	**Accroissement des financements et d'autres investissements en faveur de la santé communautaire**										
Intervention 4.1	**Mobilisation des ressources en faveur de la santé communautaire**										
Action 4.1.1	Elaboration/actualisation de la cartographie annuelle des ressources financières et autres investissements en faveur de la santé communautaire	NC	Cartographies	6	1	1	1	1	1	1	MSPHPS, PTF
Action 4.1.2	Élaboration d'un dossier d'investissement (DI) avec plan de viabilité financière de la santé communautaire	NC	DI	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, DPS, PTF

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Résultats attendus		Cibles annuelle attendues						Responsables
			Unités	Total	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 4.1.3	Organisation de forums de mobilisation des ressources financières et investissements pour la mise en œuvre du PSN SACO	NC	Forum national	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS
		NI	Forums provinciaux	26	26	0	0	0	0	0	MSPHPS, DPS, PTF
Action 4.1.4	Élaboration des plans de plaidoyer auprès des cibles primaires (Gouvernement, Parlement)	NC	Plan national	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS
		NI	Plans provinciaux	26	26	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
Action 4.1.5	Organisation des séances de plaidoyer pour l'inscription d'une ligne budgétaire consacrée à la santé communautaire	NC	Réunions	6	1	1	1	1	1	1	MSPHPS, DPS, PTF
		NI	Réunions	156	26	26	26	26	26	26	
Intervention 4.2	**Développement des mécanismes de partage des risques existants et innovations du financement durable du système de santé communautaire**										
Action 4.2.1	Mise en place d'un basket fund (panier commun) virtuel de tous les financements de la santé communautaire	NC	Caisse nationale	6	1	1	1	1	1	1	MSPHPS, DPS, PTF
		NI	Caisse provinciale	156	26	26	26	26	26	26	
Action 4.2.2	Plaidoyer auprès des APA pour les financements innovants en faveur de la santé communautaire	NC	Réunions	6	1	1	1	1	1	1	MSPHPS
		NI	Réunions de plaidoyer	156	26	26	26	26	26	26	MSPHPS, DPS, PTF
Action 4.2.3	Appui à la formation sur les initiatives communautaires des mutuelles de santé	NO	MUSA /CODESA	11 689	4 046	4 046	3 597	0	0	0	DPS, ZS, AS, CAC
Action 4.2.4	Appui des CODESA au développement des activités génératrices de revenu sous forme de coopérative	NO	Coopératives/CODESA	11 689	4 046	4 046	3 597	0	0	0	DPS, ZS, AS, CAC
Intervention 4.3	**État des lieux des populations vulnérables en vue de leur sécurisation face aux dépenses catastrophiques de santé**										
Action 4.3.1	Cartographie des populations vulnérables (ménages vivant en situation d'extrême pauvreté et n'ayant pas une bonne abordabilité financière aux soins et services de santé), tous les 2 ans	NC	Cartographie	3	1	0	1	0	1	0	MSPHPS, PTF, Mini affaires sociales, CNS
Action 4.3.2	Mise en place d'un mécanisme d'accroissement de l'abordabilité financière aux soins et services de santé de santé de base	NC	Mécanisme d'accroissement de l'abordabilité financière	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF, Mini affaires sociales, CNS

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Résultats attendus		Cibles annuelle attendues						Responsables
			Unités	Total	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Axe 5	**Développement du système d'information sanitaire communautaire et de la recherche opérationnelle appuyés par la digitalisation**										
Intervention 5.1	**Formalisation du SNIS Communautaire**										
Action 5.1.1	Mise en place du cadre normatif du SNIS communautaire	NC	Cadre normatif	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
Action 5.1.2	Vulgarisation du cadre normatif du SNIS communautaire couplée aux autres documents	NC	Sessions de vulgarisation	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
		NI	Sessions DPS	26	26	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
		NO	Sessions ZS	519	519	0	0	0	0	0	
Action 5.1.3	Finalisation du développement du SNIS communautaire	NC	Plateforme DHIS-2	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
Action 5.1.4	Formation des cadres et acteurs communautaires sur l'utilisation des outils numériques (au moins 2 membres par structures de participation communautaires)	NC	S-C/SACO	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF, DPS
		NI	Task forces	26	16	10	0	0	0	0	
		NO	UCODESA	519	310	209	0	0	0	0	
			CODESA	11 689	0	4 046	3 147	2 248	1 349	899	DPS, ZS, AS
			CAC	118 254	19 724	19 709	19 709	19 709	19 709	19 709	
Action 5.1.6	Dotation des 519 ZS en matériels et kit de communication pour l'utilisation numérique de la plateforme DHIS2-communautaire	NO	Kits de communication numérique	519	310	209	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
Action 5.1.7	Production des bulletins trimestriels et annuaires d'informations de la SACO	NC	Bulletins	24	4	4	4	4	4	4	MSPHPS, PTF
			Annuaires	6	1	1	1	1	1	1	
Action 5.1.8	Appui aux réunions mensuelles des CAC pour l'organisation de monitorage des interventions à base communautaire	NO	Réunions de monitorage	8 514 288	1 419 048	1 419 048	1 419 048	1 419 048	1 419 048	1 419 048	MSPHPS, PTF
Intervention 5.2	**Appui à la digitalisation des prestations communautaires**										
Action 5.2.1	Finalisation et validation d'un plan de la digitalisation de la SACO 2025-2030	NC	Plan de digitalisation	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
Action 5.2.2	Développement et pré test des outils numériques du SNIS communautaire	NC	Pré test	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
Action 5.2.3	Mise en place des mécanismes de connectivité adaptés au contexte du pays	NO	CAC investies en connection	118 254	19 724	19 709	19 709	19 709	19 709	19 709	MSPHPS, PTF
Action 5.2.4	Développement du portail Web en Santé communautaire pour assurer la diffusion continuelle des informations	NC	Portail Web SACO	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Résultats attendus		Cibles annuelle attendues						Responsables
			Unités	Total	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 5.2.5	Intégration du portail Web de la Santé communautaire dans celui du MSPH-PS	NC	Portail Web SACO	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
Intervention 5.3	**Documentation des bonnes pratiques et recherche opérationnelle**										
Action 5.3.1	Recherche-action sur l'approche village santé (toute la période de mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030)	NC	Recherche-action	1	1	1	1	1	1	1	MSPHPS, PTF
Action 5.3.2	Recherche-action (RA) sur les thématiques en lien avec les défis persistants de la santé communautaire	NC	Recherche-action	2	0	0	0	1	1	0	MSPHPS, PTF
Action 5.3.3	Étude sur les approches ou thématiques spécifiques (exemple AFASAC), les deux premières années de mise en oeuvre	NC	Étude	1	1	1	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
Action 5.3.4	Documentation et capitalisation des bonnes pratiques sur la redevabilité et dénonciation des abus et fraudes commis dans la communauté	NC	Enquêtes (ligne verte, suivi dirigé)	2	0	1	0	1	0	0	MSPHPS, PTF
Action 5.3.5	Extension des bonnes pratiques (ligne verte, suivi dirigé)	NO	CAC ayant intégré	118 254	19 724	19 709	19 709	19 709	19 709	19 709	MSPHPS, PTF
Action 5.3.6	Organisation des missions annuelles de partage d'expériences à l'étranger sur la santé communautaire	NC	Missions d'échanges	6	1	1	1	1	1	1	MSPHPS, PTF
Action 5.3.7	Organisation des forums internationaux et inter provinciaux d'échange d'expériences sur la santé communautaire	NC	Forums internationaux	6	1	1	1	1	1	1	MSPHPS, DPS, PTF
		NI	Forums inter provinciaux	36	6	6	6	6	6	6	MSPHPS, DPS, PTF
Intervention 5.4	**Renforcement des mécanismes de suivi-évaluation et de redevabilité à tous les niveaux**										
Action 5.4.1	Suivi semestriel des interventions communautaires en cours de mise en œuvre de ce plan à l'aide de l'outil MAA dans 26 DPS	NC	Sessions de MAA	12	2	2	2	2	2	2	MSPHPS, DPS, PTF
Action 5.4.2	Organisation des revues annuelles nationale et provinciales	NC	Revue nationale	6	1	1	1	1	1	1	MSPHPS, PTF
		NI	Revues provinciales	152	26	26	26	26	26	26	DPS, PTF
Action 5.4.3	Organisation de l'évaluation à mi-parcours et finale du PSN SACO 2025-2030	NC	Évaluation du PSN SACO	2	0	0	1	0	0	1	MSPHPS, DPS, PTF

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Résultats attendus		Cibles annuelle attendues						Responsables
			Unités	Total	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 5.4.4	Organiser des évaluations sur le niveau de mise en place et fonctionnalité des organes de participation communautaire (CAC, CODESA et UCODESA) et les SSC (tous les 2 ans)	NC	Évaluation mise en place et fonctionnalité des organes de PARTICOM	3	1	0	1	0	1	0	MSPHPS, DPS, PTF
Action 5.4.5	Organiser des évaluations des services et prestations des ASC et RECO	NC	Évaluation des services et prestations des ASC et RECO	1	0	0	0	1	0	0	MSPHPS, DPS, PTF
Action 5.5.6	Organiser des évaluations du niveau des connaissances, attitudes et pratiques des communautés par rapport aux pratiques familiales essentielles, les signes de danger et d'alertes de la mère et de l'enfant dans la communauté, la prévention et le recours aux soins et services.	NC	Évaluation des CAP	2	1	0	0	0	1	0	MSPHPS, DPS, PTF
Action 5.5.7	Organiser une étude sur la contribution de la santé communautaire sur les indicateurs de CSU	NC	Etude d'impact	1	0	0	0	1	0	0	MSPHPS, DPS, PTF
Axe 6	**Renforcement de la gouvernance en santé communautaire**										
Intervention 6.1	**Accroissement de la couverture en organes de participation communautaire**										
Action 6.1.1	Redynamisation des CODESA existants	NO	CODESA	11 689	4046	3147	2248	1349	899	0	MSPHPS, DPS, ZS, PTF
Action 6.1.2	Extension de la couverture des villages en CAC fonctionnelles	NO	CAC	118 254	55 039	12 643	12 643	12 643	12 643	12 643	
Intervention 6.2	**Renforcement de la coordination et leadership à tous les niveaux**										
Action 6.2.1	Élaboration des avant-projets des textes légaux et réglementaires sur la professionnalisation des ASC pour une assise légale	NC	Avant-projets des textes	2	2	0	0	0	0	0	MSPHPS, PTF
Action 6.2.2	Vulgarisation du PSN SACO 2025-2030 et autres documents normatifs à tous les niveaux	NC	Réunion de dissémination	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, DPS, ZS, PTF
		NI	Mission DPS	26	26	0	0	0	0	0	DPS, PTF

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Résultats attendus		Cibles annuelle attendues						Responsables
			Unités	Total	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		NO	UCODESA	519	519	0	0	0	0	0	ZS, PTF
			CODESA	11 689	11 689	0	0	0	0	0	
			CAC	118 254	118 254	0	0	0	0	0	
Action 6.2.3	Élaboration /actualisation des documents de politique, stratégies et directives	NC	Documents	4	4	0	0	0	0	0	MSPHPS
Action 6.2.4	Consolidation trimestrielle des capacités institutionnelles à tous les niveaux	NC	Appui de la direction SACO	24	4	4	4	4	4	4	MSPHPS, PTF
		NI	Appui Tasks forces	624	104	104	104	104	104	104	DPS, PTF
Intervention 6.3	**Institutionnalisation de la santé communautaire**										
Action 6.3.1	Plaidoyer pour adoption d'un avant-projet du texte légal sur l'institutionnalisation de la SACO	NO	Avant-projet de texte	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS
Action 6.3.2	Mise en place d'une structure de coordination de la SACO	NC	Arrêté créant la direction de la SACO	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS
Intervention 6.4	**Renforcement du partenariat et collaboration intra et multisectorielle**										
Action 6.4.1	Élaboration du vadémécum du partenariat dans le sous-secteur santé communautaire	NC	Un Vade-mecum	1	1	0	0	0	0	0	MSPHPS, DESP PTF
Action 6.4.2	Organisation des réunions de concertation avec les différents acteurs de la SACO	NC	Réunion trimestrielle	24	4	4	4	4	4	4	MSPHPS, OSC, PTF
Action 6.4.3	Mise en place d'un cadre multisectoriel d'échanges avec les secteurs connexes	NC	Cadre multisectoriel	12	2	2	2	2	2	2	MSPHPS,
Action 6.4.4	Célébration Journées portes ouvertes SACO	NC	Journée	6	1	1	1	1	1	1	MSPHPS, PTF
Intervention 6.5	. **Renforcement du mécanisme du contrôle citoyen par les organisations de la société civile.**										
Action 6.5.1	Actualisation biannuelle de la cartographie des OSC (OAC)	NC	Cartographie	3	1	0	1	0	1	0	OSC, PTF
Action 6.5.2	Appui à la mise en œuvre des actions et prestations du contrôle citoyen par les OSC	CODESA	Visite d'encadrement	70 134	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	OSC, PTF
		CAC	Visite d'encadrement	709 524	118 254	118 254	118 254	118 254	118 254	118 254	
Action 6.5.3	Accompagnement des structures de Particom dans l'élaboration de PAC /micro plan	CODESA	Micro plan	70 134	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Résultats attendus		Cibles annuelle attendues						Responsables
			Unités	Total	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		CAC	PAC	709 524	118 254	118 254	118 254	118 254	118 254	118 254	MSPHPS, DPS, OSC, PTF
Action 6.5.4	Organisation de l'approche BCP dans les AS ciblées	NO	CODESA	7 343	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 223	OSC, PTF

Légende : NC =Niveau central ; NI = Niveau intermédiaire ; NO = Niveau opérationnel

4.1.3. Priorisation des DPS dans la mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030

La priorisation stratégique des provinces dans le cadre du nouveau PSN repose sur une analyse rigoureuse des données épidémiologiques et d'indicateurs clés de santé publique, permettant d'identifier les zones où les besoins sont les plus criants et où l'impact des interventions communautaires sera maximal. Cette approche evidence-based garantit une allocation efficiente des ressources et une concentration des efforts là où les défis sanitaires sont les plus aigus.

Les indicateurs sélectionnés pour cette priorisation offrent une vision multidimensionnelle de la situation sanitaire des provinces. La mortalité néonatale et la mortalité infanto-juvénile constituent des mesures directes de la vulnérabilité des populations les plus jeunes et de l'efficacité des interventions en santé infantile. La faible utilisation des latrines hygiéniques est un indicateur clé des risques environnementaux et des pratiques d'hygiène, étroitement liés à la prévalence des maladies diarrhéiques et d'autres infections. La malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans reflète un problème de santé publique majeur aux conséquences à long terme sur le développement physique et cognitif.

Les indicateurs relatifs à la santé reproductive, tels que la prévalence contraceptive moderne, le taux de CPN4 (quatrième consultation prénatale) et l'Assistance Qualifiée à l'Accouchement (AQA), renseignent sur l'accès et l'utilisation des services essentiels pour la santé de la mère et du nouveau-né. La couverture vaccinale complète chez les enfants de moins de 5 ans est un indicateur fondamental de la protection contre les maladies évitables par la vaccination.

L'utilisation de la Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée (MILD) chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes est un indicateur spécifique des efforts de prévention du paludisme, une endémie majeure en RDC. La prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans vient compléter cette évaluation de la charge de morbidité liée à cette maladie. Les comportements de recherche de soins, tels que la recherche de soins pour fièvre et la recherche de conseils ou traitement pour diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans, témoignent de l'accès aux soins et de la sensibilisation des communautés aux problèmes de santé infantile.

Enfin, la connaissance des moyens de prévention du VIH chez les femmes et les hommes est un indicateur crucial dans le contexte de l'épidémie de VIH, permettant d'évaluer le niveau de sensibilisation et potentiellement l'adoption de comportements préventifs. L'agrégation et l'analyse comparative de ces indicateurs au niveau provincial permettent d'établir un classement objectif des provinces en fonction de leurs besoins relatifs en matière de santé communautaire, guidant ainsi l'allocation prioritaire des ressources et la mise en œuvre ciblée des interventions du nouveau plan stratégique.

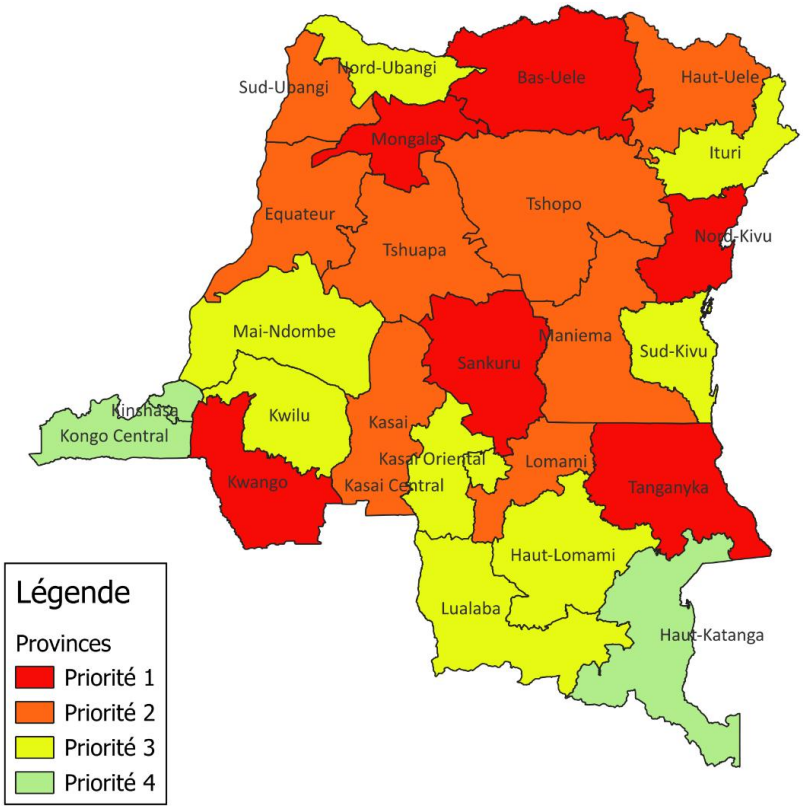


Figure 14: Priorisation des provinces

Les provinces à haute priorité (priorité 1) sont au nombre de **6** ; celles à moyenne priorité (priorité 2) sont au nombre de **8** et celles à faible priorité (priorité 3) sont au nombre de **9** et **3** provinces sont classées à très faible priorité (priorité 4).

Il sied de noter que les 3 provinces à très faible priorité s'avère être aussi les trois provinces avec indice de bien-être économique le plus élevé.

4.1.4. Description du paquet des soins et services de santé communautaire (Paquet Minimum d'Activités Communautaires)

Le paquet de soins et services de santé communautaire est un ensemble d'interventions et de prestations de santé fournies au niveau communautaire. Ce paquet vise à (i) améliorer l'accès aux soins de santé de base pour tous, en particulier pour les populations les plus éloignées ou marginalisées, (ii) promouvoir la prévention des maladies et les comportements sains au sein des communautés, (iii) renforcer la prise en charge des problèmes de santé courants au niveau communautaire, (iv) favoriser la participation et l'engagement communautaire et l'appropriation des actions de santé par les populations elles-mêmes.

Le contenu du paquet de soins et services de santé communautaire de la RDC comprend 3 types d'activités :

- La promotion de la santé et prévention des maladies ;
- Les soins curatifs (prise en charge) ;
- Les soins de soutien.

Le tableau ci-dessous présente les détails des activités du paquet.

Tableau 23: Paquet de soins et services de santé communautaire

Domaines d'intervention	Activités	ASC	RECO
Santé maternelle et reproductive	Promotion de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes chez les femmes en âge de procréer (15-49 ans)	X	X
	Distribution communautaire des contraceptifs	X	
	Promotion et suivi des consultations prénatales dans les ESS ou les stratégies avancées chez la femme enceinte (au moins 4 CPN)	X	X
	Promotion du dépistage du VIH chez la femme enceinte	X	X
	Promotion et suivi de la vaccination antitétanique (VAT) chez la femme enceinte	X	X
	Promotion de l'utilisation de la MILD chez la femme enceinte	X	X
	Promotion et suivi du traitement préventif intermittent (TPI) chez la femme enceinte (3 doses)	X	X
	Promotion et suivi de la supplémentation en fer et acide folique chez la femme enceinte	X	X
	Sensibilisation sur la reconnaissance de signes de danger de la femme enceinte et allaitante et du nouveau-né	X	X
	Promotion de l'accouchement dans un ESS	X	X
	Promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois	X	X
Vaccination infantile	Promotion du respect de calendrier vaccinal de l'enfant	X	X
	Recherche active des enfants non et insuffisamment vaccinés	X	X
	Orientation des enfants non et insuffisamment vaccinés vers les sites de vaccination	X	X
	Participation aux campagnes de vaccination des enfants et les stratégies avancées	X	X
Nutrition à Assise Communautaire (NAC)	Promotion de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE)	X	X
	Suivi du développement psychomoteur de l'enfant	X	X
	Promotion et suivi de l'allaitement continu jusqu'à 2 ans	X	X
	Promotion et suivi de l'alimentation de complément diversifiée à partir de 6 mois	X	X
	Dépistage actif de la malnutrition aigüe à l'aide du MUAC à partir de l'âge de 6 mois	X	X
	Participation aux campagnes de supplémentation en vitamine A et de déparasitage	X	X
	Sensibilisation des ménages sur la croissance physique et le développement psychomoteur de l'enfant (pesée, mensuration)	X	X
	Déparasitage au Mébendazole ou Albendazole	X	X
	Supplémentation en vitamine A	X	X
Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant	Prise en charge de la fièvre avec du Paracétamol	X	
	Diagnostic du paludisme au TDR	X	
	Prise en charge de paludisme simple avec l'ACT	X	
	Evaluation et prise en charge de la diarrhée simple avec le SRO et le Zinc	X	
	Evaluation et prise en charge de cas simple d'infections respiratoires aigües avec l'Amoxicilline dispersible	X	
	Orientation de cas grave de paludisme, diarrhée et IRA sévères et MAS	X	
	Chimioprophylaxie du Paludisme (TPI chez l'enfant)	X	
Santé des adolescents et jeunes	Education nutritionnelle et sexuelle	X	X
	Promotion du dépistage du VIH et autres IST	X	X
	Promotion de l'utilisation des préservatifs (masculin et féminin)	X	X
	Distribution des préservatifs chez les adolescents et jeunes sexuellement actifs	X	X
	Sensibilisation sur la prévention des grossesses précoces et non désirables	X	X
	Promotion de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes	X	X
	Sensibilisation sur les violences sexuelles et basées sur le genre	X	X

Domaines d'intervention	Activités	ASC	RECO
	Promotion du dépistage de la drépanocytose	X	X
Maladies infectieuses ou transmissibles	Promotion de l'utilisation de MILD en particulier chez l'enfant de moins de 5 ans	X	X
	Sensibilisation sur la prévention contre le VIH et la TB	X	X
	Promotion de l'utilisation des préservatifs (masculin et féminin)	X	X
	Promotion du dépistage du VIH	X	X
	Orientation des cas suspects de TB vers le centre de diagnostic et de prise en charge	X	X
	Conseil à l'observance au traitement de l'infection à VIH/SIDA	X	X
	Soutien nutritionnel et psychologique aux PVVIH	X	X
	Identification et soutien des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV)	X	X
	Conseil à l'observance au traitement antituberculeux	X	X
	Recherche de perdus de vue de VIH et TB	X	X
Maladies tropicales négligées (MTN)	Traitement de masse intégré (administration de médicaments) de l'onchocercose, de la filariose lymphatique, des géo helminthiases et des schistosomiases	X	
	Détection et orientation des personnes présentant des effets secondaires ou autres anomalies liées aux MTN	X	
	Recherche active des cas de MTN	X	X
	Référence /orientation des cas de MTN	X	X
Soutien psychosocial (Maladies mentales)	Sensibilisation à la santé mentale dans les communautés les plus isolées	X	X
	Détection précoce des problèmes et troubles de santé mentale courants (dépression, anxiété, troubles liés au stress post-traumatique) et des violences basées sur le genre	X	X
	Dispensation du premiers secours psychologique (PSP) et counselling, gestion du stress, gestion des informations et rumeurs	X	
	Organisation des thérapies en groupe et groupes de parole et de soutien entre pairs dans les zones affectées par des conflits	X	
	Organisation des activités de réhabilitation psychosociale (thérapie occupationnelle, activités génératrices de revenus, etc.)	X	
	Organisation de séances médiation familiale et communautaire pour réduire la stigmatisation	X	
	Orientation des cas aux centres specialisés	X	X
	Suivi à domicile des personnes atteintes de troubles sévères de santé mentale	X	X
Surveillance à base communautaire (SBC)	Recherche active des MAPEPI (Rougeole, poliomyélite, fièvre jaune, cholera, Covid 19, Mpox, MVE, etc.)	X	X
	Notification des cas des maladies évitables par la vaccination, MAPEPI	X	X
	Sensibilisation sur les mesures barrières en cas d'épidémie et pandémie	X	X
	Suivi des cas contact en cas d'épidémie ou pandémie	X	X
	Alerte sur les rumeurs ou tout événement inhabituel de santé publique (surveillance basée sur les évènements)	X	X
	Alerte sur le décès communautaire (maternel et néonatal)	X	X
	Alerte sur le décès en masse ou en série de bétail ou volaille et surveillance de la santé animale et environnementale	X	X
	Validation des alertes en situation d'urgence	X	X
Eau, hygiène et assainissement (EHA)	Promotion du lavage des mains avec de l'eau et du savon ou de la cendre	X	X
	Promotion de l'utilisation des latrines hygiénique et de l'arrêt de la défection à l'air libre	X	X
	Sensibilisation sur l'utilisation systématique des méthodes de traitement d'eau de boisson	X	X
	Promotion de l'assainissement du milieu (désherbage, débouchage des caniveaux, gestion des déchets)	X	X
	Promotion de la décontamination des ménages, lieux publics	X	X

Domaines d'intervention	Activités	ASC	RECO
	Promotion de l'Enterrement digne et sécurisé	X	X
Management et suivi participatif	Dénombrement des ménages et actualisation des cibles	X	X
	Participation aux dialogues et diagnostic communautaire du village ou du quartier	X	X
	Participation à l'élaboration du plan de développement du village ou du quartier	X	X
	Participation aux réunions mensuelles de monitorage des organes de dialogue à différents niveaux	X	X
	Collecte des données dans les ménages sous sa responsabilité, transmission du rapport mensuel et contrôle citoyen	X	X
	Participation aux activités de l'Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC)	X	X
	Notification des cas de décès dans la communauté	X	X
	Notification des effets indésirables des produits de sante	X	
Genre et protection sociale	Promotion de l'enregistrement des enfants à l'Etat civil et orientation	X	X
	Promotion de l'utilisation des mutuelles de santé à base communautaire	X	X
	La Sensibilisation contre les mariages précoces, les grossesses précoces et non désirées	X	X
	Sensibilisation contre les violences basées sur le genre (VBG)	X	X
	Soutien aux victimes des violences basées sur le genre (VBG)	X	X
Education	Promotion de l'éducation des filles	X	X
	Promotion de l'Espace communautaire d'Eveil	X	X
	Promotion de l'hygiène et assainissement à l'école (système de lave-mains, latrines améliorées)	X	X
	Promotion de l'alphabétisation fonctionnelle intensive (AFI)	X	X
Agriculture, peche et élevage	Promotion de l'élevage des petits ruminants	X	X
	Promotion des semences améliorées à l'endroit des groupements féminins	X	X
	Promotion de la pisciculture		
	Promotion des activités de peche responsable et respectuese de l'environnement		
	Promotion d'une agriculture mécanisée	X	X
Maladies non transmissibles (MNT)	Promotion de pratique du sport et de l'hygiène de vie	X	X
	Sensibilisation sur la prévention de l'hypertension artérielle (HTA)	X	X
	Sensibilisation sur la prévention contre le Diabète sucré	X	X
	Dépistage et orientation des personnes avec suspicion de l'HTA	X	
	Dépistage et orientation des personnes avec suspicion de Diabète sucré	X	
	Conseil à l'observance au traitement de HTA et Diabète	X	X
	Conseil nutritionnel et psychologique aux HTA et Diabétiques	X	X
	Suivi à domicile des maladies chroniques et invalidantes,	X	X
	Accompagnement à domicile avec les soins palliatifs et gériatriques	X	X
Rééducation et réadaptation fonctionnelle à base communautaire	Promotion du respect du code de la route pour la prévention des ATR	X	X
	Prévention des pathologies handicapantes et leurs facteurs de risque (tabagisme, consommation excessive d'alcool etc.)	X	X
	Recensement de toute personne en situation de handicap	X	X
	Pose de gestes simples pour améliorer le confort des malades	X	
	Orientation des cas vers les ESS	X	
	Suivi des patients appareillés ou non	X	

Le nouveau PSN déploie un Paquet de Soins et Services de Santé Communautaire (PSC) fondamentalement repensé pour répondre aux défis d'une nation en pleine mutation épidémiologique et nutritionnelle. Ce Paquet repose sur une reconnaissance claire des rôles

distincts et complémentaires des acteurs de première ligne. Les RECO sont explicitement mandatés pour se concentrer sur les activités de prévention primaire, la promotion active de comportements sains et l'offre d'un soutien psychosocial essentiel au sein des communautés. Leur rôle de catalyseur du changement social et de facilitateur de l'accès aux informations de santé est primordial.

Parallèlement, les ASC se voient attribuer un champ d'action élargi et intégré. En sus de leur implication dans les initiatives de prévention, de promotion de la santé et de soutien communautaire, ils sont désormais désignés pour assurer une prise en charge des affections courantes au niveau périphérique. Cette extension de leurs responsabilités vise à décentraliser l'offre de soins curatifs de base, réduisant ainsi la pression sur les structures de santé de niveau supérieur et améliorant l'accessibilité géographique et financière aux premiers recours.

L'architecture de ce paquet de soins et services témoigne d'une vision stratégique proactive face à un paysage sanitaire complexe. Tout en réaffirmant l'importance cruciale des interventions ciblant la santé maternelle et infantile, ainsi que le renforcement des programmes de nutrition et de vaccination infantile, le PSN intègre une réponse robuste et adaptée à la persistance des maladies transmissibles, qui constituent toujours un défi majeur pour la santé publique en RDC. De surcroît, il anticipe l'augmentation progressive de la prévalence des maladies non transmissibles en introduisant des actions de dépistage précoce, de gestion des cas et de prévention primaire au sein des communautés.

Le PSC est une plateforme complète qui transcende le concept de simple "soins" pour devenir un véritable modèle de santé publique intégrée et durable. Son exhaustivité se mesure à sa capacité d'adresser des problématiques historiquement reléguées du niveau communautaire, comme la gestion des Maladies non transmissibles (MNT) et la Rééducation et réadaptation fonctionnelle à base communautaire. Les activités MNT ne se limitent pas au dépistage et à l'orientation pour l'HTA et le Diabète, mais s'étendent au Conseil nutritionnel et psychologique et au Suivi à domicile des maladies chroniques et invalidantes. Ce suivi à domicile est crucial car il est directement lié à l'amélioration de l'observance thérapeutique et à la prévention des complications, un défi majeur dans la gestion des MNT en milieu rural.

La dimension la plus avancée du PSC réside dans la prise en charge des besoins des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, via la Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle (RRFC) et les Soins Palliatifs et Gériatriques. La RRFC commence par des activités de prévention, telles que la promotion du respect du code de la route pour prévenir les Accidents de la Route (ATR), et la sensibilisation contre les facteurs de risque de pathologies handicapantes (tabac, alcool). Les ASC sont chargés du Recensement de toute personne en situation de handicap, ce qui est une étape fondamentale pour planifier des interventions. Bien que la RRFC professionnelle se fasse en centre spécialisé, le rôle des ASC est de poser des gestes simples pour améliorer le confort des malades, d'assurer le Suivi des patients appareillés ou non, et surtout d'offrir l'Accompagnement à domicile avec les soins palliatifs, garantissant ainsi une fin de vie digne et des soins de support dans l'environnement familial.

L'efficacité du PSC repose sur une répartition claire des responsabilités qui doit être respectée. Les ASC sont les prestataires de services directs, avec des tâches techniques allant de la Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) simple (diagnostic TDR, ACT, SRO) à la gestion des Maladies Tropicales Négligées (MTN) par le traitement de masse. Cette délégation de tâches est une stratégie d'équité, mais sa réussite est entièrement subordonnée à la qualité de la formation initiale et continue des ASC et à leur supervision clinique régulière par les équipes des ESS.

En parallèle, les RECO opèrent comme la courroie de transmission et de surveillance du système. Leur rôle dans la Surveillance à base communautaire (SBC) est stratégique : la recherche active et la notification immédiate des MAPEPI (Maladies à Potentiel Épidémique et Pandémique), l'alerte

sur les rumeurs et les décès communautaires (maternels et néonatals). Leur efficacité dépend de la simplicité et de la rapidité des mécanismes de rapportage. Ils assurent la mobilisation sociale essentielle pour l'adhésion aux campagnes de vaccination et aux pratiques d'Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), comme l'utilisation des latrines et le traitement de l'eau.

Enfin, le caractère intersectoriel du PSC, incluant le Genre et Protection Sociale (sensibilisation VBG, promotion des mutuelles de santé) et l'Agriculture/Élevage (promotion des semences améliorées, élevage), consolide le rôle de l'agent communautaire comme un acteur de développement local intégré. Cette approche reconnaît que l'amélioration des conditions de vie, la sécurité alimentaire et l'autonomisation économique des femmes sont des leviers plus puissants pour la santé que les interventions cliniques isolées. Le succès global du PSC ne sera pas mesuré uniquement par la réduction des cas de paludisme, mais aussi par l'amélioration de l'enregistrement à l'état civil des enfants, la réduction des VBG et l'observance thérapeutique des maladies chroniques. Le défi majeur demeure le financement pérenne de cette force de travail pluri-compétente et l'équipement logistique nécessaire à la réalisation de l'ensemble de ces tâches.

4.2. Modalités d'exécution

4.2.1. Mécanisme de planification et de mise en œuvre du plan

Faisant suite à la participation de la RDC au symposium international sur l'institutionnalisation de la Santé Communautaire tenu en Afrique du Sud en décembre 2017, et en l'absence d'un cadre organique devant mettre en place une structure formelle de coordination de toutes les activités de la santé communautaires, la DGOGSS qui préside la Commission Prestations, Suivi et Mise en Œuvre a mis en place une sous-commission dénommée « Santé Communautaire » avec pour mandat d'appuyer le développement, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des prestations des activités de la santé communautaire.

Par conséquent, la planification et la mise en œuvre des interventions à base communautaires se feront à travers les structures de la santé communautaire à tous les niveaux du système sanitaire comme décrit plus haut au point relatif au rappel historique de la santé communautaire. Ces structures bénéficieront de l'appui du Gouvernement et de ses partenaires qui mettent à leur disposition des ressources humaines, financières et matérielles conformément à leur mandat.

Ainsi, la mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030 se fera de la manière suivante :

- **Au niveau central** par une structure de coordination de la santé communautaire en collaboration avec les autres direction centrales, programmes spécialisés et PTF.
- **Au niveau intermédiaire**, par la DPS, à travers la taskforce provinciale.
- **Au niveau opérationnel**, par l'ECZS, au travers l'AC, qui est le répondant autour de l'UCODESA au niveau de la ZS.
- Au niveau de l'AS, par l'IT et le CODESA.
- **Au niveau des villages/cellules**, la CAC est l'unité opérationnelle des activités communautaires.

Le plan d'action communautaire est élaboré après le diagnostic communautaire et devrait faire ancrage au PSN SACO 2025-2030. Les interventions inscrites dans le PAC devront être prises en compte également dans les PAO consolidés des ZS.

La coordination des appuis du Gouvernement, des PTF et de la société civile se fera à travers des réunions de concertation au cours desquelles les informations seront partagées à tous les niveaux.

4.2.2. Documents d'accompagnement du PSN SACO

L'opérationnalisation efficace du nouveau PSN requiert impérativement l'élaboration et la mise en œuvre d'un ensemble cohérent de documents d'appui normatifs et procéduraux. Ces instruments constituent le socle technique et organisationnel permettant de traduire les orientations stratégiques en actions concrètes et harmonisées sur le terrain. Ils visent à garantir la qualité, la standardisation et l'efficience des interventions des ASC, des RECO et des autres acteurs impliqués à tous les niveaux du système.

Parmi les documents essentiels figurent en premier lieu des normes et protocoles de prise en charge pour les affections courantes relevant du mandat des ASC. Ces outils doivent définir clairement les algorithmes décisionnels, les schémas thérapeutiques actualisés, les critères de référence vers les structures de santé de niveau supérieur, ainsi que les procédures de suivi et de documentation des cas. Des guides de prévention et de promotion de la santé sont également indispensables pour uniformiser les messages clés, les approches pédagogiques et les stratégies de mobilisation communautaire mises en œuvre par les RECO et les ASC. Ces guides devront s'adapter aux spécificités culturelles et épidémiologiques des différentes zones géographiques.

Un autre volet crucial concerne l'élaboration de procédures opérationnelles standardisées pour l'ensemble des activités du plan stratégique. Cela inclut des procédures pour la gestion des approvisionnements et des stocks d'intrants et de médicaments au niveau communautaire et des CS, pour la surveillance épidémiologique à base communautaire, pour la mise en œuvre des activités de management participatif, pour l'intégration des aspects de genre et de protection sociale dans les interventions, ainsi que pour les activités d'éducation, de rééducation et de réadaptation fonctionnelle à base communautaire. Des guides de formation et de supervision sont également nécessaires pour assurer le renforcement continu des capacités des ASC et des RECO, ainsi que pour harmoniser les pratiques de supervision et d'appui technique à tous les niveaux.

En complément, des outils de suivi et d'évaluation standardisés doivent être développés pour mesurer l'atteinte des indicateurs clés du plan stratégique, faciliter la collecte et l'analyse des données de performance, et permettre un ajustement proactif des interventions. Ces outils doivent inclure des formulaires de collecte de données harmonisés, des guides d'analyse et d'interprétation des données, ainsi que des mécanismes de rétro-information vers les acteurs de terrain. Enfin, des directives et des cadres de collaboration intersectorielle sont essentiels pour favoriser les synergies avec les autres secteurs (eau, assainissement, éducation, agriculture, etc.) et pour optimiser l'impact global du plan stratégique sur la santé et le bien-être des communautés. L'ensemble de ces documents d'appui doit être élaboré dans un processus participatif, impliquant les différents acteurs clés, et faire l'objet d'une diffusion et d'une appropriation adéquates pour garantir leur utilisation effective sur le terrain.

4.2.3. Rôles et responsabilités des intervenants

Les rôles et responsabilités des intervenants dans la mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030 sont ci-dessous décrits :

Tableau 24: Rôles et responsabilités des interventions dans la mise en oeuvre du PSN SACO 2025-2030

N°	Intervenants	Rôles et responsabilités
1	**Assemblée Nationale et Sénat**	• Voter le projet de loi portant sur l'institutionnalisation de la santé communautaire et la professionnalisation des ASC et RECO • Inscrire une ligne budgétaire sur la santé communautaire
2	**Gouvernement National**	• Mobiliser des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des interventions à base communautaire et les mutuelles de santé à travers le Fonds de promotion de la santé

N°	Intervenants	Rôles et responsabilités
		• Intégrer la santé communautaire dans toutes les politiques sociales à travers des actions synergiques sur les déterminants de santé • Mettre en place des services sociaux de base et s'assurer de leur pleine utilisation par les communautés bénéficiaires à différents niveaux
3	**Ministère de la Santé Publique, Hygiène et prévoyance sociale**	• Assurer la coordination et la planification des interventions de la santé communautaire • Mobiliser des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des interventions de la santé communautaire, y compris les ressources domestiques • Mener le plaidoyer pour l'appropriation et le financement interne et externe de la santé communautaire • Soutenir la mise en œuvre des mutuelles de santé et création des activités génératrices de revenus (AGR) • Renforcer la collaboration entre les PTF et les organisations de la société civile (OSC) impliqués dans la santé communautaire à travers des structures de coordination fonctionnelles. • Soutenir et organiser des plaidoyers sur l'institutionnalisation de la SACO et la professionnalisation des acteurs communautaires auprès de l'Assemblée Nationale.
4	**Organisations de la société civile**	• S'aligner au PSN SACO 2025-2030 • Mener le plaidoyer auprès des autorités politico-administratives pour la mobilisation des ressources domestiques • Mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les initiatives communautaires • Renforcer les capacités des acteurs des OSC pour accompagner et pérenniser les interventions de la santé communautaire • Renforcer la collaboration entre les OSC et les structures de coordination de la santé communautaire • Renforcer l'autonomisation des communautés à travers les initiatives locales de développement (ILD) • Sensibiliser la population sur ses droits et devoirs civiques, à son rôle dans la fourniture des services communautaires • Assurer le suivi communautaire et la redevabilité sociale portant sur l'accès, la disponibilité et la satisfaction des services dans le cadre du contrôle citoyen
5	**Communautés**	• Se choisir des personnes intègres avec probité morale au sein des structures de participation communautaire • Mettre en œuvre les bonnes pratiques essentielles à la santé • Identifier les obstacles en rapport avec l'accès et la disponibilité des services • Relever les défis liés à la meilleure fonctionnalité des structures de santé communautaire • Trouver des solutions locales pour répondre aux défis et augmenter l'engagement des communautés.
6	**Partenaires techniques et financiers**	• Apporter un appui technique et financier au ministère de la santé pour la santé communautaire • Appuyer la mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030 • Mobiliser les ressources extérieures en faveur de la santé communautaire • S'aligner aux orientations du PSN SACO 2025-2030 dans la mise en œuvre de leurs interventions.
7	**Institutions de recherche et Universités**	• Initier des études et recherches sur les approches communautaires innovantes • Diffuser des évidences probantes des études et recherches pouvant guider la planification et la mise en œuvre des interventions communautaires • Appuyer et accompagner le ministère de la santé dans l'application des nouvelles connaissances fondées sur des données probantes.

4.2.4. Institutionnalisation de la santé communautaire et professionnalisation des acteurs communautaires

La problématique de la motivation des RECO a été longtemps considérée comme l'un des goulots majeurs décelés dans le système de gestion et des stratégies susceptibles d'améliorer l'efficacité de leur travail. L'institutionnalisation de la santé communautaire et la professionnalisation des métiers des ASC en RDC est l'une des options pour résoudre cette problématique.

La mise en œuvre de ce plan devra impérativement prendre en compte les recommandations formulées par l'OMS[98], adaptées et adoptées consensuellement par toutes les parties prenantes lors de l'atelier de réflexion de Kola sur l'institutionnalisation et la professionnalisation des ASC pour un pilote avant le déploiement à grande échelle, l'intégration et l'optimisation de la conception et des performances ainsi que de la pérennisation du programme des ASC.

Il est essentiel de noter que les deux processus sont une démarche continue et progressive.

4.2.4.1. Processus d'institutionnalisation de la santé communautaire

L'institutionnalisation de la santé communautaire suivra deux grandes étapes, à savoir : (i) la phase de la reconnaissance officielle des ASC et (ii) celle de la professionnalisation proprement dite.

Phase 1 : Reconnaissance officielle des métiers des ASC

Pour y parvenir, trois modalités devront être abordées :

- **Création d'un cadre juridique et réglementaire** : Le MSPHPS devra proposer un avant-projet des lois à soumettre à l'Assemblée et au Sénat en vue de son adoption. Ces textes légaux et réglementaires devront être promulgués et publiés au Journal officiel pour devenir exécutoire par les autorités compétentes. Ce cadre juridique officialisera la reconnaissance des métiers des ASC. Cela inclut la création du statut juridique et des classifications professionnelles adaptées ;
- **Intégration dans le système national de santé** : Les ASC devront être intégrés dans le système de santé publique avec une reconnaissance officielle de leur rôle dans les prestations des soins de santé primaires. ;
- **Définition des statuts de l'ASC** : il sera un prestataire de services bénéficiant d'une rémunération moyennant la fourniture des services conformément aux clauses contractuelles.

Phase 2 : Professionnalisation des ASC

L'étape de la professionnalisation des ASC dont les détails des modalités sont repris dans le tableau ci-dessous, se résume aux actions suivantes :

- **Formation et certification** qui consistent à : (i) développer de programmes de formation adaptées aux réalités locales, (ii) élaborer des modules intégrés de formation en tenant compte des compétences de base des ASC, (iii) créer un partenariat avec des institutions académiques locales, (iv) s'assurer de la formation continue des ASC pour la mise à jour.
- **Création de mécanismes de rémunération et de soutien** qui consistent à : (i) offrir des motivations financières et non-financières adéquates. Cela devra inclure une prime de

[98] Directives de l'OMS sur la politique de santé et l'accompagnement au sein du système en vue d'optimiser les programmes relatifs aux agents de santé communautaires. Genève, 2010. ISBN 978-92-4-255036-8.

performance régulière ou des incitations (appui financier aux AGR, implication dans les activités de masse, les soins gratuits à eux-mêmes et leurs dépendants) basées sur des objectifs de santé mesurables conformément au cadre de performance, et (ii) d'apporter un soutien logistique et matériel (kits de santé, supports d'information, des moyens de transport pour couvrir les zones éloignées).

- **Encadrement et supervision** qui consistent à : (i) accompagner les ASC par les IT et les CAC, et (ii) rapporter et évaluer l'impact de leurs activités à travers un système clair de collecte et de suivi des données pour rendre compte auprès des autorités sanitaires et les responsables des structures de participation communautaire.
- **Renforcement des capacités gestionnaires des organes de participation communautaires** afin de garantir un flux d'informations et un soutien mutuel.
- **Sensibilisation et mobilisation des communautés par le CAC** sur le rôle crucial joué par les ASC dans la prévention des maladies, la sensibilisation sanitaire, et le soutien aux soins de santé primaires. Cela permettra de renforcer la confiance de la communauté envers les ASC (Acceptabilité et respect).
- **Partenariats avec les OAC :** auront à travailler en partenariat avec les ASC dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'accès aux soins.
- **Suivi, évaluation et redevabilité** qui consistent à : (i) mettre en place un cadre des indicateurs de suivi et d'évaluation ainsi que des outils de collecte et transmission des données communautaires, et (ii) organiser un forum communautaire par le CAC comme cadre de redevabilité pour discuter des questions majeures de santé et de respect des rôles et responsabilités des prestataires des soins et de la communauté. Ces derniers seront évalués chaque mois par l'IT.

4.2.4.2. Processus de professionnalisation des ASC

Bien que la professionnalisation concerne uniquement les ASC, les modalités décrites dans le tableau ci-dessous prennent également en compte les RECO dont le rôle demeure indispensable pour pérenniser les activités de promotion et de prévention, et qui nécessitent un renforcement des compétences.

Tableau 25 : Modalités d'exécution pour la professionnalisation des ASC et RECO en RDC.

Étapes	Modalités d'exécution	Acteurs concernés	
		ASC	RECO
Etape 1 : Sélectionner, former et certifier les ASC et RECO			
Sélection	- Niveau minimal de formation	- Être minimum diplômé(e) d'Etat	- Savoir lire et écrire avec un niveau minimum de 8ème de l'éducation de base
	- Appartenance à la communauté et l'acceptation par celle-ci	- Habiter l'aire d'intervention	- Avoir habité le village pendant au moins 12 mois
	- Examen des compétences /capacités personnelles	- Organiser un test d'évaluation initiale du niveau à standardiser	- Idem
	- Egalité des chances aux hommes et aux femmes selon le contexte	- Donner la même chance à tous, 50% de femmes	- Idem
	- Age minimal	- Être âgé(e) d'au-moins 18 ans	- Idem
	- Connaissances linguistiques et communication	- Maitriser la langue locale	- Idem

Étapes	Modalités d'exécution	Acteurs concernés	
		ASC	RECO
	- Crédibilité	- Être crédible dans la communauté et être d'une bonne moralité	- Idem
	- Volontariat	- Adhérer volontairement comme ASC	- Idem
	- Election	- Être élu par les RECO à l'occasion d'une réunion spéciale élective organisée par la CAC en présence du chef de village	- Être élu par la communauté à l'occasion d'une assemblée du village ou de la cellule (avenue/localité/bloc)
Formation	- Durée de la formation initiale	- Ancien RECO-Site : 14 jours - Ancien RECO-promotionnel : 21 jours	- 10 jours
	- Suivi post-formation	- 7 jours par mois pendant 3 mois d'affilée	- Idem
	- Examen de connaissances	- Pré-test avant formation pour évaluer les prérequis et post-test pour évaluer le niveau d'assimilation des matières dispensés	- Idem
	- Type de formation	- Privilégier les formations en paquet et utilisation des ordinogrammes de soins	- Privilégier les formations en paquet
	- Certification	- Délivrer un certificat basé sur les résultats du post-test (production de certificats + cérémonie de remise desdits certificats)	- Idem
Etape 2 : Gérer et superviser les ASC			
Supervision	- Superviseurs	- Infirmier titulaire (IT)	- ASC dans les zones où sa présence se justifie - Président de la CAC dans les zones où sa présence ne se justifie
	- Supervision formative	- Réalisée sur base d'une check-list avec retro-information	- Idem
Rémunération	- Type de motivation	- Prime	- Frais de fonctionnement et développement des AGR
	- Rythme de la motivation financière	- Mensuelle par Mobile money	- Mensuelle par Mobile money (octroyée au RECO et la CAC pour le fonctionnement et développement des AGR)
	- Autres mesures incitatives	- Remboursement transport - Activités de masse - Signes distinctifs (gilets ou EPI) - Dotation individuelle des kits (bottes, sac, etc.)	- Idem
Accord contractuel	- Contractualisation	- Contrat de prestation des services avec le MSPH-PS	- Idem
	- Liste maitresse nationale	- ASC contractant	- RECO contractant
	- Durée du contrat	- 3 ans renouvelable	- Idem

Étapes	Modalités d'exécution	Acteurs concernés	
		ASC	RECO
Progression carrière	- Evolution du rôle	- Développement et promotion de la carrière en adéquation avec les besoins de terrain (passage de l'ASC à l'AC)	- Développement et promotion de la carrière en adéquation avec les besoins de terrain (passage du RECO à l'ASC)
Etape 3 : Intégration dans les systèmes de santé et soutien de la communauté			
Taille de la population cible	- Ratio	- 1 ASC pour 300 ménages	- 1 RECO pour 50 ménages en milieu péri-urbain et rural - 1 RECO pour 75 ménages en milieu urbain
	- Situations particulières	- 2 ASC pour 300 ménages dans le village ou groupe de village à très faible démographie et en situation d'accès difficile aux ESS	- 2 RECO pour 50 ménages dans le village ou groupe de village à très faible démographie et en situation d'accès difficile aux ESS
Gestion des données	- Collecte et exploitation des données	- Permettre aux ASC de recueillir, de rassembler et d'exploiter les données de santé sur les activités de routine	- Idem
	- Digitalisation du système d'information à base communautaire	- Privilégier la digitalisation où la connectivité internet est bonne - Recours aux outils papiers dans les zones avec où la connectivité internet est limitée	- Idem
	- Suivi linéaire et individualisé des ménages et autres cibles spécifiques	- Valider les données de dénombrement provenant du RECO	- Assurer le suivi linéaire et individualisé des cibles spécifiques
Engagement communautaire	- Niveau d'engagement	- Faire participer les RECO à la sélection des ASC et à la promotion du programme	- Faire participer la communauté à la sélection des ASC et à la promotion du programme
	- Mode d'installation officielle	- Lors d'une cérémonie d'installation officielle par une autorité politico-administrative locale	- Idem
	- Implication des représentants de la communauté dans la planification, le choix de priorités, le suivi, l'évaluation et la résolution des problèmes	- Elaboration du plan d'action communautaire annuel avec l'implication de toutes les parties prenantes - Participation aux réunions de monitorage organisées par la CAC	- Idem
Mobilisation des ressources communautaires	- Contribution de la communauté	- Plaidoyer auprès des ETD pour la mobilisation des ressources locales nécessaires pour la mise en œuvre des activités prioritaires (rétrocession destinée aux ETD)	- Idem

4.2.5. Gouvernance institutionnelle de la santé communautaire

Une gouvernance solide, inclusive, transparente et multisectorielle constitue un levier fondamental pour la transformation du système de santé en RDC, en particulier dans le domaine de la santé communautaire. En effet, malgré son potentiel stratégique, la santé communautaire en RDC reste encore marquée par une faible coordination institutionnelle, la multiplicité des intervenants, la fragmentation des approches et un encadrement insuffisant des ressources humaines communautaires.

Face à ces défis, la réforme de la gouvernance institutionnelle proposée dans ce plan vise à assurer une gestion cohérente, équitable et durable des interventions de santé communautaire, du niveau central jusqu'aux communautés de base. Elle repose sur la création d'une Direction de la Santé Communautaire (DSC) au niveau national, le renforcement des structures provinciales et la consolidation du dispositif opérationnel dans les zones de santé.

4.2.5.1. Vision stratégique de la gouvernance communautaire

La gouvernance institutionnelle de la santé communautaire s'inscrit dans une logique de décentralisation, d'intégration, de professionnalisation et de redevabilité. Elle repose sur les principes suivants :

- **Leadership national fort**, avec un ancrage institutionnel formel et reconnu de la santé communautaire ;
- **Coordination multisectorielle**, tenant compte de la transversalité des déterminants sociaux de la santé ;
- **Subsidiarité**, avec un transfert clair des compétences aux niveaux provincial et local.
- **Participation communautaire**, à travers des mécanismes structurés d'engagement citoyen ;
- **Transparence et redevabilité**, grâce à des systèmes de suivi-évaluation et de redevabilité sociale ;
- **Équité**, avec une attention particulière aux zones rurales, enclavées, aux populations vulnérables et marginalisées.

4.2.5.2. Création de la Direction de la Santé Communautaire (DSC)

Rôle et mandat

La DSC sera une structure spécialisée, placée sous l'autorité directe du **Secrétariat Général à la Santé**, au sein du **Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale**. Elle sera **le point focal national** de coordination, de normalisation, de supervision et d'évaluation des activités communautaires.

Ses responsabilités clés incluent :

- La formulation des **politiques, normes, directives et référentiels** en matière de santé communautaire ;
- La coordination de la mise en œuvre du **Paquet Minimum d'Activités Communautaires (PMAC)**, en lien avec les programmes de santé prioritaires ;
- La gestion administrative et technique des **ASC**, **RECO** et autres ressources humaines communautaires ;
- La coordination du **renforcement des capacités** à tous les niveaux ;
- La supervision de la collecte, du traitement et de l'analyse des **données communautaires**, et leur intégration dans le **Système National d'Information Sanitaire (SNIS/DHIS2) ;**
- La collaboration avec les **autres Directions techniques** du ministère et les **programmes verticaux** pour garantir l'intégration des interventions au niveau communautaire ;

- La facilitation du dialogue et de la coordination **multisectorielle**, en lien avec les ministères de l'Éducation, de l'Agriculture, des Affaires sociales, du Genre, de la Jeunesse, de la Décentralisation, etc.
- Le pilotage du **cadre de suivi-évaluation, d'apprentissage et de redevabilité** des interventions communautaires.

Ancrage légal et cadre réglementaire

La création de cette direction sera consacrée par un **arrêté du Ministre ayant la santé dans ses attributions**, qui définira :

- Sa **mission**, ses **attributions spécifiques**, son **organigramme interne** (services, divisions, bureaux, etc.) ;
- Les **modalités de fonctionnement** et de **coordination interne** avec les autres entités du ministère ;
- Les relations **fonctionnelles et hiérarchiques** avec les structures provinciales et opérationnelles ;
- Les mécanismes d'**évaluation de performance**.

Cet arrêté servira de **base juridique** pour l'institutionnalisation formelle de la santé communautaire dans le système national de santé.

4.2.5.3. Renforcement de la gouvernance au niveau provincial

Création des Bureaux Santé Communautaire (BSC)

Au sein des **Divisions Provinciales de la Santé (DPS)**, des **Bureaux Santé Communautaire** seront mis en place pour coordonner, planifier, suivre et appuyer la mise en œuvre des interventions communautaires dans les Zones de Santé.

Ces bureaux, animés par des professionnels qualifiés, auront pour missions :

- D'adapter les directives nationales au contexte provincial ;
- De superviser la mise en œuvre du PMAC dans les ZS ;
- De planifier et coordonner les formations et supervisions ;
- De consolider et analyser les données communautaires ;
- De faciliter la collaboration avec les **secteurs provinciaux connexes** (éducation, affaires sociales, jeunesse, etc.) ;
- D'assurer une veille communautaire en cas de **crise sanitaire** ou humanitaire.

Cadre de coordination multisectorielle

Chaque province devra mettre en place un **cadre provincial de concertation** pour la santé communautaire, qui inclura les représentants :

- Des ministères sectoriels provinciaux ;
- Des autorités politico-administratives ;
- Des PTF ;
- Des organisations de la société civile.

Ce cadre garantira une cohérence entre les actions des différents acteurs, évitera les duplications et renforcera la redevabilité locale.

4.2.5.4. Renforcement du dispositif opérationnel au niveau des Zones de Santé

Rôle des Zones de Santé

Les ZS continueront de constituer le **noyau opérationnel** de la mise en œuvre des activités de santé communautaire. Elles seront chargées de :

- La planification, exécution et suivi des interventions communautaires dans leurs aires de santé ;
- La coordination de l'encadrement des ASC et RECO par les **animateurs communautaires (AC)** ;
- Le renforcement des structures communautaires (CAC, CODESA, UCODESA) ;
- La supervision et validation des données communautaires avant transmission aux niveaux supérieurs ;
- L'ancrage de la redevabilité sociale à travers les **revues communautaires** et les **forums communautaires**.

Animateurs communautaires : piliers du dispositif local

Les **AC** joueront un rôle pivot dans l'appui de proximité aux ASC et RECO, notamment :

- Formation continue, coaching et supervision formative ;
- Appui à la gestion des outils communautaires ;
- Mobilisation sociale et engagement communautaire ;
- Interface entre la formation sanitaire, les structures communautaires et les autorités locales.

Leur profil, cahier des charges et plan de formation devront être clairement définis dans un référentiel national harmonisé.

4.2.5.5. Mécanismes de coordination et de redevabilité

Afin d'assurer une gouvernance effective, participative et transparente de la santé communautaire en RDC, il est essentiel d'institutionnaliser des mécanismes de coordination, de dialogue technique, de concertation multisectorielle et de redevabilité à tous les niveaux du système de santé. Ces mécanismes joueront un rôle clé dans la planification, la mise en œuvre, le suivi, l'harmonisation des approches, la mobilisation des ressources, la remontée des défis du terrain, ainsi que dans l'amélioration continue de la performance des interventions communautaires.

Mécanismes de coordination technique et multisectorielle

Des instances formelles seront mises en place à chaque niveau (national, provincial et zonal) pour garantir une coordination multisectorielle intégrée, une synergie des actions entre acteurs et une cohérence dans la mise en œuvre du PSN SACO.

Tableau 26: Mécanismes de coordination technique et multisectorielle

Niveau	Instance de coordination proposée	Objectifs clés	Fréquence
National	Comité Technique National de la Santé Communautaire	- Orientations stratégiques - Harmonisation des interventions - Coordination avec les directions/programmes - Mobilisation des partenaires et ressources	Trimestrielle
Provincial	Cadre de concertation provincial de la santé communautaire	- Adaptation contextuelle des directives - Planification coordonnée - Suivi provincial - Intégration multisectorielle	Trimestrielle
Zonal	Réunion zonale de coordination de la santé communautaire	- Supervision intégrée - Échange d'expériences - Résolution conjointe des problèmes - Coordination ONG-ZS	Mensuelle

Chaque instance intégrera des représentants :

- Des institutions gouvernementales ;
- De la société civile et des leaders communautaires ;
- Des partenaires techniques et financiers.

La **redevabilité sociale** sera également promue par :

- Des mécanismes de **feedback communautaire** (boîtes à suggestions, lignes vertes, enquêtes de satisfaction, etc.) ;
- Des **audits sociaux** ;
- La **participation des citoyens** aux revues de performance.

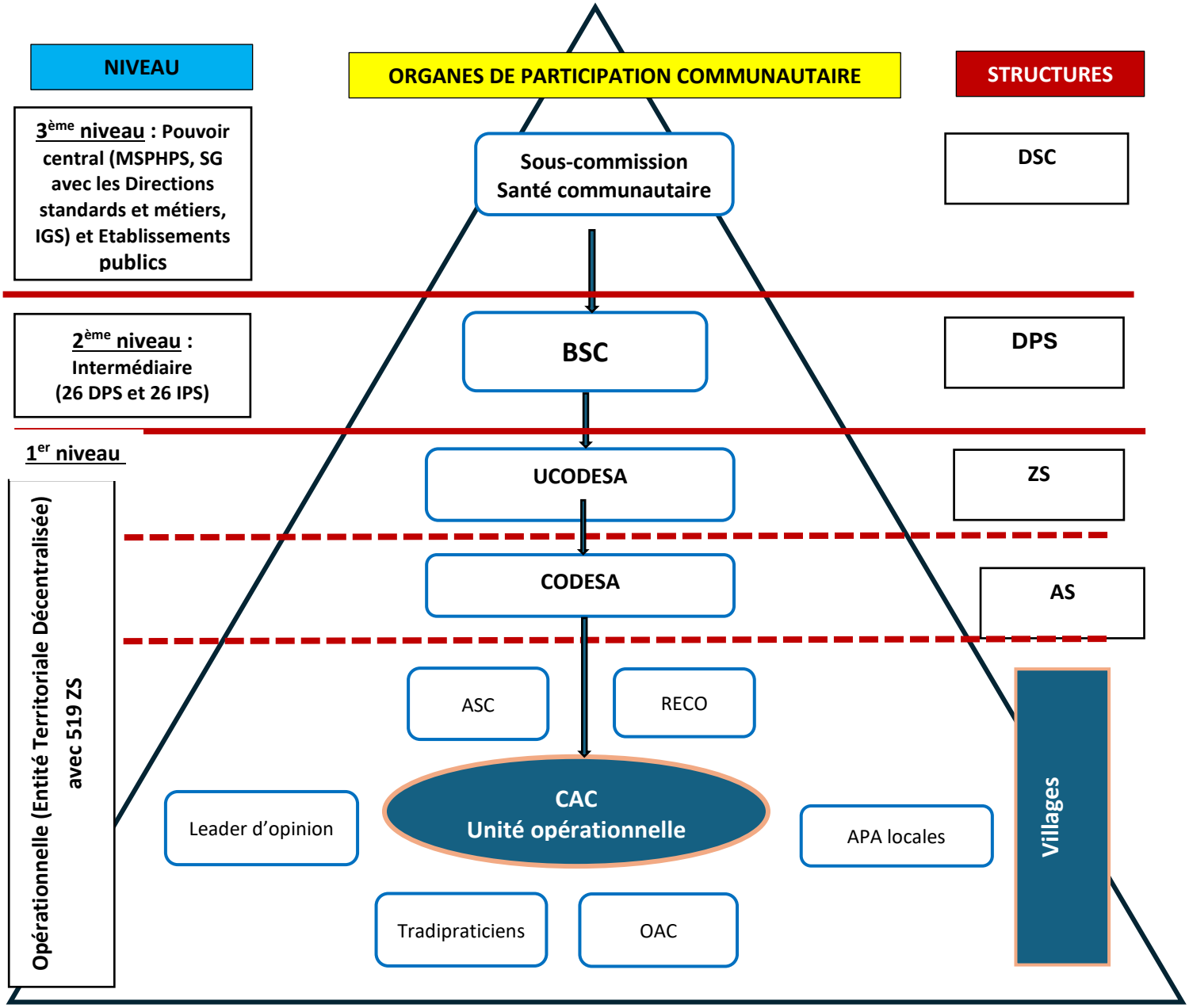


Figure 15: Cadre organisationnel de la santé communautaire

Gestion des approvisionnements et stocks

La mise en place d'un mécanisme robuste de gestion des approvisionnements et des stocks est cruciale pour garantir la disponibilité continue des médicaments et intrants essentiels aux ASC et aux RECO, leur permettant d'exercer efficacement leurs fonctions respectives de soins curatifs (pour les ASC) et de prévention/promotion (pour les RECO et potentiellement les ASC). Ce mécanisme doit s'intégrer harmonieusement avec les structures existantes de gestion des médicaments et autres intrants du système de santé de la RDC.

La chaîne logistique envisagée s'articule autour de plusieurs niveaux interconnectés. Au niveau périphérique, les ASC et les RECO, en fonction de leurs besoins spécifiques (traitement pour les ASC, matériel de sensibilisation pour les RECO et les ASC), effectuent une estimation périodique de leurs besoins en se basant sur la consommation historique, les prévisions épidémiologiques et les plans d'activités communautaires. Ces estimations sont agrégées au niveau des CS, qui constituent le premier échelon de stockage et de distribution. Les CS, sous la supervision de leur responsable, consolident les demandes des ASC et RECO de leur AS et transmettent une demande globale au niveau de l'ECZS. La ZS joue un rôle central dans la gestion des stocks intermédiaires. Elle réceptionne les demandes agrégées des CS, effectue une analyse des besoins à l'échelle de la ZS, gère un stock tampon pour anticiper les ruptures et assure la redistribution des intrants vers les CS selon un calendrier préétabli ou en cas d'urgence.

Au niveau intermédiaire, la CDR est responsable de l'acquisition, du stockage à grande échelle et de la distribution des médicaments et intrants essentiels vers les ZS. Les demandes des ZS sont basées sur leur consommation globale et leurs prévisions. Un système d'information logistique intégré est indispensable à tous les niveaux pour assurer la collecte, la transmission, l'analyse et l'utilisation des données relatives aux stocks, à la consommation, aux ruptures et aux prévisions. Ce système permet une prise de décision éclairée, l'optimisation des commandes, la prévention des surstocks et des pénuries, ainsi que le suivi de la chaîne du froid pour les produits thermosensibles. Des mécanismes de contrôle qualité à chaque étape de la chaîne, depuis la réception jusqu'à la distribution aux ASC et RECO, sont essentiels pour garantir l'intégrité et l'efficacité des produits. Enfin, des audits réguliers et des inventaires physiques doivent être effectués à tous les niveaux pour assurer la transparence et la responsabilisation dans la gestion des approvisionnements et des stocks. La formation continue du personnel à tous les niveaux de cette chaîne logistique est un investissement indispensable pour son bon fonctionnement et sa pérennisation.

4.2.6. Gestion de risque

Le cadre de gestion des risques appui les acteurs de santé communautaires à adopter des pratiques exemplaires en vue de prévenir, détecter et enquêter sur les risques de malversations ou de non atteinte des résultats escomptés dans l'actuel plan stratégique SACO. Il clarifie la manière dont les différentes composantes et les principaux intervenants contribuent, directement ou indirectement, à la gestion des risques.

La gestion de risque est un axe capital qui matérialise le respect de la bonne gouvernance, conditionnant ainsi le succès de ce plan à travers une gestion rationnelle des ressources allouées. Le cadre de gestion de risque tiendra compte des éléments suivants :

- Renforcement du contrôle interne permettant la protection des ressources physiques et la crédibilité du programme tout en prévenant et détectant les fraudes. Il visera la fiabilité des opérations et la sécurité des biens et des financements ;
- Renforcement des audits externe selon les standards ;
- Cadre fiduciaire établissant un système de transparence et de fiabilité, et permettant le transfert des compétences en gestion financière ;
- Redevabilité exigeant à tout intervenant de rendre compte à tous niveaux.

Tableau 27 : Plan de gestion des risques éventuels et mesures d'atténuation lors de la mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030

Risques et mesures d'atténuation/mitigation		
Nature	**Risques**	**Mesures d'atténuation/mitigation**
Facteurs politiques et sécuritaires	- Les ressources financières qui seront mobilisées ne seront pas à la hauteur des objectifs assignés - L'insécurité dans plusieurs régions du pays peut avoir un impact négatif sur la mise e œuvre du PSN SACO 2025-2030	- La bonne gouvernance et le plaidoyer pour plus de ressources - Accorder la priorité aux secteurs sociaux de base, dont la santé en cas d'instabilité politique ou crise sécuritaire persistante
Facteurs financiers	- Insuffisance du budget alloué à la santé communautaire - Insuffisance dans la gestion du budget alloué à la santé communautaire - Dépendance totale du financement communautaire des ressources des PTF	- Plaidoyer intense pour la mobilisation des ressources de l'Etat et pour son leadership en faveur de la santé communautaire
Risques sanitaires	- Apparition d'épidémies graves - Catastrophes naturelles	- Mécanismes de prévention des épidémies et catastrophes et opérationnalisation du COUSP - Impliquer les communautés dans la gestion des épidémies et catastrophes naturelles - Pré-positionner les moyens de lutte contre les épidémies et catastrophes naturelles
Facteurs techniques	- Insuffisance des ressources humaines qualifiées et leur répartition à l'échelle nationale - Insuffisance dans la mise en œuvre des interventions relatives à la santé communautaire	- Répartition équitable des ressources humaines qualifiées - Existence de primes d'éloignement et de technicité
Aspects socio-culturels	- Niveau d'éducation insuffisant - Les pesanteurs socio-culturelles défavorables à l'adoption des bonnes pratiques - Insuffisance dans la promotion des pratiques familiales essentielles	- Maintenir la politique d'accès à l'école et la promotion de la scolarisation et l'éducation de tous - Tenir compte des aspects socio-culturels dans la conception et la mise en œuvre des projets et programmes de développement - Faire la promotion des pratiques familiales essentielles

4.2.7. Plan de communication et vulgarisation

La mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030 maintiendra une place de choix à la communication entre les différents niveaux dans l'optique de :

- Vulgariser le PSN SACO 2025-2030 à tous les niveaux ;
- Promouvoir le changement social et de comportement.

Pour ce faire, un plan de communication sera élaboré pour décrire les approches de la communication (plaidoyer pour assurer le leadership, mobilisation sociale focalisée sur le

changement positif des normes sociales et la communication pour le changement de comportement) à mettre en œuvre en vue d'accompagner la mise en œuvre de ce plan à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du pays.

Dans le contexte actuel du processus de décentralisation, il est impératif d'instaurer une communication harmonieuse entre les niveaux central et provincial, dans l'intérêt premier de la santé de la population, en attendant que des textes réglementaires appropriés viennent combler le vide actuel.

Quant à la vulgarisation et diffusion du PSN SACO 2025-2030, elle se fera dans toutes les 26 DPS auprès de tous les intervenants exerçant des responsabilités dans la mise en œuvre de ce plan. Cette vulgarisation devra permettre de sensibiliser et mobiliser les acteurs de manière à obtenir leur engagement dans l'exécution dudit plan dans une perspective de multisectorialité.

Un lot catalytique du PSN SACO 2025-2030 sera reprographié et partagé auprès des intervenants moyennant un briefing sur les priorités et le budget du plan. Outre cela, ce plan stratégique sera également publié sur les portails Web fonctionnels du MSPHPS pour faciliter l'accès massif d'informations sur ce document à tout le monde. Des sessions de sensibilisation et de plaidoyer seront organisées à l'intention des parties prenantes afin de mobiliser les fonds supplémentaires nécessaires pour couvrir les gaps.

4.2.8. Charge de travail des ASC et RECO

La charge de travail des ASC et RECO est considérable et variée en fonction ci-dessous :

- **Taille de la population à servir** : Plus le nombre de personnes à prendre en charge est élevé, plus la charge de travail de l'ASC ou le RECO sera importante ;
- **La densité de la population** : Dans les zones densément peuplées, les ASC ou les RECO peuvent avoir besoin de parcourir de longues distances pour atteindre les ménages, ce qui augmente leur charge de travail ;
- **L'état de santé de la population** : Si la population présente des problèmes de santé complexes ou chroniques, l'ASC ou le RECO devra consacrer plus de temps à chaque cible, ce qui augmentera sa charge de travail ;
- **Les tâches spécifiques** : Les ASC peuvent être impliqués dans une variété de tâches, telles que la promotion de la santé, la prévention des maladies, la prise en charge des maladies courantes, le suivi des femmes enceintes et des enfants, etc. Plus ils ont de tâches à accomplir, plus leur charge de travail sera élevée ;
- **Les ressources disponibles** : Si les ASC ou les RECO ont accès à des outils, des équipements et des médicaments adéquats, leur travail sera facilité et leur charge de travail pourra être réduite ;
- **La formation et le soutien** : Les ASC ou les RECO qui ont reçu une formation adéquate et qui bénéficient d'un soutien régulier de la part des professionnels de santé sont plus efficaces et peuvent mieux gérer leur charge de travail.

En fonction des éléments ci-hauts cités, le tableau ci-dessous présente une estimation de la charge de travail attendu des ASC et des RECO.

Tableau 28: Estimation charge de travail des ASC et des RECO

Facteur	ASC	RECO
Temps moyen par cible	30 minutes à 2 heures	30 minutes à 1 heure
Nombre de cible par jour	6 à 15 par jour	3 à 5 par jour
Temps de travail quotidien	5 à 8 heures par jour	2 à 4 heures par jour

Il est important de trouver un équilibre dans la charge de travail des ASC et des RECO afin qu'ils puissent accomplir leurs tâches de manière efficace sans être surchargés.

Une charge de travail trop importante peut entraîner des conséquences négatives sur les ASC et RECO comme la baisse de motivation, l'épuisement professionnel (burnout), la diminution de la qualité des services, l'augmentation du risque d'erreurs et les difficultés à assurer un suivi régulier.

Afin d'optimiser la charge de travail des ASC et des RECO, il sera utile pour les superviseurs des ASC et des RECO de mettre en place les stratégies suivantes :

- **Définir clairement les tâches et les responsabilités des ASC et RECO** : il s'agira de rappeler le paquet de soins et services, cela permettra d'éviter les chevauchements et de s'assurer que chaque ASC et RECO connaît précisément son rôle ;
- **Évaluer régulièrement la charge de travail réelle des ASC et des RECO** : Il sera utile de mesurer/estimer régulièrement la charge de travail réelle des ASC et des RECO afin de détecter les éventuels problèmes de surcharge ;
- **Ajuster la charge de travail en fonction des besoins et des ressources disponibles localement** : Si un ASC ou un RECO est surchargé, il pourra être nécessaire de redistribuer certaines tâches ou d'allouer des ressources supplémentaires.

4.2.9. Rémunération et motivation des ASC et RECO

La rémunération et la motivation des agents des ASC et des RECO sont des éléments essentiels pour assurer le succès et la durabilité des interventions de santé communautaire.

Rémunération

Il existe différents modèles de rémunération pour les ASC et les RECO, qui seront expérimentés progressivement :

- **Prime** : Les ASC reçoivent mensuellement une somme d'argent pour couvrir leurs frais de déplacement, de communication ou autres dépenses liées à leur travail. Une prime similaire sera attribuée aux CAC pour assurer la bonne coordination des activités au niveau village/cellule ;
- **Incitations financières** : Les ASC reçoivent des bonus en fonction de leurs performances ou des résultats obtenus. Il en sera de même pour les CAC.

Motivation

Outre la rémunération, d'autres facteurs peuvent influencer la motivation des ASC et RECO, tels que : la reconnaissance et la valorisation de leur travail, la formation et le développement de compétences, le soutien et la supervision de qualité, l'implication dans la prise de décision etc.

Il s'agira de promouvoir les incitations non financières, qui sont des formes de récompenses ou de reconnaissance qui ne sont pas monétaires et qui peuvent être utilisées pour motiver et fidéliser les ASC et les RECO. Elles sont complémentaires aux incitations financières et peuvent être tout aussi importantes. Voici quelques exemples d'incitations non financières qui pourront être offertes aux ASC et aux RECO :

- Reconnaissance et valorisation du travail
    - **Certificats de reconnaissance** : Remettre des certificats aux ASC/RECO pour souligner leur contribution exceptionnelle ou leur engagement envers la communauté ;

- **Lettres de remerciement** : Envoyer des lettres de remerciement personnalisées aux ASC/RECO pour exprimer la gratitude pour leur travail et leur dévouement ;
- **Événements de reconnaissance** : Organiser des événements spéciaux pour célébrer les réalisations des ASC/RECO et les remercier publiquement ;
- **Mise en valeur dans les médias** : Présenter des exemples de réussite d'ASC/RECO dans les médias locaux ou nationaux pour mettre en évidence leur impact positif sur la communauté.

- Développement des compétences et opportunités de carrière

  - **Formations et ateliers** : Offrir des formations et des ateliers pertinents pour améliorer les compétences des ASC/RECO et leur permettre de se perfectionner dans leur travail ;
  - **Mentorat** : Mettre en place un programme de mentorat où les ASC/RECO expérimentés peuvent encadrer et soutenir les nouveaux ASC/RECO ;
  - **Possibilités d'avancement** : Créer des possibilités d'avancement pour les ASC/RECO qui souhaitent progresser dans leur carrière, par exemple en devenant un RECO qui devient ASC ou un ASC qui devient AC ;

- Soutien et environnement de travail positif

  - **Supervision de qualité** : Assurer une supervision régulière et constructive pour aider les ASC/RECO à améliorer leur travail et à surmonter les défis ;
  - **Réunions d'équipe :** Organiser des réunions d'équipe régulières pour permettre aux ASC/RECO de partager leurs expériences, de discuter des problèmes et de trouver des solutions ensemble ;
  - **Soutien émotionnel** : Offrir un soutien émotionnel aux ASC/RECO, car leur travail peut être stressant et émotionnellement éprouvant ;
  - **Fournitures et équipements adéquats** : S'assurer que les ASC/RECO disposent des fournitures et des équipements nécessaires pour accomplir leur travail efficacement.

- Implication et participation

  - **Consultation et participation :** Impliquer les ASC/RECO dans la prise de décision concernant les programmes de santé communautaire et les politiques qui les concernent ;
  - **Groupes de travail** : Inviter les ASC à participer à des groupes de travail ou des comités chargés d'améliorer les services de santé communautaire.

- Autres incitations non financières

  - **Accès à des services de santé** : Faciliter l'accès des ASC/RECO et de leurs familles à des services de santé de qualité ;
  - **Transport** : Aider les ASC/RECO à se déplacer pour se rendre sur leur lieu de travail, surtout dans les zones rurales ou éloignées (achat des moto, vélo, pirogue etc.).

V. Cadre de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage

5.1. Mécanisme de suivi, évaluation, apprentissage et redevabilité

5.1.1. Considérations générales

Le système de suivi, évaluation, apprentissage et redevabilité est un pilier important dans la mise en œuvre des interventions à base communautaire et passe par la mise en place d'un dispositif incluant un bon cadre de performance alimenté par un système de gestion des données fiables, assorties d'un cadre de coordination fonctionnel. Les interventions et actions planifiées dans le cadre du PSN SACO 2025-2030 seront suivies et évaluées par un système de suivi et évaluation conjoint avec trois modalités : le suivi de routine, les revues sectorielles et les évaluations indépendantes avec une évaluation à mi-parcours en 2027 (évaluation formative) et une évaluation finale en 2030 (sommative).

La promotion d'une culture de responsabilité, de transparence et de redevabilité entre les parties prenantes ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'apprentissage permettant d'adapter les stratégies en fonction des connaissances acquises, constituent des éléments clés pour maximiser les résultats positifs afin de prendre des décisions idoines, et améliorer l'efficacité.



Figure 16: Intérêt d'un système d'information sanitaire à base communautaire

Objectif général

Contribuer au suivi de la mise en œuvre des activités planifiées, évaluer les progrès réalisés à l'atteinte des objectifs du PSN SACO 2025-2030 et fournir ainsi une base solide pour la redevabilité et l'apprentissage continu.

Objectifs spécifiques

- Assurer la collecte, l'archivage, l'analyse et la diffusion des informations sur l'exécution du plan ;
- Evaluer les progrès et les performances réalisés au niveau de chaque composante et domaine d'intervention l'impact épidémiologique relatif aux interventions de santé communautaire ;

- Evaluer le niveau d'organisation des organes à base communautaire (mise en place et fonctionnalité) ;
- Orienter l'allocation et l'utilisation des ressources matérielles, financières et humaines
- Identifier les goulots d'étranglements dans la mise en œuvre efficace des interventions afin d'être proactifs dans leurs corrections ;
- Assurer la documentation des bonnes pratiques, des innovations et des leçons apprises ;
- Analyser le processus de mise en oeuvre des composantes spécifiques du plan.

5.1.2. Mécanisme de suivi et évaluation

Le mécanisme de suivi et évaluation sera construit sur base du système national d'information sanitaire (SNIS), qui sera complété par différents autres mécanismes innovants. La collecte des données se fera en deux volets à savoir la collecte des données de routine et la collecte ponctuelle des données.

Le SNIS est organisé autour de la pyramide sanitaire en 12 composantes dont l'une aborde les interventions à base communautaire. Contrairement à d'autres composantes, le SNIS communautaire intègre dans sa pyramide en dessous de l'AS, le niveau village/cellule auquel est assigné la CAC. Déjà opérationnel en 2024 après un long processus, le SNIS communautaire est construit autour de la plateforme. Le Schéma ci-dessous indique la valeur ajoutée d'un mécanisme de suivi et évaluation efficace des interventions à base communautaire

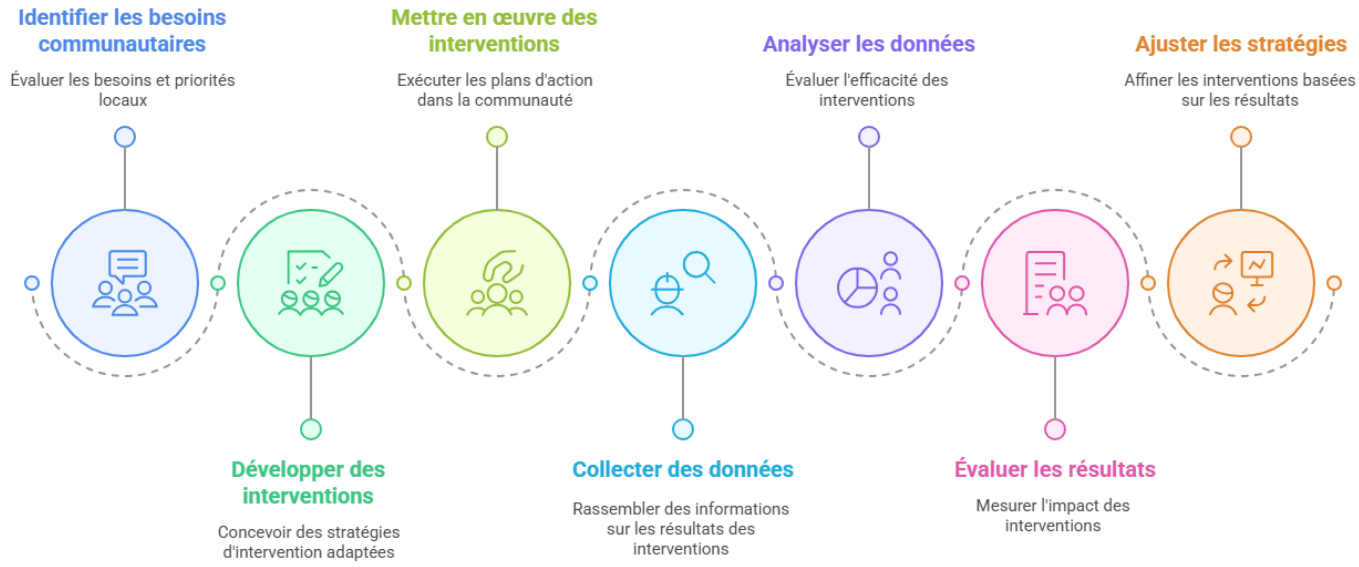


Figure 17: Valeur ajoutée du mécanisme de suivi et évaluation des interventions à base communautaire

Collecte de routine

En dépit de la qualité des données qui n'est pas optimale en termes de complétude, promptitude et de cohérence des données ainsi que la couverture qui est progressive, le SNIS communautaire permet la collecte des données, essentiellement quantitatives des activités de santé communautaire. Tous les acteurs impliqués dans le SNIS communautaire devront comprendre l'intérêt de la valorisation des données en tant qu'outil de gestion important pour la prise de décisions et renforcer ainsi leur utilisation pour la responsabilisation à l'égard du rendement et des résultats à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

La collecte des données communautaire de routine se fera avec des outils suivants :

- Registre de dénombrement et suivi des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes pour le RECO ;

- Registre de suivi de la prise en charge communautaire et visite à domicile pour le RECO ;
- Registre de prise en charge de SSC pour les ASC.

La transmission des données communautaires de routine se fera avec les outils ci-après :

- Canevas mensuel du RECO ;
- Canevas mensuel de la CAC ;
- Canevas mensuel du CODESA ;
- Canevas mensuel du SSC.

Outre les outils de collecte et de transmission susmentionnés, il existe les outils tels que :

- Carte conseil pour les signes d'orientation pour les ASC ;
- Cartes conseil effet indésirables pour les ASC ;
- Cartes conseil de traitement pour les ASC ;
- Boite à images pour les RECO et ASC ;
- Note d'orientation pour les RECO et ASC.

Les données collectées par les RECO et ASC en utilisant les outils en dur sont compilées et transmises par le Président de CAC au Président de CODESA. Ce dernier encode les données du CODESA ainsi que celles compilées par la CAC dans la plateforme DHIS2 à l'aide d'une tablette/smartphone sous la supervision de l'IT.

En fonction des moyens disponibles (équipements informatiques et forfait internet), on peut envisager l'utilisation de la tablette/smartphone au niveau de la CAC pour améliorer la complétude, promptitude et la qualité des données. L'application SSC (IASO) en cours d'utilisation devrait alimenter automatiquement le canevas mensuel SSC paramétrés dans le DHIS2. D'où la nécessité de rendre les deux plateformes interopérables.

Collectes ponctuelles des données et autres activités spécifiques

Il s'agit des enquêtes basées sur la recherche opérationnelle, les évaluations périodiques et les états des lieux. Ces enquêtes seront menées tout au long de la mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030 et porteront sur les innovations ainsi que sur des questions inhérentes à sa mise en œuvre. Ces collectes combineront les données quantitatives et qualitatives et se réaliseront selon un rythme semestriel ou annuel conformément aux besoins.

- **Recherche opérationnelle**

La recherche opérationnelle appuiera la résolution des problèmes persistants et aidera à la mise à l'échelle des expériences réussies. Elle interviendra en termes d'études thématiques partielles, pour générer de nouvelles connaissances et stratégies afin de réajuster au besoin les politiques en santé communautaire. Elle permettra d'examiner, à la phase exploratoire, les facteurs liés aux prestations des services et qui ont un impact sur le rendement, l'efficacité et la qualité des services. Elle permettra de tester de nouvelles approches et, enfin à la phase d'évaluation, elle permettra une évaluation rétrospective ou transversale de l'impact. Les résultats ainsi obtenus à la fin de chaque phase permettront le réajustement des interventions en vue de l'amélioration des performances du PSN SACO 2025-2030.

- **Evaluations périodiques**

Les évaluations périodiques auront lieu à deux périodes clés : à mi-parcours et à la fin de la période de mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030.

- A mis parcours, son but sera de se rassurer de la manière dont la mise en œuvre se déroule (processus) ;
- A la fin de la mise en œuvre, permettra de juger de l'atteinte des objectifs, et tirer les leçons nécessaires.

Pour atteindre les objectifs escomptés, les données seront collectées à travers des enquêtes transversales communautaires, quantitatives et qualitatives. Ces évaluations prendront en compte plusieurs thématiques d'enquête entre-autre :

1. Les évaluations sur le niveau de mise en place et fonctionnalité des organes de participation communautaire (CAC, CODESA et UCODESA) et les SSC ;
2. L'évaluation des services et prestations des ASC et RECO ;
3. L'évaluation des connaissances, attitudes et pratiques des communautés par rapport aux pratiques familiales essentielles, les signes de danger et d'alertes de la mère et de l'enfant dans la communauté, la prévention et le recours aux soins et services etc. ;
4. L'étude sur la contribution de la santé communautaire sur les indicateurs de CSU.

- **Monitorage Amélioré pour Action (MAA)**

Des sessions de MAA auront lieu chaque semestre avec les principales parties prenantes, notamment les autorités politico administratives locaux, les autorités sanitaires et prestataires de soins, les chefs des communautés (autorités traditionnelles, religieuses, leaders d'opinions), les membres des CAC, CODESA, UCODESA et OAC, les ASC, les influenceurs communautaires ainsi que les PTF.

S'appuyant sur le cadre des déterminants de la couverture de Tanahashi qui examine la disponibilité (intrants et médicaments, supports et outils de gestion, ressources humaines et infrastructures), l'accessibilité (géographique, financière, culturelle), l'utilisation (initiale, continue) et la qualité des soins et services. Le MAA aidera à identifier les principaux goulots d'étranglement des interventions communautaires et permettra de prendre des mesures locales opportunes (actions correctrices) pour corriger les goulots d'étranglement identifiés et améliorer la qualité et la couverture des interventions à base communautaire.

Le processus de MAA servira également aux audits de qualité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'actualité des données, à partir du niveau communautaire où les données sont collectées.

- **Revues annuelles**

Sous la direction du Secrétaire Général à la Santé Publique et Hygiène, une revue sera organisée tous les 12 mois avec la participation des personnes clés à tous les niveaux du système de santé national, en collaboration avec les principaux partenaires, afin d'évaluer le niveau de réduction des goulots d'étranglement du système de santé communautaire, mesurer l'amélioration de la couverture des interventions traceurs et identifier les mesures correctrices pour soutenir et accélérer les progrès vers la CSU. C'est dans ce cadre que seront renforcés le volet revu des interventions à base communautaire pour en faire bénéficier une attention particulière.

Ces revues des interventions à base communautaire utiliseront des données DHIS2 auditée au cours des sessions de MAA et d'autres sources des données disponibles.

- **Suivi des activités communautaires dans les CAC, CODESA et UCODESA**

Le suivi au niveau du village/cellule est assuré par l'équipe du centre de santé (IT/ITA) et le CODESA et au niveau de l'AS par l'ECZS notamment l'AC. L'ASC ou le RECO transmet son rapport d'activités au CAC et ce dernier au CODESA. Après compilation le CODESA transmet le rapport d'activité de l'AS à l'Equipe du centre de santé. Après analyse, ce dernier transmet son rapport à l'ECZS. Pour le suivi des activités, les canevas standardisés selon le niveau de mise en œuvre sont utilisés

systématiquement pour faciliter la compilation (canevas rapport mensuel RECO, ASC, CAC et CODESA). Les réunions mensuelles de suivi seront organisées tant au niveau de toutes les structures de participation communautaire, du centre de santé qu'au niveau de la zone de santé.

Le suivi au quotidien des activités communautaires sera réalisé mensuellement lors des réunions de monitorage de l'aire de santé, de la zone de santé et lors de visites de terrain pour examiner la réalité. Les activités communautaires peuvent être réorientées à tout moment dès que les acteurs impliqués constatent de faiblesses. Les missions de suivi et de supervision seront réalisées à tous les niveaux selon le rythme suivant : trimestriel pour les niveaux national et provincial et mensuel pour le niveau opérationnel (EZCZ er AS). Ces missions seront organisées de façon à être plus efficaces et permettre l'atteinte des objectifs fixés et à mesurer les progrès accomplis tout au long de la mise en œuvre. Les superviseurs seront chargés d'assurer l'accompagnement technique rapproché des acteurs communautaires. Des formulaires de supervision des ASC et RECO suivants seront développés afin d'améliorer la qualité de supervision :

- Formulaire d'observation d'une VAD intégrée et ciblée ;
- Formulaire d'évaluation de cas (vérification inopinée) ;
- Formulaire de spot check contrôle dans les ménages.

Le focus du superviseur sera placé sur les activités de soutien aux acteurs communautaires à travers :

- Le développement des compétences (démonstration ou enseignement) ;
- La vérification des stocks ou ressources (traçabilité) ;
- Le décompte des données et l'examen des dossiers ;
- Le plan des actions/ activité communautaire ;
- La gestion de charge de travail ou le calendrier.

- **Contrôle communautaire et/ou Bulletins de performance communautaire**

Sous le leadership du chef du village/cellule, la CAC mettra en place des mécanismes permettant aux membres de la communauté de signaler tout cas d'irrégularité constaté sur tous les aspects ayant trait à la mise en œuvre du plan. Les membres de la CAC doivent rechercher les solutions locales aux problèmes détectés et les signaler dans un rapport à l'échelon supérieur (CODESA, UCODESA). Et un plan de redressement sera élaboré.

- **Documentation des bonnes pratiques, des innovations et des leçons apprises**

Le MAA et les revues annuelles aideront à identifier les points forts et faibles dans la mise en œuvre du PSN SACO 2025-2030. Il sera mis en place un système d'apprentissage et d'échange pour permettre aux équipes de gestion de la santé de poser des questions et de partager des informations utiles sur les défis, les goulots d'étranglement et les solutions idoines. Grâce à la documentation continue, les nouvelles expériences seront captées, en se concentrant sur ce qui fonctionne, où, pourquoi et pour qui et les diffuser en tant que bonnes pratiques, innovations et leçons apprises.

5.2. Dispositif institutionnel du suivi et de l'evaluation

Le suivi et l'évaluation du PSN SACO 2025-2030 fera recours à diverses démarches portant sur la collecte, le traitement, l'utilisation des données pour générer les informations et permettre une prise de décisions éclairées.

5.2.1. Collecte, compilation, traitement et analyse des données

La collecte des données communautaires se fera directement dans les ménages par les ASC et RECO ou d'autres acteurs communautaires en s'appuyant sur les outils existants qui seront digitalisés pour améliorer la complétude.

Cependant, le développement du système d'information de santé communautaire et son intégration effective dans le système national d'information sanitaire (SNIS) va permettre d'harmoniser les outils existants de collecte, centralisation et transmission des données. Il s'agit notamment de la Fiche de dénombrement de la population et d'identification des ménages par le RECO ainsi que les fiches synthèse du RECO, de la CAC, du CODESA, de l'UCODESA/ZS, la DPS (bureau ayant en charge la santé communautaire) et le niveau national (la Direction ayant en charge la santé communautaire).

Quant au suivi communautaire des couples mère et nouveau-né par l'ASC ou le RECO, des canevas de collecte pour les suivis à domicile seront mis en place à l'usage de l'ASC ou RECO.

Les données collectées par l'ASC ou le RECO dans les ménages sous sa responsabilité seront compilés et rapportées dans le canevas chaque mois à la CAC pour être présentées et discutées lors de la réunion mensuelle du comité villageois avant la transmission au CODESA. A partir du CODESA, la collecte et la transmission des données communautaire suivront le circuit habituel du SNIS. Au niveau de la ZS, l'équipe cadre devra assurer la compilation et vérifier la complétude, l'exhaustivité ainsi que procéder à la validation des données. Cette compilation des données de routine devra être faite de préférence au moyen d'un logiciel approprié ou à défaut de logiciels compatibles existants ou à mettre en place de manière à faciliter leur agrégation niveau par niveau. Elle est mensuelle pour les ZS, trimestrielle pour les provinces et les directions normatives et programmes spécialisés. Ces derniers étant fédérés autour de la Sous-commission SACO.

Les données de routine devront être traitées et analysées à la même fréquence par les structures qui les produisent, en fonction des orientations du cadre normatif des différentes composantes du SNIS au fur et à mesure de leur opérationnalisation. Le traitement et l'analyse de ces données doivent se faire suivant les techniques appropriées avec la rigueur scientifique voulue.

5.2.2. Utilisation des données

L'utilisation des données et informations produites feront l'objet d'une utilisation systématique à tous les niveaux du système de santé communautaire où tous les acteurs se retrouvent notamment le comité de gestion (COGE), le Conseil d'Administration (CA) de la ZS, le CPP et le CNP-SS et dans les forums internationaux auxquels le pays participe. Elles serviront de base, au niveau national, pour le dialogue sous-sectoriel et sectoriel (planification, mobilisation des ressources) et au niveau international pour le plaidoyer en faveur de l'appui. Les revues annuelles du sous-secteur santé communautaire constitueront des moments où le tableau de bord de suivi-évaluation du PSN SACO 2025-2030 devra être passé en revue pour examen, analyse, prise de décisions et formulation de recommandations de manière conjointe.

5.2.3 Diffusion

Les données produites devront être diffusées à toutes les instances impliquées dans le renforcement du système de santé communautaire et principalement vers celles concernées par des actions correctrices à développer avant une nouvelle échéance, notamment les différents acteurs impliqués dans l'engagement communautaire. La communication devra se faire le plus rapidement possible après la tenue des revues annuelles et utiliser les nouvelles techniques de l'information et communication pour la diffusion (Mail, site web, visio-conférence, etc.). Le format papier sera utilisé pour tous les niveaux/acteurs n'ayant pas accès à l'internet.

5.2.4. Circuit de l'information

Une fois élaborés et exempts d'erreurs, les rapports périodiques des SSC, CAC et CODESA devront remonter vers les niveaux supérieurs de la pyramide pour alimenter les processus de décision de ces niveaux. La transmission des données au niveau supérieur se fera dans le strict respect du circuit de l'information ci-après :

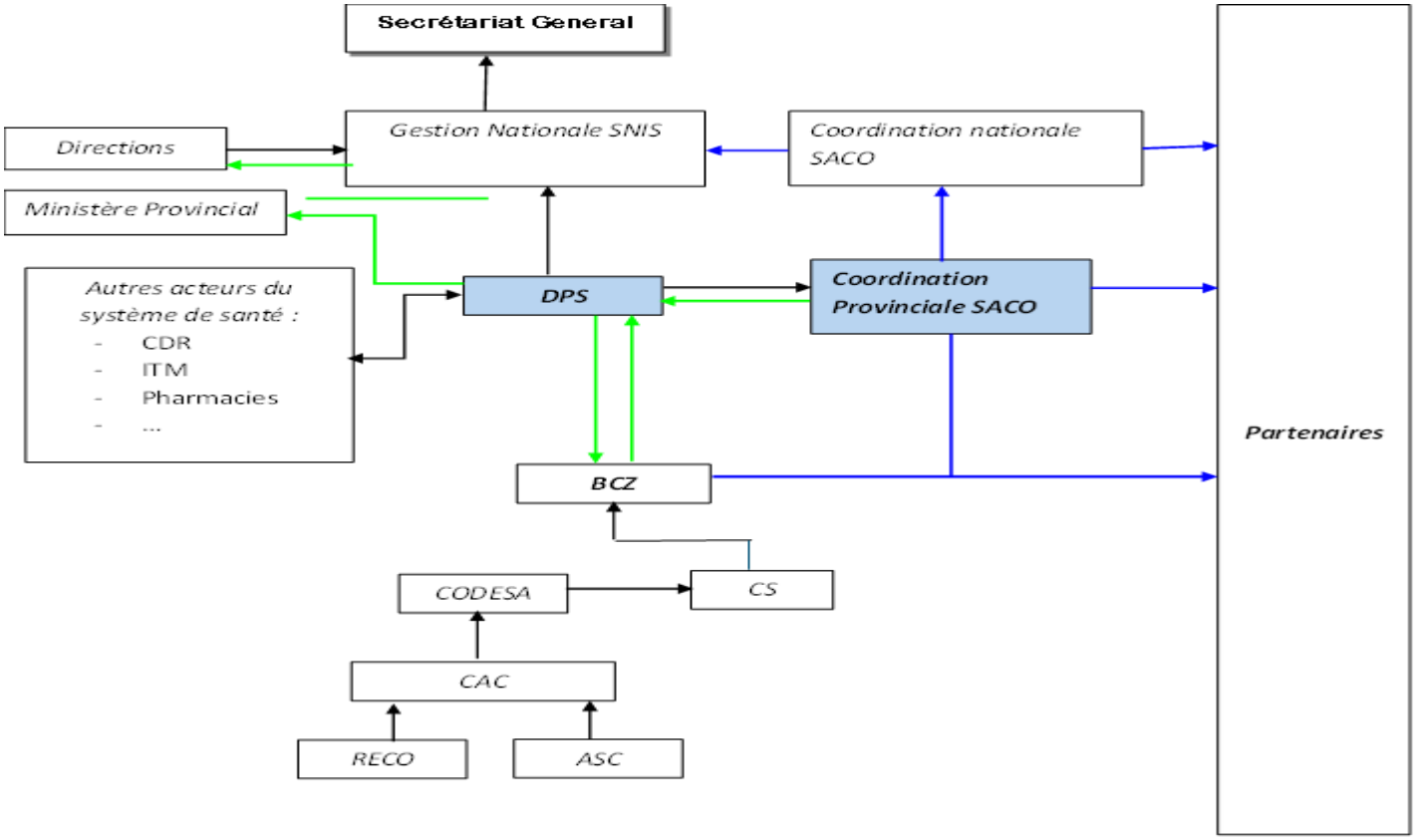


Figure 18: Circuit de l'information de santé communautaire

Le schéma ci-dessus explique la remontée des données du système de santé communautaire :

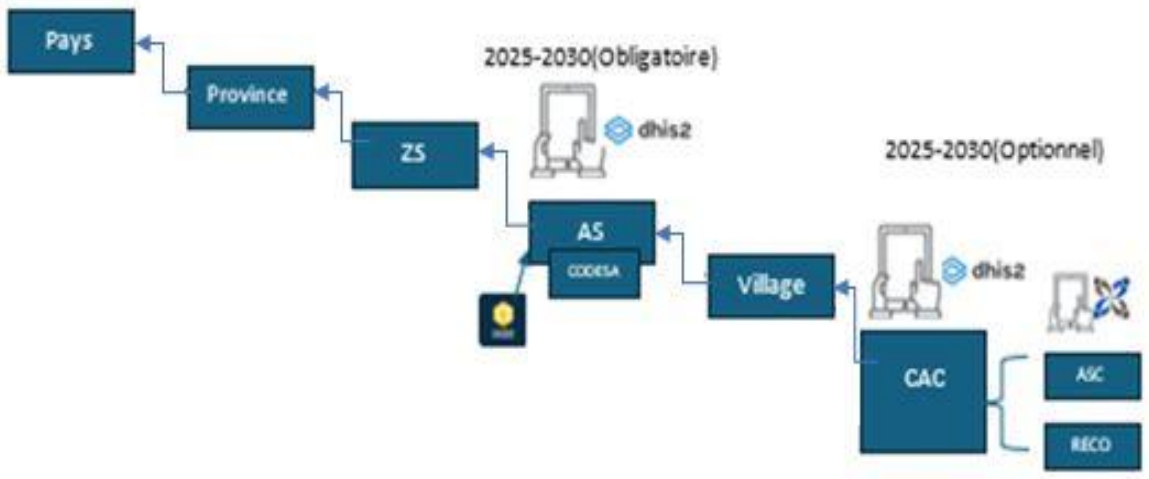


Figure 19: Remontée des données du système de santé communautaire

La construction d'un SNIS communautaire solide repose sur la digitalisation au plus bas niveau afin d'éviter non seulement le coût de reprographie des outils papiers, mais aussi les erreurs de transcription et compilation des données sur papier avant l'encodage dans la plateforme électronique. Cette digitalisation devrait être envisagée de manière progressive comme illustré dans le schéma ci-dessus.

Elle va se dérouler en quatre phases :

Phase 1 : Inventaire des équipements informatiques (tablettes, smartphones etc.) dotés au niveau des AS ainsi que de la couverture réseau mobile et internet pour apprécier les solutions de connectivité internet dans les zones non couvertes notamment l'utilisation du protocole USSD.

Phase 2 : Identification des profils, des compétences numériques et des besoins de formation des RECO et ASC, des superviseurs et des responsables locaux, ainsi que l'évaluation des charges de travail actuelles des RECO et ASC pour anticiper leur capacité d'adoption des outils numériques.

Phase 3 : Utilisation des infrastructures CLOUD (Serveurs en ligne) en attendant la mise en place d'un datacenter national.

Phase 4 : Mise à l'échelle du DHIS2 avec utilisation des outils en dur, encodage des données au niveau du CODESA si possible à la CAC en fonction des ressources disponibles et interopérabilité entre DHIS2, IASO, CommCare etc. et la mise en place de la liste maitresse nationale des ASC et RECO et la contractualisation avec les opérateurs télécoms pour le paiement électronique des ASC/CAC.

5.3. Cadre de performance

Le cadre de performance de la santé communautaire est essentiel pour améliorer la qualité et l'efficacité des services de santé fournis au niveau communautaire. Il s'agit d'un ensemble de principes, de valeurs et de pratiques qui guident la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des interventions de santé communautaire. Il repose sur plusieurs piliers fondamentaux :

- **L'approche centrée sur la personne** : Les interventions de santé communautaire doivent être adaptées aux besoins et aux préférences des individus et des communautés ;
- **La participation communautaire** : Les communautés doivent être activement impliquées dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des interventions de santé ;
- **L'équité** : Les interventions de santé communautaire doivent être accessibles et équitables pour tous, en particulier pour les groupes les plus vulnérables ;
- **La qualité** : Les interventions de santé communautaire doivent être fondées sur des données probantes et mises en œuvre avec des normes de qualité élevées ;
- **La durabilité** : Les interventions de santé communautaire doivent être conçues pour être durables à long terme, en tenant compte des ressources disponibles et des capacités locales.

Le cadre de performance de la santé communautaire sera utilisé pour :

- **Évaluer les besoins de santé des communautés** : Identifier les problèmes de santé prioritaires et les populations les plus vulnérables ;
- **Concevoir des interventions de santé communautaire** : Élaborer des plans d'action adaptés aux besoins spécifiques des communautés ;
- **Mettre en œuvre des interventions de santé communautaire** : Assurer la prestation de services de santé de qualité aux communautés ;

- **Évaluer l'impact des interventions de santé communautaire** : Mesurer les résultats des interventions et identifier les points à améliorer.

Sur base de ce cadre de performance qu'est développé le cycle de performance de la santé communautaire (voir image ci-contre) doit être adapté aux contextes locaux et aux besoins spécifiques des communautés. Il est essentiel d'impliquer activement les communautés à toutes les étapes du cycle, afin de garantir que les interventions de santé soient pertinentes, efficaces et durables.

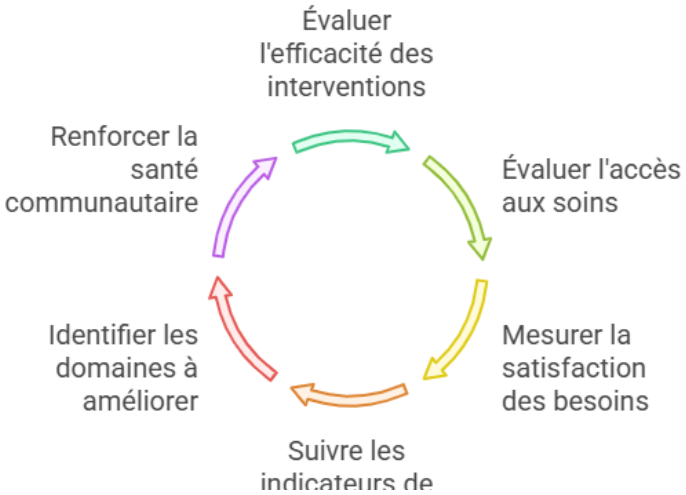


Figure 20: Cycle de performance de la santé communautaire

Le tableau ci-dessous circonscrit les indicateurs à rapporter à des fréquences bien définies avec des cibles visées durant l'exécution du PSN SACO 2025-2030. Ces indicateurs serviront de base pour apprécier l'état d'avancement des interventions à base communautaire, le niveau de performance des résultats et mesurer l'impact.

Tableau 29 : Liste des indicateurs du cadre de suivi de la progression et d'évaluation des performances du système de santé communautaire

# Code	Libellés des indicateurs par chaine des résultats	Mode de calcul		Référence des données de base		Cibles annuelles						Fréquence	Source de vérification	Ventilation	Responsables
		Numérateur	Dénominateur	Valeur	Source	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	**Indicateurs d'impact : Etat de santé et réponse aux attentes**														
	Espérance de vie à la naissance	Nbre total d'années vécues après la naissance par les 100 000 personnes initiales	Nbre de personnes dans la cohorte initiale	61,6 ans	OMS	65,5 ans	67,4 ans	69,3 ans	71,2 ans	73,1 ans	75 ans	Annuelle	EDS	Par DPS	Minplan
	Taux de mortalité maternelle	Nombre de décès maternels	Nbre total de naissances vivantes	547 pour 100 000 NV	OMS	444 pour 100 000 NV	369 pour 100 000 NV	295 pour 100 000 NV	220 pour 100 000 NV	145 pour 100 000 NV	70 pour 100 000 NV	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Taux de mortalité néonatale	Nbre de décès néonatal	Nbre total de naissances vivantes	24 pour 1000 NV	EDS 2023-2024	20 pour 1000 NV	19 pour 1000 NV	17 pour 1000 NV	15 pour 1000 NV	14 pour 1000 NV	12 pour 1000 NV	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Taux de mortalité infanto juvénile	Nbre de décès infanto juvénile	Nbre total de naissances vivantes	92 pour 1000 NV	EDS 2023-2024	76 pour 1000 NV	66 pour 1000 NV	56 pour 1000 NV	45 pour 1000 NV	35 pour 1000 NV	25 pour 1000 NV	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants ≤ 5 ans	Nbre d'enfants de moins de 5 ans avec retard de croissance	Nbre total d'enfants de moins de 5 ans examinés	45%	EDS 2023-2024	42,5 %	40%	37,5 %	35%	32,5 %	30%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
2.	**Indicateurs d'effets/résultats : Couvertures des interventions à base communautaires et facteurs de risques**														
	Résultat 1 : D'ici 2030, au moins 80% des communautés de chaque village/cellule adoptent des comportements favorables à leur santé et bien-être														

# Code	Libellés des indicateurs par chaine des résultats	Mode de calcul		Référence des données de base		Cibles annuelles						Fréquence	Source de vérification	Ventilation	Responsables
		Numérateur	Dénominateur	Valeur	Source	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Domaine de la SRMNEA														
	AQA	Nbre de femmes accouchées assisté par un prestataire qualifié	Nbre total de femmes accouchées	85%	EDS 2023-2024	86,7 %	88,3 %	90%	91,7 %	93,3 %	95%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Soins postnatals de la mère	Nbre de femmes accouchées assisté ayant bénéficiés des soins postnatals dans les 2 jours	Nbre total de femmes accouchées	29%	EDS 2023-2024	32,5 %	36%	39,5 %	43%	46,5 %	50%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	CPN 1	Nbre de femmes enceintes avec au moins une CPN	Nbre total des femmes enceintes	83,5%	EDS 2023-2024	85,4 %	87,3 %	89,3 %	91,2 %	93,1 %	95%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	CPN 4	Nbre de femmes enceintes avec au moins quatre CPN	Nbre total des femmes enceintes	44,9%	EDS 2023-2024	47,4 %	49,9 %	52,5 %	55%	57,5 %	60%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Prévalence contraceptive moderne	Nbre de clientes en âge de procréer ayant bénéficié d'au moins une méthode contraceptive moderne	Nbre total des femmes âgées de 15-49 ans	10,7%	EDS 2023-2024	13,1 %	15,5 %	17,9 %	20,2 %	22,6 %	25%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des ménages qui possèdent au moins une MII	Nbre de ménages qui possèdent au moins une MII	Nbre total des Ménages	69%	EDS 2023-2024	72,5 %	76%	79,5 %	83%	86,5 %	90%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Proportion d'enfants de moins de 5 ans qui dorment sous MII	Nbre d'enfants de moins de 5 ans qui dorment sous la MII	Nbre total d'enfants de moins de 5 ans	57%	EDS 2023-2024	60,8 %	64,7 %	68,5 %	72,3 %	76,2 %	80%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des femmes enceintes qui dorment sous MII	Nbre des femmes enceintes qui dorment sous la MII	Nbre total des femmes enceintes	60,4%	EDS 2023-2024	63,7 %	66,9 %	70,2 %	73,5 %	76,7 %	80%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des femmes enceintes suivies dans les	Nbre de femmes enceintes suivies dans les ménages	Nbre total des femmes enceintes	ND		25%	30%	35%	40%	45%	50%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS

# Code	Libellés des indicateurs par chaine des résultats	Mode de calcul		Référence des données de base		Cibles annuelles						Fréquence	Source de vérification	Ventilation	Responsables
		Numérateur	Dénominateur	Valeur	Source	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	ménages par les ASC et RECO	par les ASC et RECO													
	Proportion des femmes accouchées (en post partum immédiat) suivies dans les ménages par les ASC et RECO	Nbre de femmes accouchées suivies dans les ménages par les ASC et RECO	Nbre total de femmes accouchées	ND		25%	30%	35%	40%	45%	50%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des ménages ayant bénéficiés d'un suivi longitudinal et individualisé de la part des ASC et RECO	Nbre de ménages ayant bénéficiés d'un suivi longitudinal et individualisé de la part des ASC et RECO	Nbre total de ménages	ND		25%	30%	35%	40%	45%	50%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Domaine de la Vaccination infantile														
	Proportion d'enfants de 12-23 mois ayant été complètement vacciné avant leur premier anniversaire	Nbre d'enfants de 12-23 mois ayant été complètement vaccinés avant leur premier anniversaire	Nbre total d'enfants de 12-23 mois	21%	EDS 2023-2024	25,8 %	30,7 %	35,5 %	40,3 %	45,2 %	50%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Proportion d'enfants de 12-23 mois zéro dose	Nbre d'enfants de 12-23 mois zéro dose	Nbre total d'enfants de 12-23 mois	23%	PNDS 2024-2033	20,2 %	17,3 %	14,5 %	11,7 %	8,8%	6%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Domaine de la Nutrition														
	Proportion d'enfants qui sont allaités exclusivement aux seins jusqu'à 6 mois	Nbre d'enfants de 0 à 6 mois ayant été exclusivement allaités au sein	Nbre total d'enfants de 0 à 6 mois	52,5%	EDS 2023-2024	57,1 %	61,7 %	66,3 %	70,8 %	75,4 %	80%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Proportion d'enfants qui ont été mis au	Nbre d'enfants qui ont été mis au sein	Nbre total de nouveau-née	53,2%	EDS 2023-2024	57,7 %	62,1 %	66,6 %	71,1 %	75,5 %	80%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS

# Code	Libellés des indicateurs par chaine des résultats	Mode de calcul		Référence des données de base		Cibles annuelles						Fréquence	Source de vérification	Ventilation	Responsables
		Numérateur	Dénominateur	Valeur	Source	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	sein dans l'heure qui a suivi la naissance	dans l'heure qui a suivi la naissance													
	Proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois qui ont reçu une alimentation de complément adéquate	Nbre Pourcentage d'enfants de 6–23 mois ayant reçu des aliments et des liquides d'au moins 5 des 8 groupes d'aliments définis	Nbre d'enfants de 6 à 23 mois	13,9%	EDS 2023-2024	15,8 %	17,6 %	19,5 %	21,3 %	23,2 %	25%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Domaine de l'Eau, Hygiène et Assainissement (EHA)														
	Proportion de ménages disposant d'un dispositif de lavage des mains	Nbre de ménage ayant un dispositif de lavage des mains	Nbre total de ménage	14%	EDS 2013-2014	15,8 %	17,7 %	19,5 %	21,3 %	23,2 %	25%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Proportion de ménages utilisant des toilettes améliorées (latrines hygiéniques)	Nbre de ménages qui utilisent les latrines hygiéniques	Nbre total des ménages	18%	EDS 2013-2014	20%	22%	24%	26%	28%	30%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Domaine de la protection sociale														
	Proportion d'enfants ayant été enregistré à l'état civil dans les 90 jours suivant la naissance	Nbre d'enfants enregistré à l'état civil dans les 90 jours suivant la naissance	Nbre total d'enfants de 0-3 mois	25%	EDS 2013-2014	29,2 %	33,3 %	37,5 %	41,7 %	45,8 %	50%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Proportion de victimes de violences sexuelles ayant bénéficié de la prise en charge psychosociale	Nbre de victimes de violences sexuelles ayant bénéficié de la prise en charge psychosociale	Nbre de victimes de violences sexuelles	27%	EDS 2013-2014	23,7 %	20,3 %	17%	13,7 %	10,3 %	7%	Annuelle	EDS	Par DPS	MSPHPS
	Domaine de l'Education														
	Proportion de ménages avec	Nbre de ménages avec garçons de 6 à	Nbre total de ménages avec	86%	ISU 2021	87,5 %	89%	90,5 %	92%	93,5 %	95%	Annuelle	ISU	Par DPS	Min EPSP

# Code	Libellés des indicateurs par chaine des résultats	Mode de calcul		Référence des données de base		Cibles annuelles						Fréquence	Source de vérification	Ventilation	Responsables
		Numérateur	Dénominateur	Valeur	Source	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	enfants de 6 à 7 ans inscrits en 1ère année	7 ans inscrits en 1ère année	garçons de 6 à 7 attendus												
	Proportion de ménages avec filles de 6 à 7 ans inscrites en 1ère année.	Nbre de ménages avec filles de 6 à 7 ans inscrits en 1ère année	Nbre total de ménages avec filles de 6 à 7 ans attendus	79%	ISU 2021	80,8 %	82,7 %	84,5 %	86,3 %	88,2 %	90%	Annuelle	ISU	Par DPS	Min EPSP
	Domaine de l'environnement														
	Proportion des villages/cellules assainis grâce aux efforts des ASC et RECO	Nbre de villages/cellules assainis grâce aux efforts des ASC et RECO	Nbre total de villages/cellules	ND		10%	20%	30%	40%	50%	60%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Domaine de l'Agriculture, peche et élevage														
	Proportion des CAC avec AGR en agriculture, pêche et élevage	Nbre de CAC avec AGR en agriculture, pêche et élevage	Nbre total de CAC	ND		10%	20%	30%	40%	50%	60%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Résultat 2 : D'ici 2030, au moins 50% des communautés de chaque village/cellule ayant un accès difficile aux ESS utilisent les SSC														
	Proportion d'enfants de 0-59 mois résidant dans les communautés n'ayant pas accès facile aux ESS et ayant fait le paludisme sont traités au SSC selon les directives nationale	Nbre d'enfants de 0-59 mois résidant dans les communautés n'ayant pas accès facile aux ESS et ayant fait le paludisme sont traités au SSC selon les directives nationale	Nbre total d'enfants de 0-59 mois résidant dans les communautés n'ayant pas accès facile aux ESS et ayant fait le paludisme	ND		21%	27%	33%	38%	44%	50%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion d'enfants de 0-59 mois résidant dans les communautés n'ayant pas accès facile aux ESS et ayant fait la	Nbre d'enfants de 0-59 mois résidant dans les communautés n'ayant pas accès facile aux ESS et ayant fait la	Nbre total d'enfants de 0-59 mois résidant dans les communautés n'ayant pas accès facile aux ESS et	ND		21%	27%	33%	38%	44%	50%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS

# Code	Libellés des indicateurs par chaine des résultats	Mode de calcul		Référence des données de base		Cibles annuelles						Fréquence	Source de vérification	Ventilation	Responsables
		Numérateur	Dénominateur	Valeur	Source	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	pneumonie sont traités au SSC selon les directives nationale	pneumonie sont traités au SSC selon les directives nationale	ayant fait la pneumonie												
	Proportion d'enfants de 0-59 mois résidant dans les communautés n'ayant pas accès facile aux ESS et ayant fait la diarrhée sont traités au SSC selon les directives nationale	Nbre d'enfants de 0-59 mois résidant dans les communautés n'ayant pas accès facile aux ESS et ayant fait la diarrhée sont traités au SSC selon les directives nationale	Nbre total d'enfants de 0-59 mois résidant dans les communautés n'ayant pas accès facile aux ESS et ayant fait la diarrhée	ND		21%	27%	33%	38%	44%	50%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion d'enfants de 0-59 mois résidant dans les communautés n'ayant pas accès facile aux ESS et avec malnutrition sont traités au SSC selon les directives nationale	Nbre d'enfants de 0-59 mois résidant dans les communautés n'ayant pas accès facile aux ESS et avec malnutrition sont traités au SSC selon les directives nationale	Nbre total d'enfants de 0-59 mois résidant dans les communautés n'ayant pas accès facile aux ESS et avec malnutrition	ND		21%	27%	33%	38%	44%	50%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des ASC rénumerés	Nbre de ASC rénumerés	Nbre total de ASC existant	ND		30%	40%	50%	60%	70%	80%	Annuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des CAC appuyés financièrement	Nbre de CAC appuyés financièrement	Nbre total de CAC existantes	51%	Evaluation PSN SACO 2019-2022	56%	61%	66%	70%	75%	80%	Annuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Résultat 3 : D'ici 2030, au moins 80% des communautés de chaque village/cellule sont résilientes face aux urgences de santé publique (épidémies et catastrophes naturelles)														
	Proportion de rapports hebdomadaires des cas de MAPEPI (PFA,	Nbre de rapports hebdomadaires des cas de MAPEPI (PFA,	Nbre total de rapports hebdomadaires des cas de MAPEPI (PFA,	ND		30%	40%	50%	60%	70%	80%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS

# Code	Libellés des indicateurs par chaine des résultats	Mode de calcul		Référence des données de base		Cibles annuelles						Fréquence	Source de vérification	Ventilation	Responsables
		Numérateur	Dénominateur	Valeur	Source	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Rougeole, TNN, FHV, Cholera) rapportés par les RECO et ASC	Rougeole, TNN, FHV, Cholera) rapportés par les RECO et ASC	Rougeole, TNN, FHV, Cholera) attendus												
	Proportion de décès maternels et périnatals notifiés dans la communauté	Nbre de rapport de notification de décès maternels et périnatals notifiés dans la communauté	Nbre total de notification de décès maternels et périnatals attendus	ND		30%	40%	50%	60%	70%	80%	Mensuelle	SDMPR	Par DPS	MSPHPS
	Résultat 4 : D'ici 2030, au moins 60% des communautés sont protégées contre les dépenses catastrophiques de santé et de l'inabordabilité financière aux soins et services de santé														
	Incidence des dépenses catastrophiques en santé	Dépenses de santé des ménages supérieures à 10% du budget/revenu total des ménages	Budget/revenu total des ménages	61,6%	OMS 2024	58%	54,4 %	50,8 %	47,2 %	43,6 %	40%	Biannuel	MICS	Par DPS	MSPHPS
	Proportion de ménages adhérents aux mutuelles de santé ou autres formes d'assurance santé	Nbre de ménages ayant adhérés aux mutuelles de santé ou autres formes d'assurance santé	Nbre total de ménages	5%	MICS 2017-2018	8,3%	11,7 %	15%	18,3 %	21,7 %	25%	Biannuel	MICS	Par DPS	MSPHPS
	Résultat 5 : D'ici 2030, le sous-secteur « Santé communautaire » a un système d'information sanitaire et de recherche opérationnelle axé sur la transformation digitale fonctionnel à au moins 60%														
	Taux de complétude des rapports communautaires	Nbre des rapports communautaires transmis	Nbre total des rapports communautaires attendus	ND		10%	20%	30%	40%	50%	60%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Taux de promptitude des rapports communautaires	Nbre des rapports communautaires transmis dans les délais	Nbre total des rapports communautaires transmis	ND		10%	20%	30%	40%	50%	60%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Résultat 6 : D'ici 2030, tous les organes de gouvernance de la santé communautaire assurent une gestion optimale et jouent pleinement leurs rôles de coordination synergique à tous les niveaux pour garantir l'offre de qualité des services à base communautaires » et l'utilisation des services de santé														

# Code	Libellés des indicateurs par chaine des résultats	Mode de calcul		Référence des données de base		Cibles annuelles						Fréquence	Source de vérification	Ventilation	Responsables
		Numérateur	Dénominateur	Valeur	Source	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Proportion des résolutions exécutées dans le délai des organes de pilotage de la Particom	Nbre des résolutions exécutées dans le délai des organes de pilotage de la Particom	Nbre des résolutions exécutées par les organes de pilotage de la Particom	ND		30%	40%	50%	60%	70%	80%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion de réunions des cadres de concertation communautaire multisectorielle	Nbre des réunions de cadres de concertation communautaire multisectorielle réalisées	Nbre des réunions de cadres de concertation communautaire multisectorielle planifiées	ND		30%	40%	50%	60%	70%	80%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des OAC fonctionnel au niveau de l'Aire de santé	Nbre des OAC fonctionnel au niveau de l'Aire de santé	Nbre des OAC existant dans l'aire de santé	ND		55%	60	65%	70%	75%	80%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
3.	**Indicateurs d'extrants/produits : Accès, qualité et sécurité des services**														
	Couverture en SSC	Nbre de SSC existants	Nbre total de besoin en SSC estimé	20,7%	PNECHOL-MD	25,6 %	30,5 %	35,4 %	40,2 %	45,1 %	50%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des villages/cellules disposant d'une CAC	Nbre des villages/cellules disposant d'une CAC	Nbre total des villages/cellules	74,7%	Evaluation PSN SACO 2019-2022	77,3 %	79,8 %	82,4 %	84,9 %	87,5 %	90%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des CAC correctement mises en place	Nbre des CAC correctement mises en place	Nbre total des CAC existants	ND		55%	60%	65%	70%	75%	80%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des CAC remplissant les critères de fonctionnalité	Nbre total des CAC remplissant les critères de fonctionnalité	Nbre total des CAC existants	ND		55%	60%	65%	70%	75%	80%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des aires de santé disposant d'un CODESA	Nbre des aires de santé disposant d'un CODESA	Nbre total des aires de santé	98%	Evaluation PSN SACO 2019-2022	98,3 %	98,7 %	99%	99,3 %	99,7 %	100%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS

# Code	Libellés des indicateurs par chaine des résultats	Mode de calcul		Référence des données de base		Cibles annuelles						Fréquence	Source de vérification	Ventilation	Responsables
		Numérateur	Dénominateur	Valeur	Source	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Proportion des CODESA correctement mises en place	Nbre des CODESA correctement mises en place	Nbre total des CODESA existants	ND		65%	70%	75%	80%	85%	90%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des CODESA remplissant les critères de fonctionnalité	Nbre total des CODESA remplissant les critères de fonctionnalité	Nbre total des CODESA existants	ND		65%	70%	75%	80%	85%	90%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des zones de santé disposant d'un UCODESA	Nbre des zones de santé disposant d'un UCODESA	Nbre total des zones de santé	ND		95%	96%	97%	98%	99%	100%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des UCODESA correctement mises en place	Nbre des UCODESA correctement mises en place	Nbre total des UCODESA existants	ND		65%	70%	75%	80%	85%	90%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
	Proportion des UCODESA remplissant les critères de fonctionnalité	Nbre total des UCODESA remplissant les critères de fonctionnalité	Nbre total des UCODESA existants	ND		65%	70%	75%	80%	85%	90%	Mensuelle	DHIS2	Par DPS	MSPHPS
4.	**Indicateurs d'activités/processus (Cfr cadre programmatique)**														

VI. Cadre budgétaire

6.1. Budget estimatif de la mise en œuvre du plan

6.1.1. Estimation du budget global

Le budget global du plan stratégique national de la santé communautaire 2025-2030 s'élève à 997 084 115,1 USD (neuf cent quatre-vingt-dix-sept millions quatre-vingt-quatre mille cent quinze USD) réparti par axe stratégique et par an comme résumé dans le tableau ci-dessous.

Tableau 30 : Ventilation du budget du PSN SACO 2025-2030 par axe stratégique et par an.

#	Axes stratégiques	Budget estimatif						Total	Pourcentage (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Promotion des pratiques familiales essentielles	$53 657 629,2	$53 488 298,0	$50 029 764,9	$22 367 376,1	$22 367 376,1	$22 367 376,1	$224 277 820,4	22,5%
2	Amélioration de l'offre des soins et services de santé au niveau communautaire	$95 060 495,4	$88 720 081,6	$91 621 649,2	$95 406 986,8	$97 366 404,4	$100 267 481,2	$568 443 098,7	57,0%
3	Renforcement de la prévention, préparation et riposte communautaire face aux urgences de santé publique (épidémies et	$27 437 403,0	$26 552 274,3	$24 640 813,6	$5 858 542,3	$6 247 179,1	$5 858 542,3	$96 594 754,5	9,7%

#	Axes stratégiques	Budget estimatif						Total	Pourcentage (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	catastrophes naturelles)								
4	Accroissement des financements et d'autres investissements en faveur de la santé communautaire	$2 451 067,1	$2 552 569,0	$3 135 581,5	$23 819,0	$887 456,5	$23 819,0	$9 074 312,1	0,9%
5	Développement du système d'information sanitaire communautaire et de la recherche opérationnelle axés sur la transformation digitale	$49 166 699,0	$3 547 633,0	$3 885 054,8	$4 431 506,0	$4 563 506,0	$3 429 531,0	$69 023 929,7	6,9%
6	Renforcement de la gouvernance en santé communautaire	$9 052 876,2	$3 591 703,5	$4 444 156,5	$3 933 703,5	$4 486 131,5	$4 161 628,5	$29 670 199,6	3,0%
	Total	$236 826 170,0	$178 452 559,3	$177 757 020,5	$132 021 933,6	$135 918 053,6	$136 108 378,0	$997 084 115,1	100%

6.1.2. Estimation du budget par axes stratégiques, interventions et actions prioritaires

Tableau 31 : Budget estimatif du PSN SACO 2025-2030 par axe stratégique, par interventions et par action

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Axe 1	**Promotion des pratiques familiales essentielles**			**$53 657 629,2**	**$53 488 298,0**	**$50 029 764,9**	**$22 367 376,1**	**$22 367 376,1**	**$22 367 376,1**	**$224 277 820,4**
Intervention 1.1	**Appui aux prestations préventives et promotionnelles des organes de participation communautaires**			**$30 165 103,3**	**$29 995 772,0**	**$26 662 236,5**	**$0,0**	**$0,0**	**$0,0**	**$86 823 111,8**
Action 1.1.1	Elaboration/actualisation des documents de formation sur le paquet intégré des activités communautaires	NC	Modules de formation	$147 840,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$147 840,0**
Action 1.1.2	Mise en place des pools de formateurs nationaux et provinciaux	NC	Pool national	$21 491,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$21 491,3**
		NI	Pool provincial	$31 036,5	$31 036,5	$27 588,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$89 661,0**
Action 1.1.3	Appui à la formation des membres des organes de participation communautaire du niveau opérationnel sur le paquet intégré d'activités communautaires préventives et promotionnelles	NO	UCODESA	$205 425,0	$205 425,0	$181 458,8	$0,0	$0,0	$0,0	**$592 308,8**
			CODESA	$1 791 366,5	$1 791 366,5	$1 592 571,8	$0,0	$0,0	$0,0	**$5 175 304,8**
			CAC	$18 665 904,0	$18 665 904,0	$16 592 016,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$53 923 824,0**
Action 1.1.4	Dotation des CODESA et CAC en matériels, équipements et outils de gestion et de communication	NO	CODESA	$542 164,0	$542 164,0	$481 998,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$1 566 326,0**
			CAC	$8 759 876,0	$8 759 876,0	$7 786 604,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$25 306 356,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Intervention 1.2	**Suivi de la mise en œuvre des actions et prestations communautaires (prévention et promotion)**			**$6 091 817,9**	**$6 091 817,9**	**$5 966 820,3**	**$4 966 668,0**	**$4 966 668,0**	**$4 966 668,0**	**$33 050 460,1**
Action 1.2.1	Suivi post formation des membres des organes de Particom sur le paquet intégré d'activités communautaires	NO	CODESA	$98 525,2	$98 525,2	$87 591,4	$0,0	$0,0	$0,0	**$284 641,8**
			CAC	$1 026 624,7	$1 026 624,7	$912 560,9	$0,0	$0,0	$0,0	**$2 965 810,3**
Action 1.2.2	Suivi communautaire intégré des cibles prioritaires au niveau des ménages (Suivi longitudinal et personnalisé des ménages)	NO	CAC	$4 966 668,0	$4 966 668,0	$4 966 668,0	$4 966 668,0	$4 966 668,0	$4 966 668,0	**$29 800 008,0**
Intervention 1.3	**Communication pour le changement social et de comportement des communautés (CCSC)**			**$17 400 708,1**	**$17 400 708,1**	**$17 400 708,1**	**$17 400 708,1**	**$17 400 708,1**	**$17 400 708,1**	**$104 404 248,6**
Action 1.3.1	Élaboration du plan d'action opérationnel de santé communautaire (PAO SACO) avec plan d'action intégré de communication (PAIC) sur les PFE	NC	PAIC national	$5 910,1	$5 910,1	$5 910,1	$5 910,1	$5 910,1	$5 910,1	**$35 460,6**
		NO	Micro plan AS	$321 447,5	$321 447,5	$321 447,5	$321 447,5	$321 447,5	$321 447,5	**$1 928 685,0**
			PAC CAC	$1 625 992,5	$1 625 992,5	$1 625 992,5	$1 625 992,5	$1 625 992,5	$1 625 992,5	**$9 755 955,0**
Action 1.3.2	Promotion de l'approche "Accroître la communication de qualité dans les services de santé" (ACQUASS) à travers le marketing social et la communication pour la santé	NI	Émissions radio ou télévisées	$74 360,0	$74 360,0	$74 360,0	$74 360,0	$74 360,0	$74 360,0	**$446 160,0**
		NO (village)	Campagne de sensibilisation	$10 406 330,0	$10 406 330,0	$10 406 330,0	$10 406 330,0	$10 406 330,0	$10 406 330,0	**$62 437 980,0**
			VAD/Causeries éducatives	$4 966 668,0	$4 966 668,0	$4 966 668,0	$4 966 668,0	$4 966 668,0	$4 966 668,0	**$29 800 008,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Axe 2	**Amélioration de l'offre des soins et services de santé au niveau communautaire**			**$95 060 495,4**	**$88 720 081,6**	**$91 621 649,2**	**$95 406 986,8**	**$97 366 404,4**	**$100 267 481,2**	**$568 443 098,7**
Intervention 2.1	**Accroissement de la couverture des SSC fonctionnels de 21% à 50%**			**$69 404 223,5**	**$61 398 912,9**	**$63 124 032,9**	**$65 757 462,9**	**$66 540 432,9**	**$68 265 552,9**	**$394 490 618,0**
Action 2.1.1	Estimation des besoins en SSC par le modèle cartographique avec géoréférencement	NC	Cartographie des SSC	$863 637,5	$0,0	$0,0	$942 150,0	$0,0	$0,0	**$1 805 787,5**
Action 2.1.2	Installation des nouveaux SSC suivant l'emplacement optimisé et révisitation de l'emplacement des anciens	NO	Nouveau SSC	$728 420,0	$790 680,0	$790 680,0	$790 680,0	$790 680,0	$790 680,0	**$4 681 820,0**
Action 2.1.3	Élaboration/actualisation annuelle de la cartographie des ASC et RECO avec liste maîtresse nationale géoréférencée	NC	Liste maitresse	$16 216 162,0	$7 297 272,9	$7 297 272,9	$7 297 272,9	$7 297 272,9	$7 297 272,9	**$52 702 526,5**
Action 2.1.4	Élaboration du plan de développement et de déploiement des ASC et RECO (PDD ASC-RECO) pour une couverture nationale équitable **(y compris la prise en charge/rémunération des ASC et CAC)**	NC	Plan de déploiement	$10 164,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$10 164,0**
		NO	ASC	$9 014 400,0	$10 739 520,0	$12 464 640,0	$14 155 920,0	$15 881 040,0	$17 606 160,0	**$79 861 680,0**
			RECO	$42 571 440,0	$42 571 440,0	$42 571 440,0	$42 571 440,0	$42 571 440,0	$42 571 440,0	**$255 428 640,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Intervention 2.2	**Appui à l'offre des paquets intégrés des interventions curatives**			**$5 642 912,0**	**$7 320 772,8**	**$8 497 220,4**	**$9 649 128,0**	**$10 825 575,6**	**$12 001 532,4**	**$53 937 141,2**
Action 2.2.1	Rationalisation des intervenants dans les provinces des convergences et identification des synergies d'actions dans la mise en œuvre du paquet intégré d'interventions	NI	Plan de couverture	$10 164,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$10 164,0**
Action 2.2.2	Dotation des SSC en médicament, intrants traceurs, supports et petits matériels	NO	SSC	$5 632 748,0	$7 320 772,8	$8 497 220,4	$9 649 128,0	$10 825 575,6	$12 001 532,4	**$53 926 977,2**
Intervention 2.3	**Professionnalisation des ASC**			**$20 013 359,9**	**$20 000 395,9**	**$20 000 395,9**	**$20 000 395,9**	**$20 000 395,9**	**$20 000 395,9**	**$120 015 339,5**
Action 2.3.1	Plaidoyer auprès de la fonction publique pour l'admission des ASC certifiés comme étant des agents sous contrat	NC	Réunions de plaidoyers	$2 200,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$2 200,0**
Action 2.3.2	Mise en place d'un mécanisme d'incitation financière en faveur des acteurs communautaires (ASC et RECO)	NC	Cadre contractuel et réglementaire	$600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$600,0**
Action 2.3.3	Elaboration du manuel des procédures de contractualisation des ASC	NC	Manuel des procédures	$10 164,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$10 164,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 2.3.4	Suivi-supervision formatives périodiques intégrées	NI	Visites de suivi aux DPS	$64 555,9	$64 555,9	$64 555,9	$64 555,9	$64 555,9	$64 555,9	**$387 335,5**
		NO	Visites de suivi aux ZS	$114 180,0	$114 180,0	$114 180,0	$114 180,0	$114 180,0	$114 180,0	**$685 080,0**
			Visites de suivi aux AS	$3 857 370,0	$3 857 370,0	$3 857 370,0	$3 857 370,0	$3 857 370,0	$3 857 370,0	**$23 144 220,0**
			Visites de suivi aux CAC	$15 964 290,0	$15 964 290,0	$15 964 290,0	$15 964 290,0	$15 964 290,0	$15 964 290,0	**$95 785 740,0**
Axe 3	**Renforcement de la prévention, préparation et riposte communautaire face aux urgences de santé publique (épidémies et catastrophes naturelles)**			**$27 437 403,0**	**$26 552 274,3**	**$24 640 813,6**	**$5 858 542,3**	**$6 247 179,1**	**$5 858 542,3**	**$96 594 754,5**
Intervention 3.1	**Renforcement des capacités des acteurs et organes de participation communautaire à tous les niveaux pour la préparation et riposte**			**$25 700 299,5**	**$24 815 170,8**	**$22 903 710,1**	**$4 121 438,8**	**$4 510 075,6**	**$4 121 438,8**	**$86 172 133,5**
Action 3.1.1	Appui à l'élaboration/mise) jour de la cartographie des risques (tous les 2 ans)	NC	Cartographie	$863 637,5	$0,0	$388 636,9	$0,0	$388 636,9	$0,0	**$1 640 911,3**
Action 3.1.2	Appui à la surveillance à base communautaire à travers la promptitude et complétude des rapports MAPEPI	CAC	Rapport MAPEPI	$3 902 382,0	$3 902 382,0	$3 902 382,0	$3 902 382,0	$3 902 382,0	$3 902 382,0	**$23 414 292,0**
		CODESA	Rapport MAPEPI CODESA	$96 434,3	$96 434,3	$96 434,3	$96 434,3	$96 434,3	$96 434,3	**$578 605,5**
		NO	Rapport MAPEPI	$42 817,5	$42 817,5	$42 817,5	$42 817,5	$42 817,5	$42 817,5	**$256 905,0**
		NI	Rapport MAPEPI	$3 575,0	$3 575,0	$3 575,0	$3 575,0	$3 575,0	$3 575,0	**$21 450,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 3.1.3	Appui à l'élaboration des plans de préparation et de riposte communautaire multirisque (PPRCM)	NC	PPRCM national	$10 164,0	$10 164,0	$10 164,0	$10 164,0	$10 164,0	$10 164,0	**$60 984,0**
		NI	PPRCM provinciaux	$66 066,0	$66 066,0	$66 066,0	$66 066,0	$66 066,0	$66 066,0	**$396 396,0**
Action 3.1.4	Mise en place des pools de formateurs nationaux et provinciaux sur la préparation et riposte aux urgences de santé publique	NC	Pool national	$21 491,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$21 491,3**
		NI	Pools provinciaux	$31 036,5	$31 036,5	$27 588,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$89 661,0**
Action 3.1.5	Appui à la formation des acteurs des organes de Particom du niveau opérationnel sur la préparation et riposte	NO	UCODESA	$205 425,0	$205 425,0	$181 458,8	$0,0	$0,0	$0,0	**$592 308,8**
			CODESA	$1 791 366,5	$1 791 366,5	$1 592 571,8	$0,0	$0,0	$0,0	**$5 175 304,8**
			CAC	$18 665 904,0	$18 665 904,0	$16 592 016,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$53 923 824,0**
Action 3.1.6	Dotation en matériels et outils traceurs pour la détection précoce des maladies sous surveillance communautaire	NO	CODESA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
			CAC	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
Intervention 3.2	**Appui aux prestations des services de santé essentiels de qualité et au partenariat stratégique et à la synergie d'action selon l'approche "Une seule santé"**			**$1 737 103,5**	**$1 737 103,5**	**$1 737 103,5**	**$1 737 103,5**	**$1 737 103,5**	**$1 737 103,5**	**$10 422 621,0**
Action 3.2.1	Appui à l'assurance de la couverture vaccinale requise de la population contre les risques posés par les maladies à prévention vaccinale	NI	Tasks forces	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
		NO	UCODESA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
			CODESA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
			CAC	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 3.2.2	Appui des Task forces multisectorielles provinciales de communication à l'élaboration d'une feuille de route « Une seule santé »	NI	Task forces provinciales	$21 450,0	$21 450,0	$21 450,0	$21 450,0	$21 450,0	$21 450,0	**$128 700,0**
Action 3.2.3	Appui à l'intégration des approches multisectorielles à base communautaire à travers les CAC	NO	CAC	$1 625 992,5	$1 625 992,5	$1 625 992,5	$1 625 992,5	$1 625 992,5	$1 625 992,5	**$9 755 955,0**
Action 3.2.4	Suivi de la mise en œuvre de la feuille de route provinciale « Une seule santé »	NI	Visites de suivi	$89 661,0	$89 661,0	$89 661,0	$89 661,0	$89 661,0	$89 661,0	**$537 966,0**
Axe 4	**Accroissement des financements et d'autres investissements en faveur de la santé communautaire**			**$2 451 067,1**	**$2 552 569,0**	**$3 135 581,5**	**$23 819,0**	**$887 456,5**	**$23 819,0**	**$9 074 312,1**
Intervention 4.1	**Mobilisation des ressources en faveur de la santé communautaire**			**$294 394,0**	**$17 914,0**	**$17 914,0**	**$17 914,0**	**$17 914,0**	**$17 914,0**	**$383 964,0**
Action 4.1.1	Elaboration/actualisation de la cartographie annuelle des ressources financières et autres investissements en faveur de la santé communautaire	NC	Cartographies	$10 164,0	$10 164,0	$10 164,0	$10 164,0	$10 164,0	$10 164,0	**$60 984,0**
Action 4.1.2	Élaboration d'un dossier d'investissement (DI) avec plan de viabilité financière de la santé communautaire	NC	DI	$192 500,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$192 500,0**
Action 4.1.3	Organisation de forums de mobilisation des	NC	Forum national	$600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$600,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ressources financières et investissements pour la mise en œuvre du PSN SACO	NI	Forums provinciaux	$7 150,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$7 150,0**
Action 4.1.4	Élaboration des plans de plaidoyer auprès des cibles primaires (Gouvernement, Parlement)	NC	Plan national	$10 164,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$10 164,0**
		NI	Plans provinciaux	$66 066,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$66 066,0**
Action 4.1.5	Organisation des séances de plaidoyer pour l'inscription d'une ligne budgétaire consacrée à la santé communautaire	NC	Réunions	$600,0	$600,0	$600,0	$600,0	$600,0	$600,0	**$3 600,0**
		NI	Réunions	$7 150,0	$7 150,0	$7 150,0	$7 150,0	$7 150,0	$7 150,0	**$42 900,0**
Intervention 4.2	**Développement des mécanismes de partage des risques existants et innovations du financement durable du système de santé communautaire**			**$1 271 544,4**	**$2 534 655,0**	**$2 254 030,0**	**$5 905,0**	**$5 905,0**	**$5 905,0**	**$6 077 944,4**
Action 4.2.1	Mise en place d'un basket fund (panier commun) virtuel de tous les financements de la santé communautaire	NC	Caisse nationale	$300,0	$300,0	$300,0	$300,0	$300,0	$300,0	**$1 800,0**
		NI	Caisse provinciale	$1 430,0	$1 430,0	$1 430,0	$1 430,0	$1 430,0	$1 430,0	**$8 580,0**
Action 4.2.2	Plaidoyer auprès des APA pour les financements innovants en faveur de la santé communautaire	NC	Réunions	$600,0	$600,0	$600,0	$600,0	$600,0	$600,0	**$3 600,0**
		NI	Réunions de plaidoyer	$3 575,0	$3 575,0	$3 575,0	$3 575,0	$3 575,0	$3 575,0	**$21 450,0**
Action 4.2.3	Appui à la formation sur les initiatives communautaires des mutuelles de santé	NO	MUSA /CODESA	$152 989,4	$505 750,0	$449 625,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$1 108 364,4**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 4.2.4	Appui des CODESA au développement des activités génératrices de revenu sous forme de coopérative	NO	Coopératives/CODESA	$1 112 650,0	$2 023 000,0	$1 798 500,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$4 934 150,0**
Intervention 4.3	**État des lieux des populations vulnérables en vue de leur sécurisation face aux dépenses catastrophiques de santé**			**$885 128,8**	**$0,0**	**$863 637,5**	**$0,0**	**$863 637,5**	**$0,0**	**$2 612 403,8**
Action 4.3.1	Cartographie des populations vulnérables (ménages vivant en situation d'extrême pauvreté et n'ayant pas une bonne abordabilité financière aux soins et services de santé), tous les 2 ans	NC	Cartographie	$863 637,5	$0,0	$863 637,5	$0,0	$863 637,5	$0,0	**$2 590 912,5**
Action 4.3.2	Mise en place d'un mécanisme d'accroissement de l'abordabilité financière aux soins et services de santé de santé de base	NC	PV de mise en place	$21 491,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$21 491,3**
Axe 5	**Développement du système d'information sanitaire communautaire et de la recherche opérationnelle axés sur la transformation digitale**			**$49 166 699,0**	**$3 547 633,0**	**$3 885 054,8**	**$4 431 506,0**	**$4 563 506,0**	**$3 429 531,0**	**$69 023 929,7**
Intervention 5.1	**Formalisation du SNIS Communautaire**			**$42 953 174,0**	**$8 140,0**	**$8 140,0**	**$8 140,0**	**$8 140,0**	**$8 140,0**	**$42 993 874,0**
Action 5.1.1	Mise en place du cadre normatif du SNIS communautaire	NC	Cadre normatif	$55 053,9	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$55 053,9**
Action 5.1.2	Vulgarisation du cadre normatif du SNIS communautaire couplée aux autres documents	NC	Sessions de vulgarisation	$184 800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$184 800,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		NI	Sessions DPS	$720 720,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$720 720,0**
		NO	Sessions ZS	$7 481 073,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$7 481 073,6**
Action 5.1.3	Finalisation du développement du SNIS communautaire	NC	Plateforme DHIS-2	$33 148 599,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$33 148 599,0**
Action 5.1.4	Formation des cadres et acteurs communautaires sur l'utilisation des outils numériques (au moins 2 membres par structures de participation communautaires)	NC	S-C/SACO	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
		NI	Tasks forces	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
		NO	UCODESA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
			CODESA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
			CAC	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
Action 5.1.5	Dotation des 519 ZS en matériels et kit de communication pour l'utilisation numérique de la plateforme DHIS2-communautaire	NO	Kits de communication numérique	$1 354 787,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$1 354 787,5**
Action 5.1.6	Production des bulletins trimestriels et annuaires d'informations de la SACO	NC	Bulletins	$4 840,0	$4 840,0	$4 840,0	$4 840,0	$4 840,0	$4 840,0	**$29 040,0**
			Annuaires	$3 300,0	$3 300,0	$3 300,0	$3 300,0	$3 300,0	$3 300,0	**$19 800,0**
Action 5.1.7	Appui aux réunions mensuelles des CAC pour l'organisation de monitorage des interventions à base communautaire	NO	Réunions de monitorage	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
Intervention 5.2	**Appui à la digitalisation des prestations communautaires**			**$1 551 348,0**	**$473 016,0**	**$378 412,8**	**$264 889,0**	**$264 889,0**	**$264 889,0**	**$3 197 443,7**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 5.2.1	Elaboration et validation d'un plan sexennal de la digitalisation du SNIS-C aligné au PSN SACO	NC	Plan de digitalisation	$10 164,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$10 164,0**
Action 5.2.2	Développement et pré test des outils numériques du SNIS communautaire	NC	Pré test	$831 120,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$831 120,0**
Action 5.2.3	Mise en place des mécanismes de connectivité adaptés au contexte du pays	NO	CAC investies en connexion	$710 064,0	$473 016,0	$378 412,8	$264 889,0	$264 889,0	$264 889,0	**$2 356 159,7**
Action 5.2.4	Développement du portail Web en Santé communautaire pour assurer la diffusion continuelle des informations	NC	Portail Web SACO	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
Action 5.2.5	Intégration du portail Web e la Santé communautaire dans celui du MSPH-PS	NC	Portail Web SACO	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
Intervention 5.3	**Documentation des bonnes pratiques et recherche opérationnelle**			**$1 683 437,0**	**$1 233 437,0**	**$1 023 437,0**	**$1 983 437,0**	**$1 773 437,0**	**$1 023 437,0**	**$8 720 622,0**
Action 5.3.1	Recherche-action (RA) sur les nouvelles thématiques (village santé, ...)	NC	Recherche-action	$687 500,0	$687 500,0	$687 500,0	$687 500,0	$687 500,0	$687 500,0	**$4 125 000,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 5.3.2	Recherche-action (RA) sur les thématiques en lien avec les défis persistants de la santé communautaire	NC	Recherche-action	$0,0	$0,0	$0,0	$750 000,0	$750 000,0	$0,0	**$1 500 000,0**
Action 5.3.3	Étude sur les approches ou thématiques spécifiques	NC	Études	$660 000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$660 000,0**
Action 5.3.4	Documentation et capitalisation des bonnes pratiques sur la redevabilité et dénonciation des abus et fraudes commis dans la communauté	NC	Enquêtes (ligne verte, suivi dirigé)	$0,0	$210 000,0	$0,0	$210 000,0	$0,0	$0,0	**$420 000,0**
Action 5.3.5	Extension des bonnes pratiques (ligne verte, suivi dirigé)	NO	CAC ayant intégré	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
Action 5.3.6	Organisation des missions annuelles de partage d'expériences à l'étranger sur la santé communautaire	NC	Missions d'échanges	$32 865,0	$32 865,0	$32 865,0	$32 865,0	$32 865,0	$32 865,0	**$197 190,0**
Action 5.3.7	Organisation des forums internationaux et inter provinciaux d'échange d'expériences sur la santé communautaire	NC	Forums internationaux	$147 840,0	$147 840,0	$147 840,0	$147 840,0	$147 840,0	$147 840,0	**$887 040,0**
		NI	Forums inter provinciaux	$155 232,0	$155 232,0	$155 232,0	$155 232,0	$155 232,0	$155 232,0	**$931 392,0**
Intervention 5.4	**Renforcement des mécanismes de suivi-évaluation et de redevabilité à tous les niveaux**			**$2 978 740,0**	**$1 833 040,0**	**$2 475 065,0**	**$2 175 040,0**	**$2 517 040,0**	**$2 133 065,0**	**$14 111 990,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 5.4.1	Suivi semestriel des interventions communautaires en cours de la mise en œuvre de ce plan à l'aide de l'outil MAA dans 26 DPS	NC, NI	Sessions de MAA	$1 141 800,0	$1 141 800,0	$1 141 800,0	$1 141 800,0	$1 141 800,0	$1 141 800,0	**$6 850 800,0**
Action 5.4.3	Organisation des revues annuelles nationale et provinciales	NC	Revue nationale	$147 840,0	$147 840,0	$147 840,0	$147 840,0	$147 840,0	$147 840,0	**$887 040,0**
		NI	Revue provinc.	$543 400,0	$543 400,0	$543 400,0	$543 400,0	$543 400,0	$543 400,0	**$3 260 400,0**
Action 5.4.4	Organisation de l'évaluation à mi-parcours et finale du PSN SACO 2025-2030	NC	Évaluation du PSN SACO	$0,0	$0,0	$300 025,0	$0,0	$0,0	$300 025,0	**$600 050,0**
Action 5.4.5	Organiser des évaluations sur le niveau de mise en place et fonctionnalité des organes de participation communautaire (CAC, CODESA et UCODESA) et les SSC	NC	Évaluation mise en place et fonctionnalité des organes de PARTICOM	$342 000,0	$0,0	$342 000,0	$0,0	$342 000,0	$0,0	**$1 026 000,0**
Action 5.4.6	Organiser des évaluations des services et prestations des ASC et RECO	NC	Évaluation des services et prestations des ASC et RECO	$0,0	$0,0	$0,0	$342 000,0	$0,0	$0,0	**$342 000,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 5.5.7	Organiser des évaluations du niveau des connaissances, attitudes et pratiques des communautés par rapport aux pratiques familiales essentielles, les signes de danger et d'alertes de la mère et de l'enfant dans la communauté, la prévention et le recours aux soins et services.	NC	Évaluation des CAP	$342 000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$342 000,0	$0,0	**$684 000,0**
Action 5.5.8	Organiser une étude sur la contribution de la santé communautaire sur les indicateurs de CSU	NC	Etude d'impact	$461 700,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$461 700,0**
Axe 6	**Renforcement de la gouvernance en santé communautaire**			**$9 052 876,2**	**$3 591 703,5**	**$4 444 156,5**	**$3 933 703,5**	**$4 486 131,5**	**$4 161 628,5**	**$29 670 199,6**
Intervention 6.1	**Accroissement de la couverture en organes de participation communautaire**			**$0,0**	**$0,0**	**$0,0**	**$0,0**	**$0,0**	**$0,0**	**$0,0**
Action 6.1.1	Redynamisation des CODESA existants	NO	CODESA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
Action 6.1.2	Extension de la couverture des villages en CAC fonctionnelles	NO	CAC	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
Intervention 6.2	**Renforcement de la coordination et leadership à tous les niveaux**			**$3 852 491,0**	**$36 300,0**	**$36 300,0**	**$36 300,0**	**$36 300,0**	**$36 300,0**	**$4 033 991,0**
Action 6.2.1	Élaboration des avant-projets des textes légaux et réglementaires sur la professionnalisation des Recosites/ASC pour une assise légale	NC	Avant-projets des textes	$14 025,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$14 025,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 6.2.3	Vulgarisation du PSN SACO 2025-2030 et autres documents normatifs à tous les niveaux	NC	Réunion de dissémination	$147 840,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$147 840,0**
		NI	Mission DPS	$64 350,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$64 350,0**
		NO	UCODESA	$249 120,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$249 120,0**
			CODESA	$935 120,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$935 120,0**
			CAC	$2 365 080,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$2 365 080,0**
Action 6.2.4	Élaboration /actualisation des documents de politique, stratégies et directives	NC	Documents	$40 656,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$40 656,0**
Action 6.2.5	Consolidation trimestrielle des capacités institutionnelles à tous les niveaux	NC	Appui de la direction SACO	$7 700,0	$7 700,0	$7 700,0	$7 700,0	$7 700,0	$7 700,0	**$46 200,0**
		NI	Appui Tasks fiorces	$28 600,0	$28 600,0	$28 600,0	$28 600,0	$28 600,0	$28 600,0	**$171 600,0**
Intervention 6.3	**Institutionnalisation de la santé communautaire**			**$21 500,0**	**$0,0**	**$0,0**	**$0,0**	**$0,0**	**$0,0**	**$21 500,0**
Action 6.3.1	Plaidoyer pour adoption d'un avant-projet du texte légal sur l'institutionnalisation de la SACO	NO	Avant-projet de texte	$600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$600,0**
Action 6.3.2	Mise en place d'une structure de coordination de la SACO	NC	Arrêté créant la direction de la SACO	$20 900,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$20 900,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Intervention 6.4	**Renforcement du partenariat et collaboration intra et multisectorielle**			**$163 174,0**	**$153 010,0**	**$153 010,0**	**$153 010,0**	**$153 010,0**	**$153 010,0**	**$928 224,0**
Action 6.4.1	Élaboration du Vademecum du partenariat dans le sous-secteur santé communautaire	NC	Un Vade-mecum	$10 164,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	**$10 164,0**
Action 6.4.2	Organisation des réunions de concertation avec les différents acteurs de la SACO	NC	Réunion trimestrielle	$2 750,0	$2 750,0	$2 750,0	$2 750,0	$2 750,0	$2 750,0	**$16 500,0**
Action 6.4.3	Mise en place d'un cadre multisectoriel d'échanges avec les secteurs connexes	NC	Cadre multisectoriel	$2 420,0	$2 420,0	$2 420,0	$2 420,0	$2 420,0	$2 420,0	**$14 520,0**
Action 6.4.4	Célébration Journées portes ouvertes SACO	NC	Journée	$147 840,0	$147 840,0	$147 840,0	$147 840,0	$147 840,0	$147 840,0	**$887 040,0**
Intervention 6.5	**. Renforcement du mécanisme du contrôle citoyen par les organisations de la société civile.**			**$2 036 971,2**	**$1 569 353,5**	**$1 779 781,5**	**$1 569 353,5**	**$1 779 781,5**	**$1 839 253,5**	**$10 574 494,6**
Action 6.5.1	Actualisation biannuelle de la cartographie des OSC (OAC)	NO	CAC	$467 617,7	$0,0	$210 428,0	$0,0	$210 428,0	$0,0	**$888 473,6**
Action 6.5.2	Appui à la mise en œuvre des actions et prestations du contrôle citoyen par les OSC	CODESA	Visite d'encadrement	$257 158,0	$257 158,0	$257 158,0	$257 158,0	$257 158,0	$257 158,0	**$1 542 948,0**
		CAC	Visite d'encadrement	$975 595,5	$975 595,5	$975 595,5	$975 595,5	$975 595,5	$975 595,5	**$5 853 573,0**

# Code	Axes stratégiques, Interventions et actions prioritaires	Niveau d'exécution	Unités	Estimation annuelle						Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Action 6.5.3	Accompagnement des structures de Particom dans l'élaboration de PAC /micro plan	CODESA	Micro plan	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
		CAC	PAC	PM	PM	PM	PM	PM	PM	**$0,0**
Action 6.5.4	Organisation de l'approche BCP dans les AS ciblées	NO	CODESA	$336 600,0	$336 600,0	$336 600,0	$336 600,0	$336 600,0	$606 500,0	**$2 289 500,0**
Total				**$236 826 170,0**	**$178 452 559,3**	**$177 757 020,5**	**$132 021 933,6**	**$135 918 053,6**	**$136 108 378,0**	**$997 084 115,1**

Le budget prévoit une allocation de 30$ mensuel par ASC, ce qui constitue un premier pas vers leur reconnaissance financière. Bien que modeste, elle signale une volonté de valoriser leur rôle crucial. L'évolution du contexte économique pourrait permettre d'envisager une augmentation future de cette rémunération pour assurer motivation et rétention durables de ces acteurs clés de la santé communautaire.

Pour le fonctionnement des CAC, incluant les RECO, une enveloppe mensuelle de 30$ leur sera octroyé et cela vise à soutenir les activités de coordination et de sensibilisation locales. L'efficacité de ces cellules dépendra de l'adéquation continue des ressources à leurs besoins opérationnels pour maximiser leur impact sur la santé communautaire.

Bibliographie

1. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Glossaire de la série « Santé pour tous » (n° 9). Genève : OMS ; 1984.
2. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Glossaire pour la promotion de la santé. WHO/HPR/HEP/98.1.
3. Centres for Disease Control and Prevention-Africa. Priorités stratégiques quinquennales du CDC Afrique en matière de santé communautaire (2024-2028).
4. Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention (MSPHP). PNECHOL-MD. Guide de mise en œuvre des sites de soins communautaires. Mbanza-Ngungu : MSPHP ; Avril 2023.
5. Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention (MSPHP). PRONANUT. Informations utiles sur la mise en œuvre de la Nutrition à Assise Communautaire (NAC) en RDC.
6. République Démocratique du Congo (RDC), Présidence de la République. Politique nationale de la santé. RDC ; 2001.
7. Organisation Mondiale de la Santé (OMS), UNICEF. Les soins de santé primaires : rapport de la conférence internationale sur les soins de santé primaires, Alma-Ata (URSS), 6-12 septembre 1978. Rapport conjoint OMS/UNICEF.
8. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Déclaration d'Astana. Global Conference on Primary Health Care. Astana, Kazakhstan ; 25-26 octobre 2018.
9. Task Force Child Health. Institutionalizing Community Health: Critical principles. Johannesburg, South Africa ; 27-30 mars 2017.
10. Organisation Mondiale de la Santé (OMS), UNICEF. Institutionnalisation de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance dans la communauté (PCIME) pour mettre fin aux décès évitables d'enfants : consultation technique et plan d'action par pays, Addis-Abeba, Éthiopie ; 22-26 juillet 2019.
11. USAID, UNICEF, Last Mile Health-RDC. Programme pour l'intégration de la santé communautaire. Aperçu du pays : République Démocratique du Congo. Août 2021.
12. République Démocratique du Congo (RDC), Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Feuille de route pour la santé communautaire, mise à jour 2021 : combler le fossé des OMD par des soins de santé primaires accélérés au niveau communautaire.
13. Organisation Mondiale de la Santé (OMS), UNICEF, UNFPA, Banque Mondiale (BM). Estimation des données 2020 établies selon un modèle de régression à partir de l'information sur la fécondité, les sages-femmes et la prévalence du VIH. 2020.
14. Assemblée Générale des Nations Unies. Résolution A/RES/70/1* : Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030. New York ; 25-27 septembre 2015.
15. République Démocratique du Congo (RDC), Institut National de la Statistique, École de Santé Publique de Kinshasa, ICF. Enquête Démographique et de Santé 2023–24 : Rapport des indicateurs clés. Kinshasa, RDC et Rockville, Maryland, USA : ICF ; 2024.
16. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Tracking Universal Health Coverage 2023 Global Monitoring Report. Genève : OMS ; 2023.
17. République Démocratique du Congo (RDC), Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention (MSPHP). Plan d'extension des sites de soins communautaires en RDC 2023-2027. 2022.
18. Ministère du Plan, Institut National de la Statistique. Annuaire statistique RDC 2020. Mars 2021.
19. Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Cabinet de la Présidence de la République. Constitution de la République. 52ème Année. Kinshasa ; 5 février 2011.
20. RDC, Ministère du Plan, Ministère de la Santé Publique. Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS-Palu 2018 : Rapport final. Kinshasa ; Décembre 2019.

21. Banque Mondiale. Pourcentage de la population rurale (SP.RUR.TOTL. ZS). Disponible à : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS?view=chart. Consulté le 01-12-2024.
22. Banque Mondiale. Présentation générale de la RDC. Disponible à : https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview. Consulté le 01-12-2024.
23. Coordination Nationale de Renforcement du Système Communautaire (CNRSC). Rapport des activités de mobilisation sociale dans trois provinces (Tanganyika, Sud Ubangi et Haut Uele) : Enquête post-distribution des moustiquaires imprégnées et focus group. République Démocratique du Congo : CNRSC ; 2024.
24. Programme national de Santé de la reproduction-RDC. Rapport annuel 2022 de la SDMPR. RDC ; 2023.
25. WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, UNIDESA/Population Division. Trends in maternal mortality: 2000 to 2020.
26. Revised country report: République Démocratique du Congo (RDC) 2019. Disponible à : http://rodra.co.za/countries/drc/49-countries/drc/182-revised-country-report-republique-democratique-du-congo-rdc-2019. Consulté le 09-12-2024.
27. OCDE. Des critères améliorés pour des évaluations meilleures : critères d'évaluation révisés et actualisés. Février 2020.
28. UNICEF. Pour chaque enfant, une chance de survivre. Disponible à : https://www.unicef.org/drcongo/communiqués-de-presse/pour-chaque-enfant-une-chance-de-survivre. Consulté le 20-12-2024.
29. Wilkinson R, Marmot M. Les déterminants sociaux de la santé : les faits. 2e éd. Genève : OMS ; 2004.
30. National Primary Health Care Development Agency (NPHCDA). Community Health Influencers, Promoters and Services (CHIPS). Disponible à : https://nphcda.gov.ng/chips/. Consulté le 23-08-2024.
31. Raven J, Wurie H, Idriss A, et al. How should community health workers in fragile contexts be supported: qualitative evidence from Sierra Leone, Liberia, and Democratic Republic of Congo. Human Resources for Health. 2020. Disponible à : http://doi.org/10.1186/s12960-020-00494-8.
32. Devlin K, Egan KF, Pandit-Rajani T. Community Health Systems Catalog Country Profile: DRC. 2017. Disponible à : https://www.advancingpartners.org/sites/default/files/catalog/profiles/drc_chs_catalog_profile_0.pdf.
33. Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Surveillance à base communautaire : Principes directeurs. Genève ; 2017.
34. UNICEF. Countdown 2030: Democratic Republic of the Congo. Disponible à : https://data.unicef.org/countdown-2030/country/Democratic-Republic-of-the-Congo/1/. Consulté le 11-12-2024.
35. Direction de la Surveillance Épidémiologique-RDC. Rapport annuel 2023 des activités. Kinshasa : Direction de la Surveillance Épidémiologique-RDC ; Avril 2023.
36. Programme Solidarité Eau (pS-Eau). Fiche pays République Démocratique du Congo. Disponible à : https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_fiche_pays_republique_democratique_du_congo_rdc_2023.pdf.
37. Banque Mondiale. Indicateur GINI. Disponible à : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.GINI.
38. Programme National Multisectoriel de Lutte Contre le Sida. Rapport annuel 2020. Kinshasa, RDC ; 2021.

39. Marx P. La santé communautaire : un levier pour faciliter l'accès à la couverture maladie universelle ? Focus sur plusieurs expériences internationales de soins communautaires. 2020.
40. Assefa Y, et al. Successes and challenges of the Health Extension Program in Ethiopia: A review of the evidence. J Glob Health. 2019.
41. Mosquera PA, Decat P, Zapata Y, Borghi J, De Paepe. Experiences in community health promotion in Buenaventura, Colombia. Salud Pública Méx. 2018.
42. République Démocratique du Congo, Groupe technique de référence en évaluation (TERG) du Fonds mondial. Évaluation prospective pays : rapport annuel pays 2019-2020. Kinshasa, RDC : Juin 2020.
43. Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Revue annuelle 2022 : Vers la couverture santé universelle. République Démocratique du Congo : Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de Santé (UG-PDSS) ; 2022.
44. Coordination Nationale de Renforcement du Système Communautaire (CNRSC). Rapport annuel des activités de suivi communautaire dans le cadre du contrôle citoyen dans la province Kinshasa et Kongo Central. République Démocratique du Congo : CNRSC ; 2023.
45. Coordination Nationale de Renforcement du Système Communautaire (CNRSC). Rapport annuel du suivi communautaire dans les zones de santé de la digitalisation Binza Ozone (Kinshasa) et Boma (Kongo Central). République Démocratique du Congo : CNRSC ; 2024.
46. Bureau d'études AMD International. Rapport final d'évaluation : Approche communautaire pour améliorer les services de base pour les enfants en RDC. République Démocratique du Congo : UNICEF, SANRU et Ministère de la Santé Publique ; Janvier 2023.
47. République Démocratique du Congo, Secrétariat Général de la Santé, Direction Générale d'Organisation et de Gestion des Services et Soins de Santé. Évaluation du plan stratégique national de la santé communautaire 2019-2022 en République Démocratique du Congo. Kinshasa : Août 2024.
48. WHO. Severe Malaria Observatory. Disponible à : https://www.severemalaria.org. Consulté le 01-12-2024.
49. ICHESS. Rapport final : Évaluation de la mise en place et fonctionnalité des CAC et des CODESA dans la province du Maniema. 2023.
50. ICHESS. Rapport final : Évaluation de la mise en place et fonctionnalité des CAC et des CODESA dans la province de Kinshasa. 2022.
51. École de Santé Publique de Kinshasa (ESPK). Rapport final : Évaluation de la mise en place et fonctionnalité des CAC et des CODESA dans la province du Kongo-Central. 2022.
52. SANRU-ICHESS-FONLIV-FDSS. Projet PMNS-NAC. Rapport final : État des lieux des organes de participation communautaire et ESS dans la province du Kwilu. 2024.
53. Journal Officiel de la RDC. Ordonnance-Loi n°23/006 du 03 mars 2023 modifiant et complétant la Loi n°18/035 du 13 décembre 2018 : Article 41. Kinshasa ; 2023.
54. RD Congo, MSPHP, Coordination nationale de la PCIMNE. Plan stratégique national de la PCIMNE. Octobre 2023.
55. RD Congo, MSPHP. Rapport annuel 2022 du PNECHOL-MD. 2023.
56. UNICEF. Global Breastfeeding Scorecard 2022.
57. World Bank, UNFPA. Population data. Disponible à : https://www.unfpa.org/fr/data/world-population/CD. Consulté le 01-12-2024.
58. WHO. Immunization Dashboard: African Region. Disponible à : https://immunizationdata.who.int/dashboard/regions/african-region. Consulté le 01-12-2024.
59. DHS Program. Demographic and Health Surveys. Disponible à : https://www.dhsprogram.com. Consulté le 01-12-2024.
60. Programme National Multisectoriel de Lutte Contre le Sida. Rapport annuel 2020. Kinshasa, RDC ; 2021.

61. Wilkinson R, Marmot M. Les déterminants sociaux de la santé : les faits. 2e éd. Genève : OMS ; 2004.
62. Marx P. La santé communautaire : un levier pour faciliter l'accès à la couverture maladie universelle ? Focus sur plusieurs expériences internationales de soins communautaires. 2020.
63. Federal Ministry of Health Ethiopia. Health Sector Transformation Plan II (HSTP II) 2020/21 - 2024/25. 2020.
64. Assefa Y, et al. Successes and challenges of the Health Extension Program in Ethiopia: A review of the evidence. J Glob Health. 2019.
65. National Primary Health Care Development Agency (NPHCDA). Community Health Influencers, Promoters and Services (CHIPS). Disponible à : https://nphcda.gov.ng/chips/. Consulté le 23-08-2024.
66. Mosquera PA, Decat P, Zapata Y, Borghi J, De Paepe. Experiences in community health promotion in Buenaventura, Colombia. Salud Pública Méx. 2018.
67. République Démocratique du Congo, Groupe technique de référence en évaluation (TERG) du Fonds mondial. Évaluation prospective pays : rapport annuel pays 2019-2020. Kinshasa, RDC : Juin 2020.
68. Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Revue annuelle 2022 : Vers la couverture santé universelle. République Démocratique du Congo : Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de Santé (UG-PDSS) ; 2022.
69. Coordination Nationale de Renforcement du Système Communautaire (CNRSC). Rapport annuel des activités de suivi communautaire dans le cadre du contrôle citoyen dans la province Kinshasa et Kongo Central. République Démocratique du Congo : CNRSC ; 2023.
70. Coordination Nationale de Renforcement du Système Communautaire (CNRSC). Rapport annuel du suivi communautaire dans les zones de santé de la digitalisation Binza Ozone (Kinshasa) et Boma (Kongo Central). République Démocratique du Congo : CNRSC ; 2024.
71. UNICEF. Rapport de la revue nationale de mise en œuvre de l'initiative communauté amie des enfants et monitorage en temps réel (CFC-RTM). 2022.
72. Bureau d'études AMD International. Rapport final d'évaluation : Approche communautaire pour améliorer les services de base pour les enfants en RDC. République Démocratique du Congo : UNICEF, SANRU et Ministère de la Santé Publique ; Janvier 2023.
73. République Démocratique du Congo, Secrétariat Général de la Santé, Direction Générale d'Organisation et de Gestion des Services et Soins de Santé. Évaluation du plan stratégique national de la santé communautaire 2019-2022 en République Démocratique du Congo. Kinshasa : Août 2024.
74. Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Aide d'urgence : Urgence République Démocratique du Congo. Disponible à : https://www.unhcr.org/be/aide-durgence/urgence-republique-democratique-du-congo. Consulté le 01-12-2024.
75. Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). La crise humanitaire alarmante dans l'est de la RDC exige des mesures urgentes. Disponible à : https://www.iom.int/fr/news/la-crise-humanitaire-alarmante-dans-lest-de-la-rdc-exige-des-mesures-urgentes-pour-proteger-les-populations-vulnerables. Consulté le 01-12-2024.
76. Ministère du Genre, Famille et Enfant, EU, ONU Femmes, Groupe de la Banque Africaine de Développement. Profil genre pays de la RDC : Rapport de mission. Avril 2022.
77. UNFPA RDC. Mettre fin aux violences sexuelles et basées sur le genre. Disponible à : https://drc.unfpa.org/fr/topics/mettre-fin-aux-violences-sexuelles-et-basées-sur-le-genre. Consulté le 01-12-2024.
78. ReliefWeb. Bulletin d'information du GBV AoR, avril-juin 2024. Disponible à : https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/republique-democratique-du-

congo-bulletin-dinformation-du-gbv-aor-avril-juin-t2-2024-aout-2024. Consulté le 01-12-2024.
79. Protection Cluster. Mise à jour sur la situation de protection en RDC : recrudescence de violence, épidémies et transition. 2024.
80. RTN. RDC : 266 groupes armés actifs dans cinq provinces orientales. Disponible à : https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Monde/RDC-266-groupes-armes-actifs-dans-cinq-provinces-orientales.html. Consulté le 01-12-2024.
81. Banque Africaine de Développement. Perspectives économiques en République Démocratique du Congo. Disponible à : https://www.afdb.org/fr/pays-afrique-centrale-republique-democratique-du-congo/perspectives-economiques-en-republique-democratique-du-congo. Consulté le 01-12-2024.
82. Banque Mondiale. Changement climatique : La RDC doit renforcer ses institutions. Disponible à : https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2023/11/15/changement-climatique-afe-1123-la-r-publique-d-mocratique-du-congo-doit-renforcer-ses-institutions. Consulté le 11-12-2024.
83. Wilkinson R, Marmot M. Les déterminants sociaux de la santé : les faits. 2e éd. Genève : OMS ; 2004. pp. 8-11.
84. Assefa Y, et al. Successes and challenges of the Health Extension Program in Ethiopia: A review of the evidence. J Glob Health. 2019.
85. Devlin K, Egan KF, Pandit-Rajani T. Community Health Systems Catalog Country Profile: DRC. 2017. Disponible à : https://www.advancingpartners.org/sites/default/files/catalog/profiles/drc_chs_catalog_profile_0.pdf.
86. Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Surveillance à base communautaire : Principes directeurs. Genève ; 2017.

Annexes

Annexe 1 : Matériels et équipements pour ASC et RECO

Désignation	ASC	RECO
Sac à dos	X	
Thermomètre/Thermo flash	X	
Minuteur	X	
Caisse de conservation des médicaments	X	
Tensiomètre électronique	X	
Pèse-personne	X	
Dispositif de lavage de main	X	X
Kit assainissement (brouette, râteau, pelle, gants, raclette…)	X	X
Toise	X	
Ruban métrique	X	
MUAC	X	X
Boite à image intégrée	X	X
Chasuble/Gilet d'identification	X	X
Badge d'identification	X	X
Botte	X	X
Manteau imperméable	X	X
Aide-mémoire pour l'ASC	X	
Supports de collectes de données et de gestion des intrants	X	X
Stylo	X	X
Ciseaux, agrafeuse	X	X
Crayon de papier	X	X
Taille crayons	X	X
Gomme	X	X
Téléphone	X	X
Mégaphone	X	X
Piles alcalines (pairs de piles)	X	X
Lampe torche	X	X
Masque	X	X
Gel hydro alcoolique	X	X
Vélo, pirogue	X	X

Annexe 2 : Produits/Intrants pour ASC

Désignation
Savon
Eau de Javel
Comprimés chlorés pour eau (Aquatab)
Tests de diagnostic rapide (TDR)
Amoxicilline comprimé et sirop
Carbocystèine sirop
Paracétamol comprimé et sirop
Thérapie combinee a base d'artemisinime (ACT)
Artésunate suppositoire
Moustiquaires imprégnées d'insecticide a longue durée d'action
Sérum de réhydratation Orale (SRO)
Zinc
Chlorhexidine
Vitamine A
Mébendazole ou Albendazole
Plumpynut
Plumpy sup
Farines enrichies (CSB)

Désignation
Micronutriments en poudre (MNP)
Contraceptifs oraux combines (COC)
Pilules contraceptives d'urgence (PCU)
Pilules orales progestatives (POP)
Sayana Press
Collier du cycle
Préservatifs Masculin
Préservatifs Féminin
Sulfadoxine Pyriméthamine (SP)
Fer et acide folate
Ivermectine (Mectisan)

Annexe 3 : Estimation besoin en SSC et ASC, par ZS

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Besoin en SSC	Besoin en ASC
Bas Uele	Aketi	Rural	94	188
Bas Uele	Ango	Rural	96	192
Bas Uele	Bili	Rural	51	102
Bas Uele	Bondo	Rural	97	194
Bas Uele	Buta	Urbain	116	232
Bas Uele	Ganga	Rural	117	234
Bas Uele	Likati	Rural	90	180
Bas Uele	Monga	Rural	50	100
Bas Uele	Poko	Rural	179	358
Bas Uele	Titule	Rural	49	98
Bas Uele	Viadana	Rural	127	254
Total Bas Uele			**1 066**	**2 132**
Equateur	Basankusu	Rural	159	318
Equateur	Bikoro	Rural	80	160
Equateur	Bolenge	Urbano Rurale	28	56
Equateur	Bolomba	Rural	280	560
Equateur	Bomongo	Rural	109	218
Equateur	Djombo	Rural	49	98
Equateur	Iboko	Rural	76	152
Equateur	Ingende	Rural	141	282
Equateur	Irebu	Rural	32	64
Equateur	Lilanga Bobangi	Rural	42	84
Equateur	Lotumbe	Rural	118	236
Equateur	Lukolela	Rural	141	282
Equateur	Makanza	Rural	134	268
Equateur	Mampoko	Rural	123	246
Equateur	Mbandaka	Urbano Rurale	39	78
Equateur	Monieka	Rural	86	172
Equateur	Ntondo	Rural	66	132
Equateur	Wangata	Urbain	0	0
Total Equateur			**1 703**	**3 406**
Haut Katanga	Kafubu	Rural	161	322
Haut Katanga	Kamalondo	Urbain	0	0
Haut Katanga	Kambove	Urbano Rurale	73	146
Haut Katanga	Kampemba	Urbain	58	116
Haut Katanga	Kapolowe	Rural	125	250
Haut Katanga	Kasenga	Rural	169	338
Haut Katanga	Kashobwe	Rural	297	594
Haut Katanga	Katuba	Urbain	0	0
Haut Katanga	Kenya	Urbain	0	0
Haut Katanga	Kikula	Urbain	8	16
Haut Katanga	Kilela Balanda	Rural	68	136
Haut Katanga	Kilwa	Rural	358	716
Haut Katanga	Kipushi	Urbano Rurale	113	226
Haut Katanga	Kisanga	Urbain	53	106
Haut Katanga	Kowe	Urbain	0	0

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Besoin en SSC	Besoin en ASC
Haut Katanga	Likasi	Urbain	4	8
Haut Katanga	Lubumbashi	Urbain	26	52
Haut Katanga	Lukafu	Rural	90	180
Haut Katanga	Mitwaba	Urbain	90	180
Haut Katanga	Mufunga Sampwe	Rural	59	118
Haut Katanga	Mumbunda	Urbain	0	0
Haut Katanga	Panda	Urbain	48	96
Haut Katanga	Pweto	Rural	265	530
Haut Katanga	Ruashi	Urbain	0	0
Haut Katanga	Sakania	Rural	271	542
Haut Katanga	Tshamilemba	Urbain	0	0
Haut Katanga	Vangu	Urbain	0	0
Total Haut Katanga			**2 336**	**4 672**
Haut Lomami	Baka	Rural	0	0
Haut Lomami	Bukama	Rural	190	380
Haut Lomami	Butumba	Rural	110	220
Haut Lomami	Kabondo Dianda	Rural	116	232
Haut Lomami	Kabongo	Urbano Rurale	378	756
Haut Lomami	Kamina	Urbain	72	144
Haut Lomami	Kaniama	Rural	165	330
Haut Lomami	Kayamba	Rural	75	150
Haut Lomami	Kinda	Rural	20	40
Haut Lomami	Kinkondja	Rural	115	230
Haut Lomami	Kitenge	Rural	296	592
Haut Lomami	Lwamba	Rural	77	154
Haut Lomami	Malemba Nkulu	Rural	175	350
Haut Lomami	Mukanga	Rural	82	164
Haut Lomami	Mulongo	Rural	269	538
Haut Lomami	Songa	Rural	62	124
Total Haut Lomami			**2 202**	**4 404**
Haut Uele	Aba	Rural	141	282
Haut Uele	Boma Mangbetu	Rural	67	134
Haut Uele	Doruma	Rural	34	68
Haut Uele	Dungu	Rural	138	276
Haut Uele	Faradje	Rural	143	286
Haut Uele	Gombari	Rural	99	198
Haut Uele	Isiro	Urbano Rurale	99	198
Haut Uele	Makoro	Rural	216	432
Haut Uele	Niangara	Rural	153	306
Haut Uele	Pawa	Rural	67	134
Haut Uele	Rungu	Rural	88	176
Haut Uele	Wamba	Rural	118	236
Haut Uele	Watsa	Urbano Rurale	121	242
Total Haut Uele			**1 484**	**2 968**
Ituri	Adi	Rural	81	162
Ituri	Adja	Rural	48	96
Ituri	Angumu	Rural	15	30
Ituri	Ariwara	Rural	21	42
Ituri	Aru	Rural	52	104
Ituri	Aungba	Rural	105	210
Ituri	Bambu	Rural	62	124
Ituri	Biringi	Rural	116	232
Ituri	Boga	Rural	44	88
Ituri	Bunia	Urbano Rurale	0	0
Ituri	Damas	Rural	66	132
Ituri	Drodro	Rural	61	122
Ituri	Fataki	Rural	47	94
Ituri	Gety	Rural	51	102
Ituri	Jiba	Rural	28	56
Ituri	Kambala	Rural	70	140
Ituri	Kilo	Rural	14	28

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Besoin en SSC	Besoin en ASC
Ituri	Komanda	Rural	207	414
Ituri	Laybo	Rural	121	242
Ituri	Linga	Rural	34	68
Ituri	Lita	Rural	40	80
Ituri	Logo	Rural	6	12
Ituri	Lolwa	Rural	25	50
Ituri	Mahagi	Rural	35	70
Ituri	Mambasa	Rural	54	108
Ituri	Mandima	Rural	96	192
Ituri	Mangala	Rural	40	80
Ituri	Mongbwalu	Rural	40	80
Ituri	Nia Nia	Rural	18	36
Ituri	Nizi	Rural	18	36
Ituri	Nyankunde	Rural	35	70
Ituri	Nyarambe	Rural	19	38
Ituri	Rethy	Rural	66	132
Ituri	Rimba	Rural	7	14
Ituri	Rwampara	Urbano Rurale	49	98
Ituri	Tchomia	Rural	55	110
Total Ituri			**1 846**	**3 692**
Kongo Central	Boko Kivulu	Rural	96	192
Kongo Central	Boma Bungu	Rural	1	2
Kongo Central	Boma	Urbain	38	76
Kongo Central	Gombe Matadi	Rural	89	178
Kongo Central	Inga	Rural	52	104
Kongo Central	Kangu	Rural	48	96
Kongo Central	Kibunzi	Rural	42	84
Kongo Central	Kimpangu	Rural	76	152
Kongo Central	Kimpese	Rural	97	194
Kongo Central	Kimvula	Rural	86	172
Kongo Central	Kinkonzi	Rural	49	98
Kongo Central	Kisantu	Urbano Rurale	66	132
Kongo Central	Kitona	Urbano Rurale	3	6
Kongo Central	Kizu	Rural	2	4
Kongo Central	Kuimba	Rural	37	74
Kongo Central	Kwilu Ngongo	Urbano Rurale	47	94
Kongo Central	Lukula	Rural	65	130
Kongo Central	Luozi	Rural	94	188
Kongo Central	Mangembo	Rural	78	156
Kongo Central	Massa	Rural	35	70
Kongo Central	Matadi	Urbain	0	0
Kongo Central	Mbanza Ngungu	Urbano Rurale	21	42
Kongo Central	Muanda	Urbano Rurale	28	56
Kongo Central	Ngidinga	Rural	50	100
Kongo Central	Nselo	Rural	51	102
Kongo Central	Nsona Mpangu	Rural	69	138
Kongo Central	Nzanza	Urbain	1	2
Kongo Central	Seke Banza	Rural	95	190
Kongo Central	Sona Bata	Rural	131	262
Kongo Central	Tshela	Rural	20	40
Kongo Central	Vaku	Rural	60	120
Total Kongo Central			**1 627**	**3 254**
Kasai Oriental	Bibanga	Urbain	145	290
Kasai Oriental	Bipemba	Urbain	170	340
Kasai Oriental	Bonzola	Urbain	94	188
Kasai Oriental	Cilundu	Rural	134	268
Kasai Oriental	Citenge	Urbano Rurale	172	344
Kasai Oriental	Dibindi	Urbain	0	0
Kasai Oriental	Diulu	Urbain	0	0
Kasai Oriental	Kabeya Kamwanga	Rural	219	438
Kasai Oriental	Kansele	Urbain	0	0

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Besoin en SSC	Besoin en ASC
Kasai Oriental	Kasansa	Urbano Rurale	115	230
Kasai Oriental	Lubilanji	Urbain	0	0
Kasai Oriental	Lukelenge	Rural	0	0
Kasai Oriental	Miabi	Rural	29	58
Kasai Oriental	Mpokolo	Urbain	181	362
Kasai Oriental	Mukumbi	Rural	0	0
Kasai Oriental	Muya	Urbain	0	0
Kasai Oriental	Nzaba	Urbain	230	460
Kasai Oriental	Tshilenge	Rural	9	18
Kasai Oriental	Tshishimbi	Rural	108	216
Total Kasaï Oriental			**1 606**	**3 212**
Kwango	Boko	Rural	192	384
Kwango	Feshi	Rural	163	326
Kwango	Kahemba	Rural	215	430
Kwango	Kajiji	Rural	151	302
Kwango	Kasongo Lunda	Rural	111	222
Kwango	Kenge	Urbano Rurale	210	420
Kwango	Kimbao	Rural	185	370
Kwango	Kisanji	Rural	62	124
Kwango	Kitenda	Rural	87	174
Kwango	Mwela Lembwa	Rural	111	222
Kwango	Panzi	Rural	211	422
Kwango	Popokabaka	Rural	234	468
Kwango	Tembo	Rural	93	186
Kwango	Wamba Lwadi	Rural	71	142
Total Kwango			**2 096**	**4 192**
Kwilu	Bagata	Rural	43	86
Kwilu	Bandundu	Urbain	22	44
Kwilu	Bulungu	Rural	143	286
Kwilu	Djuma	Rural	63	126
Kwilu	Gungu	Rural	86	172
Kwilu	Idiofa	Rural	130	260
Kwilu	Ipamu	Rural	73	146
Kwilu	Kikongo	Rural	67	134
Kwilu	Kikwit Nord	Urbain	10	20
Kwilu	Kikwit Sud	Urbain	0	0
Kwilu	Kimputu	Rural	68	136
Kwilu	Kingandu	Rural	125	250
Kwilu	Koshibanda	Rural	144	288
Kwilu	Lusanga	Rural	213	426
Kwilu	Masi Manimba	Rural	118	236
Kwilu	Moanza	Rural	99	198
Kwilu	Mokala	Rural	81	162
Kwilu	Mosango	Rural	97	194
Kwilu	Mukedi	Rural	127	254
Kwilu	Mungindu	Rural	76	152
Kwilu	Pay Kongila	Rural	145	290
Kwilu	Sia	Rural	25	50
Kwilu	Vanga	Rural	86	172
Kwilu	Yasa Bonga	Rural	107	214
Total Kwilu			**2 148**	**4 296**
Kinshasa	Bandalungwa	Urbain	0	0
Kinshasa	Barumbu	Urbain	0	0
Kinshasa	Binza Meteo	Urbain	0	0
Kinshasa	Binza Ozone	Urbain	0	0
Kinshasa	Biyela	Urbain	0	0
Kinshasa	Bumbu	Urbain	0	0
Kinshasa	Gombe	Urbain	0	0
Kinshasa	Kalamu 1	Urbain	0	0
Kinshasa	Kalamu 2	Urbain	0	0
Kinshasa	Kasa Vubu	Urbain	0	0

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Besoin en SSC	Besoin en ASC
Kinshasa	Kikimi	Urbain	0	0
Kinshasa	Kimbanseke	Urbain	0	0
Kinshasa	Kingabwa	Urbain	0	0
Kinshasa	Kingasani	Urbain	0	0
Kinshasa	Kinshasa	Urbain	0	0
Kinshasa	Kintambo	Urbain	0	0
Kinshasa	Kisenso	Urbain	0	0
Kinshasa	Kokolo	Urbain	0	0
Kinshasa	Lemba	Urbain	0	0
Kinshasa	Limete	Urbain	0	0
Kinshasa	Lingwala	Urbain	0	0
Kinshasa	Makala	Urbain	0	0
Kinshasa	Maluku 1	Urbano Rurale	123	246
Kinshasa	Maluku 2	Urbano Rurale	118	236
Kinshasa	Masina 1	Urbain	0	0
Kinshasa	Masina 2	Urbain	0	0
Kinshasa	Matete	Urbain	0	0
Kinshasa	Mont Ngafula 1	Urbano Rurale	29	58
Kinshasa	Mont Ngafula 2	Urbano Rurale	7	14
Kinshasa	Ndjili	Urbain	0	0
Kinshasa	Ngaba	Urbain	0	0
Kinshasa	Ngiri Ngiri	Urbain	0	0
Kinshasa	Nsele	Urbano Rurale	34	68
Kinshasa	Police	Urbain	0	0
Kinshasa	Selembao	Urbain	0	0
Total Kinshasa			**311**	**622**
Kasai Central	Bena Leka	Rural	244	488
Kasai Central	Bena Tshadi	Rural	24	48
Kasai Central	Bilomba	Rural	94	188
Kasai Central	Bobozo	Rural	26	52
Kasai Central	Bunkonde	Rural	78	156
Kasai Central	Demba	Rural	293	586
Kasai Central	Dibaya	Rural	74	148
Kasai Central	Kalomba	Urbain	58	116
Kasai Central	Kananga	Urbain	74	148
Kasai Central	Katende	Rural	92	184
Kasai Central	Katoka	Urbain	31	62
Kasai Central	Luambo	Rural	312	624
Kasai Central	Lubondaie	Rural	116	232
Kasai Central	Lubunga	Rural	184	368
Kasai Central	Luiza	Rural	151	302
Kasai Central	Lukonga	Urbain	180	360
Kasai Central	Masuika	Rural	126	252
Kasai Central	Mikalayi	Rural	243	486
Kasai Central	Muetshi	Rural	28	56
Kasai Central	Mutoto	Rural	285	570
Kasai Central	Ndekesha	Rural	131	262
Kasai Central	Ndesha	Urbain	70	140
Kasai Central	Tshibala	Rural	252	504
Kasai Central	Tshikaji	Urbain	165	330
Kasai Central	Tshikula	Rural	110	220
Kasai Central	Yangala	Rural	130	260
Total Kasaï Central			**3 571**	**7 142**
Kasai	Banga Lubaka	Rural	152	304
Kasai	Bulape	Rural	100	200
Kasai	Dekese	Rural	100	200
Kasai	Ilebo	Rural	51	102
Kasai	Kakenge	Rural	156	312
Kasai	Kalonda Ouest	Rural	240	480
Kasai	Kamonia	Rural	241	482
Kasai	Kamwesha	Rural	451	902

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Besoin en SSC	Besoin en ASC
Kasai	Kanzala	Urbain	125	250
Kasai	Kitangwa	Rural	130	260
Kasai	Luebo	Rural	521	1 042
Kasai	Mikope	Rural	207	414
Kasai	Mushenge	Rural	213	426
Kasai	Mutena	Rural	243	486
Kasai	Mweka	Rural	36	72
Kasai	Ndjoko Mpunda	Rural	120	240
Kasai	Nyanga	Rural	80	160
Kasai	Tshikapa	Rural	143	286
Total Kasaï			**3 309**	**6 618**
Lualaba	Bunkeya	Rural	27	54
Lualaba	Dilala	Urbain	22	44
Lualaba	Dilolo	Rural	159	318
Lualaba	Fungurume	Rural	252	504
Lualaba	Kafakumba	Rural	93	186
Lualaba	Kalamba	Rural	155	310
Lualaba	Kanzenze	Rural	60	120
Lualaba	Kapanga	Rural	80	160
Lualaba	Kasaji	Rural	530	1 060
Lualaba	Lualaba	Rural	105	210
Lualaba	Lubudi	Rural	89	178
Lualaba	Manika	Urbain	0	0
Lualaba	Mutshatsha	Rural	25	50
Lualaba	Sandoa	Rural	166	332
Total Lualaba			**1 763**	**3 526**
Lomami	Kabinda	Urbain	42	84
Lomami	Kalambayi Kabanga	Rural	0	0
Lomami	Kalenda	Rural	8	16
Lomami	Kalonda Est	Rural	0	0
Lomami	Kamana	Rural	16	32
Lomami	Kamiji	Rural	101	202
Lomami	Kanda Kanda	Rural	91	182
Lomami	Lubao	Rural	200	400
Lomami	Ludimbi Lukula	Rural	0	0
Lomami	Luputa	Rural	186	372
Lomami	Makota	Urbain	0	0
Lomami	Mulumba	Rural	526	1 052
Lomami	Mweneditu	Urbain	59	118
Lomami	Ngandajika	Urbano Rurale	0	0
Lomami	Tshofa	Rural	0	0
Lomami	Wikong	Rural	60	120
Total Lomami			**1 289**	**2 578**
Mai Ndombe	Banzow Moke	Rural	81	162
Mai Ndombe	Bokoro	Rural	63	126
Mai Ndombe	Bolobo	Rural	40	80
Mai Ndombe	Bosobe	Rural	21	42
Mai Ndombe	Inongo	Urbano Rurale	116	232
Mai Ndombe	Kiri	Rural	106	212
Mai Ndombe	Kwamouth	Rural	182	364
Mai Ndombe	Mimia	Rural	48	96
Mai Ndombe	Mushie	Rural	62	124
Mai Ndombe	Nioki	Rural	29	58
Mai Ndombe	Ntandembelo	Rural	42	84
Mai Ndombe	Oshwe	Rural	118	236
Mai Ndombe	Pendjwa	Rural	49	98
Mai Ndombe	Yumbi	Rural	30	60
Total Mai Ndombe			**987**	**1 974**
Mongala	Binga	Rural	147	294
Mongala	Bongandanga	Rural	63	126
Mongala	Boso Manzi	Rural	123	246

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Besoin en SSC	Besoin en ASC
Mongala	Boso Mondanda	Rural	156	312
Mongala	Bosondjo	Rural	92	184
Mongala	Bumba	Urbano Rurale	36	72
Mongala	Lisala	Urbano Rurale	128	256
Mongala	Lolo	Rural	69	138
Mongala	Pimu	Rural	146	292
Mongala	Yamaluka	Rural	170	340
Mongala	Yambuku	Rural	112	224
Mongala	Yamongili	Rural	33	66
Total Mongala			**1 275**	**2 550**
Maniema	Alunguli	Rural	1	2
Maniema	Ferekeni	Rural	35	70
Maniema	Kabambare	Rural	80	160
Maniema	Kailo	Rural	92	184
Maniema	Kalima	Rural	35	70
Maniema	Kampene	Rural	45	90
Maniema	Kasongo	Rural	78	156
Maniema	Kibombo	Rural	55	110
Maniema	Kindu	Urbain	3	6
Maniema	Kunda	Rural	90	180
Maniema	Lubutu	Rural	44	88
Maniema	Lusangi	Rural	55	110
Maniema	Obokote	Rural	24	48
Maniema	Pangi	Rural	25	50
Maniema	Punia	Rural	57	114
Maniema	Samba	Rural	58	116
Maniema	Saramabila	Rural	76	152
Maniema	Tunda	Rural	80	160
Total Maniema			**933**	**1 866**
Nord Kivu	Alimbongo	Rural	139	278
Nord Kivu	Bambo	Rural	35	70
Nord Kivu	Beni	Urbain	27	54
Nord Kivu	Biena	Rural	91	182
Nord Kivu	Binza	Rural	53	106
Nord Kivu	Birambizo	Rural	37	74
Nord Kivu	Butembo	Urbain	0	0
Nord Kivu	Goma	Urbain	0	0
Nord Kivu	Itebero	Rural	69	138
Nord Kivu	Kalunguta	Rural	22	44
Nord Kivu	Kamango	Rural	22	44
Nord Kivu	Karisimbi	Urbain	0	0
Nord Kivu	Katoyi	Rural	104	208
Nord Kivu	Katwa	Urbano Rurale	0	0
Nord Kivu	Kayna	Rural	95	190
Nord Kivu	Kibirizi	Rural	53	106
Nord Kivu	Kibua	Rural	81	162
Nord Kivu	Kirotshe	Rural	123	246
Nord Kivu	Kyondo	Rural	46	92
Nord Kivu	Lubero	Rural	111	222
Nord Kivu	Mabalako	Rural	35	70
Nord Kivu	Manguredjipa	Rural	75	150
Nord Kivu	Masereka	Rural	53	106
Nord Kivu	Masisi	Rural	140	280
Nord Kivu	Musienene	Rural	102	204
Nord Kivu	Mutwanga	Rural	40	80
Nord Kivu	Mweso	Rural	136	272
Nord Kivu	Nyiragongo	Urbano Rurale	2	4
Nord Kivu	Oicha	Rural	11	22
Nord Kivu	Pinga	Rural	93	186
Nord Kivu	Rutshuru	Rural	19	38
Nord Kivu	Rwanguba	Rural	37	74

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Besoin en SSC	Besoin en ASC
Nord Kivu	Vuhovi	Rural	3	6
Nord Kivu	Walikale	Rural	116	232
Total Nord Kivu			**1 970**	**3 940**
Nord Ubangi	Abuzi	Rural	17	34
Nord Ubangi	Bili	Rural	119	238
Nord Ubangi	Bosobolo	Rural	123	246
Nord Ubangi	Businga	Rural	81	162
Nord Ubangi	Gbadolite	Urbano Rurale	42	84
Nord Ubangi	Karawa	Rural	286	572
Nord Ubangi	Loko	Rural	126	252
Nord Ubangi	Mobayi Mbongo	Rural	121	242
Nord Ubangi	Wapinda	Rural	13	26
Nord Ubangi	Wasolo	Rural	56	112
Nord Ubangi	Yakoma	Rural	29	58
Total Nord Ubangi			**1 013**	**2 026**
Sud Kivu	Bagira	Urbain	51	102
Sud Kivu	Bunyakiri	Rural	193	386
Sud Kivu	Fizi	Rural	191	382
Sud Kivu	Haut Plateau	Rural	242	484
Sud Kivu	Ibanda	Urbain	344	688
Sud Kivu	Idjwi	Rural	382	764
Sud Kivu	Itombwe	Rural	114	228
Sud Kivu	Kabare	Rural	455	910
Sud Kivu	Kadutu	Urbain	39	78
Sud Kivu	Kalehe	Rural	75	150
Sud Kivu	Kalole	Rural	82	164
Sud Kivu	Kalonge	Rural	110	220
Sud Kivu	Kamituga	Rural	77	154
Sud Kivu	Kaniola	Rural	165	330
Sud Kivu	Katana	Rural	123	246
Sud Kivu	Kaziba	Rural	95	190
Sud Kivu	Kimbi Lulenge	Rural	122	244
Sud Kivu	Kitutu	Rural	89	178
Sud Kivu	Lemera	Rural	86	172
Sud Kivu	Lulingu	Rural	157	314
Sud Kivu	Minembwe	Rural	58	116
Sud Kivu	Minova	Rural	143	286
Sud Kivu	Miti Murhesa	Rural	49	98
Sud Kivu	Mubumbano	Rural	0	0
Sud Kivu	Mulungu	Rural	231	462
Sud Kivu	Mwana	Rural	279	558
Sud Kivu	Mwenga	Rural	112	224
Sud Kivu	Nundu	Rural	100	200
Sud Kivu	Nyangezi	Rural	54	108
Sud Kivu	Nyantende	Rural	127	254
Sud Kivu	Ruzizi	Rural	0	0
Sud Kivu	Shabunda	Rural	206	412
Sud Kivu	Uvira	Rural	63	126
Sud Kivu	Walungu	Rural	46	92
Total Sud Kivu			**4 660**	**9 320**
Sankuru	Bena Dibele	Rural	68	136
Sankuru	Dikungu	Rural	43	86
Sankuru	Djalo Ndjeka	Rural	39	78
Sankuru	Katako Kombe	Rural	29	58
Sankuru	Kole	Rural	68	136
Sankuru	Lodja	Urbain	294	588
Sankuru	Lomela	Rural	63	126
Sankuru	Lusambo	Urbain	41	82
Sankuru	Minga	Rural	335	670
Sankuru	Omendjadi	Rural	120	240
Sankuru	Ototo	Rural	160	320

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Besoin en SSC	Besoin en ASC
Sankuru	Pania Mutombo	Rural	99	198
Sankuru	Tshudi Loto	Rural	48	96
Sankuru	Tshumbe	Rural	36	72
Sankuru	Vanga Kete	Rural	175	350
Sankuru	Wembo Nyama	Rural	47	94
Total Sankuru			**1 665**	**3 330**
Sud Ubangi	Bangabola	Rural	96	192
Sud Ubangi	Bogosenubea	Rural	238	476
Sud Ubangi	Bokonzi	Rural	189	378
Sud Ubangi	Bominenge	Rural	101	202
Sud Ubangi	Boto	Rural	85	170
Sud Ubangi	Budjala	Rural	117	234
Sud Ubangi	Bulu	Rural	72	144
Sud Ubangi	Bwamanda	Rural	193	386
Sud Ubangi	Gemena	Urbano Rurale	106	212
Sud Ubangi	Kungu	Rural	287	574
Sud Ubangi	Libenge	Rural	284	568
Sud Ubangi	Mawuya	Rural	132	264
Sud Ubangi	Mbaya	Rural	105	210
Sud Ubangi	Ndage	Rural	94	188
Sud Ubangi	Tandala	Rural	161	322
Sud Ubangi	Zongo	Urbano Rurale	34	68
Total Sud Ubangi			**2 294**	**4 588**
Tanganyika	Ankoro	Rural	156	312
Tanganyika	Kabalo	Rural	574	1 148
Tanganyika	Kalemie	Urbain	269	538
Tanganyika	Kansimba	Rural	143	286
Tanganyika	Kiambi	Rural	179	358
Tanganyika	Kongolo	Rural	594	1 188
Tanganyika	Manono	Rural	1	2
Tanganyika	Mbulula	Rural	4	8
Tanganyika	Moba	Rural	335	670
Tanganyika	Nyemba	Urbain	270	540
Tanganyika	Nyunzu	Rural	255	510
Total Tanganyika			**2 780**	**5 560**
Tshopo	Bafwagbogbo	Rural	65	130
Tshopo	Bafwasende	Rural	64	128
Tshopo	Banalia	Rural	101	202
Tshopo	Basali	Rural	27	54
Tshopo	Basoko	Rural	83	166
Tshopo	Bengamisa	Rural	81	162
Tshopo	Isangi	Rural	53	106
Tshopo	Kabondo	Urbano Rurale	14	28
Tshopo	Lowa	Rural	71	142
Tshopo	Lubunga	Urbano Rurale	46	92
Tshopo	Makiso Kisangani	Urbano Rurale	4	8
Tshopo	Mangobo	Urbain	0	0
Tshopo	Opala	Rural	155	310
Tshopo	Opienge	Rural	51	102
Tshopo	Tshopo	Urbano Rurale	38	76
Tshopo	Ubundu	Rural	85	170
Tshopo	Wanierukula	Rural	90	180
Tshopo	Yabaondo	Rural	81	162
Tshopo	Yahisuli	Rural	95	190
Tshopo	Yahuma	Rural	147	294
Tshopo	Yakusu	Rural	30	60
Tshopo	Yaleko	Rural	97	194
Tshopo	Yalimbongo	Rural	56	112
Total Tshopo			**1 534**	**3 068**
Tshuapa	Befale	Rural	111	222
Tshuapa	Boende	Urbano Rurale	206	412

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Besoin en SSC	Besoin en ASC
Tshuapa	Bokungu	Rural	134	268
Tshuapa	Busanga	Rural	54	108
Tshuapa	Djolu	Rural	152	304
Tshuapa	Ikela	Rural	109	218
Tshuapa	Lingomo	Rural	87	174
Tshuapa	Mompono	Rural	55	110
Tshuapa	Mondombe	Rural	174	348
Tshuapa	Monkoto	Rural	167	334
Tshuapa	Wema	Rural	109	218
Tshuapa	Yalifafu	Rural	80	160
Total Tshuapa			**1 438**	**2 876**
Total RDC			**48 906**	**97 812**

Annexe 4 : Projection démographique de 2025 à 2030, par ZS

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Population Totale					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bas Uele	Aketi	Rural	157 069	161 681	166 372	171 142	175 990	180 913
Bas Uele	Ango	Rural	179 413	184 682	190 041	195 489	201 026	206 650
Bas Uele	Bili	Rural	74 721	76 915	79 147	81 416	83 722	86 065
Bas Uele	Bondo	Rural	171 053	176 076	181 185	186 380	191 659	197 021
Bas Uele	Buta	Urbain	230 276	237 038	243 916	250 909	258 015	265 234
Bas Uele	Ganga	Rural	145 294	149 560	153 900	158 313	162 796	167 351
Bas Uele	Likati	Rural	87 466	90 035	92 647	95 303	98 003	100 745
Bas Uele	Monga	Rural	91 186	93 864	96 587	99 356	102 171	105 029
Bas Uele	Poko	Rural	142 326	146 505	150 756	155 078	159 471	163 932
Bas Uele	Titule	Rural	92 066	94 769	97 519	100 315	103 156	106 042
Bas Uele	Viadana	Rural	126 504	130 219	133 997	137 839	141 743	145 709
Total Bas Uele			**1 497 374**	**1 541 343**	**1 586 068**	**1 631 542**	**1 677 752**	**1 724 690**
Equateur	Basankusu	Rural	205 094	211 117	217 243	223 471	229 801	236 230
Equateur	Bikoro	Rural	128 799	132 582	136 429	140 340	144 315	148 352
Equateur	Bolenge	Urbano Rurale	90 583	93 243	95 949	98 700	101 495	104 335
Equateur	Bolomba	Rural	226 551	233 203	239 970	246 850	253 841	260 943
Equateur	Bomongo	Rural	91 281	93 961	96 688	99 460	102 277	105 138
Equateur	Djombo	Rural	76 149	78 385	80 660	82 972	85 322	87 709
Equateur	Iboko	Rural	97 201	100 055	102 958	105 910	108 910	111 957
Equateur	Ingende	Rural	125 471	129 155	132 903	136 714	140 586	144 519
Equateur	Irebu	Rural	43 139	44 406	45 694	47 004	48 336	49 688
Equateur	Lilanga Bobangi	Rural	68 810	70 830	72 885	74 975	77 098	79 255
Equateur	Lotumbe	Rural	100 602	103 556	106 561	109 616	112 721	115 874
Equateur	Lukolela	Rural	123 241	126 860	130 541	134 284	138 087	141 951
Equateur	Makanza	Rural	107 993	111 164	114 390	117 670	121 003	124 388
Equateur	Mampoko	Rural	93 153	95 888	98 671	101 500	104 374	107 294
Equateur	Mbandaka	Urbano Rurale	184 571	189 991	195 504	201 109	206 805	212 591
Equateur	Monieka	Rural	64 533	66 428	68 355	70 315	72 307	74 330
Equateur	Ntondo	Rural	57 299	58 982	60 693	62 433	64 202	65 998
Equateur	Wangata	Urbain	166 333	171 217	176 185	181 237	186 370	191 584
Total Equateur			**2 050 804**	**2 111 024**	**2 172 279**	**2 234 559**	**2 297 850**	**2 362 136**
Haut Katanga	Kafubu	Rural	157 601	162 228	166 936	171 722	176 586	181 526
Haut Katanga	Kamalondo	Urbain	32 250	33 197	34 161	35 140	36 135	37 146
Haut Katanga	Kambove	Urbano Rurale	170 217	175 215	180 299	185 468	190 721	196 057
Haut Katanga	Kampemba	Urbain	435 899	448 698	461 718	474 956	488 408	502 072
Haut Katanga	Kapolowe	Rural	287 579	296 024	304 613	313 347	322 222	331 236
Haut Katanga	Kasenga	Rural	167 970	172 902	177 920	183 021	188 204	193 470
Haut Katanga	Kashobwe	Rural	147 819	152 160	156 575	161 064	165 626	170 260

Haut Katanga	Katuba	Urbain	141 990	146 160	150 401	154 713	159 095	163 546
Haut Katanga	Kenya	Urbain	241 989	249 095	256 323	263 672	271 140	278 725
Haut Katanga	Kikula	Urbain	254 762	262 243	269 852	277 589	285 451	293 437
Haut Katanga	Kilela Balanda	Rural	69 316	71 351	73 422	75 527	77 666	79 839
Haut Katanga	Kilwa	Rural	434 660	447 423	460 406	473 606	487 021	500 646
Haut Katanga	Kipushi	Urbano Rurale	228 849	235 569	242 404	249 354	256 417	263 590
Haut Katanga	Kisanga	Urbain	485 660	499 921	514 427	529 176	544 164	559 388
Haut Katanga	Kowe	Urbain	56 758	58 425	60 120	61 844	63 595	65 374
Haut Katanga	Likasi	Urbain	223 244	229 800	236 468	243 247	250 137	257 135
Haut Katanga	Lubumbashi	Urbain	280 502	288 739	297 117	305 636	314 293	323 085
Haut Katanga	Lukafu	Rural	143 520	147 734	152 021	156 380	160 809	165 308
Haut Katanga	Mitwaba	Urbain	160 620	165 337	170 134	175 012	179 969	185 004
Haut Katanga	Mufunga Sampwe	Rural	189 980	195 558	201 233	207 002	212 865	218 821
Haut Katanga	Mumbunda	Urbain	330 303	340 002	349 868	359 899	370 093	380 447
Haut Katanga	Panda	Urbain	90 450	93 106	95 807	98 554	101 345	104 181
Haut Katanga	Pweto	Rural	305 188	314 149	323 265	332 533	341 952	351 518
Haut Katanga	Ruashi	Urbain	630 452	648 964	667 795	686 941	706 398	726 160
Haut Katanga	Sakania	Rural	386 597	397 949	409 496	421 237	433 168	445 286
Haut Katanga	Tshamilemba	Urbain	240 911	247 985	255 181	262 497	269 932	277 484
Haut Katanga	Vangu	Urbain	147 217	151 540	155 937	160 408	164 951	169 566
Total Haut Katanga			**6 442 303**	**6 631 475**	**6 823 901**	**7 019 544**	**7 218 362**	**7 420 307**
Haut Lomami	Baka	Rural	36 672	37 749	38 844	39 958	41 089	42 239
Haut Lomami	Bukama	Rural	375 240	386 258	397 466	408 862	420 442	432 205
Haut Lomami	Butumba	Rural	221 420	227 922	234 536	241 260	248 093	255 034
Haut Lomami	Kabondo Dianda	Rural	279 972	288 193	296 555	305 058	313 698	322 474
Haut Lomami	Kabongo	Urbano Rurale	408 891	420 898	433 111	445 529	458 147	470 965
Haut Lomami	Kamina	Urbain	332 260	342 017	351 941	362 031	372 285	382 700
Haut Lomami	Kaniama	Rural	325 440	334 996	344 717	354 600	364 644	374 845
Haut Lomami	Kayamba	Rural	113 188	116 512	119 893	123 330	126 823	130 371
Haut Lomami	Kinda	Rural	98 683	101 581	104 529	107 525	110 571	113 664
Haut Lomami	Kinkondja	Rural	304 700	313 647	322 748	332 001	341 405	350 956
Haut Lomami	Kitenge	Rural	308 760	317 826	327 049	336 425	345 954	355 632
Haut Lomami	Lwamba	Rural	151 731	156 187	160 719	165 327	170 009	174 765
Haut Lomami	Malemba Nkulu	Rural	380 455	391 627	402 991	414 544	426 286	438 212
Haut Lomami	Mukanga	Rural	226 365	233 012	239 773	246 647	253 633	260 729
Haut Lomami	Mulongo	Rural	345 133	355 268	365 577	376 058	386 709	397 528
Haut Lomami	Songa	Rural	216 655	223 017	229 489	236 068	242 754	249 546
Total Haut Lomami			**4 125 566**	**4 246 709**	**4 369 936**	**4 495 223**	**4 622 543**	**4 751 866**
Haut Uele	Aba	Rural	200 755	206 650	212 646	218 743	224 939	231 232
Haut Uele	Boma Mangbetu	Rural	140 016	144 127	148 309	152 562	156 883	161 272
Haut Uele	Doruma	Rural	88 662	91 266	93 914	96 607	99 343	102 122

Haut Uele	Dungu	Rural	176 592	181 778	187 052	192 415	197 865	203 401
Haut Uele	Faradje	Rural	157 907	162 544	167 260	172 056	176 929	181 879
Haut Uele	Gombari	Rural	143 385	147 595	151 878	156 232	160 657	165 152
Haut Uele	Isiro	Urbano Rurale	341 191	351 210	361 401	371 762	382 292	392 987
Haut Uele	Makoro	Rural	177 456	182 667	187 967	193 356	198 833	204 395
Haut Uele	Niangara	Rural	143 129	147 332	151 607	155 954	160 371	164 857
Haut Uele	Pawa	Rural	215 702	222 036	228 479	235 030	241 686	248 448
Haut Uele	Rungu	Rural	145 522	149 795	154 142	158 561	163 052	167 614
Haut Uele	Wamba	Rural	167 966	172 898	177 915	183 016	188 199	193 465
Haut Uele	Watsa	Urbano Rurale	352 619	362 973	373 505	384 214	395 096	406 150
Total Haut Uele			**2 450 902**	**2 522 870**	**2 596 077**	**2 670 507**	**2 746 145**	**2 822 973**
Ituri	Adi	Rural	141 444	145 598	149 822	154 118	158 483	162 917
Ituri	Adja	Rural	112 907	116 223	119 595	123 024	126 508	130 048
Ituri	Angumu	Rural	147 920	152 263	156 681	161 173	165 738	170 375
Ituri	Ariwara	Rural	181 903	187 244	192 677	198 202	203 815	209 517
Ituri	Aru	Rural	159 271	163 948	168 705	173 542	178 457	183 450
Ituri	Aungba	Rural	146 718	151 026	155 409	159 864	164 392	168 991
Ituri	Bambu	Rural	126 173	129 878	133 646	137 478	141 372	145 327
Ituri	Biringi	Rural	109 580	112 798	116 071	119 399	122 780	126 215
Ituri	Boga	Rural	58 022	59 725	61 458	63 220	65 011	66 830
Ituri	Bunia	Urbano Rurale	283 948	292 285	300 767	309 390	318 153	327 054
Ituri	Damas	Rural	97 656	100 523	103 440	106 406	109 420	112 481
Ituri	Drodro	Rural	130 449	134 279	138 176	142 137	146 163	150 252
Ituri	Fataki	Rural	110 522	113 767	117 068	120 425	123 836	127 300
Ituri	Gety	Rural	166 011	170 886	175 845	180 886	186 009	191 213
Ituri	Jiba	Rural	84 189	86 661	89 176	91 732	94 330	96 969
Ituri	Kambala	Rural	114 889	118 263	121 695	125 184	128 729	132 331
Ituri	Kilo	Rural	43 093	44 359	45 646	46 954	48 284	49 635
Ituri	Komanda	Rural	206 131	212 184	218 341	224 601	230 962	237 424
Ituri	Laybo	Rural	128 169	131 933	135 761	139 653	143 609	147 626
Ituri	Linga	Rural	118 474	121 952	125 491	129 089	132 745	136 459
Ituri	Lita	Rural	112 428	115 729	119 087	122 501	125 971	129 495
Ituri	Logo	Rural	205 070	211 092	217 217	223 444	229 773	236 201
Ituri	Lolwa	Rural	81 713	84 113	86 554	89 035	91 557	94 118
Ituri	Mahagi	Rural	166 757	171 654	176 635	181 699	186 845	192 072
Ituri	Mambasa	Rural	84 989	87 485	90 023	92 604	95 227	97 891
Ituri	Mandima	Rural	129 399	133 199	137 064	140 994	144 987	149 043
Ituri	Mangala	Rural	84 548	87 031	89 556	92 124	94 733	97 384
Ituri	Mongbwalu	Rural	116 094	119 503	122 971	126 496	130 079	133 718
Ituri	Nia Nia	Rural	87 556	90 127	92 742	95 401	98 103	100 848
Ituri	Nizi	Rural	169 015	173 978	179 027	184 159	189 375	194 673

Ituri	Nyankunde	Rural	83 269	85 714	88 202	90 730	93 300	95 910
Ituri	Nyarambe	Rural	185 557	191 006	196 548	202 183	207 910	213 726
Ituri	Rethy	Rural	175 603	180 759	186 004	191 337	196 757	202 261
Ituri	Rimba	Rural	185 401	190 845	196 383	202 013	207 735	213 546
Ituri	Rwampara	Urbano Rurale	172 173	177 229	182 372	187 600	192 914	198 311
Ituri	Tchomia	Rural	94 141	96 906	99 718	102 577	105 482	108 433
Total Ituri			**4 801 181**	**4 942 163**	**5 085 570**	**5 231 375**	**5 379 545**	**5 530 046**
Kongo Central	Boko Kivulu	Rural	379 976	391 133	402 483	414 022	425 749	437 660
Kongo Central	Boma Bungu	Rural	200 192	206 071	212 050	218 130	224 308	230 583
Kongo Central	Boma	Urbain	441 590	454 557	467 747	481 157	494 785	508 627
Kongo Central	Gombe Matadi	Rural	193 467	199 148	204 926	210 802	216 772	222 837
Kongo Central	Inga	Rural	180 236	185 529	190 912	196 386	201 948	207 598
Kongo Central	Kangu	Rural	206 849	212 923	219 101	225 383	231 767	238 251
Kongo Central	Kibunzi	Rural	136 090	140 086	144 151	148 284	152 484	156 750
Kongo Central	Kimpangu	Rural	238 581	245 587	252 713	259 959	267 322	274 800
Kongo Central	Kimpese	Rural	338 353	348 288	358 394	368 670	379 111	389 718
Kongo Central	Kimvula	Rural	163 314	168 110	172 988	177 948	182 988	188 107
Kongo Central	Kinkonzi	Rural	142 280	146 457	150 707	155 028	159 419	163 879
Kongo Central	Kisantu	Urbano Rurale	375 735	386 768	397 991	409 401	420 997	432 775
Kongo Central	Kitona	Urbano Rurale	198 755	204 591	210 527	216 563	222 697	228 927
Kongo Central	Kizu	Rural	128 383	132 153	135 988	139 887	143 849	147 873
Kongo Central	Kuimba	Rural	200 171	206 049	212 028	218 107	224 285	230 559
Kongo Central	Kwilu Ngongo	Urbano Rurale	275 081	283 159	291 375	299 729	308 219	316 841
Kongo Central	Lukula	Rural	330 415	340 117	349 987	360 021	370 218	380 575
Kongo Central	Luozi	Rural	204 609	210 617	216 729	222 943	229 257	235 671
Kongo Central	Mangembo	Rural	141 225	145 371	149 590	153 878	158 237	162 664
Kongo Central	Massa	Rural	209 385	215 533	221 787	228 146	234 608	241 172
Kongo Central	Matadi	Urbain	515 083	530 208	545 593	561 235	577 131	593 277
Kongo Central	Mbanza Ngungu	Urbano Rurale	272 337	280 334	288 469	296 739	305 144	313 681
Kongo Central	Muanda	Urbano Rurale	340 458	350 455	360 624	370 963	381 470	392 143
Kongo Central	Ngidinga	Rural	267 688	275 549	283 544	291 674	299 935	308 326
Kongo Central	Nselo	Rural	190 801	196 404	202 103	207 897	213 786	219 767
Kongo Central	Nsona Mpangu	Rural	212 720	218 966	225 320	231 780	238 345	245 013
Kongo Central	Nzanza	Urbain	313 804	323 018	332 391	341 921	351 605	361 442
Kongo Central	Seke Banza	Rural	293 529	302 148	310 916	319 830	328 889	338 090
Kongo Central	Sona Bata	Rural	206 705	212 775	218 949	225 226	231 605	238 085
Kongo Central	Tshela	Rural	172 377	177 439	182 588	187 823	193 142	198 546
Kongo Central	Vaku	Rural	154 440	158 975	163 588	168 278	173 045	177 886
Total Kongo Central			**7 624 630**	**7 848 519**	**8 076 261**	**8 307 809**	**8 543 115**	**8 782 122**
Kasai Oriental	Bibanga	Urbain	142 379	146 560	150 813	155 137	159 531	163 994
Kasai Oriental	Bipemba	Urbain	332 718	342 488	352 426	362 530	372 799	383 228

Kasai Oriental	Bonzola	Urbain	169 699	174 682	179 751	184 904	190 141	195 461
Kasai Oriental	Cilundu	Rural	173 036	178 117	183 286	188 541	193 881	199 305
Kasai Oriental	Citenge	Urbano Rurale	222 012	228 531	235 162	241 904	248 756	255 715
Kasai Oriental	Dibindi	Urbain	251 022	258 393	265 891	273 514	281 261	289 130
Kasai Oriental	Diulu	Urbain	346 352	356 522	366 867	377 386	388 074	398 931
Kasai Oriental	Kabeya Kamwanga	Rural	185 831	191 288	196 839	202 482	208 217	214 042
Kasai Oriental	Kansele	Urbain	237 613	244 590	251 688	258 904	266 237	273 685
Kasai Oriental	Kasansa	Urbano Rurale	192 099	197 739	203 477	209 311	215 239	221 261
Kasai Oriental	Lubilanji	Urbain	238 905	245 920	253 056	260 311	267 684	275 173
Kasai Oriental	Lukelenge	Rural	256 531	264 064	271 726	279 517	287 434	295 475
Kasai Oriental	Miabi	Rural	145 808	150 089	154 445	158 873	163 372	167 943
Kasai Oriental	Mpokolo	Urbain	260 284	267 927	275 702	283 606	291 639	299 798
Kasai Oriental	Mukumbi	Rural	137 460	141 497	145 603	149 777	154 019	158 328
Kasai Oriental	Muya	Urbain	309 901	319 001	328 257	337 668	347 232	356 947
Kasai Oriental	Nzaba	Urbain	272 656	280 662	288 806	297 086	305 500	314 047
Kasai Oriental	Tshilenge	Rural	270 826	278 779	286 868	295 093	303 451	311 940
Kasai Oriental	Tshishimbi	Rural	168 503	173 451	178 484	183 602	188 802	194 084
Total Kasai Orienatal			**4 313 636**	**4 440 301**	**4 569 146**	**4 700 145**	**4 833 269**	**4 968 487**
Kwango	Boko	Rural	256 491	264 022	271 683	279 473	287 388	295 428
Kwango	Feshi	Rural	176 230	181 404	186 668	192 020	197 459	202 983
Kwango	Kahemba	Rural	318 979	328 345	337 873	347 560	357 404	367 403
Kwango	Kajiji	Rural	185 578	191 027	196 570	202 206	207 933	213 751
Kwango	Kasongo Lunda	Rural	198 646	204 479	210 412	216 445	222 575	228 802
Kwango	Kenge	Urbano Rurale	334 691	344 518	354 515	364 679	375 008	385 500
Kwango	Kimbao	Rural	238 093	245 084	252 196	259 426	266 774	274 238
Kwango	Kisanji	Rural	143 154	147 357	151 633	155 981	160 399	164 886
Kwango	Kitenda	Rural	187 993	193 513	199 128	204 837	210 639	216 532
Kwango	Mwela Lembwa	Rural	118 519	121 999	125 539	129 138	132 796	136 511
Kwango	Panzi	Rural	211 523	217 734	224 052	230 476	237 004	243 634
Kwango	Popokabaka	Rural	265 560	273 357	281 290	289 354	297 550	305 874
Kwango	Tembo	Rural	122 666	126 268	129 932	133 657	137 442	141 288
Kwango	Wamba Lwadi	Rural	136 005	139 998	144 061	148 191	152 388	156 652
Total Kwango			**2 894 125**	**2 979 108**	**3 065 553**	**3 153 443**	**3 242 760**	**3 333 481**
Kwilu	Bagata	Rural	266 360	274 182	282 138	290 227	298 447	306 797
Kwilu	Bandundu	Urbain	313 159	322 355	331 708	341 219	350 883	360 700
Kwilu	Bulungu	Rural	414 433	426 602	438 981	451 567	464 357	477 348
Kwilu	Djuma	Rural	326 390	335 974	345 723	355 635	365 708	375 939
Kwilu	Gungu	Rural	375 150	386 166	397 371	408 764	420 341	432 101
Kwilu	Idiofa	Rural	431 862	444 543	457 443	470 558	483 886	497 423
Kwilu	Ipamu	Rural	306 561	315 563	324 720	334 030	343 491	353 100
Kwilu	Kikongo	Rural	281 876	290 153	298 573	307 133	315 832	324 668

Kwilu	Kikwit Nord	Urbain	358 320	368 842	379 545	390 427	401 485	412 717
Kwilu	Kikwit Sud	Urbain	384 698	395 995	407 485	419 168	431 040	443 099
Kwilu	Kimputu	Rural	296 460	305 166	314 021	323 024	332 173	341 466
Kwilu	Kingandu	Rural	162 919	167 703	172 569	177 517	182 544	187 651
Kwilu	Koshibanda	Rural	308 099	317 146	326 349	335 705	345 214	354 872
Kwilu	Lusanga	Rural	410 480	422 533	434 793	447 259	459 927	472 794
Kwilu	Masi Manimba	Rural	358 345	368 867	379 571	390 453	401 512	412 745
Kwilu	Moanza	Rural	260 877	268 538	276 330	284 252	292 303	300 481
Kwilu	Mokala	Rural	326 597	336 187	345 943	355 861	365 940	376 178
Kwilu	Mosango	Rural	182 672	188 036	193 493	199 040	204 678	210 404
Kwilu	Mukedi	Rural	267 380	275 232	283 218	291 338	299 590	307 971
Kwilu	Mungindu	Rural	192 850	198 513	204 273	210 129	216 081	222 126
Kwilu	Pay Kongila	Rural	225 763	232 392	239 136	245 992	252 959	260 036
Kwilu	Sia	Rural	166 040	170 915	175 875	180 917	186 041	191 246
Kwilu	Vanga	Rural	433 139	445 857	458 795	471 949	485 316	498 893
Kwilu	Yasa Bonga	Rural	339 410	349 376	359 514	369 821	380 296	390 935
Total Kwilu			**7 389 842**	**7 606 837**	**7 827 565**	**8 051 984**	**8 280 043**	**8 511 691**
Kinshasa	Bandalungwa	Urbain	278 635	286 817	295 140	303 602	312 201	320 935
Kinshasa	Barumbu	Urbain	302 980	311 877	320 927	330 128	339 478	348 976
Kinshasa	Binza Meteo	Urbain	886 904	912 947	939 438	966 372	993 743	1 021 545
Kinshasa	Binza Ozone	Urbain	629 325	647 804	666 602	685 713	705 135	724 863
Kinshasa	Biyela	Urbain	418 439	430 727	443 225	455 932	468 846	481 963
Kinshasa	Bumbu	Urbain	628 027	646 469	665 227	684 299	703 681	723 368
Kinshasa	Gombe	Urbain	177 246	182 451	187 745	193 128	198 598	204 154
Kinshasa	Kalamu 1	Urbain	453 870	467 197	480 754	494 537	508 544	522 772
Kinshasa	Kalamu 2	Urbain	383 169	394 421	405 866	417 502	429 327	441 338
Kinshasa	Kasa Vubu	Urbain	268 967	276 865	284 899	293 067	301 368	309 799
Kinshasa	Kikimi	Urbain	519 609	534 867	550 387	566 167	582 203	598 491
Kinshasa	Kimbanseke	Urbain	518 428	533 651	549 136	564 880	580 879	597 130
Kinshasa	Kingabwa	Urbain	451 003	464 246	477 717	491 414	505 332	519 470
Kinshasa	Kingasani	Urbain	439 435	452 339	465 465	478 810	492 371	506 146
Kinshasa	Kinshasa	Urbain	365 164	375 886	386 794	397 883	409 152	420 599
Kinshasa	Kintambo	Urbain	154 288	158 818	163 427	168 112	172 874	177 710
Kinshasa	Kisenso	Urbain	707 702	728 483	749 622	771 114	792 954	815 138
Kinshasa	Kokolo	Urbain	667 306	686 900	706 832	727 097	747 691	768 609
Kinshasa	Lemba	Urbain	401 103	412 880	424 861	437 042	449 421	461 994
Kinshasa	Limete	Urbain	495 963	510 526	525 340	540 402	555 708	571 255
Kinshasa	Lingwala	Urbain	170 744	175 757	180 857	186 043	191 312	196 664
Kinshasa	Makala	Urbain	599 432	617 034	634 939	653 143	671 642	690 432
Kinshasa	Maluku 1	Urbano Rurale	413 717	425 865	438 223	450 787	463 555	476 523
Kinshasa	Maluku 2	Urbano Rurale	162 177	166 939	171 784	176 709	181 714	186 797

Kinshasa	Masina 1	Urbain	1 002 580	1 032 019	1 061 965	1 092 412	1 123 353	1 154 781
Kinshasa	Masina 2	Urbain	592 087	609 473	627 158	645 139	663 412	681 972
Kinshasa	Matete	Urbain	520 563	535 849	551 398	567 206	583 272	599 590
Kinshasa	Mont Ngafula 1	Urbano Rurale	569 714	586 443	603 460	620 761	638 343	656 202
Kinshasa	Mont Ngafula 2	Urbano Rurale	384 911	396 214	407 711	419 400	431 279	443 344
Kinshasa	Ndjili	Urbain	601 086	618 737	636 691	654 945	673 495	692 337
Kinshasa	Ngaba	Urbain	340 418	350 414	360 583	370 921	381 426	392 097
Kinshasa	Ngiri Ngiri	Urbain	497 438	512 044	526 902	542 009	557 360	572 953
Kinshasa	Nsele	Urbano Rurale	719 947	741 087	762 591	784 455	806 674	829 242
Kinshasa	Police	Urbain	242 842	249 973	257 226	264 601	272 095	279 708
Kinshasa	Selembao	Urbain	704 748	725 442	746 492	767 894	789 644	811 735
Total Kinshasa			**16 669 969**	**17 159 465**	**17 657 383**	**18 163 625**	**18 678 081**	**19 200 630**
Kasai Central	Bena Leka	Rural	290 634	299 169	307 850	316 676	325 645	334 755
Kasai Central	Bena Tshadi	Rural	115 463	118 853	122 302	125 808	129 372	132 991
Kasai Central	Bilomba	Rural	92 449	95 164	97 925	100 733	103 586	106 484
Kasai Central	Bobozo	Rural	51 378	52 887	54 422	55 982	57 568	59 178
Kasai Central	Bunkonde	Rural	114 975	118 351	121 786	125 277	128 826	132 430
Kasai Central	Demba	Rural	341 394	351 419	361 616	371 984	382 520	393 221
Kasai Central	Dibaya	Rural	182 695	188 060	193 517	199 065	204 703	210 430
Kasai Central	Kalomba	Urbain	163 942	168 756	173 653	178 632	183 691	188 830
Kasai Central	Kananga	Urbain	286 958	295 385	303 956	312 670	321 526	330 521
Kasai Central	Katende	Rural	96 644	99 482	102 368	105 303	108 286	111 315
Kasai Central	Katoka	Urbain	136 266	140 268	144 338	148 476	152 681	156 953
Kasai Central	Luambo	Rural	275 753	283 850	292 086	300 460	308 970	317 614
Kasai Central	Lubondaie	Rural	152 032	156 496	161 037	165 654	170 346	175 112
Kasai Central	Lubunga	Rural	104 621	107 693	110 818	113 996	117 224	120 504
Kasai Central	Luiza	Rural	174 301	179 419	184 626	189 919	195 298	200 762
Kasai Central	Lukonga	Urbain	275 068	283 145	291 361	299 714	308 203	316 825
Kasai Central	Masuika	Rural	236 812	243 766	250 839	258 031	265 339	272 762
Kasai Central	Mikalayi	Rural	203 891	209 878	215 968	222 160	228 453	234 844
Kasai Central	Muetshi	Rural	115 461	118 852	122 300	125 807	129 370	132 989
Kasai Central	Mutoto	Rural	134 360	138 305	142 318	146 399	150 545	154 757
Kasai Central	Ndekesha	Rural	168 284	173 225	178 252	183 363	188 556	193 831
Kasai Central	Ndesha	Urbain	105 969	109 081	112 246	115 464	118 735	122 056
Kasai Central	Tshibala	Rural	246 648	253 890	261 258	268 748	276 360	284 091
Kasai Central	Tshikaji	Urbain	125 220	128 897	132 637	136 440	140 304	144 229
Kasai Central	Tshikula	Rural	134 821	138 780	142 807	146 901	151 062	155 288
Kasai Central	Yangala	Rural	157 697	162 327	167 038	171 827	176 693	181 636
Total Kasaï Central			**4 483 738**	**4 615 398**	**4 749 323**	**4 885 488**	**5 023 862**	**5 164 412**
Kasai	Banga Lubaka	Rural	141 600	145 758	149 988	154 288	158 658	163 097
Kasai	Bulape	Rural	153 920	158 440	163 037	167 712	172 462	177 287

Kasai	Dekese	Rural	155 946	160 525	165 183	169 919	174 732	179 620
Kasai	Ilebo	Rural	162 032	166 790	171 630	176 551	181 551	186 631
Kasai	Kakenge	Rural	166 027	170 902	175 861	180 903	186 027	191 232
Kasai	Kalonda Ouest	Rural	338 578	348 520	358 633	368 915	379 364	389 977
Kasai	Kamonia	Rural	337 245	347 148	357 221	367 462	377 870	388 442
Kasai	Kamwesha	Rural	373 218	384 177	395 324	406 658	418 176	429 876
Kasai	Kanzala	Urbain	212 257	218 490	224 830	231 276	237 827	244 480
Kasai	Kitangwa	Rural	225 400	232 018	238 751	245 596	252 552	259 618
Kasai	Luebo	Rural	224 368	230 956	237 658	244 472	251 396	258 429
Kasai	Mikope	Rural	164 204	169 026	173 930	178 917	183 985	189 132
Kasai	Mushenge	Rural	147 877	152 219	156 636	161 127	165 691	170 326
Kasai	Mutena	Rural	225 842	232 473	239 219	246 077	253 047	260 126
Kasai	Mweka	Rural	210 683	216 870	223 163	229 561	236 063	242 667
Kasai	Ndjoko Mpunda	Rural	134 769	138 727	142 752	146 845	151 004	155 229
Kasai	Nyanga	Rural	107 052	110 196	113 393	116 644	119 948	123 304
Kasai	Tshikapa	Rural	310 333	319 445	328 715	338 139	347 716	357 444
Total Kasaï			**3 791 352**	**3 902 681**	**4 015 925**	**4 131 063**	**4 248 069**	**4 366 915**
Lualaba	Bunkeya	Rural	75 628	77 849	80 108	82 405	84 739	87 110
Lualaba	Dilala	Urbain	327 859	337 486	347 279	357 236	367 354	377 631
Lualaba	Dilolo	Rural	248 109	255 395	262 806	270 340	277 997	285 775
Lualaba	Fungurume	Rural	442 212	455 197	468 405	481 834	495 482	509 344
Lualaba	Kafakumba	Rural	170 170	175 167	180 250	185 417	190 669	196 003
Lualaba	Kalamba	Rural	165 528	170 388	175 333	180 359	185 468	190 656
Lualaba	Kanzenze	Rural	290 458	298 987	307 663	316 483	325 447	334 552
Lualaba	Kapanga	Rural	205 220	211 246	217 376	223 608	229 941	236 374
Lualaba	Kasaji	Rural	356 353	366 817	377 461	388 283	399 280	410 451
Lualaba	Lualaba	Rural	230 022	236 776	243 647	250 632	257 731	264 941
Lualaba	Lubudi	Rural	153 982	158 504	163 103	167 779	172 531	177 358
Lualaba	Manika	Urbain	520 016	535 286	550 818	566 610	582 658	598 959
Lualaba	Mutshatsha	Rural	102 696	105 712	108 779	111 898	115 067	118 286
Lualaba	Sandoa	Rural	297 060	305 783	314 656	323 677	332 845	342 157
Total Lualaba			**3 585 313**	**3 690 592**	**3 797 682**	**3 906 563**	**4 017 210**	**4 129 598**
Lomami	Kabinda	Urbain	307 418	316 445	325 627	334 963	344 450	354 087
Lomami	Kalambayi Kabanga	Rural	181 024	186 339	191 746	197 244	202 830	208 505
Lomami	Kalenda	Rural	182 491	187 849	193 300	198 842	204 474	210 194
Lomami	Kalonda Est	Rural	210 057	216 225	222 499	228 878	235 361	241 945
Lomami	Kamana	Rural	180 043	185 330	190 708	196 175	201 732	207 375
Lomami	Kamiji	Rural	89 178	91 796	94 460	97 168	99 920	102 716
Lomami	Kanda Kanda	Rural	210 677	216 863	223 156	229 554	236 055	242 659
Lomami	Lubao	Rural	198 807	204 645	210 583	216 621	222 756	228 988
Lomami	Ludimbi Lukula	Rural	143 519	147 733	152 020	156 379	160 808	165 307

Lomami	Luputa	Rural	248 736	256 040	263 470	271 024	278 700	286 497
Lomami	Makota	Urbain	212 961	219 214	225 575	232 043	238 615	245 290
Lomami	Mulumba	Rural	286 319	294 727	303 279	311 974	320 810	329 785
Lomami	Mweneditu	Urbain	389 244	400 674	412 300	424 121	436 133	448 335
Lomami	Ngandajika	Urbano Rurale	279 074	287 269	295 605	304 080	312 692	321 440
Lomami	Tshofa	Rural	125 048	128 720	132 455	136 252	140 112	144 031
Lomami	Wikong	Rural	110 721	113 972	117 280	120 642	124 059	127 530
Total Lomami			**3 355 316**	**3 453 842**	**3 554 062**	**3 655 958**	**3 759 507**	**3 864 686**
Mai Ndombe	Banzow Moke	Rural	167 136	172 044	177 036	182 112	187 270	192 509
Mai Ndombe	Bokoro	Rural	290 895	299 437	308 126	316 960	325 937	335 056
Mai Ndombe	Bolobo	Rural	181 973	187 317	192 752	198 278	203 894	209 598
Mai Ndombe	Bosobe	Rural	169 191	174 159	179 213	184 351	189 572	194 876
Mai Ndombe	Inongo	Urbano Rurale	281 806	290 081	298 499	307 057	315 754	324 587
Mai Ndombe	Kiri	Rural	152 286	156 758	161 307	165 931	170 631	175 405
Mai Ndombe	Kwamouth	Rural	204 506	210 511	216 620	222 830	229 141	235 552
Mai Ndombe	Mimia	Rural	73 696	75 860	78 061	80 299	82 573	84 883
Mai Ndombe	Mushie	Rural	175 971	181 139	186 395	191 739	197 169	202 685
Mai Ndombe	Nioki	Rural	214 674	220 978	227 390	233 909	240 534	247 264
Mai Ndombe	Ntandembelo	Rural	115 053	118 431	121 868	125 362	128 912	132 519
Mai Ndombe	Oshwe	Rural	196 499	202 269	208 138	214 105	220 170	226 329
Mai Ndombe	Pendjwa	Rural	115 804	119 204	122 663	126 180	129 754	133 384
Mai Ndombe	Yumbi	Rural	154 536	159 074	163 690	168 383	173 152	177 996
Total Mai Ndombe			**2 494 027**	**2 567 261**	**2 641 756**	**2 717 496**	**2 794 464**	**2 872 644**
Mongala	Binga	Rural	253 202	260 637	268 200	275 889	283 703	291 640
Mongala	Bongandanga	Rural	148 722	153 090	157 532	162 048	166 638	171 300
Mongala	Boso Manzi	Rural	147 027	151 344	155 736	160 201	164 738	169 347
Mongala	Boso Mondanda	Rural	151 437	155 884	160 407	165 006	169 680	174 427
Mongala	Bosondjo	Rural	204 727	210 739	216 854	223 071	229 389	235 807
Mongala	Bumba	Urbano Rurale	222 380	228 910	235 553	242 306	249 169	256 140
Mongala	Lisala	Urbano Rurale	284 902	293 268	301 777	310 429	319 222	328 153
Mongala	Lolo	Rural	138 182	142 240	146 367	150 563	154 828	159 160
Mongala	Pimu	Rural	240 678	247 745	254 934	262 243	269 671	277 215
Mongala	Yamaluka	Rural	137 964	142 015	146 136	150 326	154 584	158 909
Mongala	Yambuku	Rural	269 480	277 394	285 443	293 626	301 943	310 390
Mongala	Yamongili	Rural	137 201	141 230	145 328	149 494	153 728	158 029
Total Mongala			**2 335 904**	**2 404 495**	**2 474 267**	**2 545 205**	**2 617 294**	**2 690 517**
Maniema	Alunguli	Rural	103 924	106 976	110 080	113 236	116 443	119 701
Maniema	Ferekeni	Rural	67 068	69 038	71 041	73 078	75 148	77 250
Maniema	Kabambare	Rural	174 997	180 135	185 362	190 677	196 077	201 563
Maniema	Kailo	Rural	208 689	214 817	221 050	227 387	233 828	240 370
Maniema	Kalima	Rural	175 840	181 004	186 256	191 596	197 022	202 534

Maniema	Kampene	Rural	193 124	198 795	204 563	210 428	216 388	222 442
Maniema	Kasongo	Rural	286 004	294 402	302 945	311 630	320 457	329 422
Maniema	Kibombo	Rural	128 506	132 279	136 118	140 020	143 986	148 014
Maniema	Kindu	Urbain	317 143	326 455	335 928	345 559	355 347	365 288
Maniema	Kunda	Rural	356 886	367 365	378 025	388 863	399 877	411 064
Maniema	Lubutu	Rural	163 084	167 872	172 744	177 696	182 729	187 841
Maniema	Lusangi	Rural	208 057	214 167	220 381	226 700	233 121	239 642
Maniema	Obokote	Rural	93 693	96 444	99 243	102 088	104 979	107 916
Maniema	Pangi	Rural	112 386	115 686	119 043	122 456	125 925	129 448
Maniema	Punia	Rural	145 712	149 991	154 343	158 768	163 265	167 833
Maniema	Samba	Rural	150 327	154 741	159 231	163 797	168 436	173 148
Maniema	Saramabila	Rural	184 253	189 664	195 167	200 763	206 449	212 225
Maniema	Tunda	Rural	109 532	112 749	116 020	119 347	122 727	126 160
Total Maniema			**3 179 225**	**3 272 580**	**3 367 541**	**3 464 089**	**3 562 204**	**3 661 862**
Nord Kivu	Alimbongo	Rural	251 313	258 693	266 199	273 831	281 587	289 465
Nord Kivu	Bambo	Rural	178 768	184 017	189 357	194 786	200 303	205 907
Nord Kivu	Beni	Urbain	448 078	461 236	474 619	488 227	502 055	516 101
Nord Kivu	Biena	Rural	139 231	143 319	147 478	151 706	156 003	160 368
Nord Kivu	Binza	Rural	184 715	190 139	195 656	201 266	206 966	212 756
Nord Kivu	Birambizo	Rural	202 447	208 392	214 439	220 587	226 835	233 181
Nord Kivu	Butembo	Urbain	225 425	232 045	238 778	245 624	252 581	259 647
Nord Kivu	Goma	Urbain	276 641	284 765	293 028	301 429	309 966	318 638
Nord Kivu	Itebero	Rural	199 886	205 755	211 726	217 796	223 965	230 231
Nord Kivu	Kalunguta	Rural	200 364	206 247	212 232	218 317	224 500	230 781
Nord Kivu	Kamango	Rural	123 472	127 097	130 785	134 535	138 345	142 216
Nord Kivu	Karisimbi	Urbain	558 467	574 866	591 547	608 507	625 742	643 248
Nord Kivu	Katoyi	Rural	321 642	331 087	340 694	350 462	360 388	370 471
Nord Kivu	Katwa	Urbano Rurale	464 233	477 865	491 731	505 829	520 156	534 708
Nord Kivu	Kayna	Rural	381 193	392 386	403 772	415 348	427 112	439 061
Nord Kivu	Kibirizi	Rural	362 241	372 878	383 698	394 699	405 878	417 233
Nord Kivu	Kibua	Rural	120 225	123 756	127 347	130 998	134 708	138 477
Nord Kivu	Kirotshe	Rural	436 749	449 573	462 619	475 882	489 361	503 051
Nord Kivu	Kyondo	Rural	194 821	200 542	206 361	212 278	218 290	224 397
Nord Kivu	Lubero	Rural	303 527	312 440	321 506	330 724	340 091	349 606
Nord Kivu	Mabalako	Rural	205 472	211 505	217 643	223 883	230 224	236 665
Nord Kivu	Manguredjipa	Rural	81 996	84 404	86 853	89 343	91 874	94 444
Nord Kivu	Masereka	Rural	159 701	164 390	169 161	174 010	178 939	183 945
Nord Kivu	Masisi	Rural	383 598	394 862	406 319	417 969	429 807	441 832
Nord Kivu	Musienene	Rural	270 763	278 714	286 801	295 024	303 380	311 868
Nord Kivu	Mutwanga	Rural	298 757	307 530	316 454	325 527	334 747	344 112
Nord Kivu	Mweso	Rural	440 082	453 005	466 150	479 514	493 096	506 891

Nord Kivu	Nyiragongo	Urbano Rurale	316 733	326 034	335 494	345 113	354 888	364 816
Nord Kivu	Oicha	Rural	299 986	308 794	317 755	326 865	336 123	345 526
Nord Kivu	Pinga	Rural	180 738	186 046	191 444	196 933	202 511	208 176
Nord Kivu	Rutshuru	Rural	277 229	285 369	293 650	302 069	310 625	319 315
Nord Kivu	Rwanguba	Rural	283 259	291 577	300 037	308 639	317 381	326 260
Nord Kivu	Vuhovi	Rural	127 284	131 022	134 824	138 689	142 617	146 607
Nord Kivu	Walikale	Rural	173 851	178 956	184 149	189 429	194 794	200 244
Total Nord Kivu			**9 072 890**	**9 339 306**	**9 610 306**	**9 885 836**	**10 165 837**	**10 450 242**
Nord Ubangi	Abuzi	Rural	89 797	92 434	95 116	97 843	100 615	103 429
Nord Ubangi	Bili	Rural	213 910	220 192	226 581	233 077	239 679	246 384
Nord Ubangi	Bosobolo	Rural	191 440	197 061	202 780	208 593	214 501	220 502
Nord Ubangi	Businga	Rural	139 664	143 765	147 937	152 178	156 488	160 866
Nord Ubangi	Gbadolite	Urbano Rurale	194 474	200 185	205 993	211 899	217 901	223 997
Nord Ubangi	Karawa	Rural	290 105	298 623	307 289	316 099	325 052	334 146
Nord Ubangi	Loko	Rural	142 243	146 420	150 668	154 988	159 378	163 837
Nord Ubangi	Mobayi Mbongo	Rural	152 385	156 859	161 411	166 039	170 741	175 518
Nord Ubangi	Wapinda	Rural	86 075	88 603	91 174	93 787	96 444	99 142
Nord Ubangi	Wasolo	Rural	87 070	89 626	92 227	94 871	97 558	100 288
Nord Ubangi	Yakoma	Rural	119 844	123 363	126 943	130 582	134 281	138 037
Total Nord Ubangi			**1 707 007**	**1 757 131**	**1 808 118**	**1 859 957**	**1 912 638**	**1 966 147**
Sud Kivu	Bagira	Urbain	146 659	150 966	155 346	159 800	164 326	168 923
Sud Kivu	Bunyakiri	Rural	271 465	279 437	287 545	295 789	304 167	312 676
Sud Kivu	Fizi	Rural	441 669	454 639	467 831	481 244	494 874	508 719
Sud Kivu	Haut Plateau	Rural	157 904	162 540	167 257	172 052	176 925	181 875
Sud Kivu	Ibanda	Urbain	466 447	480 144	494 076	508 241	522 636	537 258
Sud Kivu	Idjwi	Rural	300 098	308 910	317 873	326 987	336 248	345 655
Sud Kivu	Itombwe	Rural	105 925	109 036	112 200	115 417	118 686	122 006
Sud Kivu	Kabare	Rural	225 442	232 062	238 796	245 642	252 599	259 666
Sud Kivu	Kadutu	Urbain	388 384	399 788	411 389	423 184	435 170	447 344
Sud Kivu	Kalehe	Rural	188 696	194 237	199 873	205 603	211 427	217 342
Sud Kivu	Kalole	Rural	154 609	159 149	163 767	168 462	173 233	178 080
Sud Kivu	Kalonge	Rural	209 736	215 895	222 159	228 529	235 001	241 576
Sud Kivu	Kamituga	Rural	212 151	218 381	224 718	231 160	237 708	244 358
Sud Kivu	Kaniola	Rural	195 999	201 755	207 609	213 561	219 610	225 754
Sud Kivu	Katana	Rural	241 893	248 996	256 221	263 567	271 033	278 615
Sud Kivu	Kaziba	Rural	138 727	142 801	146 944	151 157	155 439	159 787
Sud Kivu	Kimbi Lulenge	Rural	386 671	398 025	409 575	421 318	433 251	445 372
Sud Kivu	Kitutu	Rural	195 027	200 754	206 579	212 502	218 521	224 634
Sud Kivu	Lemera	Rural	193 200	198 873	204 643	210 511	216 473	222 529
Sud Kivu	Lulingu	Rural	200 027	205 901	211 875	217 950	224 123	230 393
Sud Kivu	Minembwe	Rural	101 592	104 575	107 610	110 695	113 830	117 015

Sud Kivu	Minova	Rural	356 940	367 422	378 083	388 923	399 938	411 127
Sud Kivu	Miti Murhesa	Rural	275 598	283 691	291 923	300 293	308 798	317 437
Sud Kivu	Mubumbano	Rural	207 711	213 810	220 014	226 322	232 732	239 243
Sud Kivu	Mulungu	Rural	174 696	179 826	185 044	190 350	195 741	201 217
Sud Kivu	Mwana	Rural	148 318	152 673	157 103	161 607	166 184	170 834
Sud Kivu	Mwenga	Rural	153 449	157 955	162 538	167 198	171 934	176 744
Sud Kivu	Nundu	Rural	252 212	259 617	267 151	274 810	282 594	290 500
Sud Kivu	Nyangezi	Rural	185 309	190 750	196 285	201 913	207 632	213 440
Sud Kivu	Nyantende	Rural	152 533	157 012	161 568	166 201	170 908	175 689
Sud Kivu	Ruzizi	Rural	190 190	195 775	201 456	207 231	213 101	219 063
Sud Kivu	Shabunda	Rural	195 615	201 359	207 202	213 142	219 179	225 311
Sud Kivu	Uvira	Rural	361 211	371 817	382 606	393 576	404 723	416 046
Sud Kivu	Walungu	Rural	288 106	296 566	305 172	313 921	322 812	331 843
Total Sud Kivu			**7 864 210**	**8 095 134**	**8 330 032**	**8 568 856**	**8 811 555**	**9 058 073**
Sankuru	Bena Dibele	Rural	167 918	172 849	177 864	182 963	188 146	193 409
Sankuru	Dikungu	Rural	194 337	200 043	205 848	211 750	217 747	223 839
Sankuru	Djalo Ndjeka	Rural	120 765	124 311	127 918	131 586	135 313	139 098
Sankuru	Katako Kombe	Rural	177 491	182 703	188 004	193 395	198 872	204 436
Sankuru	Kole	Rural	174 900	180 036	185 260	190 572	195 969	201 452
Sankuru	Lodja	Urbain	438 963	451 852	464 964	478 294	491 841	505 601
Sankuru	Lomela	Rural	166 695	171 590	176 569	181 631	186 776	192 001
Sankuru	Lusambo	Urbain	176 748	181 938	187 218	192 585	198 040	203 580
Sankuru	Minga	Rural	204 518	210 524	216 632	222 843	229 155	235 566
Sankuru	Omendjadi	Rural	206 402	212 463	218 628	224 896	231 266	237 736
Sankuru	Ototo	Rural	186 558	192 036	197 609	203 274	209 031	214 879
Sankuru	Pania Mutombo	Rural	117 858	121 319	124 839	128 419	132 056	135 750
Sankuru	Tshudi Loto	Rural	106 264	109 384	112 559	115 786	119 065	122 396
Sankuru	Tshumbe	Rural	141 688	145 848	150 081	154 383	158 756	163 197
Sankuru	Vanga Kete	Rural	173 009	178 090	183 257	188 511	193 851	199 274
Sankuru	Wembo Nyama	Rural	141 208	145 354	149 572	153 860	158 218	162 645
Total Sankuru			**2 895 323**	**2 980 341**	**3 066 822**	**3 154 749**	**3 244 102**	**3 334 861**
Sud Ubangi	Bangabola	Rural	162 743	167 522	172 383	177 325	182 347	187 449
Sud Ubangi	Bogosenubea	Rural	191 079	196 690	202 398	208 200	214 097	220 087
Sud Ubangi	Bokonzi	Rural	260 026	267 662	275 428	283 325	291 350	299 501
Sud Ubangi	Bominenge	Rural	179 152	184 412	189 763	195 204	200 733	206 349
Sud Ubangi	Boto	Rural	206 538	212 603	218 772	225 044	231 418	237 893
Sud Ubangi	Budjala	Rural	154 146	158 672	163 276	167 958	172 715	177 547
Sud Ubangi	Bulu	Rural	185 552	191 001	196 543	202 178	207 904	213 721
Sud Ubangi	Bwamanda	Rural	256 997	264 543	272 220	280 024	287 956	296 012
Sud Ubangi	Gemena	Urbano Rurale	398 269	409 964	421 860	433 955	446 246	458 731
Sud Ubangi	Kungu	Rural	247 765	255 040	262 441	269 965	277 612	285 378

Sud Ubangi	Libenge	Rural	242 109	249 218	256 450	263 802	271 274	278 863
Sud Ubangi	Mawuya	Rural	174 852	179 986	185 209	190 519	195 915	201 396
Sud Ubangi	Mbaya	Rural	76 808	79 064	81 358	83 690	86 061	88 468
Sud Ubangi	Ndage	Rural	153 667	158 180	162 770	167 436	172 179	176 996
Sud Ubangi	Tandala	Rural	319 616	329 001	338 548	348 254	358 118	368 137
Sud Ubangi	Zongo	Urbano Rurale	90 893	93 562	96 277	99 037	101 842	104 692
Total Sud Ubangi			**3 300 213**	**3 397 120**	**3 495 695**	**3 595 917**	**3 697 766**	**3 801 217**
Tanganyika	Ankoro	Rural	379 453	390 596	401 930	413 453	425 163	437 058
Tanganyika	Kabalo	Rural	369 492	380 342	391 379	402 599	414 002	425 585
Tanganyika	Kalemie	Urbain	503 218	517 995	533 026	548 308	563 838	579 612
Tanganyika	Kansimba	Rural	245 709	252 924	260 263	267 725	275 307	283 010
Tanganyika	Kiambi	Rural	247 243	254 503	261 888	269 397	277 027	284 777
Tanganyika	Kongolo	Rural	463 232	476 834	490 671	504 738	519 034	533 555
Tanganyika	Manono	Rural	455 977	469 367	482 986	496 834	510 906	525 199
Tanganyika	Mbulula	Rural	285 545	293 929	302 458	311 130	319 942	328 893
Tanganyika	Moba	Rural	484 645	498 876	513 352	528 070	543 027	558 219
Tanganyika	Nyemba	Urbain	470 075	483 878	497 919	512 195	526 702	541 437
Tanganyika	Nyunzu	Rural	371 911	382 831	393 940	405 234	416 712	428 370
Total Tanganyika			**4 276 501**	**4 402 076**	**4 529 812**	**4 659 683**	**4 791 661**	**4 925 715**
Tshopo	Bafwagbogbo	Rural	62 513	64 349	66 216	68 114	70 044	72 003
Tshopo	Bafwasende	Rural	75 208	77 417	79 663	81 947	84 268	86 626
Tshopo	Banalia	Rural	128 940	132 726	136 577	140 493	144 472	148 514
Tshopo	Basali	Rural	85 515	88 026	90 580	93 177	95 816	98 497
Tshopo	Basoko	Rural	152 752	157 237	161 800	166 439	171 153	175 941
Tshopo	Bengamisa	Rural	105 281	108 372	111 517	114 714	117 963	121 263
Tshopo	Isangi	Rural	151 217	155 657	160 174	164 766	169 433	174 173
Tshopo	Kabondo	Urbano Rurale	155 215	159 772	164 409	169 122	173 912	178 778
Tshopo	Lowa	Rural	118 992	122 486	126 040	129 654	133 326	137 056
Tshopo	Lubunga	Urbano Rurale	136 966	140 988	145 079	149 238	153 465	157 759
Tshopo	Makiso Kisangani	Urbano Rurale	401 194	412 975	424 958	437 142	449 523	462 099
Tshopo	Mangobo	Urbain	191 802	197 434	203 163	208 987	214 906	220 919
Tshopo	Opala	Rural	119 463	122 971	126 539	130 167	133 854	137 598
Tshopo	Opienge	Rural	57 257	58 939	60 649	62 388	64 155	65 950
Tshopo	Tshopo	Urbano Rurale	170 594	175 603	180 699	185 879	191 144	196 492
Tshopo	Ubundu	Rural	91 705	94 397	97 137	99 922	102 752	105 626
Tshopo	Wanierukula	Rural	70 641	72 716	74 826	76 971	79 151	81 365
Tshopo	Yabaondo	Rural	151 157	155 596	160 111	164 701	169 366	174 104
Tshopo	Yahisuli	Rural	86 946	89 499	92 096	94 737	97 420	100 145
Tshopo	Yahuma	Rural	190 799	196 402	202 101	207 895	213 783	219 764
Tshopo	Yakusu	Rural	148 453	152 812	157 246	161 755	166 336	170 990
Tshopo	Yaleko	Rural	139 729	143 832	148 005	152 249	156 561	160 941

Tshopo	Yalimbongo	Rural	100 638	103 593	106 599	109 656	112 761	115 916
Total Tshopo			**3 092 976**	**3 183 798**	**3 276 183**	**3 370 112**	**3 465 565**	**3 562 520**
Tshuapa	Befale	Rural	195 656	201 401	207 245	213 187	219 225	225 358
Tshuapa	Boende	Urbano Rurale	278 209	286 378	294 688	303 137	311 723	320 443
Tshuapa	Bokungu	Rural	216 695	223 058	229 531	236 112	242 799	249 592
Tshuapa	Busanga	Rural	105 964	109 076	112 241	115 459	118 729	122 051
Tshuapa	Djolu	Rural	248 840	256 147	263 580	271 136	278 816	286 616
Tshuapa	Ikela	Rural	197 441	203 238	209 136	215 132	221 225	227 414
Tshuapa	Lingomo	Rural	142 372	146 553	150 805	155 129	159 523	163 986
Tshuapa	Mompono	Rural	150 086	154 494	158 977	163 534	168 166	172 871
Tshuapa	Mondombe	Rural	182 565	187 926	193 379	198 923	204 557	210 280
Tshuapa	Monkoto	Rural	131 773	135 643	139 579	143 580	147 647	151 778
Tshuapa	Wema	Rural	115 693	119 090	122 546	126 060	129 630	133 257
Tshuapa	Yalifafu	Rural	177 748	182 967	188 276	193 674	199 160	204 732
Total Tshuapa			**2 143 042**	**2 205 970**	**2 269 981**	**2 335 062**	**2 401 199**	**2 468 377**
Total RDC			**117 837 369**	**121 297 541**	**124 817 246**	**128 395 791**	**132 032 399**	**135 726 214**

Annexe 5 : Estimation nombre de ménage de 2025 à 2030, par ZS

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Nombre de ménage					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bas Uele	Aketi	Rural	30 541	31 526	32 531	33 557	34 605	35 673
Bas Uele	Ango	Rural	34 886	36 010	37 159	38 331	39 528	40 748
Bas Uele	Bili	Rural	14 529	14 997	15 476	15 964	16 462	16 971
Bas Uele	Bondo	Rural	33 260	34 332	35 427	36 545	37 686	38 849
Bas Uele	Buta	Urbain	44 776	46 219	47 693	49 198	50 733	52 300
Bas Uele	Ganga	Rural	28 252	29 162	30 092	31 042	32 011	32 999
Bas Uele	Likati	Rural	17 007	17 556	18 115	18 687	19 270	19 865
Bas Uele	Monga	Rural	17 731	18 302	18 886	19 482	20 090	20 710
Bas Uele	Poko	Rural	27 674	28 566	29 477	30 407	31 357	32 325
Bas Uele	Titule	Rural	17 902	18 479	19 068	19 670	20 284	20 910
Bas Uele	Viadana	Rural	24 598	25 391	26 201	27 027	27 871	28 731
Total Bas Uele			**291 156**	**300 540**	**310 125**	**319 910**	**329 895**	**340 080**
Equateur	Basankusu	Rural	39 879	41 165	42 478	43 818	45 186	46 581
Equateur	Bikoro	Rural	25 044	25 852	26 676	27 518	28 377	29 253
Equateur	Bolenge	Urbano Rurale	17 613	18 181	18 761	19 353	19 957	20 573
Equateur	Bolomba	Rural	44 051	45 471	46 921	48 402	49 913	51 454
Equateur	Bomongo	Rural	17 749	18 321	18 905	19 502	20 111	20 731
Equateur	Djombo	Rural	14 807	15 284	15 771	16 269	16 777	17 295
Equateur	Iboko	Rural	18 900	19 509	20 131	20 767	21 415	22 076

Equateur	Ingende	Rural	24 397	25 184	25 987	26 807	27 643	28 497
Equateur	Irebu	Rural	8 388	8 659	8 935	9 217	9 504	9 798
Equateur	Lilanga Bobangi	Rural	13 380	13 811	14 251	14 701	15 160	15 628
Equateur	Lotumbe	Rural	19 561	20 192	20 836	21 493	22 164	22 848
Equateur	Lukolela	Rural	23 964	24 736	25 525	26 330	27 152	27 990
Equateur	Makanza	Rural	20 999	21 676	22 367	23 073	23 793	24 527
Equateur	Mampoko	Rural	18 113	18 697	19 293	19 902	20 523	21 157
Equateur	Mbandaka	Urbano Rurale	35 889	37 046	38 227	39 433	40 664	41 919
Equateur	Monieka	Rural	12 548	12 952	13 366	13 787	14 218	14 657
Equateur	Ntondo	Rural	11 142	11 501	11 867	12 242	12 624	13 014
Equateur	Wangata	Urbain	32 343	33 385	34 450	35 537	36 646	37 777
Total Equateur			**398 767**	**411 620**	**424 747**	**438 149**	**451 824**	**465 773**
Haut Katanga	Kafubu	Rural	30 645	31 632	32 641	33 671	34 722	35 794
Haut Katanga	Kamalondo	Urbain	6 271	6 473	6 679	6 890	7 105	7 325
Haut Katanga	Kambove	Urbano Rurale	33 098	34 164	35 254	36 366	37 501	38 659
Haut Katanga	Kampemba	Urbain	84 758	87 490	90 280	93 129	96 035	99 000
Haut Katanga	Kapolowe	Rural	55 918	57 720	59 561	61 441	63 358	65 314
Haut Katanga	Kasenga	Rural	32 661	33 714	34 789	35 886	37 006	38 149
Haut Katanga	Kashobwe	Rural	28 743	29 669	30 615	31 581	32 567	33 572
Haut Katanga	Katuba	Urbain	27 609	28 499	29 408	30 336	31 283	32 249
Haut Katanga	Kenya	Urbain	47 053	48 570	50 119	51 700	53 314	54 960
Haut Katanga	Kikula	Urbain	49 537	51 134	52 764	54 429	56 128	57 861
Haut Katanga	Kilela Balanda	Rural	13 478	13 912	14 356	14 809	15 271	15 743
Haut Katanga	Kilwa	Rural	84 517	87 241	90 024	92 864	95 762	98 719
Haut Katanga	Kipushi	Urbano Rurale	44 498	45 933	47 397	48 893	50 419	51 976
Haut Katanga	Kisanga	Urbain	94 434	97 478	100 586	103 760	106 999	110 302
Haut Katanga	Kowe	Urbain	11 036	11 392	11 755	12 126	12 505	12 891
Haut Katanga	Likasi	Urbain	43 409	44 808	46 237	47 696	49 184	50 703
Haut Katanga	Lubumbashi	Urbain	54 542	56 300	58 096	59 929	61 799	63 707
Haut Katanga	Lukafu	Rural	27 907	28 806	29 725	30 663	31 620	32 596
Haut Katanga	Mitwaba	Urbain	31 232	32 238	33 266	34 316	35 387	36 480
Haut Katanga	Mufunga Sampwe	Rural	36 941	38 131	39 347	40 589	41 856	43 148
Haut Katanga	Mumbunda	Urbain	64 226	66 296	68 410	70 568	72 771	75 018
Haut Katanga	Panda	Urbain	17 587	18 154	18 733	19 324	19 927	20 543
Haut Katanga	Pweto	Rural	59 342	61 255	63 208	65 203	67 238	69 313
Haut Katanga	Ruashi	Urbain	122 588	126 539	130 575	134 694	138 898	143 187
Haut Katanga	Sakania	Rural	75 172	77 595	80 069	82 595	85 173	87 803
Haut Katanga	Tshamilemba	Urbain	46 844	48 354	49 896	51 470	53 077	54 715
Haut Katanga	Vangu	Urbain	28 626	29 548	30 490	31 452	32 434	33 436
Total Haut Katanga			**1 252 670**	**1 293 045**	**1 334 282**	**1 376 381**	**1 419 341**	**1 463 159**
Haut Lomami	Baka	Rural	7 131	7 360	7 595	7 835	8 079	8 329

Haut Lomami	Bukama	Rural	72 963	75 315	77 717	80 169	82 671	85 223
Haut Lomami	Butumba	Rural	43 054	44 442	45 859	47 306	48 782	50 288
Haut Lomami	Kabondo Dianda	Rural	54 439	56 194	57 986	59 815	61 682	63 586
Haut Lomami	Kabongo	Urbano Rurale	79 507	82 069	84 687	87 359	90 085	92 866
Haut Lomami	Kamina	Urbain	64 606	66 688	68 815	70 986	73 202	75 462
Haut Lomami	Kaniama	Rural	63 280	65 320	67 403	69 529	71 700	73 913
Haut Lomami	Kayamba	Rural	22 009	22 718	23 443	24 182	24 937	25 707
Haut Lomami	Kinda	Rural	19 188	19 807	20 439	21 083	21 741	22 413
Haut Lomami	Kinkondja	Rural	59 247	61 157	63 107	65 098	67 130	69 203
Haut Lomami	Kitenge	Rural	60 037	61 972	63 948	65 966	68 025	70 125
Haut Lomami	Lwamba	Rural	29 503	30 454	31 425	32 417	33 429	34 461
Haut Lomami	Malemba Nkulu	Rural	73 977	76 362	78 797	81 283	83 820	86 408
Haut Lomami	Mukanga	Rural	44 015	45 434	46 883	48 362	49 872	51 411
Haut Lomami	Mulongo	Rural	67 109	69 272	71 481	73 737	76 038	78 386
Haut Lomami	Songa	Rural	42 127	43 485	44 872	46 288	47 733	49 206
Total Haut Lomami			**802 193**	**828 049**	**854 457**	**881 416**	**908 927**	**936 988**
Haut Uele	Aba	Rural	39 036	40 294	41 579	42 891	44 229	45 595
Haut Uele	Boma Mangbetu	Rural	27 225	28 103	28 999	29 914	30 848	31 800
Haut Uele	Doruma	Rural	17 240	17 796	18 363	18 943	19 534	20 137
Haut Uele	Dungu	Rural	34 337	35 444	36 574	37 728	38 906	40 107
Haut Uele	Faradje	Rural	30 704	31 694	32 705	33 736	34 789	35 863
Haut Uele	Gombari	Rural	27 880	28 779	29 697	30 634	31 590	32 565
Haut Uele	Isiro	Urbano Rurale	66 343	68 481	70 665	72 895	75 170	77 490
Haut Uele	Makoro	Rural	34 505	35 617	36 753	37 913	39 096	40 303
Haut Uele	Niangara	Rural	27 831	28 728	29 644	30 579	31 534	32 507
Haut Uele	Pawa	Rural	41 942	43 294	44 675	46 084	47 523	48 990
Haut Uele	Rungu	Rural	28 296	29 208	30 139	31 090	32 061	33 051
Haut Uele	Wamba	Rural	32 660	33 713	34 788	35 885	37 005	38 148
Haut Uele	Watsa	Urbano Rurale	68 565	70 775	73 032	75 336	77 687	80 086
Total Haut Uele			**476 564**	**491 925**	**507 613**	**523 629**	**539 972**	**556 643**
Ituri	Adi	Rural	27 503	28 389	29 295	30 219	31 162	32 124
Ituri	Adja	Rural	21 954	22 662	23 385	24 122	24 875	25 643
Ituri	Angumu	Rural	28 762	29 689	30 636	31 603	32 589	33 595
Ituri	Ariwara	Rural	35 370	36 510	37 674	38 863	40 076	41 313
Ituri	Aru	Rural	30 969	31 968	32 987	34 028	35 090	36 173
Ituri	Aungba	Rural	28 529	29 448	30 387	31 346	32 324	33 322
Ituri	Bambu	Rural	24 534	25 324	26 132	26 956	27 798	28 656
Ituri	Biringi	Rural	21 307	21 994	22 695	23 412	24 142	24 888
Ituri	Boga	Rural	11 282	11 646	12 017	12 396	12 783	13 178
Ituri	Bunia	Urbano Rurale	55 212	56 992	58 809	60 665	62 558	64 489

Ituri	Damas	Rural	18 989	19 601	20 226	20 864	21 515	22 179
Ituri	Drodro	Rural	25 365	26 183	27 018	27 870	28 740	29 627
Ituri	Fataki	Rural	21 490	22 183	22 890	23 613	24 350	25 101
Ituri	Gety	Rural	32 280	33 320	34 383	35 468	36 575	37 704
Ituri	Jiba	Rural	16 370	16 898	17 437	17 987	18 548	19 121
Ituri	Kambala	Rural	22 340	23 060	23 795	24 546	25 312	26 093
Ituri	Kilo	Rural	8 379	8 649	8 925	9 207	9 494	9 787
Ituri	Komanda	Rural	40 081	41 373	42 692	44 039	45 414	46 816
Ituri	Laybo	Rural	24 922	25 725	26 545	27 383	28 238	29 109
Ituri	Linga	Rural	23 037	23 779	24 537	25 312	26 102	26 907
Ituri	Lita	Rural	21 861	22 566	23 285	24 020	24 770	25 534
Ituri	Logo	Rural	39 875	41 160	42 473	43 813	45 180	46 575
Ituri	Lolwa	Rural	15 889	16 401	16 924	17 458	18 003	18 559
Ituri	Mahagi	Rural	32 425	33 470	34 538	35 627	36 739	37 873
Ituri	Mambasa	Rural	16 526	17 058	17 602	18 158	18 724	19 302
Ituri	Mandima	Rural	25 161	25 972	26 800	27 646	28 509	29 389
Ituri	Mangala	Rural	16 440	16 970	17 511	18 064	18 627	19 202
Ituri	Mongbwalu	Rural	22 574	23 301	24 045	24 803	25 577	26 367
Ituri	Nia Nia	Rural	17 025	17 573	18 134	18 706	19 290	19 885
Ituri	Nizi	Rural	32 864	33 923	35 005	36 110	37 237	38 386
Ituri	Nyankunde	Rural	16 191	16 713	17 246	17 790	18 346	18 912
Ituri	Nyarambe	Rural	36 080	37 243	38 431	39 644	40 881	42 143
Ituri	Rethy	Rural	34 145	35 246	36 370	37 517	38 688	39 882
Ituri	Rimba	Rural	36 050	37 212	38 399	39 610	40 847	42 108
Ituri	Rwampara	Urbano Rurale	33 478	34 557	35 659	36 784	37 932	39 104
Ituri	Tchomia	Rural	18 305	18 895	19 498	20 113	20 741	21 381
Total Ituri			**933 563**	**963 653**	**994 385**	**1 025 760**	**1 057 776**	**1 090 432**
Kongo Central	Boko Kivulu	Rural	73 884	76 266	78 698	81 181	83 715	86 299
Kongo Central	Boma Bungu	Rural	38 926	40 181	41 462	42 771	44 106	45 467
Kongo Central	Boma	Urbain	85 865	88 632	91 459	94 344	97 289	100 293
Kongo Central	Gombe Matadi	Rural	37 619	38 831	40 069	41 334	42 624	43 940
Kongo Central	Inga	Rural	35 046	36 176	37 329	38 507	39 709	40 935
Kongo Central	Kangu	Rural	40 221	41 517	42 841	44 193	45 572	46 979
Kongo Central	Kibunzi	Rural	26 462	27 315	28 186	29 075	29 983	30 908
Kongo Central	Kimpangu	Rural	46 391	47 886	49 413	50 972	52 563	54 186
Kongo Central	Kimpese	Rural	65 791	67 911	70 077	72 288	74 544	76 846
Kongo Central	Kimvula	Rural	31 756	32 779	33 824	34 892	35 981	37 092
Kongo Central	Kinkonzi	Rural	27 665	28 557	29 468	30 398	31 346	32 314
Kongo Central	Kisantu	Urbano Rurale	73 060	75 414	77 819	80 275	82 780	85 336
Kongo Central	Kitona	Urbano Rurale	38 647	39 892	41 165	42 463	43 789	45 141
Kongo Central	Kizu	Rural	24 963	25 768	26 590	27 429	28 285	29 158

Kongo Central	Kuimba	Rural	38 922	40 177	41 458	42 766	44 101	45 462
Kongo Central	Kwilu Ngongo	Urbano Rurale	53 488	55 212	56 973	58 770	60 605	62 476
Kongo Central	Lukula	Rural	64 247	66 318	68 433	70 592	72 796	75 043
Kongo Central	Luozi	Rural	39 785	41 067	42 377	43 714	45 079	46 470
Kongo Central	Mangembo	Rural	27 460	28 345	29 249	30 172	31 114	32 075
Kongo Central	Massa	Rural	40 714	42 026	43 366	44 735	46 131	47 555
Kongo Central	Matadi	Urbain	100 155	103 383	106 680	110 046	113 481	116 984
Kongo Central	Mbanza Ngungu	Urbano Rurale	52 955	54 661	56 405	58 184	60 000	61 853
Kongo Central	Muanda	Urbano Rurale	66 200	68 334	70 513	72 738	75 008	77 324
Kongo Central	Ngidinga	Rural	52 050	53 728	55 442	57 191	58 976	60 797
Kongo Central	Nselo	Rural	37 100	38 296	39 517	40 764	42 036	43 334
Kongo Central	Nsona Mpangu	Rural	41 362	42 695	44 057	45 447	46 865	48 312
Kongo Central	Nzanza	Urbain	61 017	62 984	64 993	67 043	69 136	71 270
Kongo Central	Seke Banza	Rural	57 075	58 915	60 794	62 712	64 669	66 666
Kongo Central	Sona Bata	Rural	40 193	41 488	42 811	44 162	45 540	46 946
Kongo Central	Tshela	Rural	33 518	34 598	35 702	36 828	37 977	39 150
Kongo Central	Vaku	Rural	30 030	30 998	31 987	32 996	34 026	35 076
Total Kongo Central			**1 482 567**	**1 530 352**	**1 579 157**	**1 628 982**	**1 679 826**	**1 731 686**
Kasai Oriental	Bibanga	Urbain	27 685	28 577	29 489	30 419	31 368	32 337
Kasai Oriental	Bipemba	Urbain	64 695	66 780	68 910	71 084	73 303	75 566
Kasai Oriental	Bonzola	Urbain	32 997	34 061	35 147	36 256	37 387	38 542
Kasai Oriental	Cilundu	Rural	33 646	34 730	35 838	36 969	38 123	39 300
Kasai Oriental	Citenge	Urbano Rurale	43 169	44 560	45 981	47 432	48 913	50 423
Kasai Oriental	Dibindi	Urbain	48 810	50 383	51 990	53 630	55 304	57 011
Kasai Oriental	Diulu	Urbain	67 346	69 517	71 734	73 997	76 307	78 663
Kasai Oriental	Kabeya Kamwanga	Rural	36 134	37 298	38 488	39 702	40 942	42 205
Kasai Oriental	Kansele	Urbain	46 203	47 692	49 213	50 765	52 350	53 966
Kasai Oriental	Kasansa	Urbano Rurale	37 353	38 556	39 786	41 041	42 322	43 629
Kasai Oriental	Lubilanji	Urbain	46 454	47 951	49 480	51 041	52 634	54 259
Kasai Oriental	Lukelenge	Rural	49 881	51 489	53 131	54 807	56 518	58 263
Kasai Oriental	Miabi	Rural	28 352	29 265	30 199	31 151	32 124	33 116
Kasai Oriental	Mpokolo	Urbain	50 611	52 242	53 908	55 609	57 345	59 115
Kasai Oriental	Mukumbi	Rural	26 728	27 590	28 470	29 368	30 285	31 220
Kasai Oriental	Muya	Urbain	60 258	62 201	64 184	66 209	68 276	70 384
Kasai Oriental	Nzaba	Urbain	53 016	54 725	56 470	58 252	60 070	61 925
Kasai Oriental	Tshilenge	Rural	52 661	54 358	56 091	57 861	59 667	61 509
Kasai Oriental	Tshishimbi	Rural	32 765	33 821	34 899	36 000	37 124	38 270
Total Kasai Orienatal			**838 763**	**865 797**	**893 408**	**921 597**	**950 362**	**979 702**
Kwango	Boko	Rural	49 873	51 481	53 122	54 799	56 509	58 254
Kwango	Feshi	Rural	34 267	35 371	36 499	37 651	38 826	40 025
Kwango	Kahemba	Rural	62 024	64 023	66 065	68 149	70 276	72 446

Kwango	Kajiji	Rural	36 085	37 248	38 436	39 648	40 886	42 148
Kwango	Kasongo Lunda	Rural	38 626	39 871	41 142	42 440	43 765	45 116
Kwango	Kenge	Urbano Rurale	65 079	67 176	69 319	71 506	73 738	76 014
Kwango	Kimbao	Rural	46 296	47 788	49 312	50 868	52 456	54 075
Kwango	Kisanji	Rural	27 835	28 733	29 649	30 584	31 539	32 513
Kwango	Kitenda	Rural	36 554	37 732	38 936	40 164	41 418	42 696
Kwango	Mwela Lembwa	Rural	23 045	23 788	24 547	25 321	26 112	26 918
Kwango	Panzi	Rural	41 130	42 455	43 809	45 191	46 602	48 041
Kwango	Popokabaka	Rural	51 637	53 301	55 001	56 736	58 507	60 313
Kwango	Tembo	Rural	23 852	24 620	25 406	26 207	27 025	27 860
Kwango	Wamba Lwadi	Rural	26 445	27 298	28 168	29 057	29 964	30 889
Total Kwango			**562 747**	**580 885**	**599 410**	**618 322**	**637 621**	**657 306**
Kwilu	Bagata	Rural	51 792	53 462	55 167	56 907	58 683	60 495
Kwilu	Bandundu	Urbain	60 892	62 855	64 859	66 906	68 994	71 124
Kwilu	Bulungu	Rural	80 584	83 181	85 834	88 542	91 306	94 125
Kwilu	Djuma	Rural	63 465	65 510	67 600	69 732	71 909	74 129
Kwilu	Gungu	Rural	72 946	75 297	77 698	80 150	82 651	85 203
Kwilu	Idiofa	Rural	83 973	86 680	89 444	92 266	95 146	98 083
Kwilu	Ipamu	Rural	59 609	61 530	63 493	65 496	67 540	69 625
Kwilu	Kikongo	Rural	54 809	56 576	58 380	60 222	62 102	64 019
Kwilu	Kikwit Nord	Urbain	69 673	71 919	74 213	76 554	78 944	81 381
Kwilu	Kikwit Sud	Urbain	74 802	77 213	79 676	82 190	84 755	87 372
Kwilu	Kimputu	Rural	57 645	59 503	61 401	63 338	65 315	67 331
Kwilu	Kingandu	Rural	31 679	32 700	33 743	34 807	35 894	37 002
Kwilu	Koshibanda	Rural	59 908	61 839	63 811	65 825	67 879	69 975
Kwilu	Lusanga	Rural	79 815	82 388	85 015	87 698	90 435	93 227
Kwilu	Masi Manimba	Rural	69 678	71 924	74 218	76 559	78 949	81 386
Kwilu	Moanza	Rural	50 726	52 361	54 031	55 736	57 475	59 250
Kwilu	Mokala	Rural	63 505	65 552	67 642	69 777	71 954	74 176
Kwilu	Mosango	Rural	35 520	36 664	37 834	39 027	40 246	41 488
Kwilu	Mukedi	Rural	51 991	53 666	55 378	57 125	58 908	60 727
Kwilu	Mungindu	Rural	37 499	38 707	39 942	41 202	42 488	43 800
Kwilu	Pay Kongila	Rural	43 898	45 313	46 758	48 234	49 739	51 275
Kwilu	Sia	Rural	32 285	33 326	34 389	35 474	36 581	37 710
Kwilu	Vanga	Rural	84 221	86 936	89 709	92 539	95 427	98 373
Kwilu	Yasa Bonga	Rural	65 996	68 123	70 296	72 514	74 777	77 086
Total Kwilu			**1 436 914**	**1 483 227**	**1 530 530**	**1 578 820**	**1 628 098**	**1 678 362**
Kinshasa	Bandalungwa	Urbain	54 179	55 925	57 709	59 530	61 388	63 283
Kinshasa	Barumbu	Urbain	58 913	60 812	62 751	64 731	66 751	68 812
Kinshasa	Binza Meteo	Urbain	172 454	178 012	183 689	189 485	195 399	201 431
Kinshasa	Binza Ozone	Urbain	122 369	126 313	130 341	134 454	138 650	142 931

Kinshasa	Biyela	Urbain	81 363	83 986	86 664	89 398	92 189	95 035
Kinshasa	Bumbu	Urbain	122 116	126 052	130 072	134 176	138 364	142 636
Kinshasa	Gombe	Urbain	34 465	35 575	36 710	37 868	39 050	40 256
Kinshasa	Kalamu 1	Urbain	88 252	91 097	94 002	96 968	99 995	103 082
Kinshasa	Kalamu 2	Urbain	74 505	76 907	79 359	81 863	84 418	87 024
Kinshasa	Kasa Vubu	Urbain	52 299	53 985	55 706	57 464	59 258	61 087
Kinshasa	Kikimi	Urbain	101 035	104 292	107 618	111 013	114 478	118 012
Kinshasa	Kimbanseke	Urbain	100 805	104 055	107 373	110 761	114 218	117 744
Kinshasa	Kingabwa	Urbain	87 695	90 522	93 408	96 356	99 363	102 431
Kinshasa	Kingasani	Urbain	85 446	88 200	91 013	93 884	96 815	99 803
Kinshasa	Kinshasa	Urbain	71 004	73 293	75 630	78 016	80 451	82 935
Kinshasa	Kintambo	Urbain	30 000	30 967	31 955	32 963	33 992	35 041
Kinshasa	Kisenso	Urbain	137 609	142 044	146 574	151 199	155 918	160 731
Kinshasa	Kokolo	Urbain	129 754	133 936	138 207	142 568	147 018	151 557
Kinshasa	Lemba	Urbain	77 992	80 506	83 073	85 695	88 369	91 097
Kinshasa	Limete	Urbain	96 437	99 546	102 720	105 961	109 268	112 642
Kinshasa	Lingwala	Urbain	33 200	34 270	35 363	36 479	37 618	38 779
Kinshasa	Makala	Urbain	116 556	120 313	124 150	128 067	132 064	136 142
Kinshasa	Maluku 1	Urbano Rurale	80 445	83 038	85 686	88 390	91 148	93 962
Kinshasa	Maluku 2	Urbano Rurale	31 534	32 551	33 589	34 649	35 730	36 833
Kinshasa	Masina 1	Urbain	194 946	201 229	207 647	214 198	220 884	227 703
Kinshasa	Masina 2	Urbain	115 128	118 839	122 629	126 498	130 446	134 473
Kinshasa	Matete	Urbain	101 221	104 483	107 815	111 217	114 688	118 229
Kinshasa	Mont Ngafula 1	Urbano Rurale	110 778	114 348	117 995	121 718	125 517	129 392
Kinshasa	Mont Ngafula 2	Urbano Rurale	74 844	77 256	79 720	82 235	84 802	87 420
Kinshasa	Ndjili	Urbain	116 878	120 645	124 493	128 421	132 429	136 517
Kinshasa	Ngaba	Urbain	66 192	68 326	70 505	72 730	75 000	77 315
Kinshasa	Ngiri Ngiri	Urbain	96 724	99 842	103 026	106 276	109 593	112 977
Kinshasa	Nsele	Urbano Rurale	139 990	144 502	149 110	153 815	158 616	163 512
Kinshasa	Police	Urbain	47 219	48 741	50 296	51 883	53 502	55 154
Kinshasa	Selembao	Urbain	137 034	141 451	145 962	150 567	155 267	160 060
Total Kinshasa			**3 241 383**	**3 345 857**	**3 452 561**	**3 561 495**	**3 672 656**	**3 786 040**
Kasai Central	Bena Leka	Rural	56 512	58 334	60 194	62 093	64 031	66 008
Kasai Central	Bena Tshadi	Rural	22 451	23 175	23 914	24 668	25 438	26 224
Kasai Central	Bilomba	Rural	17 976	18 556	19 147	19 751	20 368	20 997
Kasai Central	Bobozo	Rural	9 990	10 312	10 641	10 977	11 319	11 669
Kasai Central	Bunkonde	Rural	22 356	23 077	23 813	24 564	25 331	26 113
Kasai Central	Demba	Rural	66 382	68 522	70 707	72 938	75 215	77 537
Kasai Central	Dibaya	Rural	35 524	36 669	37 838	39 032	40 251	41 493
Kasai Central	Kalomba	Urbain	31 878	32 905	33 954	35 026	36 119	37 234
Kasai Central	Kananga	Urbain	55 797	57 596	59 433	61 308	63 221	65 173

Kasai Central	Katende	Rural	18 792	19 398	20 016	20 648	21 292	21 950
Kasai Central	Katoka	Urbain	26 496	27 350	28 222	29 113	30 022	30 948
Kasai Central	Luambo	Rural	53 619	55 347	57 112	58 914	60 753	62 628
Kasai Central	Lubondaie	Rural	29 562	30 515	31 488	32 481	33 495	34 529
Kasai Central	Lubunga	Rural	20 343	20 999	21 668	22 352	23 050	23 761
Kasai Central	Luiza	Rural	33 892	34 984	36 100	37 239	38 401	39 587
Kasai Central	Lukonga	Urbain	53 485	55 209	56 970	58 767	60 602	62 473
Kasai Central	Masuika	Rural	46 047	47 531	49 047	50 594	52 173	53 784
Kasai Central	Mikalayi	Rural	39 646	40 923	42 228	43 561	44 920	46 307
Kasai Central	Muetshi	Rural	22 451	23 174	23 913	24 668	25 438	26 223
Kasai Central	Mutoto	Rural	26 126	26 968	27 828	28 706	29 602	30 515
Kasai Central	Ndekesha	Rural	32 722	33 777	34 854	35 953	37 076	38 220
Kasai Central	Ndesha	Urbain	20 605	21 269	21 948	22 640	23 347	24 067
Kasai Central	Tshibala	Rural	47 959	49 505	51 084	52 696	54 340	56 018
Kasai Central	Tshikaji	Urbain	24 348	25 133	25 935	26 753	27 588	28 440
Kasai Central	Tshikula	Rural	26 215	27 060	27 923	28 804	29 703	30 620
Kasai Central	Yangala	Rural	30 663	31 652	32 661	33 691	34 743	35 816
Total Kasai Central			**871 838**	**899 938**	**928 639**	**957 939**	**987 838**	**1 018 335**
Kasai	Banga Lubaka	Rural	27 533	28 421	29 327	30 253	31 197	32 160
Kasai	Bulape	Rural	29 929	30 894	31 879	32 885	33 911	34 958
Kasai	Dekese	Rural	30 323	31 300	32 298	33 318	34 357	35 418
Kasai	Ilebo	Rural	31 506	32 522	33 559	34 618	35 698	36 800
Kasai	Kakenge	Rural	32 283	33 324	34 386	35 471	36 578	37 708
Kasai	Kalonda Ouest	Rural	65 835	67 956	70 124	72 336	74 594	76 897
Kasai	Kamonia	Rural	65 575	67 689	69 848	72 051	74 300	76 594
Kasai	Kamwesha	Rural	72 570	74 909	77 298	79 737	82 226	84 764
Kasai	Kanzala	Urbain	41 272	42 603	43 961	45 348	46 764	48 207
Kasai	Kitangwa	Rural	43 828	45 240	46 683	48 156	49 659	51 192
Kasai	Luebo	Rural	43 627	45 033	46 469	47 936	49 432	50 958
Kasai	Mikope	Rural	31 929	32 958	34 009	35 082	36 177	37 294
Kasai	Mushenge	Rural	28 754	29 681	30 627	31 594	32 580	33 585
Kasai	Mutena	Rural	43 914	45 329	46 775	48 250	49 756	51 293
Kasai	Mweka	Rural	40 966	42 287	43 635	45 012	46 417	47 850
Kasai	Ndjoko Mpunda	Rural	26 205	27 050	27 912	28 793	29 692	30 608
Kasai	Nyanga	Rural	20 816	21 487	22 172	22 871	23 585	24 313
Kasai	Tshikapa	Rural	60 342	62 287	64 274	66 302	68 371	70 482
Total Kasai			**737 207**	**760 968**	**785 237**	**810 012**	**835 294**	**861 082**
Lualaba	Bunkeya	Rural	14 706	15 180	15 664	16 158	16 662	17 177
Lualaba	Dilala	Urbain	63 750	65 805	67 904	70 046	72 233	74 462
Lualaba	Dilolo	Rural	48 243	49 798	51 387	53 008	54 662	56 350
Lualaba	Fungurume	Rural	85 986	88 757	91 588	94 477	97 426	100 434

Lualaba	Kafakumba	Rural	33 089	34 155	35 244	36 356	37 491	38 649
Lualaba	Kalamba	Rural	32 186	33 223	34 283	35 365	36 468	37 594
Lualaba	Kanzenze	Rural	56 478	58 298	60 158	62 056	63 992	65 968
Lualaba	Kapanga	Rural	39 904	41 190	42 504	43 845	45 213	46 609
Lualaba	Kasaji	Rural	69 291	71 524	73 805	76 134	78 510	80 934
Lualaba	Lualaba	Rural	44 726	46 168	47 640	49 144	50 677	52 242
Lualaba	Lubudi	Rural	29 941	30 906	31 892	32 898	33 925	34 972
Lualaba	Manika	Urbain	101 114	104 373	107 702	111 100	114 568	118 105
Lualaba	Mutshatsha	Rural	19 969	20 612	21 270	21 941	22 626	23 324
Lualaba	Sandoa	Rural	57 762	59 623	61 525	63 466	65 447	67 468
Total Lualaba			**697 144**	**719 614**	**742 564**	**765 993**	**789 901**	**814 287**
Lomami	Kabinda	Urbain	59 776	61 702	63 670	65 679	67 729	69 820
Lomami	Kalambayi Kabanga	Rural	35 199	36 334	37 492	38 675	39 882	41 114
Lomami	Kalenda	Rural	35 484	36 628	37 796	38 989	40 206	41 447
Lomami	Kalonda Est	Rural	40 844	42 161	43 505	44 878	46 279	47 707
Lomami	Kamana	Rural	35 008	36 137	37 289	38 466	39 666	40 891
Lomami	Kamiji	Rural	17 340	17 899	18 470	19 053	19 647	20 254
Lomami	Kanda Kanda	Rural	40 965	42 285	43 634	45 011	46 415	47 848
Lomami	Lubao	Rural	38 657	39 903	41 175	42 475	43 800	45 153
Lomami	Ludimbi Lukula	Rural	27 907	28 806	29 725	30 662	31 620	32 596
Lomami	Luputa	Rural	48 365	49 924	51 516	53 142	54 801	56 492
Lomami	Makota	Urbain	41 409	42 744	44 107	45 499	46 919	48 367
Lomami	Mulumba	Rural	55 673	57 468	59 300	61 171	63 081	65 028
Lomami	Mweneditu	Urbain	75 686	78 126	80 617	83 161	85 757	88 404
Lomami	Ngandajika	Urbano Rurale	54 264	56 013	57 800	59 623	61 484	63 383
Lomami	Tshofa	Rural	24 315	25 099	25 899	26 716	27 550	28 401
Lomami	Wikong	Rural	21 529	22 223	22 932	23 655	24 394	25 147
Total Lomami			**652 423**	**673 451**	**694 928**	**716 855**	**739 229**	**762 051**
Mai Ndombe	Banzow Moke	Rural	32 499	33 546	34 616	35 708	36 823	37 960
Mai Ndombe	Bokoro	Rural	56 563	58 386	60 248	62 149	64 089	66 067
Mai Ndombe	Bolobo	Rural	35 384	36 524	37 689	38 878	40 092	41 329
Mai Ndombe	Bosobe	Rural	32 898	33 959	35 042	36 147	37 275	38 426
Mai Ndombe	Inongo	Urbano Rurale	54 796	56 562	58 366	60 207	62 086	64 003
Mai Ndombe	Kiri	Rural	29 611	30 566	31 540	32 536	33 551	34 587
Mai Ndombe	Kwamouth	Rural	39 765	41 047	42 356	43 692	45 056	46 447
Mai Ndombe	Mimia	Rural	14 330	14 792	15 263	15 745	16 236	16 738
Mai Ndombe	Mushie	Rural	34 217	35 319	36 446	37 596	38 769	39 966
Mai Ndombe	Nioki	Rural	41 742	43 088	44 462	45 865	47 296	48 756
Mai Ndombe	Ntandembelo	Rural	22 371	23 092	23 829	24 581	25 348	26 130
Mai Ndombe	Oshwe	Rural	38 208	39 440	40 697	41 981	43 292	44 628
Mai Ndombe	Pendjwa	Rural	22 517	23 243	23 984	24 741	25 513	26 301

Mai Ndombe	Yumbi	Rural	30 049	31 017	32 006	33 016	34 047	35 098
Total Mai Ndombe			**484 950**	**500 580**	**516 544**	**532 842**	**549 473**	**566 437**
Mongala	Binga	Rural	49 234	50 821	52 441	54 096	55 784	57 507
Mongala	Bongandanga	Rural	28 918	29 850	30 802	31 774	32 766	33 777
Mongala	Boso Manzi	Rural	28 589	29 510	30 451	31 412	32 392	33 392
Mongala	Boso Mondanda	Rural	29 446	30 395	31 365	32 354	33 364	34 394
Mongala	Bosondjo	Rural	39 808	41 091	42 402	43 739	45 105	46 497
Mongala	Bumba	Urbano Rurale	43 241	44 634	46 058	47 511	48 994	50 506
Mongala	Lisala	Urbano Rurale	55 398	57 183	59 007	60 869	62 768	64 706
Mongala	Lolo	Rural	26 869	27 735	28 619	29 522	30 444	31 384
Mongala	Pimu	Rural	46 798	48 307	49 847	51 420	53 025	54 662
Mongala	Yamaluka	Rural	26 826	27 691	28 574	29 476	30 396	31 334
Mongala	Yambuku	Rural	52 399	54 088	55 813	57 574	59 371	61 204
Mongala	Yamongili	Rural	26 678	27 538	28 416	29 313	30 228	31 161
Total Mongala			**454 204**	**468 843**	**483 795**	**499 060**	**514 636**	**530 524**
Maniema	Alunguli	Rural	20 208	20 859	21 524	22 203	22 896	23 603
Maniema	Ferekeni	Rural	13 041	13 461	13 891	14 329	14 776	15 232
Maniema	Kabambare	Rural	34 027	35 124	36 244	37 388	38 555	39 745
Maniema	Kailo	Rural	40 578	41 886	43 222	44 586	45 977	47 397
Maniema	Kalima	Rural	34 191	35 293	36 419	37 568	38 740	39 936
Maniema	Kampene	Rural	37 552	38 762	39 998	41 260	42 548	43 862
Maniema	Kasongo	Rural	55 612	57 404	59 235	61 104	63 011	64 956
Maniema	Kibombo	Rural	24 987	25 793	26 615	27 455	28 312	29 186
Maniema	Kindu	Urbain	61 667	63 654	65 684	67 757	69 872	72 029
Maniema	Kunda	Rural	69 394	71 631	73 916	76 248	78 628	81 055
Maniema	Lubutu	Rural	31 711	32 733	33 777	34 842	35 930	37 039
Maniema	Lusangi	Rural	40 456	41 760	43 091	44 451	45 838	47 253
Maniema	Obokote	Rural	18 218	18 805	19 405	20 017	20 642	21 279
Maniema	Pangi	Rural	21 853	22 557	23 277	24 011	24 760	25 525
Maniema	Punia	Rural	28 333	29 246	30 179	31 131	32 103	33 094
Maniema	Samba	Rural	29 230	30 172	31 135	32 117	33 119	34 142
Maniema	Saramabila	Rural	35 827	36 982	38 161	39 365	40 594	41 847
Maniema	Tunda	Rural	21 298	21 984	22 686	23 401	24 132	24 877
Total Maniema			**618 183**	**638 107**	**658 458**	**679 233**	**700 433**	**722 057**
Nord Kivu	Alimbongo	Rural	48 866	50 442	52 050	53 692	55 368	57 078
Nord Kivu	Bambo	Rural	34 760	35 881	37 025	38 193	39 385	40 601
Nord Kivu	Beni	Urbain	87 126	89 935	92 803	95 731	98 719	101 766
Nord Kivu	Biena	Rural	27 073	27 945	28 837	29 746	30 675	31 622
Nord Kivu	Binza	Rural	35 917	37 074	38 257	39 464	40 696	41 952
Nord Kivu	Birambizo	Rural	39 365	40 634	41 929	43 252	44 602	45 979

Nord Kivu	Butembo	Urbain	43 833	45 246	46 688	48 162	49 665	51 198
Nord Kivu	Goma	Urbain	53 791	55 525	57 296	59 104	60 948	62 830
Nord Kivu	Itebero	Rural	38 867	40 119	41 399	42 705	44 038	45 398
Nord Kivu	Kalunguta	Rural	38 960	40 215	41 498	42 807	44 143	45 506
Nord Kivu	Kamango	Rural	24 008	24 782	25 573	26 379	27 203	28 043
Nord Kivu	Karisimbi	Urbain	108 591	112 091	115 666	119 315	123 039	126 838
Nord Kivu	Katoyi	Rural	62 542	64 557	66 616	68 718	70 863	73 051
Nord Kivu	Katwa	Urbano Rurale	90 268	93 177	96 149	99 182	102 278	105 435
Nord Kivu	Kayna	Rural	74 121	76 510	78 950	81 441	83 983	86 575
Nord Kivu	Kibirizi	Rural	70 436	72 706	75 025	77 392	79 807	82 271
Nord Kivu	Kibua	Rural	23 377	24 131	24 900	25 686	26 488	27 305
Nord Kivu	Kirotshe	Rural	84 923	87 661	90 456	93 310	96 223	99 193
Nord Kivu	Kyondo	Rural	37 882	39 103	40 350	41 623	42 922	44 247
Nord Kivu	Lubero	Rural	59 019	60 921	62 864	64 848	66 872	68 936
Nord Kivu	Mabalako	Rural	39 953	41 241	42 556	43 899	45 269	46 666
Nord Kivu	Manguredjipa	Rural	15 944	16 458	16 982	17 518	18 065	18 623
Nord Kivu	Masereka	Rural	31 053	32 054	33 076	34 120	35 185	36 271
Nord Kivu	Masisi	Rural	74 588	76 993	79 448	81 955	84 513	87 122
Nord Kivu	Musienene	Rural	52 648	54 345	56 078	57 848	59 653	61 495
Nord Kivu	Mutwanga	Rural	58 092	59 964	61 876	63 829	65 821	67 853
Nord Kivu	Mweso	Rural	85 572	88 330	91 147	94 022	96 957	99 950
Nord Kivu	Nyiragongo	Urbano Rurale	61 587	63 572	65 599	67 669	69 781	71 936
Nord Kivu	Oicha	Rural	58 331	60 211	62 131	64 091	66 092	68 132
Nord Kivu	Pinga	Rural	35 144	36 276	37 433	38 614	39 819	41 049
Nord Kivu	Rutshuru	Rural	53 906	55 643	57 418	59 229	61 078	62 964
Nord Kivu	Rwanguba	Rural	55 078	56 853	58 667	60 518	62 406	64 333
Nord Kivu	Vuhovi	Rural	24 750	25 547	26 362	27 194	28 043	28 909
Nord Kivu	Walikale	Rural	33 804	34 894	36 007	37 143	38 302	39 485
Total Nord Kivu			**1 764 173**	**1 821 035**	**1 879 110**	**1 938 399**	**1 998 901**	**2 060 611**
Nord Ubangi	Abuzi	Rural	17 461	18 023	18 598	19 185	19 784	20 395
Nord Ubangi	Bili	Rural	41 594	42 934	44 304	45 701	47 128	48 583
Nord Ubangi	Bosobolo	Rural	37 224	38 424	39 650	40 901	42 177	43 479
Nord Ubangi	Businga	Rural	27 157	28 032	28 926	29 839	30 770	31 720
Nord Ubangi	Gbadolite	Urbano Rurale	37 814	39 033	40 278	41 549	42 846	44 168
Nord Ubangi	Karawa	Rural	56 409	58 227	60 084	61 980	63 915	65 888
Nord Ubangi	Loko	Rural	27 658	28 550	29 460	30 390	31 338	32 306
Nord Ubangi	Mobayi Mbongo	Rural	29 630	30 585	31 561	32 557	33 573	34 609
Nord Ubangi	Wapinda	Rural	16 737	17 276	17 827	18 390	18 964	19 549
Nord Ubangi	Wasolo	Rural	16 930	17 476	18 033	18 602	19 183	19 775
Nord Ubangi	Yakoma	Rural	23 303	24 054	24 821	25 604	26 403	27 219
Total Nord Ubangi			**331 918**	**342 616**	**353 543**	**364 698**	**376 080**	**387 691**

Sud Kivu	Bagira	Urbain	28 517	29 436	30 375	31 333	32 311	33 309
Sud Kivu	Bunyakiri	Rural	52 785	54 486	56 224	57 998	59 808	61 654
Sud Kivu	Fizi	Rural	85 880	88 648	91 475	94 362	97 307	100 311
Sud Kivu	Haut Plateau	Rural	30 703	31 693	32 704	33 736	34 789	35 863
Sud Kivu	Ibanda	Urbain	90 698	93 621	96 607	99 655	102 766	105 938
Sud Kivu	Idjwi	Rural	58 352	60 233	62 154	64 115	66 116	68 157
Sud Kivu	Itombwe	Rural	20 597	21 260	21 939	22 631	23 337	24 058
Sud Kivu	Kabare	Rural	43 836	45 249	46 692	48 165	49 668	51 202
Sud Kivu	Kadutu	Urbain	75 519	77 953	80 439	82 977	85 567	88 209
Sud Kivu	Kalehe	Rural	36 691	37 873	39 081	40 314	41 573	42 856
Sud Kivu	Kalole	Rural	30 063	31 032	32 021	33 032	34 063	35 114
Sud Kivu	Kalonge	Rural	40 782	42 096	43 439	44 810	46 208	47 635
Sud Kivu	Kamituga	Rural	41 252	42 581	43 939	45 326	46 740	48 183
Sud Kivu	Kaniola	Rural	38 111	39 339	40 594	41 875	43 182	44 515
Sud Kivu	Katana	Rural	47 035	48 551	50 099	51 680	53 293	54 938
Sud Kivu	Kaziba	Rural	26 975	27 844	28 732	29 639	30 564	31 507
Sud Kivu	Kimbi Lulenge	Rural	75 186	77 609	80 084	82 611	85 190	87 820
Sud Kivu	Kitutu	Rural	37 922	39 144	40 393	41 667	42 968	44 294
Sud Kivu	Lemera	Rural	37 567	38 777	40 014	41 277	42 565	43 879
Sud Kivu	Lulingu	Rural	38 894	40 148	41 428	42 735	44 069	45 430
Sud Kivu	Minembwe	Rural	19 754	20 391	21 041	21 705	22 382	23 073
Sud Kivu	Minova	Rural	69 405	71 642	73 927	76 259	78 640	81 067
Sud Kivu	Miti Murhesa	Rural	53 589	55 316	57 080	58 881	60 719	62 593
Sud Kivu	Mubumbano	Rural	40 388	41 690	43 019	44 377	45 762	47 175
Sud Kivu	Mulungu	Rural	33 969	35 064	36 182	37 323	38 488	39 677
Sud Kivu	Mwana	Rural	28 840	29 769	30 718	31 688	32 677	33 686
Sud Kivu	Mwenga	Rural	29 837	30 799	31 781	32 784	33 807	34 851
Sud Kivu	Nundu	Rural	49 041	50 622	52 236	53 884	55 566	57 282
Sud Kivu	Nyangezi	Rural	36 032	37 194	38 380	39 591	40 826	42 087
Sud Kivu	Nyantende	Rural	29 659	30 615	31 592	32 588	33 606	34 643
Sud Kivu	Ruzizi	Rural	36 981	38 173	39 391	40 634	41 902	43 195
Sud Kivu	Shabunda	Rural	38 036	39 262	40 514	41 793	43 097	44 427
Sud Kivu	Uvira	Rural	70 235	72 499	74 811	77 172	79 580	82 037
Sud Kivu	Walungu	Rural	56 021	57 826	59 670	61 553	63 474	65 434
Total Sud Kivu			**1 529 152**	**1 578 438**	**1 628 777**	**1 680 168**	**1 732 609**	**1 786 099**
Sankuru	Bena Dibele	Rural	32 651	33 703	34 778	35 875	36 995	38 137
Sankuru	Dikungu	Rural	37 788	39 006	40 250	41 520	42 815	44 137
Sankuru	Djalo Ndjeka	Rural	23 482	24 239	25 012	25 801	26 606	27 428
Sankuru	Katako Kombe	Rural	34 512	35 625	36 761	37 921	39 104	40 311
Sankuru	Kole	Rural	34 008	35 105	36 224	37 367	38 533	39 723
Sankuru	Lodja	Urbain	85 354	88 105	90 915	93 783	96 710	99 696

Sankuru	Lomela	Rural	32 413	33 458	34 525	35 614	36 726	37 859
Sankuru	Lusambo	Urbain	34 368	35 475	36 607	37 762	38 940	40 143
Sankuru	Minga	Rural	39 767	41 049	42 358	43 695	45 059	46 450
Sankuru	Omendjadi	Rural	40 134	41 427	42 748	44 097	45 474	46 878
Sankuru	Ototo	Rural	36 275	37 444	38 639	39 858	41 102	42 371
Sankuru	Pania Mutombo	Rural	22 917	23 656	24 410	25 180	25 966	26 768
Sankuru	Tshudi Loto	Rural	20 662	21 328	22 009	22 703	23 412	24 134
Sankuru	Tshumbe	Rural	27 550	28 438	29 345	30 271	31 216	32 180
Sankuru	Vanga Kete	Rural	33 641	34 725	35 832	36 963	38 117	39 293
Sankuru	Wembo Nyama	Rural	27 457	28 342	29 246	30 169	31 110	32 071
Total Sankuru			**562 979**	**581 125**	**599 658**	**618 578**	**637 885**	**657 578**
Sud Ubangi	Bangabola	Rural	31 644	32 664	33 706	34 770	35 855	36 962
Sud Ubangi	Bogosenubea	Rural	37 154	38 352	39 575	40 824	42 098	43 397
Sud Ubangi	Bokonzi	Rural	50 561	52 190	53 855	55 554	57 288	59 056
Sud Ubangi	Bominenge	Rural	34 835	35 958	37 105	38 275	39 470	40 688
Sud Ubangi	Boto	Rural	40 160	41 455	42 777	44 126	45 504	46 908
Sud Ubangi	Budjala	Rural	29 973	30 939	31 926	32 933	33 961	35 009
Sud Ubangi	Bulu	Rural	36 080	37 242	38 430	39 643	40 880	42 142
Sud Ubangi	Bwamanda	Rural	49 972	51 582	53 227	54 907	56 620	58 368
Sud Ubangi	Gemena	Urbano Rurale	77 441	79 937	82 487	85 089	87 745	90 454
Sud Ubangi	Kungu	Rural	48 177	49 729	51 315	52 934	54 587	56 272
Sud Ubangi	Libenge	Rural	47 077	48 594	50 144	51 726	53 340	54 987
Sud Ubangi	Mawuya	Rural	33 999	35 095	36 214	37 357	38 523	39 712
Sud Ubangi	Mbaya	Rural	14 935	15 416	15 908	16 410	16 922	17 444
Sud Ubangi	Ndage	Rural	29 880	30 843	31 826	32 831	33 855	34 901
Sud Ubangi	Tandala	Rural	62 148	64 151	66 196	68 285	70 416	72 590
Sud Ubangi	Zongo	Urbano Rurale	17 674	18 243	18 825	19 419	20 025	20 643
Total Sud Ubangi			**641 708**	**662 391**	**683 516**	**705 082**	**727 089**	**749 536**
Tanganyika	Ankoro	Rural	73 783	76 161	78 590	81 069	83 600	86 180
Tanganyika	Kabalo	Rural	71 846	74 161	76 527	78 941	81 405	83 918
Tanganyika	Kalemie	Urbain	97 848	101 002	104 223	107 511	110 867	114 290
Tanganyika	Kansimba	Rural	47 777	49 317	50 889	52 495	54 133	55 805
Tanganyika	Kiambi	Rural	48 075	49 625	51 207	52 823	54 472	56 153
Tanganyika	Kongolo	Rural	90 073	92 976	95 941	98 968	102 057	105 208
Tanganyika	Manono	Rural	88 662	91 520	94 439	97 418	100 459	103 560
Tanganyika	Mbulula	Rural	55 523	57 312	59 140	61 006	62 910	64 852
Tanganyika	Moba	Rural	94 237	97 274	100 376	103 543	106 775	110 071
Tanganyika	Nyemba	Urbain	91 404	94 350	97 359	100 430	103 565	106 762
Tanganyika	Nyunzu	Rural	72 316	74 647	77 027	79 458	81 938	84 467
Total Tanganyika			**831 542**	**858 344**	**885 717**	**913 663**	**942 180**	**971 268**

Tshopo	Bafwagbogbo	Rural	12 155	12 547	12 947	13 356	13 773	14 198
Tshopo	Bafwasende	Rural	14 624	15 095	15 577	16 068	16 570	17 081
Tshopo	Banalia	Rural	25 072	25 880	26 705	27 548	28 407	29 285
Tshopo	Basali	Rural	16 628	17 164	17 711	18 270	18 840	19 422
Tshopo	Basoko	Rural	29 702	30 659	31 637	32 635	33 654	34 693
Tshopo	Bengamisa	Rural	20 471	21 131	21 805	22 493	23 195	23 911
Tshopo	Isangi	Rural	29 403	30 351	31 319	32 307	33 316	34 344
Tshopo	Kabondo	Urbano Rurale	30 181	31 153	32 147	33 161	34 196	35 252
Tshopo	Lowa	Rural	23 137	23 883	24 645	25 422	26 216	27 025
Tshopo	Lubunga	Urbano Rurale	26 632	27 491	28 367	29 262	30 176	31 107
Tshopo	Makiso Kisangani	Urbano Rurale	78 010	80 524	83 092	85 714	88 389	91 118
Tshopo	Mangobo	Urbain	37 295	38 497	39 725	40 978	42 257	43 561
Tshopo	Opala	Rural	23 229	23 978	24 742	25 523	26 320	27 132
Tshopo	Opienge	Rural	11 133	11 492	11 859	12 233	12 615	13 004
Tshopo	Tshopo	Urbano Rurale	33 171	34 240	35 332	36 447	37 584	38 745
Tshopo	Ubundu	Rural	17 831	18 406	18 993	19 592	20 204	20 828
Tshopo	Wanierukula	Rural	13 736	14 179	14 631	15 092	15 563	16 044
Tshopo	Yabaondo	Rural	29 392	30 339	31 307	32 294	33 302	34 330
Tshopo	Yahisuli	Rural	16 906	17 451	18 008	18 576	19 156	19 747
Tshopo	Yahuma	Rural	37 100	38 296	39 517	40 764	42 036	43 334
Tshopo	Yakusu	Rural	28 866	29 796	30 747	31 717	32 707	33 716
Tshopo	Yaleko	Rural	27 169	28 045	28 940	29 853	30 784	31 735
Tshopo	Yalimbongo	Rural	19 569	20 199	20 843	21 501	22 172	22 857
Total Tshopo			**601 412**	**620 796**	**640 594**	**660 806**	**681 431**	**702 469**
Tshuapa	Befale	Rural	38 044	39 270	40 523	41 801	43 106	44 437
Tshuapa	Boende	Urbano Rurale	54 096	55 840	57 621	59 439	61 294	63 186
Tshuapa	Bokungu	Rural	42 135	43 493	44 880	46 296	47 741	49 215
Tshuapa	Busanga	Rural	20 604	21 268	21 947	22 639	23 346	24 066
Tshuapa	Djolu	Rural	48 386	49 945	51 538	53 164	54 823	56 516
Tshuapa	Ikela	Rural	38 391	39 629	40 892	42 183	43 499	44 842
Tshuapa	Lingomo	Rural	27 683	28 576	29 487	30 417	31 367	32 335
Tshuapa	Mompono	Rural	29 183	30 124	31 085	32 066	33 066	34 087
Tshuapa	Mondombe	Rural	35 499	36 643	37 812	39 005	40 222	41 464
Tshuapa	Monkoto	Rural	25 623	26 448	27 292	28 153	29 032	29 928
Tshuapa	Wema	Rural	22 496	23 221	23 962	24 718	25 489	26 276
Tshuapa	Yalifafu	Rural	34 562	35 676	36 814	37 975	39 161	40 370
Total Tshuapa			**416 703**	**430 133**	**443 851**	**457 855**	**472 146**	**486 722**
Total RDC			**22 912 822**	**23 651 331**	**24 405 607**	**25 175 645**	**25 961 427**	**26 762 915**

Annexe 6 : Estimation besoin en RECO de 2025 à 2030, par ZS

Province	Zone de Santé	Milieu de vie	Besoin en RECO					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bas Uele	Aketi	Rural	611	631	651	671	692	713
Bas Uele	Ango	Rural	698	720	743	767	791	815
Bas Uele	Bili	Rural	291	300	310	319	329	339
Bas Uele	Bondo	Rural	665	687	709	731	754	777
Bas Uele	Buta	Urbain	597	616	636	656	676	697
Bas Uele	Ganga	Rural	565	583	602	621	640	660
Bas Uele	Likati	Rural	340	351	362	374	385	397
Bas Uele	Monga	Rural	355	366	378	390	402	414
Bas Uele	Poko	Rural	553	571	590	608	627	646
Bas Uele	Titule	Rural	358	370	381	393	406	418
Bas Uele	Viadana	Rural	492	508	524	541	557	575
Total Bas Uele			**5 525**	**5 703**	**5 885**	**6 070**	**6 260**	**6 453**
Equateur	Basankusu	Rural	798	823	850	876	904	932
Equateur	Bikoro	Rural	501	517	534	550	568	585
Equateur	Bolenge	Urbano Rurale	352	364	375	387	399	411
Equateur	Bolomba	Rural	881	909	938	968	998	1 029
Equateur	Bomongo	Rural	355	366	378	390	402	415
Equateur	Djombo	Rural	296	306	315	325	336	346
Equateur	Iboko	Rural	378	390	403	415	428	442
Equateur	Ingende	Rural	488	504	520	536	553	570
Equateur	Irebu	Rural	168	173	179	184	190	196
Equateur	Lilanga Bobangi	Rural	268	276	285	294	303	313
Equateur	Lotumbe	Rural	391	404	417	430	443	457
Equateur	Lukolela	Rural	479	495	510	527	543	560
Equateur	Makanza	Rural	420	434	447	461	476	491
Equateur	Mampoko	Rural	362	374	386	398	410	423
Equateur	Mbandaka	Urbano Rurale	718	741	765	789	813	838
Equateur	Monieka	Rural	251	259	267	276	284	293
Equateur	Ntondo	Rural	223	230	237	245	252	260
Equateur	Wangata	Urbain	431	445	459	474	489	504
Total Equateur			**7 760**	**8 010**	**8 265**	**8 526**	**8 792**	**9 064**
Haut Katanga	Kafubu	Rural	613	633	653	673	694	716
Haut Katanga	Kamalondo	Urbain	84	86	89	92	95	98
Haut Katanga	Kambove	Urbano Rurale	662	683	705	727	750	773
Haut Katanga	Kampemba	Urbain	1 130	1 167	1 204	1 242	1 280	1 320
Haut Katanga	Kapolowe	Rural	1 118	1 154	1 191	1 229	1 267	1 306

Haut Katanga	Kasenga	Rural	653	674	696	718	740	763
Haut Katanga	Kashobwe	Rural	575	593	612	632	651	671
Haut Katanga	Katuba	Urbain	368	380	392	404	417	430
Haut Katanga	Kenya	Urbain	627	648	668	689	711	733
Haut Katanga	Kikula	Urbain	660	682	704	726	748	771
Haut Katanga	Kilela Balanda	Rural	270	278	287	296	305	315
Haut Katanga	Kilwa	Rural	1 690	1 745	1 800	1 857	1 915	1 974
Haut Katanga	Kipushi	Urbano Rurale	890	919	948	978	1 008	1 040
Haut Katanga	Kisanga	Urbain	1 259	1 300	1 341	1 383	1 427	1 471
Haut Katanga	Kowe	Urbain	147	152	157	162	167	172
Haut Katanga	Likasi	Urbain	579	597	616	636	656	676
Haut Katanga	Lubumbashi	Urbain	727	751	775	799	824	849
Haut Katanga	Lukafu	Rural	558	576	594	613	632	652
Haut Katanga	Mitwaba	Urbain	416	430	444	458	472	486
Haut Katanga	Mufunga Sampwe	Rural	739	763	787	812	837	863
Haut Katanga	Mumbunda	Urbain	856	884	912	941	970	1 000
Haut Katanga	Panda	Urbain	234	242	250	258	266	274
Haut Katanga	Pweto	Rural	1 187	1 225	1 264	1 304	1 345	1 386
Haut Katanga	Ruashi	Urbain	1 635	1 687	1 741	1 796	1 852	1 909
Haut Katanga	Sakania	Rural	1 503	1 552	1 601	1 652	1 703	1 756
Haut Katanga	Tshamilemba	Urbain	625	645	665	686	708	730
Haut Katanga	Vangu	Urbain	382	394	407	419	432	446
Total Haut Katanga			**20 188**	**20 839**	**21 504**	**22 182**	**22 875**	**23 581**
Haut Lomami	Baka	Rural	143	147	152	157	162	167
Haut Lomami	Bukama	Rural	1 459	1 506	1 554	1 603	1 653	1 704
Haut Lomami	Butumba	Rural	861	889	917	946	976	1 006
Haut Lomami	Kabondo Dianda	Rural	1 089	1 124	1 160	1 196	1 234	1 272
Haut Lomami	Kabongo	Urbano Rurale	1 590	1 641	1 694	1 747	1 802	1 857
Haut Lomami	Kamina	Urbain	861	889	918	946	976	1 006
Haut Lomami	Kaniama	Rural	1 266	1 306	1 348	1 391	1 434	1 478
Haut Lomami	Kayamba	Rural	440	454	469	484	499	514
Haut Lomami	Kinda	Rural	384	396	409	422	435	448
Haut Lomami	Kinkondja	Rural	1 185	1 223	1 262	1 302	1 343	1 384
Haut Lomami	Kitenge	Rural	1 201	1 239	1 279	1 319	1 360	1 402
Haut Lomami	Lwamba	Rural	590	609	629	648	669	689
Haut Lomami	Malemba Nkulu	Rural	1 480	1 527	1 576	1 626	1 676	1 728
Haut Lomami	Mukanga	Rural	880	909	938	967	997	1 028
Haut Lomami	Mulongo	Rural	1 342	1 385	1 430	1 475	1 521	1 568
Haut Lomami	Songa	Rural	843	870	897	926	955	984
Total Haut Lomami			**15 613**	**16 116**	**16 630**	**17 155**	**17 691**	**18 237**
Haut Uele	Aba	Rural	781	806	832	858	885	912

Haut Uele	Boma Mangbetu	Rural	545	562	580	598	617	636
Haut Uele	Doruma	Rural	345	356	367	379	391	403
Haut Uele	Dungu	Rural	687	709	731	755	778	802
Haut Uele	Faradje	Rural	614	634	654	675	696	717
Haut Uele	Gombari	Rural	558	576	594	613	632	651
Haut Uele	Isiro	Urbano Rurale	1 327	1 370	1 413	1 458	1 503	1 550
Haut Uele	Makoro	Rural	690	712	735	758	782	806
Haut Uele	Niangara	Rural	557	575	593	612	631	650
Haut Uele	Pawa	Rural	839	866	893	922	950	980
Haut Uele	Rungu	Rural	566	584	603	622	641	661
Haut Uele	Wamba	Rural	653	674	696	718	740	763
Haut Uele	Watsa	Urbano Rurale	1 371	1 415	1 461	1 507	1 554	1 602
Total Haut Uele			**9 531**	**9 838**	**10 152**	**10 473**	**10 799**	**11 133**
Ituri	Adi	Rural	550	568	586	604	623	642
Ituri	Adja	Rural	439	453	468	482	498	513
Ituri	Angumu	Rural	575	594	613	632	652	672
Ituri	Ariwara	Rural	707	730	753	777	802	826
Ituri	Aru	Rural	619	639	660	681	702	723
Ituri	Aungba	Rural	571	589	608	627	646	666
Ituri	Bambu	Rural	491	506	523	539	556	573
Ituri	Biringi	Rural	426	440	454	468	483	498
Ituri	Boga	Rural	226	233	240	248	256	264
Ituri	Bunia	Urbano Rurale	1 104	1 140	1 176	1 213	1 251	1 290
Ituri	Damas	Rural	380	392	405	417	430	444
Ituri	Drodro	Rural	507	524	540	557	575	593
Ituri	Fataki	Rural	430	444	458	472	487	502
Ituri	Gety	Rural	646	666	688	709	731	754
Ituri	Jiba	Rural	327	338	349	360	371	382
Ituri	Kambala	Rural	447	461	476	491	506	522
Ituri	Kilo	Rural	168	173	179	184	190	196
Ituri	Komanda	Rural	802	827	854	881	908	936
Ituri	Laybo	Rural	498	515	531	548	565	582
Ituri	Linga	Rural	461	476	491	506	522	538
Ituri	Lita	Rural	437	451	466	480	495	511
Ituri	Logo	Rural	797	823	849	876	904	931
Ituri	Lolwa	Rural	318	328	338	349	360	371
Ituri	Mahagi	Rural	648	669	691	713	735	757
Ituri	Mambasa	Rural	331	341	352	363	374	386
Ituri	Mandima	Rural	503	519	536	553	570	588
Ituri	Mangala	Rural	329	339	350	361	373	384
Ituri	Mongbwalu	Rural	451	466	481	496	512	527

Ituri	Nia Nia	Rural	340	351	363	374	386	398
Ituri	Nizi	Rural	657	678	700	722	745	768
Ituri	Nyankunde	Rural	324	334	345	356	367	378
Ituri	Nyarambe	Rural	722	745	769	793	818	843
Ituri	Rethy	Rural	683	705	727	750	774	798
Ituri	Rimba	Rural	721	744	768	792	817	842
Ituri	Rwampara	Urbano Rurale	670	691	713	736	759	782
Ituri	Tchomia	Rural	366	378	390	402	415	428
Total Ituri			**18 671**	**19 273**	**19 888**	**20 515**	**21 156**	**21 809**
Kongo Central	Boko Kivulu	Rural	1 478	1 525	1 574	1 624	1 674	1 726
Kongo Central	Boma Bungu	Rural	779	804	829	855	882	909
Kongo Central	Boma	Urbain	1 145	1 182	1 219	1 258	1 297	1 337
Kongo Central	Gombe Matadi	Rural	752	777	801	827	852	879
Kongo Central	Inga	Rural	701	724	747	770	794	819
Kongo Central	Kangu	Rural	804	830	857	884	911	940
Kongo Central	Kibunzi	Rural	529	546	564	582	600	618
Kongo Central	Kimpangu	Rural	928	958	988	1 019	1 051	1 084
Kongo Central	Kimpese	Rural	1 316	1 358	1 402	1 446	1 491	1 537
Kongo Central	Kimvula	Rural	635	656	676	698	720	742
Kongo Central	Kinkonzi	Rural	553	571	589	608	627	646
Kongo Central	Kisantu	Urbano Rurale	1 461	1 508	1 556	1 605	1 656	1 707
Kongo Central	Kitona	Urbano Rurale	773	798	823	849	876	903
Kongo Central	Kizu	Rural	499	515	532	549	566	583
Kongo Central	Kuimba	Rural	778	804	829	855	882	909
Kongo Central	Kwilu Ngongo	Urbano Rurale	1 070	1 104	1 139	1 175	1 212	1 250
Kongo Central	Lukula	Rural	1 285	1 326	1 369	1 412	1 456	1 501
Kongo Central	Luozi	Rural	796	821	848	874	902	929
Kongo Central	Mangembo	Rural	549	567	585	603	622	641
Kongo Central	Massa	Rural	814	841	867	895	923	951
Kongo Central	Matadi	Urbain	1 335	1 378	1 422	1 467	1 513	1 560
Kongo Central	Mbanza Ngungu	Urbano Rurale	1 059	1 093	1 128	1 164	1 200	1 237
Kongo Central	Muanda	Urbano Rurale	1 324	1 367	1 410	1 455	1 500	1 546
Kongo Central	Ngidinga	Rural	1 041	1 075	1 109	1 144	1 180	1 216
Kongo Central	Nselo	Rural	742	766	790	815	841	867
Kongo Central	Nsona Mpangu	Rural	827	854	881	909	937	966
Kongo Central	Nzanza	Urbain	814	840	867	894	922	950
Kongo Central	Seke Banza	Rural	1 142	1 178	1 216	1 254	1 293	1 333
Kongo Central	Sona Bata	Rural	804	830	856	883	911	939
Kongo Central	Tshela	Rural	670	692	714	737	760	783
Kongo Central	Vaku	Rural	601	620	640	660	681	702
Total Kongo Central			**28 004**	**28 907**	**29 829**	**30 770**	**31 730**	**32 710**

Kasai Oriental	Bibanga	Urbain	369	381	393	406	418	431
Kasai Oriental	Bipemba	Urbain	863	890	919	948	977	1 008
Kasai Oriental	Bonzola	Urbain	440	454	469	483	498	514
Kasai Oriental	Cilundu	Rural	673	695	717	739	762	786
Kasai Oriental	Citenge	Urbano Rurale	863	891	920	949	978	1 008
Kasai Oriental	Dibindi	Urbain	651	672	693	715	737	760
Kasai Oriental	Diulu	Urbain	898	927	956	987	1 017	1 049
Kasai Oriental	Kabeya Kamwanga	Rural	723	746	770	794	819	844
Kasai Oriental	Kansele	Urbain	616	636	656	677	698	720
Kasai Oriental	Kasansa	Urbano Rurale	747	771	796	821	846	873
Kasai Oriental	Lubilanji	Urbain	619	639	660	681	702	723
Kasai Oriental	Lukelenge	Rural	998	1 030	1 063	1 096	1 130	1 165
Kasai Oriental	Miabi	Rural	567	585	604	623	642	662
Kasai Oriental	Mpokolo	Urbain	675	697	719	741	765	788
Kasai Oriental	Mukumbi	Rural	535	552	569	587	606	624
Kasai Oriental	Muya	Urbain	803	829	856	883	910	938
Kasai Oriental	Nzaba	Urbain	707	730	753	777	801	826
Kasai Oriental	Tshilenge	Rural	1 053	1 087	1 122	1 157	1 193	1 230
Kasai Oriental	Tshishimbi	Rural	655	676	698	720	742	765
Total Kasai Orienatal			**13 455**	**13 888**	**14 331**	**14 784**	**15 245**	**15 716**
Kwango	Boko	Rural	997	1 030	1 062	1 096	1 130	1 165
Kwango	Feshi	Rural	685	707	730	753	777	800
Kwango	Kahemba	Rural	1 240	1 280	1 321	1 363	1 406	1 449
Kwango	Kajiji	Rural	722	745	769	793	818	843
Kwango	Kasongo Lunda	Rural	773	797	823	849	875	902
Kwango	Kenge	Urbano Rurale	1 302	1 344	1 386	1 430	1 475	1 520
Kwango	Kimbao	Rural	926	956	986	1 017	1 049	1 082
Kwango	Kisanji	Rural	557	575	593	612	631	650
Kwango	Kitenda	Rural	731	755	779	803	828	854
Kwango	Mwela Lembwa	Rural	461	476	491	506	522	538
Kwango	Panzi	Rural	823	849	876	904	932	961
Kwango	Popokabaka	Rural	1 033	1 066	1 100	1 135	1 170	1 206
Kwango	Tembo	Rural	477	492	508	524	541	557
Kwango	Wamba Lwadi	Rural	529	546	563	581	599	618
Total Kwango			**11 255**	**11 618**	**11 988**	**12 366**	**12 752**	**13 146**
Kwilu	Bagata	Rural	1 036	1 069	1 103	1 138	1 174	1 210
Kwilu	Bandundu	Urbain	812	838	865	892	920	948
Kwilu	Bulungu	Rural	1 612	1 664	1 717	1 771	1 826	1 882
Kwilu	Djuma	Rural	1 269	1 310	1 352	1 395	1 438	1 483
Kwilu	Gungu	Rural	1 459	1 506	1 554	1 603	1 653	1 704
Kwilu	Idiofa	Rural	1 679	1 734	1 789	1 845	1 903	1 962

Kwilu	Ipamu	Rural	1 192	1 231	1 270	1 310	1 351	1 393
Kwilu	Kikongo	Rural	1 096	1 132	1 168	1 204	1 242	1 280
Kwilu	Kikwit Nord	Urbain	929	959	990	1 021	1 053	1 085
Kwilu	Kikwit Sud	Urbain	997	1 030	1 062	1 096	1 130	1 165
Kwilu	Kimputu	Rural	1 153	1 190	1 228	1 267	1 306	1 347
Kwilu	Kingandu	Rural	634	654	675	696	718	740
Kwilu	Koshibanda	Rural	1 198	1 237	1 276	1 316	1 358	1 399
Kwilu	Lusanga	Rural	1 596	1 648	1 700	1 754	1 809	1 865
Kwilu	Masi Manimba	Rural	1 394	1 438	1 484	1 531	1 579	1 628
Kwilu	Moanza	Rural	1 015	1 047	1 081	1 115	1 150	1 185
Kwilu	Mokala	Rural	1 270	1 311	1 353	1 396	1 439	1 484
Kwilu	Mosango	Rural	710	733	757	781	805	830
Kwilu	Mukedi	Rural	1 040	1 073	1 108	1 143	1 178	1 215
Kwilu	Mungindu	Rural	750	774	799	824	850	876
Kwilu	Pay Kongila	Rural	878	906	935	965	995	1 025
Kwilu	Sia	Rural	646	667	688	709	732	754
Kwilu	Vanga	Rural	1 684	1 739	1 794	1 851	1 909	1 967
Kwilu	Yasa Bonga	Rural	1 320	1 362	1 406	1 450	1 496	1 542
Total Kwilu			**27 369**	**28 251**	**29 152**	**30 072**	**31 011**	**31 968**
Kinshasa	Bandalungwa	Urbain	722	746	769	794	819	844
Kinshasa	Barumbu	Urbain	786	811	837	863	890	917
Kinshasa	Binza Meteo	Urbain	2 299	2 373	2 449	2 526	2 605	2 686
Kinshasa	Binza Ozone	Urbain	1 632	1 684	1 738	1 793	1 849	1 906
Kinshasa	Biyela	Urbain	1 085	1 120	1 156	1 192	1 229	1 267
Kinshasa	Bumbu	Urbain	1 628	1 681	1 734	1 789	1 845	1 902
Kinshasa	Gombe	Urbain	460	474	489	505	521	537
Kinshasa	Kalamu 1	Urbain	1 177	1 215	1 253	1 293	1 333	1 374
Kinshasa	Kalamu 2	Urbain	993	1 025	1 058	1 092	1 126	1 160
Kinshasa	Kasa Vubu	Urbain	697	720	743	766	790	814
Kinshasa	Kikimi	Urbain	1 347	1 391	1 435	1 480	1 526	1 573
Kinshasa	Kimbanseke	Urbain	1 344	1 387	1 432	1 477	1 523	1 570
Kinshasa	Kingabwa	Urbain	1 169	1 207	1 245	1 285	1 325	1 366
Kinshasa	Kingasani	Urbain	1 139	1 176	1 214	1 252	1 291	1 331
Kinshasa	Kinshasa	Urbain	947	977	1 008	1 040	1 073	1 106
Kinshasa	Kintambo	Urbain	400	413	426	440	453	467
Kinshasa	Kisenso	Urbain	1 835	1 894	1 954	2 016	2 079	2 143
Kinshasa	Kokolo	Urbain	1 730	1 786	1 843	1 901	1 960	2 021
Kinshasa	Lemba	Urbain	1 040	1 073	1 108	1 143	1 178	1 215
Kinshasa	Limete	Urbain	1 286	1 327	1 370	1 413	1 457	1 502
Kinshasa	Lingwala	Urbain	443	457	472	486	502	517
Kinshasa	Makala	Urbain	1 554	1 604	1 655	1 708	1 761	1 815

Kinshasa	Maluku 1	Urbano Rurale	1 609	1 661	1 714	1 768	1 823	1 879
Kinshasa	Maluku 2	Urbano Rurale	631	651	672	693	715	737
Kinshasa	Masina 1	Urbain	2 599	2 683	2 769	2 856	2 945	3 036
Kinshasa	Masina 2	Urbain	1 535	1 585	1 635	1 687	1 739	1 793
Kinshasa	Matete	Urbain	1 350	1 393	1 438	1 483	1 529	1 576
Kinshasa	Mont Ngafula 1	Urbano Rurale	2 216	2 287	2 360	2 434	2 510	2 588
Kinshasa	Mont Ngafula 2	Urbano Rurale	1 497	1 545	1 594	1 645	1 696	1 748
Kinshasa	Ndjili	Urbain	1 558	1 609	1 660	1 712	1 766	1 820
Kinshasa	Ngaba	Urbain	883	911	940	970	1 000	1 031
Kinshasa	Ngiri Ngiri	Urbain	1 290	1 331	1 374	1 417	1 461	1 506
Kinshasa	Nsele	Urbano Rurale	2 800	2 890	2 982	3 076	3 172	3 270
Kinshasa	Police	Urbain	630	650	671	692	713	735
Kinshasa	Selembao	Urbain	1 827	1 886	1 946	2 008	2 070	2 134
Total Kinshasa			**46 136**	**47 623**	**49 141**	**50 692**	**52 274**	**53 888**
Kasai Central	Bena Leka	Rural	1 130	1 167	1 204	1 242	1 281	1 320
Kasai Central	Bena Tshadi	Rural	449	463	478	493	509	524
Kasai Central	Bilomba	Rural	360	371	383	395	407	420
Kasai Central	Bobozo	Rural	200	206	213	220	226	233
Kasai Central	Bunkonde	Rural	447	462	476	491	507	522
Kasai Central	Demba	Rural	1 328	1 370	1 414	1 459	1 504	1 551
Kasai Central	Dibaya	Rural	710	733	757	781	805	830
Kasai Central	Kalomba	Urbain	425	439	453	467	482	496
Kasai Central	Kananga	Urbain	744	768	792	817	843	869
Kasai Central	Katende	Rural	376	388	400	413	426	439
Kasai Central	Katoka	Urbain	353	365	376	388	400	413
Kasai Central	Luambo	Rural	1 072	1 107	1 142	1 178	1 215	1 253
Kasai Central	Lubondaie	Rural	591	610	630	650	670	691
Kasai Central	Lubunga	Rural	407	420	433	447	461	475
Kasai Central	Luiza	Rural	678	700	722	745	768	792
Kasai Central	Lukonga	Urbain	713	736	760	784	808	833
Kasai Central	Masuika	Rural	921	951	981	1 012	1 043	1 076
Kasai Central	Mikalayi	Rural	793	818	845	871	898	926
Kasai Central	Muetshi	Rural	449	463	478	493	509	524
Kasai Central	Mutoto	Rural	523	539	557	574	592	610
Kasai Central	Ndekesha	Rural	654	676	697	719	742	764
Kasai Central	Ndesha	Urbain	275	284	293	302	311	321
Kasai Central	Tshibala	Rural	959	990	1 022	1 054	1 087	1 120
Kasai Central	Tshikaji	Urbain	325	335	346	357	368	379
Kasai Central	Tshikula	Rural	524	541	558	576	594	612
Kasai Central	Yangala	Rural	613	633	653	674	695	716
Total Kasai Central			**16 019**	**16 536**	**17 063**	**17 601**	**18 151**	**18 711**

Kasai	Banga Lubaka	Rural	551	568	587	605	624	643
Kasai	Bulape	Rural	599	618	638	658	678	699
Kasai	Dekese	Rural	606	626	646	666	687	708
Kasai	Ilebo	Rural	630	650	671	692	714	736
Kasai	Kakenge	Rural	646	666	688	709	732	754
Kasai	Kalonda Ouest	Rural	1 317	1 359	1 402	1 447	1 492	1 538
Kasai	Kamonia	Rural	1 312	1 354	1 397	1 441	1 486	1 532
Kasai	Kamwesha	Rural	1 451	1 498	1 546	1 595	1 645	1 695
Kasai	Kanzala	Urbain	550	568	586	605	624	643
Kasai	Kitangwa	Rural	877	905	934	963	993	1 024
Kasai	Luebo	Rural	873	901	929	959	989	1 019
Kasai	Mikope	Rural	639	659	680	702	724	746
Kasai	Mushenge	Rural	575	594	613	632	652	672
Kasai	Mutena	Rural	878	907	935	965	995	1 026
Kasai	Mweka	Rural	819	846	873	900	928	957
Kasai	Ndjoko Mpunda	Rural	524	541	558	576	594	612
Kasai	Nyanga	Rural	416	430	443	457	472	486
Kasai	Tshikapa	Rural	1 207	1 246	1 285	1 326	1 367	1 410
Total Kasai			**14 469**	**14 935**	**15 412**	**15 898**	**16 394**	**16 900**
Lualaba	Bunkeya	Rural	294	304	313	323	333	344
Lualaba	Dilala	Urbain	850	877	905	934	963	993
Lualaba	Dilolo	Rural	965	996	1 028	1 060	1 093	1 127
Lualaba	Fungurume	Rural	1 720	1 775	1 832	1 890	1 949	2 009
Lualaba	Kafakumba	Rural	662	683	705	727	750	773
Lualaba	Kalamba	Rural	644	664	686	707	729	752
Lualaba	Kanzenze	Rural	1 130	1 166	1 203	1 241	1 280	1 319
Lualaba	Kapanga	Rural	798	824	850	877	904	932
Lualaba	Kasaji	Rural	1 386	1 430	1 476	1 523	1 570	1 619
Lualaba	Lualaba	Rural	895	923	953	983	1 014	1 045
Lualaba	Lubudi	Rural	599	618	638	658	678	699
Lualaba	Manika	Urbain	1 348	1 392	1 436	1 481	1 528	1 575
Lualaba	Mutshatsha	Rural	399	412	425	439	453	466
Lualaba	Sandoa	Rural	1 155	1 192	1 230	1 269	1 309	1 349
Total Lualaba			**12 844**	**13 258**	**13 681**	**14 112**	**14 553**	**15 002**
Lomami	Kabinda	Urbain	797	823	849	876	903	931
Lomami	Kalambayi Kabanga	Rural	704	727	750	774	798	822
Lomami	Kalenda	Rural	710	733	756	780	804	829
Lomami	Kalonda Est	Rural	817	843	870	898	926	954
Lomami	Kamana	Rural	700	723	746	769	793	818
Lomami	Kamiji	Rural	347	358	369	381	393	405
Lomami	Kanda Kanda	Rural	819	846	873	900	928	957

Lomami	Lubao	Rural	773	798	824	849	876	903
Lomami	Ludimbi Lukula	Rural	558	576	594	613	632	652
Lomami	Luputa	Rural	967	998	1 030	1 063	1 096	1 130
Lomami	Makota	Urbain	552	570	588	607	626	645
Lomami	Mulumba	Rural	1 113	1 149	1 186	1 223	1 262	1 301
Lomami	Mweneditu	Urbain	1 009	1 042	1 075	1 109	1 143	1 179
Lomami	Ngandajika	Urbano Rurale	1 085	1 120	1 156	1 192	1 230	1 268
Lomami	Tshofa	Rural	486	502	518	534	551	568
Lomami	Wikong	Rural	431	444	459	473	488	503
Total Lomami			**11 869**	**12 252**	**12 643**	**13 042**	**13 449**	**13 864**
Mai Ndombe	Banzow Moke	Rural	650	671	692	714	736	759
Mai Ndombe	Bokoro	Rural	1 131	1 168	1 205	1 243	1 282	1 321
Mai Ndombe	Bolobo	Rural	708	730	754	778	802	827
Mai Ndombe	Bosobe	Rural	658	679	701	723	746	769
Mai Ndombe	Inongo	Urbano Rurale	1 096	1 131	1 167	1 204	1 242	1 280
Mai Ndombe	Kiri	Rural	592	611	631	651	671	692
Mai Ndombe	Kwamouth	Rural	795	821	847	874	901	929
Mai Ndombe	Mimia	Rural	287	296	305	315	325	335
Mai Ndombe	Mushie	Rural	684	706	729	752	775	799
Mai Ndombe	Nioki	Rural	835	862	889	917	946	975
Mai Ndombe	Ntandembelo	Rural	447	462	477	492	507	523
Mai Ndombe	Oshwe	Rural	764	789	814	840	866	893
Mai Ndombe	Pendjwa	Rural	450	465	480	495	510	526
Mai Ndombe	Yumbi	Rural	601	620	640	660	681	702
Total Mai Ndombe			**9 699**	**10 012**	**10 331**	**10 657**	**10 989**	**11 329**
Mongala	Binga	Rural	985	1 016	1 049	1 082	1 116	1 150
Mongala	Bongandanga	Rural	578	597	616	635	655	676
Mongala	Boso Manzi	Rural	572	590	609	628	648	668
Mongala	Boso Mondanda	Rural	589	608	627	647	667	688
Mongala	Bosondjo	Rural	796	822	848	875	902	930
Mongala	Bumba	Urbano Rurale	865	893	921	950	980	1 010
Mongala	Lisala	Urbano Rurale	1 108	1 144	1 180	1 217	1 255	1 294
Mongala	Lolo	Rural	537	555	572	590	609	628
Mongala	Pimu	Rural	936	966	997	1 028	1 061	1 093
Mongala	Yamaluka	Rural	537	554	571	590	608	627
Mongala	Yambuku	Rural	1 048	1 082	1 116	1 151	1 187	1 224
Mongala	Yamongili	Rural	534	551	568	586	605	623
Total Mongala			**9 084**	**9 377**	**9 676**	**9 981**	**10 293**	**10 610**
Maniema	Alunguli	Rural	404	417	430	444	458	472
Maniema	Ferekeni	Rural	261	269	278	287	296	305

Maniema	Kabambare	Rural	681	702	725	748	771	795
Maniema	Kailo	Rural	812	838	864	892	920	948
Maniema	Kalima	Rural	684	706	728	751	775	799
Maniema	Kampene	Rural	751	775	800	825	851	877
Maniema	Kasongo	Rural	1 112	1 148	1 185	1 222	1 260	1 299
Maniema	Kibombo	Rural	500	516	532	549	566	584
Maniema	Kindu	Urbain	822	849	876	903	932	960
Maniema	Kunda	Rural	1 388	1 433	1 478	1 525	1 573	1 621
Maniema	Lubutu	Rural	634	655	676	697	719	741
Maniema	Lusangi	Rural	809	835	862	889	917	945
Maniema	Obokote	Rural	364	376	388	400	413	426
Maniema	Pangi	Rural	437	451	466	480	495	510
Maniema	Punia	Rural	567	585	604	623	642	662
Maniema	Samba	Rural	585	603	623	642	662	683
Maniema	Saramabila	Rural	717	740	763	787	812	837
Maniema	Tunda	Rural	426	440	454	468	483	498
Total Maniema			**11 953**	**12 338**	**12 731**	**13 133**	**13 543**	**13 961**
Nord Kivu	Alimbongo	Rural	977	1 009	1 041	1 074	1 107	1 142
Nord Kivu	Bambo	Rural	695	718	741	764	788	812
Nord Kivu	Beni	Urbain	1 162	1 199	1 237	1 276	1 316	1 357
Nord Kivu	Biena	Rural	541	559	577	595	613	632
Nord Kivu	Binza	Rural	718	741	765	789	814	839
Nord Kivu	Birambizo	Rural	787	813	839	865	892	920
Nord Kivu	Butembo	Urbain	584	603	623	642	662	683
Nord Kivu	Goma	Urbain	717	740	764	788	813	838
Nord Kivu	Itebero	Rural	777	802	828	854	881	908
Nord Kivu	Kalunguta	Rural	779	804	830	856	883	910
Nord Kivu	Kamango	Rural	480	496	511	528	544	561
Nord Kivu	Karisimbi	Urbain	1 448	1 495	1 542	1 591	1 641	1 691
Nord Kivu	Katoyi	Rural	1 251	1 291	1 332	1 374	1 417	1 461
Nord Kivu	Katwa	Urbano Rurale	1 805	1 864	1 923	1 984	2 046	2 109
Nord Kivu	Kayna	Rural	1 482	1 530	1 579	1 629	1 680	1 732
Nord Kivu	Kibirizi	Rural	1 409	1 454	1 500	1 548	1 596	1 645
Nord Kivu	Kibua	Rural	468	483	498	514	530	546
Nord Kivu	Kirotshe	Rural	1 698	1 753	1 809	1 866	1 924	1 984
Nord Kivu	Kyondo	Rural	758	782	807	832	858	885
Nord Kivu	Lubero	Rural	1 180	1 218	1 257	1 297	1 337	1 379
Nord Kivu	Mabalako	Rural	799	825	851	878	905	933
Nord Kivu	Manguredjipa	Rural	319	329	340	350	361	372
Nord Kivu	Masereka	Rural	621	641	662	682	704	725
Nord Kivu	Masisi	Rural	1 492	1 540	1 589	1 639	1 690	1 742

Nord Kivu	Musienene	Rural	1 053	1 087	1 122	1 157	1 193	1 230
Nord Kivu	Mutwanga	Rural	1 162	1 199	1 238	1 277	1 316	1 357
Nord Kivu	Mweso	Rural	1 711	1 767	1 823	1 880	1 939	1 999
Nord Kivu	Nyiragongo	Urbano Rurale	1 232	1 271	1 312	1 353	1 396	1 439
Nord Kivu	Oicha	Rural	1 167	1 204	1 243	1 282	1 322	1 363
Nord Kivu	Pinga	Rural	703	726	749	772	796	821
Nord Kivu	Rutshuru	Rural	1 078	1 113	1 148	1 185	1 222	1 259
Nord Kivu	Rwanguba	Rural	1 102	1 137	1 173	1 210	1 248	1 287
Nord Kivu	Vuhovi	Rural	495	511	527	544	561	578
Nord Kivu	Walikale	Rural	676	698	720	743	766	790
Total Nord Kivu			**33 328**	**34 402**	**35 499**	**36 619**	**37 762**	**38 928**
Nord Ubangi	Abuzi	Rural	349	360	372	384	396	408
Nord Ubangi	Bili	Rural	832	859	886	914	943	972
Nord Ubangi	Bosobolo	Rural	744	768	793	818	844	870
Nord Ubangi	Businga	Rural	543	561	579	597	615	634
Nord Ubangi	Gbadolite	Urbano Rurale	756	781	806	831	857	883
Nord Ubangi	Karawa	Rural	1 128	1 165	1 202	1 240	1 278	1 318
Nord Ubangi	Loko	Rural	553	571	589	608	627	646
Nord Ubangi	Mobayi Mbongo	Rural	593	612	631	651	671	692
Nord Ubangi	Wapinda	Rural	335	346	357	368	379	391
Nord Ubangi	Wasolo	Rural	339	350	361	372	384	396
Nord Ubangi	Yakoma	Rural	466	481	496	512	528	544
Total Nord Ubangi			**6 638**	**6 852**	**7 071**	**7 294**	**7 522**	**7 754**
Sud Kivu	Bagira	Urbain	380	392	405	418	431	444
Sud Kivu	Bunyakiri	Rural	1 056	1 090	1 124	1 160	1 196	1 233
Sud Kivu	Fizi	Rural	1 718	1 773	1 830	1 887	1 946	2 006
Sud Kivu	Haut Plateau	Rural	614	634	654	675	696	717
Sud Kivu	Ibanda	Urbain	1 209	1 248	1 288	1 329	1 370	1 413
Sud Kivu	Idjwi	Rural	1 167	1 205	1 243	1 282	1 322	1 363
Sud Kivu	Itombwe	Rural	412	425	439	453	467	481
Sud Kivu	Kabare	Rural	877	905	934	963	993	1 024
Sud Kivu	Kadutu	Urbain	1 007	1 039	1 073	1 106	1 141	1 176
Sud Kivu	Kalehe	Rural	734	757	782	806	831	857
Sud Kivu	Kalole	Rural	601	621	640	661	681	702
Sud Kivu	Kalonge	Rural	816	842	869	896	924	953
Sud Kivu	Kamituga	Rural	825	852	879	907	935	964
Sud Kivu	Kaniola	Rural	762	787	812	837	864	890
Sud Kivu	Katana	Rural	941	971	1 002	1 034	1 066	1 099
Sud Kivu	Kaziba	Rural	539	557	575	593	611	630
Sud Kivu	Kimbi Lulenge	Rural	1 504	1 552	1 602	1 652	1 704	1 756
Sud Kivu	Kitutu	Rural	758	783	808	833	859	886

Sud Kivu	Lemera	Rural	751	776	800	826	851	878
Sud Kivu	Lulingu	Rural	778	803	829	855	881	909
Sud Kivu	Minembwe	Rural	395	408	421	434	448	461
Sud Kivu	Minova	Rural	1 388	1 433	1 479	1 525	1 573	1 621
Sud Kivu	Miti Murhesa	Rural	1 072	1 106	1 142	1 178	1 214	1 252
Sud Kivu	Mubumbano	Rural	808	834	860	888	915	943
Sud Kivu	Mulungu	Rural	679	701	724	746	770	794
Sud Kivu	Mwana	Rural	577	595	614	634	654	674
Sud Kivu	Mwenga	Rural	597	616	636	656	676	697
Sud Kivu	Nundu	Rural	981	1 012	1 045	1 078	1 111	1 146
Sud Kivu	Nyangezi	Rural	721	744	768	792	817	842
Sud Kivu	Nyantende	Rural	593	612	632	652	672	693
Sud Kivu	Ruzizi	Rural	740	763	788	813	838	864
Sud Kivu	Shabunda	Rural	761	785	810	836	862	889
Sud Kivu	Uvira	Rural	1 405	1 450	1 496	1 543	1 592	1 641
Sud Kivu	Walungu	Rural	1 120	1 157	1 193	1 231	1 269	1 309
Total Sud Kivu			**29 285**	**30 229**	**31 193**	**32 177**	**33 181**	**34 206**
Sankuru	Bena Dibele	Rural	653	674	696	718	740	763
Sankuru	Dikungu	Rural	756	780	805	830	856	883
Sankuru	Djalo Ndjeka	Rural	470	485	500	516	532	549
Sankuru	Katako Kombe	Rural	690	712	735	758	782	806
Sankuru	Kole	Rural	680	702	724	747	771	794
Sankuru	Lodja	Urbain	1 138	1 175	1 212	1 250	1 289	1 329
Sankuru	Lomela	Rural	648	669	690	712	735	757
Sankuru	Lusambo	Urbain	458	473	488	503	519	535
Sankuru	Minga	Rural	795	821	847	874	901	929
Sankuru	Omendjadi	Rural	803	829	855	882	909	938
Sankuru	Ototo	Rural	726	749	773	797	822	847
Sankuru	Pania Mutombo	Rural	458	473	488	504	519	535
Sankuru	Tshudi Loto	Rural	413	427	440	454	468	483
Sankuru	Tshumbe	Rural	551	569	587	605	624	644
Sankuru	Vanga Kete	Rural	673	694	717	739	762	786
Sankuru	Wembo Nyama	Rural	549	567	585	603	622	641
Total Sankuru			**10 461**	**10 799**	**11 143**	**11 495**	**11 853**	**12 219**
Sud Ubangi	Bangabola	Rural	633	653	674	695	717	739
Sud Ubangi	Bogosenubea	Rural	743	767	791	816	842	868
Sud Ubangi	Bokonzi	Rural	1 011	1 044	1 077	1 111	1 146	1 181
Sud Ubangi	Bominenge	Rural	697	719	742	766	789	814
Sud Ubangi	Boto	Rural	803	829	856	883	910	938
Sud Ubangi	Budjala	Rural	599	619	639	659	679	700

Sud Ubangi	Bulu	Rural	722	745	769	793	818	843
Sud Ubangi	Bwamanda	Rural	999	1 032	1 065	1 098	1 132	1 167
Sud Ubangi	Gemena	Urbano Rurale	1 549	1 599	1 650	1 702	1 755	1 809
Sud Ubangi	Kungu	Rural	964	995	1 026	1 059	1 092	1 125
Sud Ubangi	Libenge	Rural	942	972	1 003	1 035	1 067	1 100
Sud Ubangi	Mawuya	Rural	680	702	724	747	770	794
Sud Ubangi	Mbaya	Rural	299	308	318	328	338	349
Sud Ubangi	Ndage	Rural	598	617	637	657	677	698
Sud Ubangi	Tandala	Rural	1 243	1 283	1 324	1 366	1 408	1 452
Sud Ubangi	Zongo	Urbano Rurale	353	365	377	388	401	413
Total Sud Ubangi			**12 834**	**13 248**	**13 670**	**14 102**	**14 542**	**14 991**
Tanganyika	Ankoro	Rural	1 476	1 523	1 572	1 621	1 672	1 724
Tanganyika	Kabalo	Rural	1 437	1 483	1 531	1 579	1 628	1 678
Tanganyika	Kalemie	Urbain	1 305	1 347	1 390	1 433	1 478	1 524
Tanganyika	Kansimba	Rural	956	986	1 018	1 050	1 083	1 116
Tanganyika	Kiambi	Rural	962	992	1 024	1 056	1 089	1 123
Tanganyika	Kongolo	Rural	1 801	1 860	1 919	1 979	2 041	2 104
Tanganyika	Manono	Rural	1 773	1 830	1 889	1 948	2 009	2 071
Tanganyika	Mbulula	Rural	1 110	1 146	1 183	1 220	1 258	1 297
Tanganyika	Moba	Rural	1 885	1 945	2 008	2 071	2 135	2 201
Tanganyika	Nyemba	Urbain	1 219	1 258	1 298	1 339	1 381	1 423
Tanganyika	Nyunzu	Rural	1 446	1 493	1 541	1 589	1 639	1 689
Total Tanganyika			**15 369**	**15 865**	**16 370**	**16 887**	**17 414**	**17 952**
Tshopo	Bafwagbogbo	Rural	243	251	259	267	275	284
Tshopo	Bafwasende	Rural	292	302	312	321	331	342
Tshopo	Banalia	Rural	501	518	534	551	568	586
Tshopo	Basali	Rural	333	343	354	365	377	388
Tshopo	Basoko	Rural	594	613	633	653	673	694
Tshopo	Bengamisa	Rural	409	423	436	450	464	478
Tshopo	Isangi	Rural	588	607	626	646	666	687
Tshopo	Kabondo	Urbano Rurale	604	623	643	663	684	705
Tshopo	Lowa	Rural	463	478	493	508	524	541
Tshopo	Lubunga	Urbano Rurale	533	550	567	585	604	622
Tshopo	Makiso Kisangani	Urbano Rurale	1 560	1 610	1 662	1 714	1 768	1 822
Tshopo	Mangobo	Urbain	497	513	530	546	563	581
Tshopo	Opala	Rural	465	480	495	510	526	543
Tshopo	Opienge	Rural	223	230	237	245	252	260
Tshopo	Tshopo	Urbano Rurale	663	685	707	729	752	775
Tshopo	Ubundu	Rural	357	368	380	392	404	417
Tshopo	Wanierukula	Rural	275	284	293	302	311	321
Tshopo	Yabaondo	Rural	588	607	626	646	666	687

Tshopo	Yahisuli	Rural	338	349	360	372	383	395
Tshopo	Yahuma	Rural	742	766	790	815	841	867
Tshopo	Yakusu	Rural	577	596	615	634	654	674
Tshopo	Yaleko	Rural	543	561	579	597	616	635
Tshopo	Yalimbongo	Rural	391	404	417	430	443	457
Total Tshopo			**11 780**	**12 159**	**12 547**	**12 943**	**13 347**	**13 759**
Tshuapa	Befale	Rural	761	785	810	836	862	889
Tshuapa	Boende	Urbano Rurale	1 082	1 117	1 152	1 189	1 226	1 264
Tshuapa	Bokungu	Rural	843	870	898	926	955	984
Tshuapa	Busanga	Rural	412	425	439	453	467	481
Tshuapa	Djolu	Rural	968	999	1 031	1 063	1 096	1 130
Tshuapa	Ikela	Rural	768	793	818	844	870	897
Tshuapa	Lingomo	Rural	554	572	590	608	627	647
Tshuapa	Mompono	Rural	584	602	622	641	661	682
Tshuapa	Mondombe	Rural	710	733	756	780	804	829
Tshuapa	Monkoto	Rural	512	529	546	563	581	599
Tshuapa	Wema	Rural	450	464	479	494	510	526
Tshuapa	Yalifafu	Rural	691	714	736	760	783	807
Total Tshuapa			**8 334**	**8 603**	**8 877**	**9 157**	**9 443**	**9 734**
Total RDC			**417 474**	**430 930**	**444 673**	**458 703**	**473 020**	**487 623**

Annexe 6 : Participants aux travaux d'élaboration du PSN SACO 2025-2030

N°	Nom	Institution	E-mail	Téléphone
MSPHPS				
1	Dr Bijou Pekwa	Cabinet MSPHPS	samupekwa@aol.com	+243820651002
2	Dr Bosstron Kukambu	Cabinet MSPHPS	bosstronkukambu505@gmail.com	+243816835188
3	Dr Theodore Assani	SG SPH	drtheodoreassani@yahoo.fr	+243810818975
4	Dr Bosco Ngosse	SG SPH	ngossesaolona23@yahoo.com	+243813972198
5	Dr Sylvie Nseya	SG SPH	sylvienseya10@gmail.com	+243810531300
6	Dr Patrick Obey	SG SPH	obeypatrick01@gmail.com	+243822549426
7	Dr Emilia Sana	INSP	emiliasana@hotmail.fr	+243820066173
8	M Alain Bokonda	INSP	bokondalain@gmail.com	+243810763355
9	M Elvis Tshibasu	ANICNS	elvistshibasu@anicns.gouv.cd	+243893336899
10	Dr Veronique Molano	CN-CSU	vmolano63@gmail.com	+243815200207
11	Dr Jean-Marcel Bokingo	DGOGSS	marcelbokingo@yahoo.fr	+243854791863
12	Dr Moise Kakule	DGOGSS	drkakulemoise@gmail.com	+243812409989
13	Dr Emery Ngudua	DGOGSS	ngudua@gmail.com	+243811964663
14	Dr Christian Siboko	DGOGSS	csiboko90@gmail.com	+243821518696
15	Mme Nadine Rubango	DGOGSS	nadinerubango@gmail.com	+243814899819
16	M Franck Mondombo	DGOGSS	albert.kadjunga@gmail.com	+243814591403
17	Dr Justin Muhindo	DGOGSS	justinokir@gmail.com	+243819922871
18	Dr Justin Kabonjo	DGOGSS	justinkabodjo@gmail.com	+243822549426
19	Dr Rachel Ngwangwa	DGOGSS	rachelngwangwa@gmail.com	+243815744657
20	Mme Raïssa Malimingi	DGOGSS	rmalimingi@gmail.com	+243999646013
21	M Eric Katanga	DGOGSS	katanga.eric@gmail.com	+243815111381
22	Mme Angèle Banseka	DGOGSS	angelbanseka@gmail.com	+243840745544
23	Dr Joachim Ondendakemi	DGOGSS	drjoachimonde@gmail.com	+243810393296
24	Dr Bonas Bontamba	DGOGSS	drbotamba@gmail.com	+243818371224
25	M Bavon Luana	DGOGSS		+243818107715
26	M Marcel Makangu	DEP	marcelmakangu@yahoo.fr	+243814048462
27	Dr Placide Welo	PNECHOL-MD	placidewelo@gmail.com	+243828888911
28	Dr Didier Gasigwa	PNECHOL-MD	didier.gasigwa@outlook.com	+243816061975
29	Dr Albert Kadjunga	PNECHOL-MD	albert.kadjunga@gmail.com	+243823795770
30	M Guy-Bijoux Alia	PNECHOL-MD	guybijoux@gmail.com	+243811996571
31	M Raoul Kamanda	PNCPS	raoulkamanda2@gmail.com	+243819500379
32	Dr Bibi Mboma	PNSR	bimbo_tshi@yahoo.fr	+243813402255
33	Mme Angele Shangambulu	PNSR	angeleshanga@gmail.com	+243822766725
34	Dr Bruno Bindamba	PRONANUT	bbindamba@gmail.com	+243824020356
35	Dr John Makengo	PRONANUT	makengo_j@yahoo.fr	+243829139707
36	M Evariste Mbombeshayi	PRONANUT	evaristembombe@yahoo.fr	+243815397241
37	Dr Ambroise Umba	PNLT	ambroiseumba@yahoo.fr	+243899219725
38	Mme Mireille Bambule	PNLS	mireillebambule70@gmail.com	+243818107482
39	Mme Clarisse Mbo	PNLP	clarissekaboyi@gmail.com	+243823084286
40	Dr Blaise Mumbungu	PNLP	mumbungublaise@gmail.com	+243817077644
41	Dr Emery Shandende	PNLCD	shandendeemery@yahoo.fr	+243815799092
Autres ministères				
42	M Godefroid Kayemba	MIN FINANCES	godefroidkayemba1@gmail.com	+243899600096

PTF				
43	Dr Lydia Mulongo	UNICEF	lmkabamba@unicef.org	+243817152626
44	Dr Freddy Salumu	UNICEF	fsalumu@unicef.org	+243817096213
45	M Medard Moke	UNICEF	mmoke@unicef.org	+243815138481
46	Dr Pomie Mungala	SANRU	pomie.mungala@sanru.org	+243971019111
47	Dr Papy Luntadila	SANRU	papy.luntadila@sanru.org	+243814955436
48	Dr Adrien N'siala	SANRU	adrien.nsiala@sanru.org	+243971019131
49	M Francis Lwapa	RTSL	flwapa@rtsl.org	+243840036909
50	Dr Billy Yumaine	RTSL	byumaine@rtsl.org	+243814203050
51	M Trad Haton	PATH	thatton@path.org	+243817085700
52	Dr Saira Nawaz	PATH	snawaz@path.org	+14107390026
53	Dr Ernest Mbo	PATH	eilenga@path.org	+243815433023
54	Dr Jimmy Anzolo	PATH	janzolo@path.org	+243812002299
55	Dr Alexis Mwanza	PATH	amwanza@path.org	+243815352222
56	Dr Dolla Ngwanga	Village Reach	dolla.ngwanga@villagereach.org	+243815847439
57	Dr Rigo-Fraterne Muhayangabo	Mothers2Mothers	rigofraterne@gmail.com	+243972194019
58	Dr Francine Ngalula	BM	fngalula@worldbank.org	+243812463011
OSC				
59	M Etienne Tshimanga	CNRSC	etiennetshimanga@cnrsc.org	+243813182187
ICHESS				
60	Dr Ngashi Ngongo	ICHESS	nngongo@ichess-us.org>	+243978099629
61	Dr Gullit Lufiauluisu	ICHESS	glufiauluisu@ichess-us.org	+243833465290
62	Dr Toto Ezombe	ICHESS	tezombe@ichess-us.org	+243815108837
63	Dr Mireille Meta	ICHESS	mmeta@ichess-us.org	+243812645372
64	Dr Lucien Banze	ICHESS	lbanze@ichess-us.org	+243970836299
65	Dr Godé Mpemba	ICHESS	gmpemba@ichess-us.org	+243997555410
66	Dr Prince Lumbu	ICHESS	plumbu@ichess-us.org	+243825363907
67	Dr Jude Ngashi	ICHESS	Jngashi@ichess-us.org	+243812782656
68	Dr Jean Shonganye	ICHESS	Jshonganye@ichess-us.org	+243815892930
69	M Jean Lubuanga	ICHESS	jlubuanga@ichess-us.org	+243812271621
70	M Emmanuel Nsamba	ICHESS	ensamba@ichess-us.org	+243972527949
71	M Josué-Socrate Ilunga	ICHESS	jsilunga@ichess-us.org	+243820829592
72	M Prince Nsamba	ICHESS	pnsamba@ichess-us.org	+243822004180